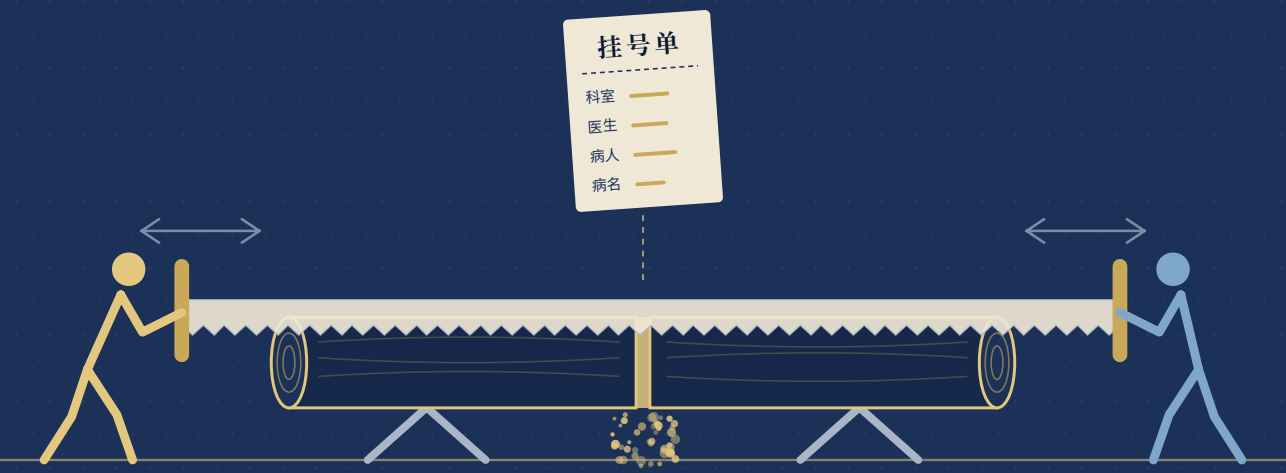
SDE UNIVERSES
德麦国际专著 · 第 571 号

普通人都能明白的

医患复合体状态发生学

病不在病人身上，也不在医生眼里



医
医生位：锯的这一头

锯口
病在这里，不在哪一头

患
病人位：锯的那一头

王德生　著

德麦国际出版社
Demai International Press

德麦国际专著 · 第 571 号

医患复合体状态发生学

病不在病人身上，也不在医生眼里

王德生　著

德麦国际出版社
Demai International Press · Singapore

出　版　信　息

书名	《医患复合体状态发生学——病不在病人身上，也不在医生眼里》
副题	病不在病人身上，也不在医生眼里
英文书名	The State Genesis of the Doctor–Patient Complex
著者	王德生
执笔	王德生口述母题与承重命题并裁定，Claude 执笔与统稿
出版	德麦国际出版社（Demai International Press）· 新加坡
编号	德麦国际专著第 571 号
ISBN	979-8-90690-590-1
定价	US$20.00
开本	170 mm × 240 mm
字数	约 19.3 万字（前言、导读、导论、四编十六章、结语、附录与后记正文 193,495 个汉字）
版次	2026 年 11 月第 1 版
完稿	2026 年 11 月 3 日

AI 协作声明：本书的母题与四条承重命题由王德生于 2026 年 11 月 3 日口述，并由他裁定；正文由 AI（Claude）执笔与统稿：十位执笔者按同一张交接卡分章写成，再经统稿与三审。写作与审读用的是同一个底座，彼此不能当作独立证据；本书没有经过独立学术评审。

编号与 ISBN：本书为德麦国际专著第 571 号，ISBN　979-8-90690-590-1，按站内书目序列与校验位计算，上站前已对站内书目与预留档核过无重号。

健康说明：本书只谈理解，不给诊疗、用药建议。身体或心里的难处真的大了，请找医生或心理咨询师。

引文说明：玻尔、巴拉德、恩格尔、福柯、叙事医学、循证医学等各家的说法一律转述大意，凡带引号处，请读作「大意如此」；拿不准处标〔待核〕。参考书目逐条核过作者、题名、年份与出版者。

书中人物均为虚构：周老师、周岚、豆豆一家，以及各章出现的病人、医生、家属与诊室场景，都是为说明道理而设的构想，不指任何真人，也不承担任何证据。

全书结构：出版信息、题词、作者介绍、成书说明、前言、导读、目录；导论；四编十六章（第一编拆掉三个先在者，第二编诊断：状态发生的开端，第三编三态与转换，第四编复合体的病与修复）；结语；参考书目；附录五件；后记；版本说明。

版权所有　侵权必究

医学研究的不是人的病，而是医患复合体的状态发生；

诊断不是发现的终点，而是状态发生的开端。

——王德生口述，2026 年 11 月 3 日

作者介绍

王德生（Desheng Wang），博士，SIO 本体论与 SDE 发生学（显露·差异序列·特征纠缠）创立者，德麦国际（Demai International）创始人、董事长，主持 SDE Universes 平台与德麦国际专著出版体系。计算数学出身：湘潭大学数学系本科、硕士，中国科学院数学研究所博士，中国科学院计算数学研究所博士后；曾任英国威尔士大学斯旺西分校高级研究员、新加坡南洋理工大学数学系助理教授（博导）与资深研究科学家，在计算数学与图形学国际期刊发表论文四十余篇。2015 年起回国推广三视角方法论，在各地高校讲学数百场；2024 年提出 SIO 本体论与意义三律，后凝练为 SDE 发生学。

本书的母题——医学研究的不是人的病，而是医患复合体的状态发生；诊断不是发现的终点，而是状态发生的开端——由王德生口述提出；正文由 AI（Claude）执笔与统稿，经三审。

成书说明

这是一本普通人都能明白的书，请按它实际做到的范围来读。

谁写的。本书由王德生著。2026 年 11 月 3 日，他口述了本书的四条承重命题：不是病人生病了，也不是医生看病，而是「医生—病人这个生命互动复合体」生病了，这是健康发生学；这是量子力学「系统状态的发生里有观察者的参与和建构」的延伸，但观察者仍然是发现学，本书连观察者一起拆掉；所谓诊断，就是健康发生学的开始，发现学里诊断是终点，发生学里诊断是起点；精确的说法是「医生—病人」互动复合体的状态发生学，健康与病不是两样东西，是同一复合体的状态。四条命题按原话登记在附录二。定题、定大纲之后，十位执笔者按同一张交接卡分章写出初稿，再经统稿与三审。

哪些是转述。书中所论各家学说，一律转述大意；直接引号只用通行短语。转述不能代替读原著。

哪些是构想。书中的人物、病例与诊室场景，都是为说明道理而设的构想，不是观察记录，也不是临床研究。

哪些是本书自己的判断。「复合体生病」「诊断是开端」「三态与转换」「科室与读数一起显出」「病名是第一次回写」「解散是最好的痊愈」是本书立的说法，不是医学的公论；附录二把口述命题与本书自己的解释分开登记，附录四写明本书自认最弱的几处与推翻条件。

哪些不是。本书不给诊疗、用药建议，不主张任何新疗法，不反对循证医学；「复合体生病」不等于责任稀释，该追责仍追责。

正文字数。前言、导读、导论、四编十六章、结语、附录与后记的正文实计 193,495 个汉字；章题、节题、表格与参考书目不计入。

前言

◆ 一、一段口述

2026 年 11 月 3 日，王德生博士在一次谈话里，把一个想法从头说了一遍。

那天说的话不长，前后不过一顿饭的工夫。可它是一步一步往里收的：每说一步，前一步里还松着的地方就紧一分。本书的全部内容，都从这段话里长出来。

所以前言不先讲道理，先把这段话的来路摆出来。你看清了它是怎样一步步收紧的，后面的十六章就不会觉得突然。

收紧一共五步。

第一步，从一句日常话开始：医院里出的事，不是病人生病了，也不是医生在看病。

第二步，说这件事是量子力学那条思路的应用。

第三步，补一句要紧的限定：那条思路里的观察者，仍然是发现学。

第四步，落到医院里最常见的一个动作：诊断，就是开始。

第五步，把前四步收成一个名字：状态发生学。

下面一步一步讲。

◆ 二、第一步：不是病人生病了

先从一个你一定见过的场面说起。

一个人头晕了两个星期，去了医院。医生问了半天，开了几项检查。结果出来，一切正常。医生说：「没查出大问题，回去注意休息。」

病人走出诊室，心里更不踏实了。

这个场面，通常有两种讲法。

一种讲法说：病人生病了，病在他身上，医生没查出来，是医生的事，或者是仪器的事。另一种讲法说：医生在看病，病是现成的，看得准不准，看医生的本事。

两种讲法吵了很多年，其实站在同一个地方：病是一个先在的东西，长在某个人身上，等着被看见。

王德生博士那天的第一句话，把这个地方挪开了。大意是：不是病人生病了，也不是医生看病，是「医生—病人」这个生命互动的复合体，生病了。

这句话先别急着当成口号。它说的是一件很具体的事。头晕的人，没查出问题的医生，等了三小时的挂号窗口，还有那张写着「未见明显异常」的单子，合在一起，是一件事。这件事卡住了。卡住的不是其中某一个人。

这就是本书所说的健康发生学的头一步：把承载「病」的那个东西，从一个人身上，换到一个互动的整体上。

这一步还很松。因为听的人可以问：复合体是什么？它是不是把「病」说虚了？这些问题，留给后面。

◆ 三、第二步：这是量子力学的应用

第二步，王德生博士说：这是量子力学的应用。

这句话要说得很小心，因为它最容易被说歪。

本书不说「量子力学证明了医学怎样」。也不说「人的意识能改变病情」。那样的话，被物理学家一问就站不住。

本书借的是量子力学里一个很朴素的看法：一个系统的状态，不是先放在那里、等人来读的；读数的形成里，有测量安排的参与。玻尔管这叫「现象」：不是脱离测量的对象，而是对象与测量安排合在一起的结果（玻尔，大意如此〔核：大意〕）。

把这个看法搬到诊室里，意思就近了：一个人的「病」，并非先放在他身上、等医生来读。读出什么，和谁来读、在哪里读、怎样问、怎样查，是一起形成的。

同一个头晕的人，挂神经内科和挂心内科，路上遇到的问题不同，做的检查不同，最后落在病历上的话也不同。没有谁出错。状态在不同的互动里，长成了不同的样子。

所以第二步比第一步又紧了一点：不只是「病在复合体里」，而是「状态的发生里，本来就有观察的参与和建构」。

可是话说到这里，还差一个要紧的限定。

◆ 四、第三步：观察者仍然是发现学

第三步，王德生博士补了一句，也是全书最硬的一句：观察者，仍然是发现学。

先说什么是发现学。

发现学的样子是：先有一个现成的东西，人去找到它、读出它、说清它。找得好不好，看人的本事。「真相」是终点。

再说什么是发生学。发生学的样子是：东西不是现成的，是在互动里一点点长出来的；长出来之后，才看上去像一个现成的东西。

量子力学那条思路，已经往前走了一大步：它承认观察者不是旁观者，观察者参与了状态的形成。这一步很了不起，把发现者从幕后请到了台前。

可是请到台前以后，他还站在那里。

「观察者参与建构」这句话里，有一个先在的人：他先在，他去观察，他去建构。建构主义的说法，也是这样：知识是人建构的，所以病也是人建构的。这仍然是一个发动者在做事，只是他做的事从「发现」换成了「建构」。

本书把这叫作发现学的内部改良。改良得很好，可是承重的那根梁没换：先有一个发动者。

王德生博士的主张是，连这个发动者一起拆掉。观察者不是先在的。观察者和他观察的状态，是同一场发生沉淀下来的两头。

放回诊室里说：「医生」这个位子（专业上叫号位），不是先有一个医生、再去看病。是挂号那一刻，这个位子才和「病人」的位子、和「科室」、和「病名」一起显出来。

第三步，就这样把前两步又收紧了一圈。

◆ 五、第四步：诊断就是开始

第四步落在医院里最普通的一个动作上：诊断。

在发现学里，诊断是终点。病是现成的，医生把它找到，说出名字，事情就算有了答案。「确诊」两个字，听上去就像一块石头落了地。

王德生博士的说法正好倒过来：所谓诊断，就是健康发生学的开始。

为什么？因为诊断那一刻，有三样东西一起出现了：

「病人」的位子，「医生」的位子，还有「病名」。

之前，只有一个说不清的难受。之后，一个人成了病人，一个人成了医生，一个难受有了名字。名字写进病历，也写进日子：从此，这个人吃什么、做什么、怎么向家人说话、怎么看自己，都带上了这个名字。

诊断不是把一件事了结了，是把一件事开了头。开的是什么头？是这个复合体第一次有了形状，往下怎么走，才真正开始。

这一步最贴近日子。很多人都有过这样的经验：拿到诊断书的那一天，觉得一切才刚刚开始。

◆ 六、第五步：收成状态发生学

最后一步，是把前四步收成一个名字。

王德生博士给的精确说法是：「医生—病人」互动复合体的状态发生学。

为什么不叫「疾病发生学」？因为疾病发生学已经默认了：先有一个叫「病」的东西，它发生了。

为什么也不叫「健康发生学」就完事？因为那个名字太宽，容易被理解成「怎样保持健康」的小窍门。

「状态」这个词，把健康和病放回了同一个地方：它们不是两样东西，是同一个复合体的两种状态。要问的不是「病从哪来」，而是「这个复合体的状态怎样发生，怎样转换」。

到这里，五步收紧了：

从「病人的病」，到「复合体的病」；

从「复合体的病」，到「状态的发生里有观察者的参与」；

从「观察者的参与」，到「观察者本身也是发生的沉淀」；

从「诊断是终点」，到「诊断是开端」；

最后，收成「状态发生学」。

收得很紧，也收得很小。小到可以放进一个挂号窗口里看。

把五步放回一个人的日子里

五步讲完，可以拿一个人的日子再走一遍。

书里有一位周老师，62 岁，退休的中学语文老师，头晕了两个星期，去了医院。

第一步，他走进诊室的时候，别人问他「哪里不舒服」，他答不上来。他说的头晕，一半在头上，一半在心里。这件事不在他一个人身上，也不在医生一个人身上；是他、医生、候诊的长椅、等结果的下午，一起在做的一件事。

第二步，医生问一句，他答一句；医生换一个问法，他就想起另一件事。他说出来的「头晕」，是在这一问一答里一点点成形的，不是早就在他肚子里装好、等着被取出来的。

第三步，医生写病历的时候，也许心里想：我只是在忠实地记录。可是他问什么、不问什么，先查哪一项，本身就是在参与。参与的人，也是在这一场里才成了「医生」的。他不是站在场外的一个裁判。

第四步，几天后，一个名字落在了病历上。周老师回到家，对女儿说：「医生说了，是这个。」他说这话时，语气里有一点松，也有一点紧。松的是终于有个说法；紧的是，这个说法从此要跟着他过日子了。

第五步，如果有人问这位老人：你这一趟，是怎么回事？最贴近的回答，是：我、医生、一张单子，还有我女儿那个没有去的诊室，一起把一件事做了出来。这就是状态发生。

五步放在一个人身上，没有一步是新道理，每一步都是他自己的经验。

◆ 七、判词

五步走完，全书的脊梁就立起来了。先把它摆在桌上：

医学研究的不是人的病，而是医患复合体的状态发生；诊断不是发现的终点，而是状态发生的开端。

这句话分两半。

前一半说：承载者换了。医学面对的对象，不是躺在床上的那个人，而是这个人和他的医生、他的医院、他的家，合起来的一个互动。

后一半说：诊断的位置换了。它从一条路的尽头，挪到了另一条路的起点。

这两半不是新发明出来的口号，它们各自都踩在医生和病人早就知道的事上。一个有经验的医生都知道，同一个病，换一个病人，换一个家庭，结局不同。一个久病的人都知道，拿到诊断以后，最难的日子才开始。

本书做的事，只是把这些人人知道、却没有地方安放的经验，放进一个说得通的说法里。

◆ 八、为什么是现在

这本书为什么现在写？

因为有三件事，今天正好撞在一起。

第一件，检查越来越准，人却越来越不踏实。指标出来了，报告厚了，可「查不出问题但就是难受」的人，比过去更多地走进了诊室。

第二件，医生和病人都在说累。医生说，指标压着，时间压着，每句话都得想想会不会被追究。病人说，三分钟看完一个病，问不完要问的话。两头都累，说明累的不是某一头。

第三件，会说话的机器进来了。它能读片子，能写病历，能回答病人半夜睡不着时的问题。医生和病人之间，多出了一个位子。这个位子是谁的？是工具，还是第三个方？

这三件事，用「病人有病、医生看病」的老办法，都说得吃力。换成「复合体的状态」来看，反倒顺了。

◆ 九、拆不是骂

还要说清楚一条规矩。

拆不是骂。发现学的医学，是人类最了不起的成就之一。它让天花绝迹，让手术不再等于赌命，让许多从前只能等死的人活了下来。

本书对它只有一个请求：在它对的地方，让它对到底；在它够不着的地方，别硬说它够得着。

所以每一章，都先说发现学的医学对在哪里。然后才说，它停在了哪里。

这本书里还会提到几位近邻：玻尔、巴拉德、恩格尔、福柯，还有叙事医学的倡导者（美国医生丽塔·卡伦，中文译名不一）和循证医学的开创者们。他们各自走到了一步，本书向他们学，也要说出本书和他们的分别。他们的话，书中只转述大意，括号里注常见出处，拿不准的改写成稳妥的说法。

◆ 十、给读者的几句话

书里有一家人：周老师，他的女儿周岚，外孙豆豆。他们是虚构的，只负责让每一个判断，落到同一家人的日子里。

书里不给诊疗建议，也不教用药。它只讲怎样理解。

如果你正在身体或心里的难处里，请记住：身体或心里的难处真的大了，请找医生或心理咨询师。

最后，一本讲「复合体」的书，也盼着被读者回写。读到哪里觉得不对，就把那一处带回你自己的诊室、你自己的病床边试一试。试出来的，比这本书写的更要紧。

为什么写给普通人

最后一个问题：为什么不写给医生，不写给哲学家，写给普通人？

因为复合体里的每一个人，都是普通人。

没有人一出生就是医生，没有人一辈子都不是病人。一个医生，下了班，要陪父亲去复诊；一个病人，换一个场合，是别人的家属。每个人在一生里，要在这个复合体的不同位子上，站许多次。

所以这本书不预设你读过量子力学，也不预设你读过任何医学书。它只预设一件事：你去过医院，或者陪人去过医院。

那就够了。

◆ 十一、这本书怎样写成

最后交代一下这本书的写法。

全书分四编十六章，前有导读和导论，后有结语和附录。每一章按同一个顺序走，从你遇到过的事进去，到一句可以抄进本子的话出来。

王德生博士的口述，本书只用第三人称转述，不替他说「我」。凡是他明确说出的命题，书中都不改动意思；凡是本书自己的推演，会标明「待验」。

书里的人物都是虚构的。周老师一家三口，不对应任何真人，也不承担任何证据。他们只负责一件事：让每一个判断，掉到一个具体的晚上。

书里没有一个字是诊疗建议。

导读

◆ 一、这本书的地图

全书四编，十六章，前有导论，后有结语和附录。

四编是一条往里走的路。先清地基，再看开头，再看中段，最后看病在哪里、怎样修。

第一编　拆掉三个先在者：病人、医生、观察者都不先于互动。 共四章。

医学的老看法里，有三个人物站得太稳：带着病来的病人，负责发现的医生，站在一旁的观察者。第一编把这三个人物一个一个请下台。

第 1 章问：病人是不是带着病来的？进诊室之前，只有不适和苦；「我是病人」是一个位子，不是一个身份。第 2 章问：医生是不是发现者？同一副身体，换一个医生、换一家医院，读出不同的病。没有谁错，只是复合体不同。

第 3 章讲观察者。量子力学里的观察者、玻尔的「现象」、巴拉德的说法，都往前走了一步，可是都给发动者留了座。建构主义也是。第 3 章要说清：这是发现学的内部改良。第 4 章换位：状态属于复合体。安慰剂、反安慰剂、医源性疾病、过度医疗，原来在医学里被当作「干扰项」，现在成了正文。

第二编　诊断：状态发生的开端。 共四章。

第 5 章写诊断之前：没有形状的苦。「查不出问题但就是难受」，在这一章里不是例外，是常态。第 6 章写诊断即开题。病人位、医生位、病名，一起出现。病名是第一次回写，写进病历，也写进日子。

第 7 章处理一个好用的比喻：「科室就是测量基」。挂消化科读出胃炎，挂心理科读出焦虑，这个比喻很有力，可是它预设了有一个人在选。第 7 章要把它收回来，改写为：科室与读数，一起显出。第 8 章问：病名是通路，还是笼子？同一个诊断，有的复合体流通，有的被病名压住。复诊和第二意见，不是纠错，是重新起头。

第三编　三态与转换：定型靠一锅粥和悬着活着。 共四章。

第 9 章讲介生态：悬着的治疗。病名已立，结局未定，每次复诊都是一次状态转换。第 10 章讲秩序态靠混沌态和介生态活着。一个从来不进入悬着的人，不是健康，是把一锅粥压住了。

第 11 章讲不对易：器质性和心因性是两种读数，不能同时测准，越追一边，另一边越模糊。第 12 章讲解散：最好的痊愈，是复合体不再被需要。出院，是一种秩序态。

第四编　复合体的病与修复。 共四章。

第 13 章写医生端的症状：职业倦怠、指标焦虑、防御性医疗。它们不是医生个人的毛病，是复合体的症状。第 14 章写痛则不通：复合体卡在哪一处。说不出，读不懂，回写不进，三处卡法不同。

第 15 章问：复合体生病，责任在哪里？不取消问责，只是重新找修复的地方。第 16 章写医生—病人—AI。AI 是新进来的位子，不是工具。这是人与机器合成新主体的第一个行业样本。

读完四编，你会发现一个顺序：先拆地基上的人，再看一件事怎么开头，再看它怎么悬着、怎么落定，最后看它坏在哪里、怎么修。

◆ 二、这四句总判断，先露个底

每一编结束的时候，都有一句总判断，加粗，单独站着。先把四句摆在这里，让你有个底。

第一编的总判断是：

病人、医生、观察者，都不是先于这场互动而在的；他们是这场互动沉下来的三个位子。

第二编的总判断是：

诊断不是把一团苦收成一个名字，而是让一个复合体第一次有了形状。

第三编的总判断是：

定下来的东西，靠一锅粥和悬着活着；不肯悬着的复合体，不是健康，是被压住了。

第四编的总判断是：

复合体生病了，追责照追；追的是修复的地方，不是替罪的人。

四句话，读完全书回头再看，意思会比现在深。

从哪一章开始最容易

不知道从哪里下手，可以挑一章。

第 5 章最容易。它讲的是「查不出问题但就是难受」，几乎每个人都经历过，读起来像在说自己家里的事。第 9 章也不难。它讲的是病名立了、结局没定的那段日子。有人在这段日子里待过，读到会点头。

最不容易的是第 3 章，后面会专门提醒。

读书时记一笔

最后有一个小办法，供读者试。

准备一个小本子，每读完一章，只记三行。

第一行，抄下章末那句「带走的话」。

第二行，写一件你自己身边的事，是这一章里说过的。哪怕只有一句：「上周妈妈去复诊，回来说医生没怎么讲话。」

第三行，用随身三问问它一遍：这次的病，放在谁身上了？

三行，两分钟。读完全书，你有了十六页小笔记。那十六页，比这本书更是你的。

目录里的判断

只看目录，就能看出全书在拆什么。

编题都是一个主题，加一句判断。第一编，主题是拆三个先在者，判断是它们都不先于互动。第二编，主题是诊断，判断是它是状态发生的开端。第三编，主题是三态与转换，判断是定型靠一锅粥和悬着活着。第四编，主题是复合体的病与修复。

章题则是一个画面，或者一个直接的结论：「病人不是带着病来的」「医生不是发现者」「观察者仍是发现学」。

读目录就像读一篇很短的论证。哪一章你最不服气，可以先从那一章读起。

◆ 三、三条读法路线

不是每个人都有时间读完二十万字。下面三条路，各有各的走法。

只有一个下午：读导论，再读第 6 章、第 10 章、第 12 章。

导论讲全书的钥匙；第 6 章讲诊断为什么是开头；第 10 章讲悬着为什么不是坏事；第 12 章讲治好是怎么回事。这四样读完，全书的骨架你就握住了。

为家里有病人来的：先读第 1 章和第 5 章，再读第 8 章、第 9 章，最后读第 15 章。

第 1 章和第 5 章让你知道，那个说不清的难受，为什么不是你「想多了」。第 8 章和第 9 章讲拿到病名以后的日子，怎样别被名字压住，怎样在悬着里等。第 15 章谈责任，对家里人尤其要紧：家人也在复合体里，但不必替所有事背锅。

为当医生来的：先读第 2 章和第 7 章，再读第 13 章、第 14 章，最后读第 16 章。

第 2 章和第 7 章讲医生位是怎么显出来的，科室是怎么回事。第 13 章和第 14 章讲医生端的累，说它不是个人的软弱。第 16 章讲 AI 进来以后，你和病人之间多了什么。

还有一条小路，给想一个问题找一章的人：

想知道「为什么检查正常人还难受」，读第 5 章。

想知道「为什么换一家医院说法不一样」，读第 2 章和第 8 章。

想知道「安慰剂到底是怎么回事」，读第 4 章。

想知道「病好了怎么算」，读第 12 章。

想知道「医生为什么越来越累」，读第 13 章。

想知道「AI 来了，我还要不要找医生」，读第 16 章。

◆ 四、陪读的一家人

书里反复出现一家三代。他们是虚构的，不承担任何证据，只负责让每一个判断，落到同一家人的日子里。

周老师，62 岁，退休的中学语文老师。血压高了八年，药一直在吃，有一本红皮本子记着每天的数，可每次量血压，心里总要先紧一下。他教了三十多年书，习惯把事情讲清楚，也习惯别人把事情对他讲清楚。

周岚，34 岁，周老师的女儿，社区医院的全科医生，已经做了五年。

她在诊室里是医生。在父亲的病床前，她是家属。她自己发烧的那几天，她是病人。一个人，三个位子，换得极快。书里很多地方，借她看「位子会换」这件事。

豆豆，7 岁，周岚的儿子，周老师的外孙。常咳嗽，一咳就是几个星期。他还不会说「我难受」，只会说「我不想去」。

这一家人，同时有医生位，也有病人位，正好让你看见：位子是会换的。

你读到后面，会发现周老师有时是病人，有时是周岚的「病人家属」，有时在豆豆面前是外公。同一个人，不同的位子，说出来的话也不一样。

为什么只有一家人

书里只放了一家人，没有放第二家，更没有放一大群。

这是有意的。一家人，三代，三个位子，已经足够让你看见：同一个人，可以是病人，也可以是医生，也可以是家属。多放几家，只会让人名多起来，反倒冲淡了「位子会换」这件事。

周老师、周岚、豆豆之外，书里偶尔会出现一两位路过的人，比如候诊区的另一位病人，窗口里的一位工作人员。他们只出现一次，不记名字。

◆ 五、全书的十个画面

如果你喜欢先看画面，再看道理，下面是全书最常回来的十个画面。每个画面，背后都有一章。

一张挂号单，捏在手里，还有点温。（导论）

一个人站在诊室门口，说不清自己哪里不好。（第 1 章、第 5 章）

同一副身体，放在两家医院的两张桌子上，读出两种说法。（第 2 章）

一个站在玻璃后面的观察者，被人请进了房间，可还是站在那里。（第 3 章）

一粒糖做的药片，让有的人好了，让有的人更难受了。（第 4 章）

一个名字写在病历首页，写了很久，擦不掉。（第 6 章、第 8 章）

病名立了，结局没定，一个人在走廊里来回走。（第 9 章）

一个人平时从不生病，一病就倒下。（第 10 章）

出院那天，病房的灯关了，两个人各自走开。（第 12 章）

诊室里多了一块屏幕，屏幕背后有一个看不见的第三方。（第 16 章）

十个画面，是十张可以单独看的小图。你哪一天忘了书里写什么，只要记得其中一张，就能顺着它找回去。

◆ 六、读的时候容易卡住的几个地方

书里有几处，读者最容易卡住。提前说一声，免得你误会自己读不懂。

第一处，「复合体」这个词。它听上去像一个化学名词，其实指的是很平常的东西：两个人加上他们之间正在发生的事。你可以暂时把它想成「这一场」。

第二处，「位子」这个词。位子不是职位，是一个人在某一场互动里站的地方。周岚在诊室里站在医生位，在父亲床前站在家属位，位子换了，人没换。

第三处，「发现」与「发生」的分别。这是全书的一把尺子。发现是说：东西先在，人去找到它。发生是说：东西在互动里长出来，长出来以后才看上去像先在的。你读到每一章，只要问一句：这一处，是在找东西，还是在长东西？

第四处，「观察者」一章，第 3 章。它是全书最硬的一章，里面有量子力学，有建构主义。如果你觉得吃力，可以先跳过，直接读第 4 章，等读完全书，再回头读它。书的主线不会断。

第五处，「病不在病人身上」这句话。你读到时，可能会生出一点抗拒：我明明有病，疼的是我。这个抗拒是对的，本书也不要你放弃它。后面每一章，都会回到这个抗拒上，一点一点把它放到该放的地方。

七个词，一页纸

导论里会用一张挂号单，把七个词各用一遍。这里先给一页纸，供你随时翻回来对。

形状：一件事在某一次互动里露出来的样子。

路：形状怎样一步步长成这样的，那一串有先后的不同。

土：让路能走、形状能长的那片缠在一起的地。

回写：长出来的东西，又倒回去改了路和土。

一锅粥：还没有形状，什么都搅在一起的状态。

正在成形：形状刚冒出来，还没有定，悬着的状态。

定型：形状立住了，可以反复用的状态。

前四个词，管「事怎样发生」；后三个词，管「事处在哪个阶段」。全书不再增加新词，遇到别的说法，都会指回这七个。

◆ 七、书里会遇到的几个名字

书里会提到几位近邻。先认个脸，后面见到就不陌生。

玻尔，量子力学的奠基人之一。书里借他的「现象」一词，说测量安排和对象合在一起才有读数〔核：大意〕。

巴拉德（Karen Barad），物理学出身的当代科学哲学家，著有《与宇宙中途相遇》（2007）。书里提到她的「agential cut」，意思大致是：对象和观察者的分别，是在互动里被切分出来的，不是事先摆好的〔核：大意〕。

恩格尔，提出生物-心理-社会模式的医生。他在 1977 年的一篇文章里提醒：医学不能只看身体〔核：大意〕。

福柯，写过《临床医学的诞生》（1963）。书里借他说明：医生的「看」，是被历史做出来的〔核：大意〕。

叙事医学的倡导者，把病人的故事请进了医学的中心。

循证医学的开创者们，把大样本的证据放到了治疗的前面。

这几位，每一位都在本书的某一章，被认真地对待一次：先说他对在哪里，再说本书和他的分别。

◆ 八、本书自认最弱的几处

一本敢写判词的书，也该说说自己最站不稳的地方。

第一处，第 3 章对建构主义的概括。「建构主义是发现学的内部改良」这句话，说得很干脆，可是建构主义内部流派很多，不是每一派都留着先在的发动者。这一处可能说得太宽，附录会列出需要收窄的地方。

第二处，急症和外伤。一个人被车撞了，送进急诊，抢救的几分钟里，没有人在谈状态怎样发生。本书的说法在这样的场面里解释力偏弱。本书认下这一点，并且不硬说它够得着。

第三处，安慰剂的机制。第 4 章把安慰剂当作复合体状态的一个侧面来讲，可是安慰剂究竟怎样起作用，医学界本身还在争，本书的解释只能标「待验」。

第四处，第 16 章。AI 进入诊室的时间还太短，没有足够多的经验可以对账。这一章是本书里最新的一章，也是最可能要改的一章。

这四处，读者可以直接拿来挑本书的错。挑出来的，本书再版时会改。

◆ 九、判词怎样才算错

一句能抄进本子的判断，要能被推翻，才配站在第一页。

本书的判词是：

医学研究的不是人的病，而是医患复合体的状态发生；诊断不是发现的终点，而是状态发生的开端。

它在什么时候算错？下面把推翻条件写成人话。

第一，如果有人拿出一种病，不经任何诊断、挂号、询问、检查，就稳稳地呈现为同一个样子；换任何一家医院、任何一个医生，读出来的都分毫不差。那么前一半就要收窄。

当然，有些病是这样的：摔断了腿，换哪家医院，腿都是断的。本书不否认这样的事，只说：腿断了以后，怎么治、治到什么程度、日子怎么过，已经不在这条线上。

第二，如果有人证明，在诊断之后，复合体的状态不再变化，病人和医生各回各位，一切按原来的样子走——后一半就要改。

可是日常经验几乎都在另一边：拿到诊断，一切才开始。

第三，如果有人拿出一种观察理论：不需要先在的发动者，又解释得了状态的形成。那么「观察者仍是发现学」这一条站不住，第 3 章就要改写。

第四，如果有人证明，说「复合体生病」，必然会导致责任被冲淡，无人可追——第 15 章就要重写。

第五，如果有人在医学史里找到一个例子，说明：把诊断当成起点，反而让病人的结局变坏——那就要回头看，是本书哪一处写得不够。

这五条，随便哪一条被找到，本书都愿意改。

◆ 十、随身三问

读到后面，你可能会忘记很多细节。没关系，只带走三个问句。

第一问：这次的病，放在谁身上了？

是放在病人身上，还是放在医生身上，还是放回这两个人加上他们的家、他们的医院，合成的整体里？

第二问：这一处，是发现，还是开头？

诊断、检查、病名、复诊，每一样都问一句：这是在收尾，还是在起头？

第三问：这个名字，是通路，还是笼子？

病名、诊断、标签，写进日子里以后，是让事情流通了，还是把事情压住了？

这三问不用答对，用的时候，只要问出口，就够了。

书里的小记号

书里有几种小记号，先认一下。

〔核〕和〔核：大意〕，表示这条出处已经对过，或者只转述了大意。

〔待核〕，表示本书拿不准、需要再核。这一版付印之前已逐条核过：查实的改成〔核〕，查不实的改写成不带细节的说法，所以正文里已经看不到这个记号。

「待验」，表示这是本书自己的解释，还没有经过检验，欢迎你拿去试。

「据说」，表示这是一个流传的说法，不保证细节。

这些记号不是装饰。一本敢下判词的书，该让你一眼看清，哪些话是对过的，哪些话还悬着。

◆ 十一、凡带引号处，读作「大意如此」

书里凡是带引号的话，请都读作「大意如此」。

引号里的话，要么是转述某位学者的大意，要么是陪读人物说的虚构的话，要么是常见的说法。它们不是逐字引用。

书里提到的学者，只转述大意，括号里标常见出处。拿不准的地方，付印前已核过，或改写成不带细节的说法。

版权期内的著作，只做单句的短引。

如果你想核对原话，请找原书。

◆ 十二、每一章的样子

每一章走同一条路，九件事，顺序大体不变。

第一件，「你一定有过这样的时刻」：从你可能遇到过的事进去。

第二件，老看法：发现学的医学怎么说。先说它对在哪里。

第三件，本书的说法：这一处，复合体的状态是怎么发生的。

第四件，只看一端会怎样：只盯着病人，或者只盯着医生，会出什么事。

第五件，今天与机器：适用的章才有。

第六件，一个完整的例子：多半是周家人的某一天。

第七件，放回日子里：落到一个具体的晚上，给一个明天能试的小办法。

第八件，带走的话：一句，能抄进本子。

第九件，两行小账，再加「想一想」。

两行小账，下面导论末尾细讲。

◆ 十三、给医生、给家属、给读书会的几句话

这本书的读者，不止一种。

如果你是医生。书里不会教你怎样看病。你的专业，书里一个字也不碰。它只请你在每一天的某一个时刻，停一下：这个病人坐下来的时候，我们两个人之间，正在发生什么？你不用改变任何一项诊疗规范，也不用多花时间。你只是多了一个看的角度。很多医生读到第 13 章会有一点释然：原来累的不只是自己。

如果你是家属。书里也不教你怎样护理，怎样劝病人吃药。它只请你看见：你也在复合体里。你不是旁观者，也不是责任的唯一承担者。你说的每一句话，都是在推拉里的一次用力。你能做的，是别用得太猛，也别松手。

如果你自己正在病里。书里不会说「你的病是你想出来的」。它只说，你不是一个人在承担这件事。这件事是你和你的医生、你的家、你身处的医院，一起在做的。

如果你是读书会的带读人。可以每次读一章，用章末的「想一想」开头。不要求答案，只请每个人讲一件自己的事。讲完以后，再看这一章，哪一句最贴。

不管你是哪一种读者，有一个共同的请求：读到哪一处，觉得不对，请先别急着放下。先问一句：我的不对，是因为书写得不对，还是因为我习惯了另一种放法？两者都有可能。这两种可能，本书都愿意听。

◆ 十四、如果读不下去

最后一条，是给读到一半想放下的人。

放下也没关系。

这本书是为日子里用的，不是为读完而读的。你读了一章，明天在候诊室里多问了自己一句「这次的病，放在谁身上了」，这本书就用上了。

读不下去，多半有两种原因。一种是书写得不够好，那是本书的责任。另一种是你现在正好在一个很难的时刻，不想听任何道理。后一种，请先放下书，去做一件对自己好的小事。

书会在这里。

◆ 十五、一条界线

最后说一条界线。

本书只谈理解，不给诊疗建议，也不教用药。书中写到病例，用的都是具体但虚构的人。

读这本书，不会替代你和你的医生之间的任何一次谈话。

身体或心里的难处真的大了，请找医生或心理咨询师。

目 录

作者介绍 iv

成书说明 v

前言 vi

导读 xiv

导论 1

第一编　拆掉三个先在者：病人、医生、观察者都不先于互动 **21**

第 1 章　病人不是带着病来的 22

第 2 章　医生不是发现者 41

第 3 章　观察者仍是发现学 59

第 4 章　承载者换位：复合体 77

第二编　诊断：状态发生的开端 **95**

第 5 章　诊断之前：没有形状的苦 96

第 6 章　诊断即开题 112

第 7 章　为什么「科室就是测量基」要收回 131

第 8 章　通路还是笼子：病名的两种回写 149

第三编　三态与转换：定型靠一锅粥和悬着活着 **167**

第 9 章　介生态：悬着的治疗 169

第 10 章　秩序态依靠混沌态与介生态 187

第 11 章　不对易：器质性与心因性 205

第 12 章　解散：最好的痊愈 225

第四编　复合体的病与修复 **247**

第 13 章　医生端的症状 248

第 14 章　痛则不通：复合体卡在哪一维 267

第 15 章　复合体生病，责任在哪里 286

第 16 章　医生—病人—AI：三方复合体 303

结语　再拉一遍那把锯 319

参考书目 329

附录 333
附录一　近邻与敌人对账表 334
附录二　口述命题登记 340
附录三　十大常见误读 343
附录四　本书自认最弱的几处与推翻条件 346
附录五　练习 349
后记 352
版本说明　本版字数、版本与交付 357

导论

◆ 一、一张挂号单

周老师头晕两个星期了。

不是天旋地转的那种。是早上起床，站直了，眼前轻轻晃一下；下午批改外孙豆豆的拼音作业，低头久了，抬起来，屋子慢半拍才回到原位。他自己量过血压，数字比平时高一点，不算吓人。

女儿周岚在社区医院做全科医生，电话里说：「爸，你来我这儿，我给你看。」

周老师没有去。

他说：「你是我女儿，我坐在你面前，话都不好好说。」

这句话里藏着一件事，先放着，后面会回来。

第二天一早，他去了离家两站路的一家大医院。挂号窗口排着长队，他前面是一个抱着孩子的年轻母亲，后面是一位拄拐杖的老先生。轮到他，窗口里的人头也不抬，问：「哪个科？」

周老师愣了一下。

他不知道头晕该挂哪个科。他说：「就是头晕，血压也有点高。」

「那挂心内科吧。」窗口里的人说。

机器吐出一张小纸条。纸条上有他的名字，有一个就诊序号，有「心内科」三个字，有一个日期，有一个诊室的号码，还有一行小字，写着挂号费。

周老师把纸条捏在手里，往电梯走去。

这就是一张挂号单。它很小，比一张公交卡还窄。

可是请你注意：在他捏起这张纸条之前，和捏起这张纸条之后，发生了一些事。

◆ 二、挂号那一刻

捏起纸条之前，周老师是什么？

他是一位头晕了两个星期的老人。他有一个模模糊糊的担心，有一点不好意思麻烦女儿，有一个他自己都说不清的怕。这时候，没有「病人」，也没有「医生」，更没有「心内科的病」。只有一团还没有形状的不适，裹在他的日子里。

捏起纸条之后呢？

他有了一个名字，印在纸条上。他有了一个科室，叫心内科。他有了一个去处，诊室门口的长椅。他有了一个身份，叫「病人」。同时，在诊室里坐着的那个人，被这张纸条召成了「医生」。

注意这个顺序。不是先有一个病人、一个医生，然后他们碰面，纸条是个记录。是纸条出来的那一刻，「病人」「医生」「科室」「病名」这几样东西，才开始一起露面。

本书把这个瞬间叫作**挂号那一刻**。

挂号那一刻，「病人」「医生」「科室」「病名」开始一起显影。

它是全书的总钥匙。后面十六章，每一章都是在这一刻的某一个侧面上，把这把钥匙再转一圈。

为什么选这个瞬间当钥匙？

因为它是医学里最平常、最容易被忽略的一刻。人人都挂过号，人人都觉得那只是一个手续。可恰恰是这个手续，把一团没有形状的东西，变成了医学能够处理的东西。

手续不是旁观记录，手续是动手的一部分。

◆ 三、七个词，用这张单子各用一遍

本书用七个家常词，讲所有的事。下面就用这张挂号单，把七个词各用一遍。

形状。 形状是一件事露出来的样子。

周老师头晕，最初没有形状，只是「不太对劲」。到了窗口，这团东西第一次有了一个样子：「头晕，血压高」，变成了心内科的一个挂号。再到诊室，它又变一次：医生写下「头晕待查」，这就是又一个形状。

专业的话，形状就是显露（SDE 里的 S）。本书平时只说形状。

形状不是事情本来的样子，是事情在这一次互动里露出来的样子。换一个窗口，换一个问法，形状就不同。

路。 路是形状怎样一步一步长成这样的，那一串有先后、会修正的不同。

周老师的路是这样的：先是轻轻晃一下，再是低头抬头慢半拍，再是量血压。接着是和女儿通电话，不愿意在女儿面前坐下。最后是一大早去排队，听窗口那句「哪个科」。

这一串里，顺序不能乱。没有那通电话，就没有他「不愿去女儿那里」的决定；没有那个决定，就没有大医院的窗口。

专业的话，路叫差异序列。

土。 土是让路能走、形状能长的那片缠在一起的地。

周老师的土里有：他教了一辈子书，习惯被人当先生；他和女儿的关系，亲到不好意思；大医院的排队制度，窗口不问来龙去脉；他对「老年人头晕」的模糊的怕，他对血压药的一种长年的不满。

土不是背景，土在推。同一团头晕，落在另一个人的土里，会长成另一个形状。

专业的话，土叫特征纠缠。

回写。 回写是长出来的东西，又倒回去改了土和路。

纸条上写着「心内科」三个字。他在长椅上等的时候，心里已经在想：是不是心脏出问题了？本来只是头晕，现在带上了「心」字。这个字回过头来，改了他的担心，也改了他接下来会怎样描述自己。

病名是回写最典型的东西。它是从这场互动里长出来的，写进病历，也写进日子，然后倒过来，改写互动本身。

一锅粥。 一锅粥是还没有形状的状态，所有的东西都搅在一起。

周老师早上起床那一刻，就是一锅粥：头晕、血压、对女儿的情绪、对大医院的怕、对老的怕，全搅在一起，分不清哪是哪。

正在成形。 正在成形是形状刚冒出来、还没有定的状态。

他坐在心内科诊室里，医生问：「晕多久了？」「什么时候晕？」「吃的什么药？」每问一句，形状就更清一点，可是还没定。医生可能说：「做个心电图、查个血，再看。」这是悬着。

定型。 定型是形状已经立住，成了一个可以反复用的样子。

几天以后，医生可能写下一个名字：高血压引起的头晕，或者别的什么。这个名字一立，周老师的日子里就多了一个固定的东西：每天吃药，每周量血压，每个季度来复诊。

七个词用完了。你会注意到，三个状态词，一锅粥、正在成形、定型，其实是同一张挂号单上的三个时刻。

◆ 四、三态，再走一遍

把三个状态（专业上叫混沌态、介生态、秩序态）再单独走一遍，能看出它们的关系。

第一站，一锅粥。 周老师坐在家里的早晨。

这时候，没有人在「治」什么，也没有人在「得」什么。有的只是一团。这一团里什么都有，什么都没成形。

要紧的是：一锅粥不是坏事。每一件后来成形的东西，都是从一锅粥里来的。

第二站，正在成形。 周老师坐在诊室里。

问诊、检查、等结果，这一站是整个医疗过程里最长、也最让人难受的一站。因为形状已经开始露了，可还没有定。「可能是这个，也可能是那个」，是这一站的口头禅。

本书把这一站叫作悬着。

悬着，是很多人最怕的一站，所以很多人想尽快结束它：催着医生给个说法，催着自己接受一个名字。可是后面的章节会说，悬着也是整个复合体最有力量的一站。

第三站，定型。 周老师拿着药，走出医院。

名字立了，路有了，日子里多了一个固定的样子。这一站像是终点，可它其实还是起点：定下来的形状，会回写进土里，然后再生出下一轮的一锅粥。

这就是为什么本书说：诊断不是终点，是开端。

三态不是一条直线，是一个来回。一锅粥长成形状，形状定成型，定型的东西用久了，又会在某一天松动，回到悬着，甚至回到一锅粥。

周老师服药三个月，某一天又觉得头晕，这一次不是原来的晕法。那天早上，旧的名字松了，新的一锅粥又开始冒泡。

三态之间怎么转

三态不是单行道，转换也不是自动的。

从一锅粥到正在成形，要有一个推的力。周老师那天去了窗口，窗口里的人问了他一句，这就是推。没有这个推，那团东西可以在家里再搅半年。

从正在成形到定型，也要一个推。可能是一次检查，一个名字，一次医生的笃定的口气。有时候，推得太早，形状还没长好就被钉死了。有时候，推得太晚，人悬在半空，累得不行。

从定型回到正在成形，需要一个松的力。可能是一次复诊里新出现的信号，一个第二意见，一个家人的一句话。

这些推和松，没有一个是一个人做的。它们都是复合体里的动作。

所以第三编才会花四章，专门讲这些转换。

◆ 五、位子会换

回到开头那句话：「你是我女儿，我坐在你面前，话都不好好说。」

这句话是说：同一个周老师，在周岚的诊室里，和在大医院陌生医生的诊室里，说出来的话不一样。

不是他撒谎。是位子不同，说出来的东西也不同。

在周岚面前，周老师是父亲，也是病人，两个位子打架。他想说「我怕」，又想说「爸没事」。话到嘴边，成了一句含糊的「就是有点晕」。

在陌生医生面前，他只有病人这一个位子。他的话反倒清楚：「两个星期，早上重，低头久了更明显，血压比平时高二三十。」

这就是为什么，本书总说「位子」。位子不是人，位子是一个人在某一场互动里站的地方。

周岚也一样。她在自己的诊室里是医生。在父亲的病床前，她是家属，又是医生，又是女儿，三个位子一起挤过来。哪一个位子占上风，复合体的状态就往哪一边偏。

位子会换，所以「病人」和「医生」不是两种人，是两个位子。

◆ 六、同一张单子，换三种走法

一个说法好不好，看它能不能在别的场面里再用一次。下面把同一张挂号单，换三种走法。

走法一：窗口里的人换一句话。

窗口里的人问：「哪个科？」周老师答：「就是头晕，血压也有点高。」

假如那天窗口里的人多问了一句：「晕的时候是转，还是晃？」周老师会想一想，说：「是晃，不是转。」

这一句，纸条上可能还是印着「心内科」。可是在周老师心里，那团东西已经不一样了：有人问过，有人听过，他自己也第一次把「晃」和「转」分开了。形状又清楚了一点。

窗口那一句话，不是挂号以外的闲谈，它是挂号的一部分。窗口怎么问，决定了这团东西往哪里长。

走法二：同一张单子，递给豆豆。

豆豆 7 岁，咳了三个星期。周岚在自己的诊室里，没法给自己的孩子看病，只好带他去隔壁的儿科。

挂号单上写着「儿科」。豆豆捏着单子，问：「妈妈，我是病人吗？」

周岚愣住了。

她在这一刻想起来，自己每天对着别的孩子说「来，让阿姨看看」，却从没听过一个孩子问「我是病人吗」。她说：「你是来看医生的小朋友。」

这个答案不算错，可是她知道，不够。豆豆那一问，问的是位子：我现在站在哪里？

这一问里，有一个很深的东西。一个 7 岁的孩子，还没有「我是病人」这件事，他只是咳。是挂号单，是白大褂，是候诊区别的孩子的哭声，把他一点点推向那个位子。

走法三：周岚自己发烧。

周岚发烧了，38 度 5。她给自己量体温，翻抽屉，吃药，这一天她既是医生，又是病人。

她在自己的诊室里，没有给自己挂号。可是她心里有一张看不见的挂号单：我现在是病人，我不上班了。

这张看不见的单子，同样把她放进了一个位子。她开始用病人的口气说话：「我头好痛，什么都不想做。」同一个人，一小时前给别人开退烧药，现在自己一句话都不想多说。

三种走法，一张单子。你会发现，每一次，单子上的字不一定变，变的是推拉的方式。

◆ 七、诊断就是开始：再用这张单子说一遍

前言里讲过，王德生博士说：所谓诊断，就是健康发生学的开始。这一句，值得用这张单子再讲一遍。

假如周老师做完检查，医生说：「是高血压引起的，调一下药。」

发现学的听法是：病找到了，事情有了答案，往后就是照着答案做。

发生学的听法是：从这一刻起，有三样新东西出现了。

一是「病人」的位子。从此，周老师在家里被叫作「吃药的人」，在亲戚面前是「血压高的」。他自己说话也会变：「我现在不能吃咸的。」

二是「医生」的位子。这个医生不再是陌生人，他成了周老师每个季度要见一次的人。他说的话，比以前任何人说的都重。

三是「病名」。这三个字，写进病历首页，也写进周老师的日子。药盒上，随访本上，女儿给他买的减盐勺上，都有这个名字的影子。

这三样东西一起出现，就是诊断那一刻的全部。

接下来的事，才是真正的内容：他吃了药，晕不晕了；他信不信这个说法；医生下一次怎么回应他；女儿在旁边是松一口气，还是更紧张。这些，没有一样是诊断书上写得出来的，可没有一样不是从诊断书那一刻开始的。

所以是开始。

第一次回写：从纸条到病历

纸条捏在手里，故事才刚开头。

周老师在诊室里坐下，医生看了一眼他手里的纸条，在电脑上点开一个页面。屏幕上出现他的名字，那是纸条上的同一个名字。医生开始敲字。

这是第一次回写：纸条上的三个字，「心内科」，被抄进了病历。从这一刻起，他就带着「心内科」三个字，在这家医院里走。

之后，检查单上会印他的名字、科室、检查项目。化验室里的人，看到这张单子，会默认这位病人是「心内科的」。药房里的人，看到处方，会默认他吃的是「心内科的药」。每经过一个窗口，这个归类就被确认一次，也被加固一次。

这个归类，一开始不过是窗口里一个人的随口一句：「那挂心内科吧。」

可是随口一句，一路写下去，就成了周老师在这家医院里的名分。假如那天窗口里的人说的是「那挂神经内科吧」，他的名分、他的路、他后来被问的问题，都会不同。

没有谁错。这是回写的力气：一个很小的开头，一路写下去，成了很大的结果。

回写是双向的。病历写进了他的日子，他的日子也写进了病历。他下一次来复诊，说「我又晕了」，医生在原来的页面上添一行。页面和日子，来来回回地改。

三样东西的关系

挂号那一刻，有三样东西一起露面：病人的位子，医生的位子，病名。

这三样的关系，值得单独看一眼。

它们不是三件独立的东西，凑在一起。把任何一样拿走，另外两样都会变。

没有了病名，「病人」是一个说不清自己的人，「医生」是一个不知道该做什么的人。两个人面对面坐着，只能聊天。

没有了医生的位子，病名没有人说出口，它只是一团模糊的怕。「病人」独自在家里，对着血压计发呆。

没有了病人的位子，医生的位子是空的。白大褂挂在门后，听诊器放在桌上，一切都在，可什么也不发生。

三样东西，缺一样，另两样都站不稳。所以本书说它们是**一起显影**的。不是三个人到场，是一件事，同时露出三个面。

这就是为什么，本书不说「病人得病」「医生诊断」。这两句话里，都已经先放进了一个先在的主体。本书说的是：在这场互动里，病人位、医生位、病名一起出现。

◆ 八、老办法怎么讲这张单子

为了让你看清本书和老办法的分别，把同一张挂号单，用两种方式讲一遍。

发现学的讲法。

周老师患有一种病，这种病在他挂号之前就已经存在了。他头晕，是这种病的症状。他去医院，是为了让医生把这种病找出来。医生通过问诊、检查，发现了这种病，并且给它起了名字。这个名字，就是诊断。诊断出来了，事情就有了答案，剩下的是治疗。

这个讲法很顺，几乎所有人都是这样想的。它的好处是清楚，每一步都有主语：周老师有病，医生找病。

发生学的讲法。

周老师头晕了两个星期，裹在一团还没有形状的不适里。他去了医院，窗口里的人说「那挂心内科吧」，一张纸条出来了。在这一刻，一个病人位、一个医生位、一个科室一起露面。医生问了几句话，做了几项检查，每一问、每一查，都让

那团不适更清一点。几天后，一个名字落在病历上，这个名字写进了他的日子，之后的一切，都从这里开始。

这个讲法没有主语。不是周老师在做什么，也不是医生在做什么。是一场事在走，走着，露出了「病人」「医生」「病名」。

两种讲法，哪个对？

本书的回答是：发现学的讲法没有错，在它够得着的地方，它很有用。可是它有一个看不见的预设：病先在，人先在。发生学的讲法把这个预设拿掉，让「先在」从结果里长出来。

读到这里，你可以问自己一句：我平时讲自己或家人的病，用的是哪一种讲法？

位子不是身份

最后叮嘱一句，免得后面读岔。

位子不是身份。

「病人」是周老师在这场互动里站的位子，不是他这个人的名字。他一旦走出医院，回到家里，给豆豆讲古诗，他站的是外公的位子，是老师的位子。

可是位子有黏性。一个人在病人位上站久了，周围的人会开始把这个位子当成他的身份，他自己也会。「他是个病人」「我就是个病人」，这两句话，是位子慢慢被写成身份的样子。

这件事，本书叫作回写：位子写进了日子，日子又反过来把位子写得更死。第 1 章会专门讲，怎样看见这一写。

土里的三块地

土不是一整块。周老师的土，至少有三块地。

手上碰得到的那一块。 他的血压计，他的药盒，他的拖鞋，他家离医院两站路的距离。这是日子里实打实的东西。

脑子里想的那一块。 他对「老年人头晕」的了解，他从报纸上看来的一点知识，他教过的学生里有人也得过类似的病，他脑子里关于高血压的一堆说法。

心里的那一块。 他对女儿的亲和不好意思，他对老的怕，他那句「话都不好好说」。

一件事在一块地上通了，不等于在另两块地上也通。周老师知道「头晕可能是血压波动」，脑子里通了；可是一想到要去女儿那里，心里还是堵着。这就是很多人都有过的那种感觉：道理明明白白，日子还是过不顺。

本书说复合体卡住，说的常常就是这种情况：三块地没有一起通。第 14 章专门讲这件事。

为什么叫「状态」

为什么不说「病的发生」，要说「状态的发生」？

因为周老师没有病的时候，也有状态。

他有精神好的早晨，有累的下午，有一听到女儿声音就松下来的晚上。这些，没有一样是病。可是他头晕的那两个星期，这些状态都变了：早晨更紧，下午更累，晚上的松变成了藏。

你看：健康和病，不是两样东西。是同一个人、同一个复合体，在不同的时刻露出的不同状态。从「好的早晨」到「头晕的早晨」，没有一条清清楚楚的线，是一路滑过去的。

所以本书问的不是「病从哪来」。本书问：这个复合体的状态，是怎样发生的？又是怎样从这一种，转到那一种的？

这样问，有一个好处：不会把人分成两类，一类健康，一类有病。每个人都在不同的状态里，来来回回。

◆ 九、读者会问的四个问题

讲到这里，读者多半有几个问题。先答在这里。

问：腿断了呢？腿断了总是真的吧？

是真的。本书不说这些是假的。腿断了，骨头断了，这是实打实的。

可是请你看腿断了以后的事：送哪家医院，谁来接骨，用不用手术，恢复怎么练，几个月后能不能走路，走路时心里怕不怕。这些东西，没有一样是「腿断了」这一句话能决定的。它们都是在复合体里发生的。

问：那急救的时候，也要讲复合体吗？

不需要。急救的几分钟里，医生用的是最好的发现学的医学，本书一句话也不插。本书只在急救之后、之外的那些日子里说话。

问：这么说，医生该怎么办？

书里不给医生开处方。它只请医生在某一刻，多问自己一句：这个病人坐在我面前，我们之间此刻在发生什么？这一问，不用多花时间，只是多一个看的方向。

问：既然老医学已经很有用，为什么还要一个新名字？

因为有一些事，老医学的说法够不着：查不出问题但就是难受，同一个诊断有人好有人坏，医生和病人都累。这些事不是不重要，也不是靠再多一项检查能解决。它们需要一个能装下「互动」的说法。

◆ 十、总比喻：拉大锯

这么多词，需要一个总比喻把它们串起来。本书选的是拉大锯。

你小时候也许见过：两个人面对面站着，中间一根粗木头，一把长长的大锯。一个人推过去，另一个人拉回来；对方推过来，这一头再拉回去。一推一拉，锯齿咬进木头，木屑一点点落下来。

问一句：锯口是哪一头锯出来的？

答不出来。推的人有功，拉的人也有功。一头松了劲，锯就卡住，木头里夹着锯条，谁也动不了。一头太使劲，另一头会被拽得踉跄，锯条弯了，口子歪了。要锯得顺，是两头的劲合在一起，锯口才直。锯完以后，两个人把锯放下，各自走开。

把这个画面放到诊室里：医生一头，病人一头，中间是那件说不清的难受。诊断、检查、问话、等待、复诊，是一推一拉。哪一头也锯不出一个叫「病」的口子来；口子是在推拉之间长出来的。

这个比喻有三处很贴：

第一，**锯口不属于哪一头。** 状态属于这个推拉的整体。

第二，一头松了，锯就卡住。　医患关系里最常见的卡法，就是一头不拉了：病人不再说，或者医生不再听。

第三，锯完，各自走开。好的结局，是复合体不再被需要。第 12 章会讲这个。

可是任何比喻都有错处。拉大锯有三处错，要先说清楚，因为这三处错，正好对上本书要拆的三个先在者。

第一处错：拉大锯里，两个人和一把锯，都是先在的。木头还没锯之前，两个人已经站在那里。

医患不是这样。在挂号那一刻之前，没有「医生」，也没有「病人」。有的只是两个人，各自在各自的日子里。周老师不是先成了病人才去挂号；是挂号这个动作，把他放进了病人的位子。所以拉大锯这个比喻里的「两个人」，在本书里要换成「两个位子」。

第二处错：锯木头是先说好了要锯成什么的。要锯成两段，要锯成一块板，目标在锯之前就有。

医患的目标不是这样。「治什么」「治到什么程度」，往往是在推拉里一点点改的。周老师一开始想要的是「查出来、没事」，几次复诊以后，想要的变成了「别让它影响睡觉」。目标和锯口一样，是长出来的。

第三处错：拉大锯是两个人，一把锯，一根木头。

可是诊室里的第三方不止一个：家属、保险、医院的规章、病历系统，还有今天越来越常见的 AI。第 16 章要专门讲，这个第三方进来以后，锯子就不再是两头的事。

记着这三处错。每次你用拉大锯想一件事，到了这三处，就把它改一下：两个人换成两个位子，目标换成长出来的，两头换成不止两头。

◆ 十一、还有第三只手：机器

周老师那天没有用手机。可是你只要想一想今天的日子，就会发现，这张挂号单旁边，常常多一只手。

不少人在出门之前，已经把症状输进了手机里的某个程序，问过一遍。程序给了一个回答，有时是几个可能的方向，有时是一句「建议尽快就医」。等这个人走到窗口，他的那一团不适，已经带上了一个说法。这个说法没有医生签字，可是它已经在了：他说「头晕」的时候，心里想的是屏幕上读到的那几个词。

挂号那一刻，因此有了新的变化。以前，是窗口、纸条、诊室，三样东西把一团不适推向形状。现在，多了一个看不见的位子，它在窗口之前就开始推了。

这个位子是什么？是工具，是顾问，还是第三个说话的人？本书把这个问题留到第 16 章。这里只先记下一句：复合体不止两头，今天的锯，常常有第三只手。

◆ 十二、近邻对上哪把扳手

书里会提到几位近邻。他们各自走到了一步，本书向他们学，也要说清楚差在哪里。

下面是一张预览表。每一行，都在后面的章节里展开。

他的词	大白话	大致对上	差在哪里
玻尔的「现象」	对象和测量安排合在一起，才有读数	挂号那一刻：科室与读数一起显出	仍留着「测量者」这个先在的人〔核：大意〕
巴拉德的「agential cut」	在互动里划出「谁是对象、谁是观察者」的那一刀	病人位与医生位一起显影	本书不用「切」这个动作，只说位子一起显出〔核：大意〕
恩格尔的生物-心理-社会模式	病要同时看身体、心里、社会	土：多层地一起推	本书不先摆好几层，而是问它们怎样一起长出来〔核：大意〕
福柯的《临床医学的诞生》	医生的「凝视」是被历史做出来的	医生位不是先在的	多写知识与制度怎样塑造医生的「看」，本书再问病人一端怎样回写〔核：大意〕
叙事医学	病人的故事要被认真听	说不出的苦转成可读的形状	本书进一步问：故事怎样在医患互动里长出来〔核：大意〕
循证医学	用大样本的证据来定怎么治	路：别人走过的路是证据	证据的平均，要怎样落进这一个复合体的土里

这张表不是给近邻排座次。每一位，都有一块本书得向他借的地。

◆ 十三、先清三个误会

这样一个说法，很容易被读歪。在往下走之前，先清三个误会。

第一个误会：这是说病是假的。不是。

周老师头晕，是真的头晕。他早上站起来眼前晃，这是真的；血压数字高，这也是真的。本书一个字都没有说这些东西是编出来的。

本书说的是：这些真东西，是在什么地方、以什么形状被读到的。病不是假的，也不是先摆在那里等人去拿。

一个很平常的对照：下雨是真的，可「今天算不算下大雨」，要看你是在伞底下还是在屋里。雨是真的，「大」不「大」，要有人在雨里才有的说。

病也一样。头晕是真的，「这算不算病」「算哪一种」「要不要吃药」，是在互动里长出来的。

第二个误会：这是推卸医生的责任。不是。

有人会听成：既然是复合体生病，医生就没责任了；既然状态是互动里长出来的，医生就没错了。

恰恰相反。把病放在复合体里，医生的责任没有变小，只是换了一种说法。

一个医生漏了一句该问的话，一个检查该做没做，一个解释说得让人更慌——这些都是复合体里的动作，都要追，该追的要追。

追责本身，也是修复的一部分。不追，复合体里的那个口子不会自己合。第 15 章会专门讲：不取消问责，只是把问责对准修复的地方。

第三个误会：这是量子玄学。不是。

有人一听「量子力学」四个字，就想到「意识改变世界」「心想事成」一类的话。

本书一句也不说这些。「意识影响病情」这类话，物理学家一问「那你怎么解释退相干」，就站不住了。本书不靠那条路。

本书对量子力学只做一件事：把它当作近邻。它留了一个观察者；本书借它的思路，再把那位观察者一起拆掉。仅此而已。

你可以把量子力学整个拿掉，本书的主线不会断。因为主线是挂号那一刻：病人位、医生位、科室、病名，一起露面。这是每个人都见过的事，不需要任何物理学来撑。

三个误会清完了。

七个词，最容易用错的三处

七个词用顺了很方便，用错了也很容易。先说三处最常见的误用。

第一处：把形状当成事情本来的样子。　形状是这一次互动里露出来的样子，不是事情的本来面目。周老师那天的「头晕待查」，是那天那个诊室里的形状。换一天，换一个人，形状会不同。

第二处：把路当成一条必然的路。　路是走过以后回头看，才排得出来的一串。往前走的时候，每一步都有别的可能。周老师的那通电话，可以换成另一种说法；他那天也可以直接去女儿那里。

第三处：把土当成背景。　土不是舞台布景，土在推。周老师教了一辈子书这件事，不是他的「背景介绍」，它真的在推着他对医生说话的方式。

记住这三处，用起七个词来，就不容易滑到老办法上去。

本书怎样用证据

这本书里有三种话，请你分清。

一种是**场景**：周老师、周岚、豆豆的事。这是虚构的，它的用处是让道理落地，不是证明道理。

一种是**转述**：玻尔、巴拉德、恩格尔、福柯这些人的看法。书里只转述大意，括号里标常见出处，拿不准的改写成稳妥的说法。

一种是**本书的说法**：从母题推下来的判断。这类话本书自己负责，推演不到位的，标「待验」。

三种话的分量不同。场景只举例，转述要核对，本书的说法要接受检验。哪一种话该放多重的信任，你心里有数就好。

◆ 十四、把四编放回这张单子上

最后，把全书四编放回挂号单上，当作一张地图来看。

第一编拆的是单子上的人。单子上写着一个名字，那个名字是「病人」吗？窗口后面有一个人，那个人是「医生」吗？旁边站着看的人，是在场外吗？

第二编看的是单子本身。单子出来之前是什么？单子出来的那一刻是什么？单子上的字，进了病历、进了日子，会长出什么？

第三编看的是单子之后。一个人拿着单子去诊室，拿着结果回来，在悬着里来回；单子变成病名，病名变成定型；定型的东西，怎样又松回去。

第四编看的是这张单子上出的毛病。医生端的累，病人端的堵，家属端的慌，AI 端新进来的那一块屏幕。

这就是全书。

四编十六章，都在这张小小的纸条里。

◆ 十五、三个月后：周老师怎样了

回到开头。周老师那天拿着药，走出了医院。

三个月后，他复诊了一次。这一次，故事可以往两个方向走。

一个方向是：医生看了他的记录，问他这三个月睡得怎么样，晕的时候还有没有那种慢半拍的感觉，家里谁在帮他量血压。周老师说了很多。他发现，这个名字，那三个字，已经不像第一天那么沉了。它成了他和医生之间一个可以反复拿出来看、可以改、可以补的东西。

本书把这样的名字叫作通路：它让事情流通。

另一个方向是：医生看了一眼屏幕，说：「继续吃药，三个月后再来。」周老师想问睡不好的事，话到嘴边，咽了回去。他回家以后，跟女儿说：「医生说不用管，就是老毛病。」那三个字，在他心里慢慢变硬了，成了一个不能再碰的东西。

本书把这样的名字叫作笼子：它把事情压住。

同一个名字，同一种药，同一个医生，可是两个复合体。区别不在名字里，在名字被怎样用。

第 8 章要讲的，就是这件事。

同一把钥匙，转十六圈

回头看，全书其实只做一件事：拿着挂号那一刻这把钥匙，转十六圈。

第一圈到第四圈，转在单子上的三个人物和一个承载者上。

第五圈到第八圈，转在单子本身，和单子出来以后的头一段路上。

第九圈到第十二圈，转在单子之后：悬着，定型，不对易，解散。

第十三圈到第十六圈，转在这张单子出了毛病的地方。

十六圈转完，你会发现，钥匙没换，门换了十六扇。每一扇门里，是同一张纸条，同一个复合体，同一次显影，只是你站的角度不同。

◆ 十六、小账怎么记

每一章最后，都有两行小账。

读到这里，你已经知道这本书的钥匙是什么，也知道它的比喻有三处错。小账就是把这些放在一起，一章一章地对。

第一行：这一处，开门还是关门？

开的是哪一扇？是形状、路、土、回写四扇里的哪一扇？关的又是哪一扇？

拿这篇导论自己来记一笔：

这一篇开的是形状那扇门：挂号单一出，一团不适有了形状。开的是路那扇门：从通电话到排队，一步一步。土和回写也各开了一点。关的是：把「病人」「医生」当作先在身份的那扇门。

第二行：病放在一个人身上，还是放回复合体里？

这是本书自己的病。几乎每个人读书的时候，都会不知不觉地回到「是他的病」「是她的错」。第二行小账，就是在每一章末尾拦一下自己：这一章里的病，我是不是又放回到某一个人身上了？

还拿这篇导论记：全文有一处，写到「周老师把纸条捏在手里」。纸条是他捏的，看上去是他的动作。可是纸条是窗口给的，窗口是医院设的，规矩是排队的。这一处，病没有放在他一个人身上。

两行小账不是考试，是一个习惯。记几十章以后，你的眼睛会变，看别人家的病，也不会再只盯着一个人。

读完全书，把十六笔小账连起来，就是一本总账。

◆ 十七、接下来

下面进入第一编。

第一编的任务是拆。拆三个站得太稳的人物：带着病来的病人，负责发现的医生，站在一旁的观察者。

拆不是骂，拆是为了让后面的东西有地方长。拆完以后，你会发现，医院里发生的事，没有变少，只是找到了一个更好放的地方。

先从周老师手里的那张纸条说起。

> **带 走 的 话**
>
> **一张挂号单出来的那一刻，病人、医生、科室和病名，才一起露面；之前，只有一团还没有形状的不适。**

> **小　账**
>
> **这一处，开门还是关门：**这一篇开了「形状」和「路」两扇门，关了「病人医生是先在身份」那一扇。
>
> 病放在一个人身上，还是放回复合体里？放回复合体里了。纸条是窗口给的，不单是周老师捏的。

> **想 一 想**
>
> 你最近一次去医院，进诊室之前，心里是一团什么？出来以后，这一团有名字了吗？那个名字，是谁给的？是医生，是你，还是挂号单上的那三个字？

◆



第　一　编

拆掉三个先在者：
病人、医生、观察者都不先于互动

编　序

这一编四章，先拆三样东西。

你走进医院，眼前摆着三样看上去不用解释的东西：一个带着病来的病人，一个把病找出来的医生，还有一双站在旁边、只管看清楚的眼睛。大家都默认，它们在你挂号之前，就已经各就各位了。

第 1 章问病人：进诊室之前，他身上到底有没有「病」？第 2 章问医生：他是把早已在那里的东西找出来，还是和病人一起，让一样东西第一次出现？第 3 章把那双眼睛请出来。量子力学早就说过，看会改变被看的东西，所以有人以为观察者的问题已经解决了。本书要说的是，它只解决了一半。第 4 章把三样东西拆走以后空出来的位置，交给另一个承载者。

这一编要让你看见的反差是：日子里最稳当的三样东西，恰恰是最晚才站稳的。病人、医生和看清楚的眼睛，都不在挂号之前，而在挂号之后，一起长出来。

01

第 1 章

病人不是带着病来的

◆ 一、你一定有过这样的时刻

周老师今年 62 岁，退休前教了三十多年中学语文。

他的血压高了好些年。可要是你在八年前的一个秋天早上问他：「你有病吗？」他大概会笑一笑，说：「我？就是这阵子头有点沉。」

头沉是真的。早上起来，脖子后面发紧，像戴了一顶小一号的帽子。批作文批到一半，眼睛会花一下。他没当回事，以为是年纪，是熬夜，是秋天。

那个周末，小区门口搭了个棚子，社区在做义诊。他是出来买豆浆的，被一位戴袖标的志愿者拉住了：「大爷，量个血压吧，不要钱。」

袖带鼓起来，慢慢松下去。志愿者看了一眼数字，又看了他一眼。

「您这个，得去医院看看。」

就这一句话。周老师拎着豆浆回家，路上豆浆凉了。

那天以前，他是一个头有点沉的人。那天以后，他是一个「血压高」的人。

这中间，他的身体变了吗？也许没有。那个数字，说不定早就是那个数了。变的是别的东西：他开始早晚量血压，开始翻食品包装上的含盐量，开始在老同学的饭桌上说「我这个血压啊」。

你大概也有过类似的时刻。一句话、一张单子、一个箭头，忽然把一团说不清的难受，变成了一个有名字的东西。你听见的那一刻，心里「咯噔」一下。

那么问题来了：他是哪一刻，有了病？

是头沉的那些早晨吗？是袖带松开的那一下吗？还是后来，他在挂号窗口前报出自己名字的那一刻？

这一章要问的，就是这个。

◆ 二、老看法：病先在身体里，人只是带着它来

先说老看法。它不是随便说说的，它是医学两百多年来最结实的一块地基。

老看法是这样的：病是身体里的一件事。一根骨头断了，断在那里；一处肺里有了阴影，阴影在那里；一种细菌占了血液，它们就在血液里。人不管知不知道，病都在。人走进医院，只是把这件已经发生的事带了来，交给医生去查。

所以病人是「带着病来的人」。病在先，人在后；病是主，诊断是认领。

用大白话说，这就是本书说的发现学医学：病早就在那里，医生的本事，是把它找出来。

这个看法对在哪里？对在很多地方，而且是要紧的地方。

一个孩子从树上摔下来，胳膊拐了一个不该有的弯。不用任何解释，拍一张片子，谁来看都是骨折。一个人高烧三天，化验里查出了某种明确的病菌，换哪家医院都查得出。这类事里，病有清楚的边，有可以重复的查法，不同的人去查，查到的差不多。

在这样的条件下，「病先在身体里」几乎完全成立。本书不跟它争。

你想想急诊室。一个人被抬进来，满头是血，话也说不出。没有人此刻会问，他是不是「病人」，也没有人需要问。抢救就是抢救，救人要紧。

这个老看法，中国人听着也不陌生。《韩非子·喻老》里讲过扁鹊见蔡桓公的故事（大意如此）：扁鹊一见国君，就说：「您的病在皮肤的纹理里，不治会深。」桓公说：「我没有病。」过了些日子，扁鹊又来，说病到了肌肉；再来，说病到了肠胃；最后一次，他远远看了一眼，转身就走。桓公派人去问，扁鹊说：病在骨髓里，我没有办法了。

这个故事的底子，是一个很结实的想法：病在那里，一层一层往里走；医生看得见，国君不肯认。病不会因为你不承认就不在。

故事说得很好，也说得对。本书想在这里加一个小小的问题：那四次见面里，桓公一直没有坐上病人位。他的身体里到底有没有东西，不归本书管；可他没有坐过那把凳子，扁鹊始终是站在殿上说话的人，不是坐在诊桌后面的人。

两个人之间，那张只需要一个人点头的单，一直没有开出来。

可是，你有没有发现：这个看法，是从那些最清楚的病里长出来的？

它的底下，偷偷放着一个预设：既然骨折是先于诊断的，那么所有的病，都像骨折一样，先于诊断。既然拍片之前骨头已经断了，那么每个人走进诊室的时候，身上都已经带着一个等着被找出来的东西。

这个推广，一步一步，看上去顺理成章。本书要在中间停一下。

停在哪一步？停在「人走进诊室的时候」。

◆ 三、进诊室之前，只有不适和苦

你站在医院的挂号机前，看见一个年轻人。

他三十岁出头，背着电脑包，手里攥着手机。屏幕上是挂号的页面，科室一栏，他点进去，又退出来。再点进去，又退出来。后面排队的人开始咳嗽。

他第三次退出来的时候，回头看了一眼，不好意思地让出位置，站到一边去。过了半分钟，他又走回来，按了下去。

你不认识他，不知道他要挂什么。可你多半能看出一件事：在他按下去之前，他身上有些东西不太对。可能是胸口发闷，可能是总睡不着，可能是这半年什么都提不起劲。

这些东西是真的。本书一点也不想说它们是假的。

可你要注意，在他按下去之前，这些东西叫什么？

它们不叫「病」。他自己没有叫它病，不然他不会退出来三次。一个已经确认自己有病的人，不会站在机器前犹豫「我该不该挂这个号」。

它们叫两样别的东西。

第一样，叫不适。身体里的感觉：闷、胀、酸、晕、疼、喘不上气。它们有部位，有时间，有时能指给人看。

第二样，叫苦。这个更难说。苦不是一个部位，是日子过不下去的那个味道。夜里睡不着，白天撑着；一个人的时候好些，一开会就慌；明明什么也没做，累得像刚搬过家。

不适和苦，有时一起来，有时一前一后。可它们有一个共同的样子：没有名字，没有边，也没有对面的人。

用本书的话说，这是一锅粥。

一锅粥，不是说它不真。粥是真的，烫是真的。只是它还没有形状：你说不清哪一口是米，哪一口是水。

所以在进诊室之前，那个年轻人身上有的是一锅粥。「病」是后来才有的东西。

这不是文字游戏。你想想，这锅粥里的东西，本来可以长成很多种样子。同样的胸闷，可以被叫作「心脏的事」，可以被叫作「胃的事」，可以被叫作「压力大」，也可以被叫作「岁数到了」。哪一个名字落下来，哪一条路就开了；别的名字，就暂时收起来了。

哪一个名字落下来，不是由胸闷自己决定的。

再举一个。一个人刚丢了工作，三个星期里，胃一直隐隐地疼，吃不下饭。他去了医院，医生问：「什么时候开始的？」他说：「三个星期前。」医生没有问他三个星期前发生了什么。他拿到的名字是「胃炎」。

另一个人，同样是三个星期前丢了工作，同样是胃疼，却先走进了一位愿意多问两句的医生的诊室。医生问：「那阵子，家里有什么事吗？」他一愣，说：「我丢了工作。」那一刻，他的胃疼，被放在了另一条线上。

两个人的疼，也许一模一样。可他们各自带着出门的，不是同一样东西。

这就是为什么本书说，进诊室之前，只有不适和苦。名字是后来的，是对面的人一起落下的。

你留意过日常的说法吗？人们说「不舒服」「难受」「不对劲」「哪儿都不得劲」。这些词有一个共同的脾气：它们不指任何一个器官。「不舒服」只告诉你人和自己的身体之间，有点别扭，没告诉你别扭在哪里。

老百姓用这些词，是很准的。因为这时候，那锅粥里真的还没有器官。要等到有人把听诊器放上来，有人问「是这儿疼，还是这儿疼」，那团别扭才开始往某个地方落。

落下去以后，说法就变了：「我胃不好」「我心脏有点问题」「我颈椎不行」。人们很快忘了，这些话是后来才有的。

◆ 四、「我是病人」，是一个位子，不是一张身份证

那他是怎么从一锅粥，变成「病人」的？

先看一个很平常的事实：病人这个词，不是挂在人身上的，是挂在场合上的。

周老师在家里不是病人。他给外孙讲古诗，给阳台上的茉莉浇水，跟老伴为了电视调台吵两句，没有一个时刻，他是以「病人」的身份在过日子。

周老师在老同学聚会上，也不是病人。大家聊起当年的校长，聊起谁家孩子出息，谁也不会指着他说：这位是高血压患者。

周老师一走进诊室，在那张凳子上坐下，对面坐着一个穿白大褂的人，桌上摊着一张挂号单，上面印着他的名字。

这个时候，他是病人。

不是因为他的血压突然变高了，而是因为：有一个位子，在这一刻出现了，他坐了上去。

这个位子，本书叫它病人位。它是一个相互的位子：只有对面有一个医生位，这边才有病人位；只有一张挂号单把两边接起来，这一对位子才立得住。拆掉任何一头，另一头也就塌了。

这里要交代一个词。老说法里，把一个人在一场互动中占的位置，叫号位（一号位、二号位、三号位）。本书大多数时候只说「位子」，你记住这个家常的词就行。

中文里其实一直藏着这个意思。我们把病人叫作「病号」，这个「号」字，同挂号的「号」是同一个。病号，就是被编了号的那个位子上的人。住院的时候，护士在床头挂一块牌子，写着床号，写着姓名，那是位子的牌子。你从牌子上看，那张床上躺着的是谁，不如说，那张床是谁的位子。

位子和身份，差在哪里?

身份像身份证，是你揣在口袋里走到哪儿带到哪儿的东西。位子像电影院的座位，你坐上去，才有「观众」；你站起来，就不是了。

身份是你的，位子是一场互动给你留的。

说到这里，可以回答很多人心里的一个疙瘩了：为什么有的人明明难受了好几年，就是不觉得自己是「病人」？为什么有的人一听到某个词，整个人就「病」了下去?

因为前一种人，没有坐上那个位子；后一种人，被人按了上去。

位子是互动给的，不是人带来的。

这不等于说，位子是假的。坐上病人位的人，会得到很多东西：有人听他说，有人替他查，有人准他请假，家里人开始让着他。这些都是真的好处。位子也有代价：他得接受一个名字，一种说法，一段被人盯着的日子。

好处和代价，都是位子带来的，不是那团不适自己带来的。

位子上还有一套看不见的规矩。

病人要把话说清楚：哪里疼，疼多久，疼的时候像什么。说不清楚的，要想办法说清楚。病人要配合：该查的查，该吃的吃，该来的来。病人要有一点耐心，有一点信任，不要太挑剔，也不要太随便。

这些规矩，没有写在哪一张纸上。可每一个坐上去的人，都在不知不觉中学会了。有人学得好，被夸「是个好病人」；有人学不会，被说成「事儿多」。

你想想，一个本来就不会把苦说成「哪里疼多久」的人——一个习惯了忍着、绕着、不好意思开口的人——他坐上这个位子，会多吃力。

不是他病得更重，而是这个位子，对他不太合身。

◆ 五、位子靠三样东西立起来

一个位子要站稳，靠什么？

回到挂号机前的那个年轻人。他最后按下了那个键。从那一下开始，有三样东西，一样一样地出现了。

第一样，是对面的人。

他按下去的时候，其实已经默认：那边有一个会听他说话的人，一个被社会承认可以处理这类事的人。要是对面没有人，这个位子是立不起来的。荒岛上的人胸口闷，他会难受，会害怕，可他没有「病人」这个位子可坐。

第二样，是一张单。

挂号单、病历本、检查申请、一张诊断证明，都是单。单的作用很朴素：它把一团说不清的东西，登记成一件可以交接的事。有了单，这件事就可以从挂号处传到诊室，从诊室传到检验科，从检验科传回诊室，还可以传到单位的人事处，传到保险公司，传到家里的饭桌上。

没有单的时候，难受是私人的；有了单，难受变成了一件有记录、有去处的事。

药店里的情形，是一个有意思的中间状态。你走进去，说「我嗓子疼」，柜台后面的人看你一眼，说「你这个是上火了」。那个人没有白大褂，没有挂号单，可他说的那个词，已经让你的难受有了去处。

这是一个坐了一半的位子。你既不是病人，也不再只是一个难受的人。这样的位子，在日子里到处都是。

第三样，是一个词。

诊室里，那个年轻人说了很多话，可有一句最要紧：医生在病历本上写下的那个词。那个词，也许是一个病名，也许只是「待查」。它一落笔，他就从一个说不清自己怎么了的人，变成了一个有「名头」的人。

这三样东西，缺哪一样，位子都不稳。

对面没有人，只有单和词，那是自己在网上查病，位子是漂着的。有人有单，没有词，那是一场「检查都正常」的就诊，位子悬在半空，所以很多人最难受的，恰恰是「没查出什么」。有人有词，没有单，那是熟人饭桌上一句「你这可能是……」，位子坐了一半。

三样东西齐了，病人位才站稳。

你看，这三样东西，没有一样是长在身体里的。对面的人、一张单、一个词，都是一场互动里的东西。

再把它们翻过来看一看：病人位的对面，是医生位。医生位也要靠这三样东西立起来：有一个愿意开口的人，有一张承认他的单，有一个他可以写下的词。两边的位子，同时升起，同时站稳。

本书把这样一个整体，叫做医生—病人复合体。你可以先把它想成一张桌子，两边各有一把椅子，桌上有一张单，一个词。桌子本身，不属于任何一个人。第 4 章会专门谈它。这里先记住一句：位子是成对出现的。

站稳的这一刻，哪怕你什么都没做，你也已经不是原来那个人了。你有了一个位子，也有了一个可以被问的问题：你是什么病的病人？

所以说，**病人不是带着病来的，是带着苦来，和对面的人、一张单、一个词一起，坐出来的。**

那个在挂号机前犹豫了三次的年轻人，半小时后从诊室里走了出来。

他手里多了一张纸，上面有一个他从没见过的词，后面跟着一行小字：三个月后复查。他站在走廊里，把纸折了两折，放进电脑包的侧袋。

走出医院大门，他没有马上回公司。他在门口的台阶上坐了一会儿，给一个朋友发了一条消息：「我好像，有点情况。」

半小时前，他还只是一个「这半年不太对劲」的人。现在，他有了「情况」。这个词，是他自己都没注意到的一次搬家：从一团说不清的难受，搬进了一间有门牌的屋子。

把两种说法并排放一放，差别就清楚了。

老说法说：病在先，人带着它来，医生把它找出来，人这才成了病人。

本书的说法是：苦在先，人带着它来；对面的人、一张单、一个词，和这个人一起，把苦第一次排成了形状；形状有了名字，人这才坐上了病人位。

两句话里，「先」字落的地方不同。老说法把先后落在「病」上，本书把先后落在「苦」上；老说法把病人当成病的搬运者，本书把病人当成一场互动里的一头。

◆ 六、血压的故事：数字没变，位子来了

回到周老师和那个数字。

志愿者说「您这个得去医院看看」以后，周老师过了两天才去。他去的是离家最近的一家医院，挂的是心内科。

那天他等了四十分钟。轮到他的时候，医生在电脑上点了几下，问：「多久了？」

「头沉，有一阵子。」

「吃过药没有？」

「没有。」

医生又量了一遍血压，嘴里「嗯」了一声。她开了单子，让他去做几项检查，说一周后再来。

周老师拿着单子下楼的时候，说不清心里是什么滋味。不是害怕，也不是松一口气，是一种很奇怪的感觉：好像有一扇门，在他身后轻轻关上了。

那扇门是什么门？

是「我是一个健康的人」这扇门。他从前没意识到自己是靠着这扇门过日子的。门关上的那一刻，他才知道它一直在。

一周后，检查回来，医生指着单子说了一个病名，说得很平常，像说「今天有雨」。

从那天起，周老师家里多了一样东西：一个小小的电子血压计，放在茶几抽屉里。多了一个习惯：早晚各量一次，记在一个红皮本子上。多了一句口头禅：「我这个血压。」

也多了一样别人看不见的东西：每次头沉的时候，他会先想一想，是不是血压。

老伴有一回悄悄跟周岚说：「你爸现在，一头沉就去摸血压计，比以前紧张多了。」

周岚没有说话。她知道，这几年父亲的血压数字，其实比从前平稳。可父亲的日子，比从前绷得紧。

志愿者，心内科医生，那份单子，那个病名，都没有做错什么。每一步都是认真的，每一步都有它的道理。可每一步叠起来，一个人的日子，就有了一个新的重心。

这个重心，也是真的。它不是血压带来的，是那一场场互动带来的。

再后来，是一次老同学的聚会。

酒杯斟到他面前的时候，旁边的人伸手挡了一下：「老周血压高，别给他倒。」

没有人恶意。大家是真心的，是疼他。可周老师手里的杯子，停在半空。他忽然意识到，在这张饭桌上，「病人」的位子已经替他摆好了。那个位子上，没有他的名字，却有他的形状。

八年前，同一张桌子，同一批人，他自己倒的酒，没有人拦过。

有意思的地方就在这里。

头沉，还是那个头沉。可头沉从「这阵子有点累」，变成了「是不是血压」。一锅粥里的一口，被捞了出来，贴上了名字。

于是，粥开始有了形状。

这就是本书整本书要反复看的那个动作：不适和苦，到了诊室里，和一个医生位、一个病名、一份病历一起，第一次成了形状。

注意，本书没有说血压是假的。袖带上的数字是真数字，血管是真血管，该管的要管。本书说的只是：病人这个位子，不是血压自己带来的。血压自己带不来一个医生，带不来一张挂号单，更带不来一个叫作「我是病人」的我。

这些东西，是一起出现的。

◆ 七、没坐上位子的人

有了位子，就有没坐上位子的人。

周老师的老伴，姓梁。她腰疼了很多年。每年冬天，早上起床，她得先扶着床沿坐一会儿，才能站起来。

家里人都知道。周老师有时会说：「你去看看吧。」她说：「老毛病，忍忍就过去了。」

忍了好多年。

她不是不信医生。她给外孙带去医院，一站就是一上午，从不嫌烦。可轮到自己，她总是觉得，这点疼，不够格。

不够什么格？不够去占一个位子的格。

在她心里，病人的位子是留给那些「真的有病」的人的：躺在床上起不来的，脸色发白的，检查单子上全是箭头的。她这点疼，每天还能做饭、买菜、接外孙，算什么？

你看，她的苦，一点都不比别人少。可她没有坐上去。

这样的人很多。他们不是不知道，是觉得自己「还不算」。也有人是不敢：一旦坐上去，怕被说成「矫情」；怕麻烦家里人；怕查出点什么，日子就要变。

你可以回头想想自己身边：谁是那个疼了很久，却总说「不碍事」的人？他是真的不碍事，还是在替一个他不敢去坐的位子，找了一个体面的理由？

还有一种人，是被挡在门外的：他去了，对面的人说「你这个没什么」，单子上写着「未见异常」。位子没立起来，他又被送回了那锅粥里。

这些人，在发现学的医学里，很难被看见。因为那里的逻辑是：有病，才会来；没来，就是没病，或者病不重。没有位子的苦，不在账上。

本书把这样的苦，也放进正文。

因为你一旦承认「病人」是一个位子，就会问：谁有机会坐？谁没有？谁坐得太快？谁被拦在外面？哪些苦被位子接住了，哪些苦在位子之外？

这些问题，发现学问不出来。它的眼睛，只盯着「已经有病的人」。

梁阿姨后来是怎么去的医院，是另一个故事。那年冬天，外孙在她身边蹲下来，看着她扶着床沿，学着她的样子，一点一点站起来，笑着说：「外婆，你怎么像机器人？」

她也笑了。笑完，她对周老师说：「下周，陪我去一趟吧。」

你看，那把凳子，是被一个孩子的玩笑，轻轻推了一下，才坐下去的。

◆ 八、只看一端，会怎样

把「病先在身上」这句话推到头，日子里会长出一些很熟的话。

第一句，是对着迟到的人说的：「你怎么不早点来？」

这句话里有一个预设：病早就在那里了，是你自己拖着没来。所以拖，是你的错。

这句话有时候是对的。有的东西，的确越早看越好。可它说得多了，就会长出另一样东西：一个人在门口犹豫的那三次，被当成了懒、怕、不当回事。没有人问：他那三次犹豫里，有什么？

他可能怕被说成「有病」。他可能一路上都在算，请一上午假要扣多少钱。他可能上一次进医院，被一句话打了回来：「你这个没什么，别想太多。」

他犹豫，是因为他知道一旦坐上那个位子，很多东西会变。

第二句，是对着没查出毛病的人说的：「你没有病。」

「没有病」三个字，说的人往往是好意，想让人放心。可对一个难受了半年的人来说，这三个字常常是一扇关上的门。苦还在，可是对面的位子已经站起来了：你没有病，那你来干什么？

这样的人，常常转身，去挂另一家医院的号。

不是他不信，是那锅粥还在，没人接。

还有一种更隐蔽的版本，是对着家里人说的：「你就是想太多。」

说这话的人，多半是心疼。可听这话的人，常常只听到一件事：我的难受，不被算数。他从此不再提。苦并没有少，只是从饭桌上，退回了夜里。

这几句话，有的把病当成病人的私产，有的把苦当成了不存在。方向相反，根子是同一个：都以为病在进门之前，已经长好了。

还有一种更隐蔽的说法，不在别人嘴里，在病人自己心里：「我怎么会得这个病？」

这句话问得很自然，也很沉。它的背后站着同一个想法：病是我身上长出来的一样东西，所以要从我身上找原因。我吃得太咸，我熬夜太多，我脾气太急。找来找去，找到的往往是自己的过错。

要是病人能多看一眼，他会看见：这个「病」，不只是他身上的事。它是他、他的医生、他的家人、一份指南、一条线，一起搭出来的。他的盐吃得多不多，是一个因素；那条线划在哪里，也是。

这样想，不是给他找借口，是给他松一口气：那件压在他一个人肩上的事，原来有好几个人一起扛。

反过来，也有一端。有人读到这里，会说：那就是说，医生给人「安」了个病名？病是医生造出来的？

不是。

不适是真的，苦是真的，血压的数字是真的，肿块也是真的。本书从头到尾不说这些是假。本书说的只有一件事：从「不适和苦」到「我是某某病的病人」，中

间要经过一个互动，没有这个互动，这个人就还是一个难受的人，而不是一个病人。

这两个说法不一样。前一个说病不真；后一个说病人的位子要靠一场互动才站得起来。

还有一种容易滑过去的读法：既然位子是互动给的，那人就不用对自己负责了。

也不是。位子是一起坐出来的，坐上去以后，自己做什么，照样重要。这个话题，第 15 章会专门谈。

◆ 九、今天，位子在诊室外面就坐上了

过去，一个人要成为病人，大概得走进一间诊室。今天不用。

你手腕上的东西，会在夜里三点提醒你：心率偏高。你随手搜一下「胸口发紧」，屏幕上跳出来十几种病名，每一个后面都跟着一句「建议尽快就医」。你把体检报告拍下来发给朋友，朋友说：这个箭头，我妈也有。

有一天半夜，周老师睡不着，摸黑拿起手机，在对话框里敲：「早上起来头沉，血压 150 多，是不是要中风了？」

屏幕那头很快回了他一大段话，条理清楚，措辞谨慎，最后一句是：建议及时就医。

他看完，再也没睡着。

第二天早上，他没有吃早饭，就让老伴陪着去量了血压。数字比平时低一点。他松了一口气，又有点说不上来的不踏实：夜里的那一阵害怕，是真的，可它跟袖带上的数字，好像不是一回事。

他把这件事讲给周岚听。周岚没有说「别信那些」，她只问：「它问你什么了？」

周老师想了想：「它没问我什么。它就是，说了一堆。」

周岚点点头。她没再说下去。她心里想的是：一个只有回答、没有追问的位子，和一个肯停下来问你一句的位子，对面坐着的人，感觉是不一样的。

你看，这个夜里，没有挂号单，没有白大褂，没有医院。可是一个位子已经出现了：周老师那头，是一个吓醒了的病人；对面，是一个会说话的东西，坐的是类似医生的位子。

这件事，第 16 章会专门谈：机器不是递给人的一件工具，它是一个新的位子。这里先记下一个小小的观察：位子不一定在医院里出现。它在哪里出现，一个人就在哪里开始当病人。

体检报告也是这样。你拿到一张纸，上面印着十几个项目，有几个后面带着向上的箭头。你还没见到任何医生，就已经在心里替自己排了一遍：这个箭头是什么意思，要紧不要紧，会不会和我头一个月的头晕有关。

有人说，这样一来，人就更早地知道自己的身体了，这是好事。这话一半对。早知道，有早知道的好处，很多东西越早处理越省力。本书不反对。

可早知道也有一个脾气：它把一个人的日子，提前切成了「检查之前」和「检查之后」两截。切开的那一刻，他不一定准备好了。

这张纸，是一张没有医生在场的单。它先把位子摆好了，等你自己去坐。

这对本章的意思是：「病人」的位子，比我们想的要容易坐上，也比我们想的要难下来。

容易坐上，是因为现在到处都有位子在等你：一个手环，一个箭头，一个搜索框。

难下来，是因为位子一旦坐稳，会在日子里留下痕迹——习惯、口头禅、每次头沉时先想的那一句话。第 6 章讲的「病名是第一次回写」，说的就是这个。

◆ 十、一个完整的例子：七岁的豆豆，是谁让他成了病人

再看一个不是周老师的例子，因为周老师是个成年人，他自己走进了诊室。

有一种病人，自己没有走进任何地方，是被带进去的。

周老师的外孙豆豆，七岁，上小学一年级。这个秋天，他咳嗽了两个星期。

白天，他在学校里没事。下课追着同学跑，一口气跑上三楼。夜里，他会咳醒两三次，咳几声，翻个身，又睡着了。他自己不觉得有什么。早上起来，照样扒两口饭就要出门。

先让他成为「有点不对」的，是老师。

那天课堂上，他连着咳了几声，老师停下来，看着他，说：「你是不是不舒服？回去让妈妈带你看看。」全班同学都转过头来。

豆豆愣了一下。他不觉得自己不舒服。可那一刻，他觉得自己有点不一样了。

放学回家，他把老师的话学给周岚听。周岚问：「你夜里咳不咳？」他说：「有时候。」

那天晚上，周岚对着手机，翻了一个多小时。第二天一早，她给豆豆挂了号。

到了诊室，医生问的第一个问题，不是问豆豆，是问周岚：「咳多久了？夜里重不重？有没有发烧？」医生问了五六个问题，豆豆一个也没有答。他只是坐在那里，看着墙上的卡通贴画。

过了一会儿，医生放下笔，把凳子往前拉了一点，蹲到豆豆旁边：「豆豆，你咳嗽的时候，喉咙里是痒，还是疼？」

豆豆想了想，说：「痒。像有一根头发。」

医生点点头，又问：「那夜里咳醒了，你怕不怕？」

豆豆低下头，小声说：「有一点。因为黑。」

这一问一答，周岚在旁边听着，才第一次知道，儿子夜里咳醒之后，是怕黑的。

你看，同一个孩子，医生换了一种问法，他说出来的东西，就换了一批。「痒」「头发」「怕黑」，这些词，在医生问周岚的时候，一个都没有出来。孩子的苦，不是等在那里被发现的，是在这一问一答里，才有了词。

还有一点要看：在这一幕里，最后被叫作「病人」的那个人，是整场对话里说话最少的一个。

他的病人位，是老师先给的一半，周岚给了一半，挂号单封上了最后一道。他自己，从头到尾没有「决定」过什么。

可没有人会说，豆豆的咳嗽是假的。夜里咳醒的那几次，是真的。

再往后看一步。从那天起，豆豆的日子里多了好几样新东西：晚饭后有一勺糖浆，睡前外婆会进来摸摸他的额头，体育课上老师特意问一句「你今天能跑吗」。同学们起初好奇，过了几天，开始叫他「咳咳」。

他不讨厌这个外号，也说不上喜欢。只是有一天，他在作文里写：「我是一个爱咳嗽的人。」

七岁的孩子，已经把一个位子，写进了对自己的说法里。

大人也一样，只是写得没有那么直白。

周老师的位子，周岚帮他坐过一半。那年冬天，是周岚在电话里说：「爸，你上回那个数，真得再去查一查。」他本来想拖。女儿说了三遍，他才去。

后来他对老伴说：「要不是丫头催，我还不去。」

老伴说：「你看，是你女儿让你当的病人。」

周老师笑着摇头：「是我让她当了医生。」

两个人都对了一半。位子不是一个人坐的，也不是一个人给的。它是两头一起，一寸一寸挪出来的。

这个例子帮我们把一件事看清楚了：**病人位不是病人自己占的，是整场互动合起来，替他留的。**对一个七岁的孩子来说，这件事摆在明面上。对一个 62 岁的成年人，它同样成立，只是藏得深一些，看上去像是他「自己决定」去看病的。

◆ 十一、放回日子里

回到周老师。

晚上，周老师翻出那本红皮本子，一页一页地看。八年的数字，密密麻麻，有的页角卷了。

他忽然问周岚：「要是那天我没被拉住，我现在是不是活得轻松些？」

周岚想了想，说：「也许轻松些，也许哪天摔一跤，才知道。」

周老师笑了：「你这话，跟没说一样。」

周岚也笑了。她没有给他一个答案，因为她知道，这个问题的答案，没有一个在「那天以前」。它们都在后面的日子里，一天一天地长。

可有一件事是肯定的：那个数字不会自己走进诊室。

这样想，有一点小小的好处。下次你自己、你的爸妈、你的孩子，觉得「哪里不太对」的时候，可以在去医院之前，先做一件很小的事。

拿一张纸，写三行。

第一行：哪里不舒服，什么时候开始的。第二行：它让我哪些事做不下去了。第三行：我最担心的是什么。

这三行，不是在帮你「自己诊断」，也不是替医生干活。它做的是另一件事：把一锅粥，先盛出一小碗，放在桌上。

你有了一碗，走进诊室时，你带去的就不是一个「我好像有病」，而是一份你自己看得见的苦。诊室里那场互动，会从你的这碗粥开始，而不只是从一张化验单开始。

这是本书能给你的、明天就能试的小办法。它不是医嘱，也不是药方。

如果你家里也有一位像梁阿姨那样的人，疼了很多年，总说「忍忍就好」，你可以试一件更小的事：不要劝她「去看看」，去问她「疼起来的时候，是什么样的」。

让她先说一遍。说完，你再说：「你刚才说的这些，值得让医生听一听。」

这样，你没有推她去占一个位子，只是帮她把那锅粥，从心里搬到了桌上。

如果是你自己要去，还有一个更小的做法：到了诊室，先别急着等医生问。你可以说一句：「我先说一下，我是怎么走进这间屋子的。」然后讲讲，是谁让你来的，来之前你怕什么。

很多医生愿意听这一句。听了，他对面的这个人，就不只是一张单子上的名字了。

本书只谈理解，不给诊疗和用药建议。身体或心里的难处真的大了，请找医生或心理咨询师。

另有一句话，留给那些觉得自己「还没到去医院的地步」的人：你不用等到自己确认是「病人」，才可以去问。难受，就足够坐到那把凳子前。

带 走 的 话

进诊室之前，你只有不适和苦；「病人」是挂号之后，和医生一起坐出来的位子。

小　账

这一处，开门还是关门：这一章开的是「路」那一扇——把病人从「带着病的人」，松回「正在成形」的一个过程里。

病放在一个人身上，还是放回复合体里？「你怎么不早点来」把病放在了一个人身上；本章把它放回了「挂号那一刻」的互动里。

想 一 想

你最近一次觉得「哪里不对」，是怎么变成「我得去看看」的？中间有谁说了什么，或者有什么东西提醒了你？

你认识的人里，有没有谁难受了很久，却一直不肯认自己是「病人」？他怕的，也许是那个位子，而不是那个病。

◆

02

第 2 章

医生不是发现者

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你拿着同一份检查报告，先给一位医生看，再给另一位医生看。

第一位看了很久，翻到后面几页，皱着眉说：「这个要重视，别拖。」

第二位扫了一眼，笑了笑：「这个很多人都有，先不管它，半年后再看。」

两个人都穿着白大褂，都在医院里坐了十几年，都没有说错话的样子。你拿着报告走出门，站在走廊里，心里只有一个念头：到底听谁的？

这种时候，你多半会替自己找一个解释。要么是说，一个医生比另一个强，一个看出来了，一个漏掉了；要么是说，有一个人在吓唬你，有一个人在糊弄你。

总之，你会觉得，一定有一个人错了。因为那张报告上的东西，是同一样东西。

你可能还会做一件事：回家上网，把两位医生说的话，各搜一遍。搜出来的东西，也是各说各的。你更乱了。

这时候，你心里还有一个声音：医学不是一门科学吗？科学，不就是该有一个答案的吗？

这个念头太自然了，自然到几乎没有人问它从哪儿来。

它从一个想法里来：**病是一件先在那里的事，医生的本事，是把它读出来。** 读对了，是好医生；读错了，是差医生。同一份报告，读出来的东西不一样，必然有人读错了。

这一章要问的，就是这个想法。

不过，本书先不急着拆。先要把它的好处，一样一样摆出来。

◆ 二、老看法：医生是发现者，对在哪里

发现学的医学，说起来很短：病早就在那里，医生是去找的人。

像一个探矿的人。矿脉在山里，不管有没有人来，它都在。探矿人带着仪器，一寸一寸敲，终于敲到了，他喊一声：「在这儿。」功劳在他的眼力和手艺，可矿不是他造的。

这个比喻，放在医学里，有三层意思。

第一层，病在先，医生在后。病灶在身体里，不因为被看见才有。

第二层，看得越准，越接近真相。医生之间的差别，是手艺的差别，是仪器的差别，是见过的多不多的差别。

第三层，好医生之所以好，是因为他像一面干净的镜子：自己尽量不在里面，只让病如实地映出来。所以我们要求医生「客观」，要求他「不带感情地看」，要求他「按规范来」。

这套想法不是凭空来的。近代的临床医学，有一条很硬的根：医生在床边听到的症状，后来在解剖台上，一样一样对到了器官里去。咳嗽对到了肺里的某一处，水肿对到了心的某一处（这是十八至十九世纪病理解剖学一路积累下来的路子，这里只说大意）。症状是外面的，病灶是里面的，症状是影子，病灶是东西。

只要你相信这条线，医生的本事，就是顺着影子，摸到东西。

这一整套想法，对医学做了很大的事。

它让一代又一代医生，去练眼睛，练手，练听诊器上那一点点区别。它让人们造出了显微镜、X 光、化验仪，让原来靠猜的东西，变成了可以看见的。它让一个村医和一个大医院的专家，面对同一个肺炎，能说出差不多的话。

没有这套想法，就没有今天的医院。这一点，本书老老实实认下来。

医院里的很多日子，也确实靠它撑着。深夜的化验室里，没有人说「复合体」，一个人盯着显微镜，只想把那一个细胞看准。一个外科医生在手术台前，不会停下来问「这个肿块是怎样被显影出来的」，他要做的，是切对地方。

这种专心，是一种本事，也是一种德行。如果一个医生对每一样东西都问「这是谁和谁拉出来的」，那他大概没法做手术。本书不要求他这样做。

再说，它在什么条件下完全成立。

条件有三个。第一，病的边是清楚的：骨折就是骨折，肿块就是肿块。第二，查法是稳的：同一张片子，换三个有经验的医生来看，说的差不多。第三，病人和医生之间，不需要靠说话才把病立起来：就算病人昏迷着，病也在那里，也能查出来。

你想一想急诊室里的情形。一个人被抬进来，不省人事，医生一边看一边喊：「血压掉了，快拿血。」没有人此刻会问，这是「谁和谁的复合体」，也没有人需要问。病就在那里，抢救就是抢救。

在这样的地方，发现学是对的，本书不拆。

可是，你有没有注意到：我们日常去医院，大部分的事，不在这三个条件里？

头沉、胃胀、睡不着、累、心里发慌、浑身这儿那儿不对劲——这些东西，边不清楚，查法不稳定，而且恰恰要靠病人和医生一句一句地说，才能成形。

发现学医学，是用急诊室的眼睛，看了整座医院。

◆ 三、同一副身体，换一个医生

先看第一个现象：医生换了，读出来的东西，常常换了。

医学自己早就知道这件事。几位医生看同一批影像，几位医生读同一批切片，意见并不总是一样；就连同一位医生，隔一阵子再看同一张片子，有时也会改口（医学里对这类「读片者之间是否一致」的问题，早有专门的研究，这里只说大意）。

医学怎么看待这件事呢？它叫它「误差」。

误差，就是离开了正确答案。既然有误差，就要想办法消灭它：多培训，多统一，多会诊，出标准，写指南。方向很清楚：让所有医生看同一张片子的时候，说出同一句话。

这个方向没有错。它也真的让很多事靠谱了很多。

可是，请你停一下，想想一个很具体的场面。

周岚所在的社区医院，每周五下午有一个小会。几位医生把一周里难读的片子摆出来，一起看。

有一回，墙上挂着一张胸片，是一位退休工人的。老陈在医院干了二十多年，他指着肺纹理说：「这是老慢支的底子，抽了一辈子烟的人，都是这样。」

年轻的小吴摇摇头：「我看不出多严重，这个年纪，大多数人是这样的。」

坐在角落的另一位说：「还是三个月后复查一下吧，稳妥。」

三个人看的，是同一张片子。三个人，都认真，都有证书，都没有睡过头。他们读出来的，是三个不一样的东西：一个读出了「底子」，一个读出了「寻常」，一个读出了「待观察」。

发现学医学的第一反应，是找出那个错的。可这一次，会议室里没有人觉得谁在犯错。老陈见过太多抽烟的老人，所以他的眼睛先看见了烟。小吴刚来三年，他先拿手里的参考范围去对。第三位医生，上个月刚碰到一个被漏掉的病例，他的手先替他稳了稳。

他们看见的，不只是那张片子。还有各自这些年，坐在桌子对面的那些人。

读出来的东西不一样，不奇怪。

周岚对这件事，有她自己的体会。有一天吃饭，她对父亲说：「爸，我有时候想，我周一上午看一个人，和周五下午看同一个人，说的话不一定一样。」

周老师吓了一跳：「那你周几看得准？」

周岚笑起来：「不是准不准的事。周一上午我精神好，一个人说头晕，我会多问几句；周五下午，候诊的人排到门口，我就只能问最要紧的两三样了。」

她停了一下，又说：「同一个我，同一个病人，读出来的，是不一样的。」

这句话，从一个医生自己嘴里说出来，比任何道理都有分量。

你看，这里有一个很容易滑过去的地方：我们总以为，是「同一张片子」被三个人各读了一遍。

可事实上，三个人面前摆着的，已经不是同一样东西了。老陈面前的是片子加上他二十年见过的烟民，小吴面前的是片子加上他手里的参考表，第三位面前的是片子加上上个月那个被漏掉的病例。

片子是一张。读片，是三场。

◆ 四、换医院，换指南：线是划出来的

再看第二个现象：换了医院，换了指南，读出来的东西也会换。

拿血压来说。血压是一个连续的数，从低到高，一格一格往上走。可「高血压」这个词，是一条线：线以下，叫正常；线以上，叫病。

这条线，不是山上的一道石缝，不是人一出生就刻在血管上的。它是一群人，坐在一间会议室里，对着许多年的研究资料，吵了又吵，才划下来的。

而且这条线，不同的地方、不同的年份，划得不完全一样。有的指南把线划在 130/80 那一带，有的把线划在 140/90 那一带（比如 2017 年美国的指南把线划在 130/80，2018 年欧洲的指南仍把线划在 140/90）。

线往下挪一点，一夜之间，「高血压人群」就多出一大批人。线往上挪一点，又有一大批人，从「病人」回到了「正常人」。

没有人的血管在这一夜变了。变的是线。

这里面有一个极要紧的细节，要说清楚：划线的人，不是在乱划。每一条线的背后，都有人在认真地算：线划在这里，能少几个中风，多几个被药物打扰的人，值不值。这是医学里最费心的一类工作。

本书不说这条线是「假的」。本书只想说，线是一场互动的结果，不是山里原来就有的石缝。

线一划下来，就有了一个新的东西：门槛。过了线的人，有资格坐上病人位；没过线的人，坐不上，或者坐得不太稳。

门槛不只在医院里。很多地方的报销，要凭一个明确的病名；一份保险的理赔，要凭一张写着病名的证明；单位里的一次请假，要凭一张盖了章的纸。这些东西都在等着那一条线：线画在哪里，纸上写什么，别的好处和代价就跟着落在哪里。

所以线移动一点点，改变的不只是医生口里的一句话，还有一个人家里的开销、单位里的安排、饭桌上的称呼。

你再想想周五下午会议室里那三位医生。他们手里的线，不一定是同一条；他们心里想着的人，也不是同一批。这两样叠在一起，读出来的东西不同，便是很自然的事。

发现学医学说：线应该统一，统一了，误差就没有了。

可它忽略了：线统一了，换的只是一项；医生、病人、诊室、时间、说话的方式，还有许多项，也在换。

◆ 五、不是误差，是复合体不同

现在把两个现象放在一起看。

医生换了，读出的东西换；指南换了，读出的东西也换。发现学说，这是误差，一定有一个对的。

本书的说法不一样：这不是误差，是复合体不同。

先说什么叫「复合体」。

你有没有看过两个人拉一把大锯？

一根粗木头，横在两条凳子上。一个人站在这一头，一个人站在那一头，锯子在中间，一拉一送，木屑一层一层落下来。

有人问：那道锯口，是谁锯出来的？

是这头的人？是那头的人？都不是，也都是。锯口不是哪一头锯出来的，是两个人拉出来的。一头松了劲，锯子就卡住；一头使猛了，锯子就跑偏。要是换一个人去拉另一头，同一根木头，锯出来的口，不会一模一样。

本书把这个叫拉大锯。它是全书的总比喻。

你把诊室放进去：一头是病人，一头是医生，锯子是他们之间的话、问、查、听、停顿，木头是这具身体和这些日子。

锯口是什么？是诊断，是此刻读出来的那个状态。

现在，你再回头看会议室里的那三位医生，还有你自己在走廊里听到的那两种话。

换一个医生，等于换了拉锯的另一头人；换一家医院，等于换了锯子和凳子；换一份指南，等于换了锯齿的样子。木头还是那根木头，可锯口，不会一样。

这样一来，同一副身体读出的病不同，就不是「有人拉错了」，而是拉的不是同一把锯。

这里要公道地说一句：木头不是不管事的。一根松木和一根硬木，锯口一定不同；一副身体的确有它自己的纹理，骨折就是骨折，不会因为换了医生就变成感冒。这也是为什么在急诊室里，发现学几乎全对：那里木头的纹理极硬，锯法影响很小。

可在大多数日子里，木头的纹理不那么硬，锯法的影响就大了。

所以本书不说「医生说了算」，也不说「身体说了算」。本书说，承载这个状态的，是这一对人加上他们的诊室、指南、话和时间，合起来的一个整体。

有人可能会问：既然读出来的口不一样，那我听谁的？

本书的回答，说起来不像一个回答：不是在两道口里选一道，而是把两道口都带上，再起一次头。

你想想两个人一起拉锯，锯到一半发现口歪了。他们不会争论哪一道歪得对，他们会停下来，看看是锯齿钝了，还是木头纹理偏了，再换一个角度，重新起锯。一道口的好坏，只有放在整把锯里才能判断。

这个整体，本书叫它医生—病人复合体。

它不是一个新发明的名词，是一个提醒：读出来的东西，属于它。

这个整体里，到底有什么？不妨一样一样数一数：

坐在那里的这个医生，他这一天的精神，他这些年见过的病，他心里的那份指南。坐在对面的这个病人，他这半年的睡眠，他怕的是什么，他愿意说多少。这间诊室，它的时钟和它的门，门外还有多少人在等。这张桌子上的电脑，它的格子能写什么、不能写什么。这一次问话的次序，先问了哪句，后问了哪句。还有这家医院的规矩，这个地方的习惯，这个时代对「病」的看法。

这些东西，没有一样是「主角」，也没有一样可以单独拎出来，说读出的东西是它决定的。它们是合在一起拉的。

所以本书的说法，只有一句：读数不是被发现的，是被拉出来的。拉出来之后，它会成为一个事实，进入病历，进入日子。可它成为事实的路，要从这一把锯说起。

◆ 六、线会移动：病的名单是改过的

换医生、换指南，是一个横着的比较。再来一个竖着的：换年代。

病的名单，不是写好了贴在墙上的。它会改。

有一类事，人人都知道。1973 年，美国精神医学会把同性恋，从它的诊断手册里拿掉了。在那之前，进入这本手册的人，是「病人」；在那之后，同样的人，同样的日子，不再是。

没有人的身体在那一年发生什么变化。变的是，哪些人坐在会议桌旁，他们看见了什么，社会怎样看待这件事，那条线，往哪边挪了。

再看一个反方向的。有些东西，在以前没有名字，后来有了。一个在今天被叫作「失眠」「焦虑」「倦怠」的人，几十年前，也许只被叫作「脾气不好」「想不开」「没出息」。名字有了，位子才有；位子有了，才有人去坐。

对这样的事，发现学医学有一个现成的说法：以前错了，现在终于发现了真相。

这个说法，有时候对。

比如，有些胃溃疡，过去长期被认为主要和压力、胃酸有关；后来有人发现，其中不少和一种细菌有关（这是澳大利亚的沃伦和马歇尔在 1980 年代初的发现，后来获了诺贝尔奖）。这是一次真正的发现，一块真的东西被找到了，很多人因此好得更快。本书也要为它鼓掌。

可你再看这件事的另一面：在没发现以前，那些得了溃疡的人，常被说成「爱操心、性子急」。被发现之后，这个说法渐渐淡去。变化的不只是胃，还有那个人的日子——他在家里、在单位，被人怎样看，怎样说。

找到一个细菌，是一次发现。可发现一旦落地，又进入了复合体：医生能说的话变了，病人能坐的位子变了，那个叫作「性子急」的病名，悄悄退场了。

所以本书对待「线会移动」，有一个小小的分寸：有的挪动，是找到了新东西；有的挪动，是线搬了家。两者要分开看，不能混在一起，更不能因为第一类是真的，就说第二类也是真的。

不过无论哪一类，一个共同的事实是：名单是人坐在一起，一轮一轮改出来的。改的过程，是复合体的事；改完的结果，会回过头，变成下一代复合体的土。

◆ 七、医生的位子也会换：周岚的三个晚上

说了这么久医生，还有一样东西要拆：「医生」这个词，是不是一个人身上带着的东西？

看周岚。

周岚 34 岁，在社区医院做全科医生，五年了。

星期二上午的诊室里，她坐在桌子后面，面前是一个又一个老人。她说话快，句子短，一边听一边在电脑上敲。她问：「哪里不舒服？多久了？吃药没有？」她看舌头，量血压，听肺。三分钟，五分钟，一个人起身，下一个人坐下。

在这间屋子里，她是医生。凳子上的人叫她「周医生」，她也说得出一整套话：「这个数偏高，再观察，下周复查。」

这是她的第一个位子。

同一个星期的星期五晚上，周老师因为头沉得厉害，被周岚送到另一家医院，在留观室里躺了一夜。

周岚坐在床边的塑料椅上。

监护仪的屏幕上，数字一格一格地跳。她认得每一个数，知道每一个数在医学上是什么意思。她甚至看得出护士下一步要做什么。

可她一句医嘱也没有说。

护士进来量血压，她没有伸手去看袖带。医生查房的时候，她站在床脚，说的是：「我爸这几天头沉，夜里睡得不好。」说得像任何一个家属。

周老师在床上说：「你不用在这儿守着，你明天还要上班。」

她说：「没事。」

她心里有一个声音，在对着屏幕说话。嘴上，什么也没说。

这是她的第二个位子：家属。这个位子上，她的知识一点没少，可医生这个位子，不是她的了。

半夜，值班护士路过，看见她盯着屏幕，低声问了一句：「周医生，你帮着看一眼？」

周岚摇摇头：「你们看，我不是这里的医生。」

护士笑了一下，没再说话。她们都明白：这个晚上，周岚的白大褂不在这里，她的位子，也不在这里。

那个声音，她没法拿出来用。因为在这间屋子里，她的父亲是病人，另一个人是医生，她没有位子可以坐在医生的那一头。

再换一个晚上。

几个月后，周岚自己发烧了。三十九度，嗓子像吞了刀片。她在家里翻出体温枪，量了两次，又对着手机灯照自己的喉咙，看见两侧肿得发白。

她知道可能是什么。她甚至知道第二天要开哪些单子。

可她拖了一整天，才去找同事。

同事问：「你自己不是医生吗，怎么不先给自己开点？」

她笑了一下，说不出口：她给别人开药的时候，从来没觉得难。可轮到自己，她发现自己在两个位子之间，互相不服。医生那一头说：你是个明白人，别小题大做。病人那一头说：我难受，我想有人管我。

这是她的第三个位子：病人。同一个人，同一个脑子，同一套知识。

后来她对一个新来的实习医生说起这几个晚上。实习医生问：「那你觉得，哪一个才是真正的你？」

周岚想了想，说：「都是我。可没有一个，是我一个人。」

三个晚上，读出来的东西，完全不同。诊室里，她读出的是别人的「病」；病床前，她读出的是父亲的「不放心」；自己发烧时，她读出的是一个想被照顾的人。

她的医学知识，一样都没有丢。丢的，是位子。

这件事告诉我们：**医生不是一种人，是一个位子**。

和病人位一样，医生位也是一场互动给的。这边有一个愿意把苦说出来的人、一份挂号单、一间屋子、一套被承认的规矩，那边才有一个叫「医生」的位子站得起来。拆掉这些，白大褂就只是一件衣服。

白大褂也是位子的一部分。它让对面的人知道，该把什么话交给你。你想想，一个穿着病号服、坐在床边的人，同样懂医学，说出的话，别人听起来的分量，就是不一样的。

不是别人偏心，是位子在替人说话。

发现学把医生当成了一种人：有执照、有手艺、有一双好眼睛。这些全是真的。可「他在这一刻是医生」，是另外一件事，那是复合体给的。

你还可以反过来想：位子是对面给的。

有一回，周岚在诊室里碰到一位不肯坐下的中年人。他站着，抱着胳膊，说：「我就是来开个单子，你别问那么多。」

周岚按平时的路子，问了几句，他一概不答。她说：「那我没法判断。」他说：「你们医生就是麻烦。」

那十分钟里，周岚的一身本事，一样都没有用上。她坐在医生的椅子上，可医生位没有站起来。因为对面的人，不肯把他的那一头交过来。

后来她想明白了：她那天缺的，不是知识，是一个愿意同她拉锯的人。位子是两头一起才立得住的。

◆ 八、只看一端，会怎样

把医生当成发现者，日子里会长出几种很熟的情形。

第一种，是找「名医」。

人们相信，世上一定有一个人，他一看就看对。所以排队挂专家号，托人找关系，把几个月的力气，都押在一个人身上。押对了，是福气；押错了，就觉得被辜负。

可你想想拉大锯：就算最好的锯手，换了一把钝锯、一个不配合的搭档、一根纹理特别古怪的木头，锯口也不一定漂亮。名医的好，一半在他，一半在他怎样和对面的人拉起来。

名医的另一面，是被他看过的人。一个人在名医的诊室里坐了二十分钟，出来说：「他真懂我。」他说的「懂」，不只是医生的知识，还有医生在那二十分钟里，愿意把锯子的节奏，放到他的节奏上。

第二种，是追究「谁看错了」。

出了事，第一个问题是：哪个医生没看出来？这个问题有它的道理，该问的要问。可如果只剩这一个问题，其他的东西就被盖住了：那天病人是怎么说的？说了多少？医生有多少时间？有没有地方让病人把那句最要紧的话说出口？

这些东西，在发现学的眼里，是背景。在本书里，它们是锯子本身。

第三种，是医生自己。

一个把自己当成「发现者」的医生，会在每次读错的时候，觉得是自己的眼睛不行。他越是认真，越是责备自己。年头久了，这种责备会换一副样子：不敢下结论，什么都要多查一项；或者反过来，把话说得极短、极硬，免得被追问。

这些，第 13 章会细细讲。这里先记一笔：把医生当发现者，不光是病人吃亏，医生也吃亏。

还有一层，是往标准化那头走的时候容易漏掉的。

为了让所有医生读出同一句话，医院会把问话的格子排好：先问哪三样，再查哪五项，每一样填多少字。这个办法让很多事稳了。可格子排得越满，留给病人那一句「还有一件事」的地方，就越少。

那一句「还有一件事」，常常是整场就诊里最要紧的一句，也常常是在医生的手已经放在门把手上的时候，才说出来的。

要是医生是发现者，这句话是可有可无的补充。要是诊断是拉出来的，这句话，也许就是锯子最后的一道齿。

要小心另一个方向：别因为这一章，就觉得「怎么读都行」。

不是。复合体不同，不等于每一种读出来的东西都同样好。有的读出来，贴着这个人的日子；有的读出来，走偏了，漏了该看的，或者多看了不该看的。走偏了，就要纠偏；该追责，还是要追责。

只是纠偏和追责的对象，从一个人的眼睛，放大成了一整架锯：谁的手松了，谁的齿钝了，谁的凳子没放稳。

那么，读出来不一样的时候，怎么分？可以粗粗分成三种情形。

第一种，边清楚的东西。骨折、明确的感染、明显的肿块。这时候，两个医生读出的不一样，多半有一个人漏了，或者查得不够。这是急诊室的世界，发现学说得对，该纠错就纠错。

第二种，落在线边上的东西。一个数字刚好在两条线之间，一条线说是病，一条线说还不是。这时候，不同的读法都站得住，问题不在谁错，而在选了哪一条线，和这条线对这个人的日子意味着什么。

第三种，说不清的苦。头沉、乏力、心里发慌、睡不好。这时候，读出来的东西，几乎全看那把锯怎么拉。同一个人，可以被读成好几种样子。这里最需要的，不是找到「对」的那一种，而是让锯子拉得久一点、拉得细一点。

这三种情形，本书在后面的章节里会反复用到。

有人会担心：这样说，不是给医生开脱了吗？

不是。拉锯的人，有一个人是医生。他那一头的手，松没松，齿钝没钝，他自己最该先看。他的职业给了他更多的位置、更多的知识、更多的选择，他那一头的责任，也相应地更重。

本书只是不让责任只停在一个人的眼睛上。眼睛要查，凳子也要查，时间表要查，规矩要查。能一起查，才有机会真的少一些下一次。

◆ 九、今天与机器：同一张片子，问两个模型

今天，新的情形出现了。

一个人把同一张片子，拍照发给两个不同的 AI 问答工具，得到两段意思相近、重点却不一样的话。他又把同一份化验单，隔一天再问一次，措辞换了一点，回答的口气也跟着换了一点。

很多人看到这里，会觉得：机器也不靠谱，它有时说得重，有时说得轻。

可你想想，这和前面的事，是不是同一件？

不同的模型，是不同的锯手。不同的问法，是不同的锯路。你在对话框里的措辞、你贴上去的内容、你是半夜慌着问的还是白天平静地问的，都是锯子的一部分。

机器没有绕过这件事。它是把这件事摊在了桌面上。

发现学的想法，会让人去追问：哪一个模型才是对的？哪一个才是那个「真」的读数？本书会提醒另一个问题：你和它拉的是一把什么锯？

这件事，第 16 章会专门谈：机器进入诊室，不是递来一件新工具，它是复合体里多出来的一个位子。

这一章先记住一点：一旦你不再期待「某个人或某台机器，能把病读出来」，你就能更平静地对待每一次读数。它是一次读数，是这一把锯锯出来的口。下一次，换一个人、换一个时间，再起一次头，是正常的。

再往前想一步。有些读片的程序，会在影像上标出一个概率，比如「这一处，有多大的可能是某某」。医生看到它，病人也可能看到它。

这个数字，会像一根手指，指向影像上的一点。医生的眼睛很难不顺着看过去。它不是在替医生看，它是在替医生的眼睛，先定了一个方向。

这没有什么不好，这往往救了很多人。可它是一个新的拉锯的人，站进了复合体里。

这不是要你不信机器。机器可以非常有用，它能把很多医生一辈子也读不完的片子读一遍，把一个人忘了问的东西提醒一遍。本书要说的只是：它给出的，也是一次读数，来自它和你之间的这一把锯。

你拿着它的话去见你的医生，两把锯就接在了一起。这比任何一把单独的锯，都更有机会拉出一道合适的口。

◆ 十、一个完整的例子：周老师的两次门诊

把整件事再走一遍，用周老师。

这是去年冬天的事。那阵子，他的数字比往常往上走了一点，他去了那家离家最近的医院，挂了心内科。那天上午人多，医生三分钟一个号。

医生看了他的血压记录，说：「您这个数，得加强管理了。」说完在病历上写了一行。

周老师点头。他走出诊室，在走廊长椅上坐了一会儿，把「加强管理」四个字在嘴里默念了几遍。

回到家，他没说什么。只是从那天起，量血压从早晚各一次，变成了一天三次，红皮本子上的格子，一页比一页挤。

第二次，是半年后。他去体检中心做年度体检，那里的医生是个年轻人，一边翻报告，一边问他：「平时睡得怎样？爬楼梯累不累？吃盐多不多？」

他答得很慢，这是半年来第一次有人这样一件一件问他。年轻人听完，说：「您这个数，偏高一点，但整体不算严重。生活方式调一调，三个月后再看看。」

周老师愣了一下：「那我还要一天量三次吗？」

年轻人说：「这个要看复查结果，也要和您的主治医生商量，不要自己改。」

周老师出了体检中心，心里很乱。这半年，他把自己当一个「控制得不好的人」在过。现在忽然有人说，也许没那么重。是他前半年白紧张了？还是体检中心的医生看轻了？

他在体检中心门口的花坛边坐了好一会儿。花坛里种着一排矮矮的月季，开得不太认真。他想起半年前，自己从心内科出来时，也是在一张长椅上坐了这么久。

同样是坐着，心里的东西，换了一个方向。

两边的话，都站得住。第一位医生背后有一套规范，第二位医生背后有另一套侧重。两边都没有说错。

可两边读出来的，是两个不同的周老师：一个是「得加强管理的人」，一个是「偏高但可以观察的人」。

周老师夹在中间。

这时候，发现学的问法是：到底哪个对？周老师应该听谁的？

本书的问法不同：这两次门诊，各是一场怎样的拉锯？第一场，三分钟，一个站在「谨慎」那头的医生；第二场，二十分钟，一个站在「看全貌」那头的医生。两场拉出来的东西不同，是自然的。

对周老师最要紧的，不是赶紧决定相信谁，而是把这两场放在一起看——并且回到有他主治医生的那场互动里，把两边的话都带进去。（这一点，第 8 章会讲：复诊和第二意见，不是来纠错的，是来重新起头的。）

老伴在旁边听着，插了一句：「你要是前半年没那样紧着量，现在是不是更糟？」

周老师说：「我哪知道。」

这句「我哪知道」，是最老实的一句。没有一个人，能同时过两遍同一个半年。每一场就诊，都只在一个方向上，把日子往前推了一步。推出去的那一步，就成了新的土。

三个星期后，周老师带着两份记录，回到了他的主治医生那里。

那是一位五十来岁的医生，说话不快。他把两份记录都看了，没有说哪一份对。他问：「这两个医生，一个让你加强管理，一个让你先观察，你自己是怎么想的？」

周老师愣了一下。过去几年，他很少被问「你自己是怎么想的」。他想了很久，说：「我怕这么一天天绷着。可我也怕松下来，万一……」

他没有说下去。医生点点头：「那我们先把你怕的这两件事，一件一件摆出来。」

这一次，桌上放着的不只是血压的数字，还有一个老人没有说出过口的两种怕。

锯子又起了一个新头。

这不是前两场的「更正」，也不是对前两场的「裁决」。它是第三场，把前两场都带了进来的第三场。

本书不告诉他该怎么管，那是他和他的医生之间的事。

◆ 十一、放回日子里

晚上，周老师把两次门诊的事，讲给周岚听。

他讲得有些委屈，也有些糊涂。

周岚听完，没有说「爸，我觉得哪个医生说得对」。她知道，这句话她随时可以说，而且说出来，会让父亲马上轻松一点。

可她停了一下，问了另一句：「第一个医生，问你什么了？第二个医生，问你什么了？」

周老师想了想：「第一个，问我血压记录。第二个，问我睡觉、吃盐、爬楼梯。」

「那你觉得，他们是在看同一个东西吗？」

周老师不说话了。过了一会儿，他说：「好像是，也好像不是。」

这句「好像是，也好像不是」，就是这一章想让你听到的。

一个小办法，你明天就能试：下次你拿着同一份结果，听到两种不同的话，先别急着判谁对谁错。把两位医生各自问了你什么、没问你什么，写在一张纸上。再去见你信得过的那位医生，把这张纸放在桌上，说：「这是我听到的两种话，我想听听你怎么看。」

这不是去对质，是让下一场拉锯，把前两场的东西也带进来。

还有一个更小的办法：当医生说一个判断时，你可以问一句：「您是根据什么，说到这一步的？」

这句话不是质疑，是请他把锯子举起来，让你看一眼。

本书只谈理解，不给诊疗和用药建议。身体或心里的难处真的大了，请找医生或心理咨询师。

如果你自己就是医生，也有一件很小的事可以试：在写下一个判断之前，心里先过一句——我今天读出来的，是在什么样的一把锯上读出来的？这一把锯，今天快不快，对面的人说了多少，我没问到的是哪一样？

这不是要你多写一页病历，只是让你在落笔前，停半秒钟。那半秒钟里，你把自己从「发现者」的位子上，请下来一点点，坐回拉锯的人那里。

带 走 的 话

同一副身体读出不同的病，不是有人读错了，是拉的不是同一把锯。

小　账

这一处，开门还是关门：这一章开的是「土」那一扇——医生读出的东西，扎根在诊室、指南、话和时间这片土里。

病放在一个人身上，还是放回复合体里？「哪个医生看错了」把病放在一个人的眼睛上；本章把它放回了这一对人和他们的锯子里。

想 一 想

你有没有拿着同一份结果，听到过两种不同的话？那两次，你各自说了什么、被问了什么？

想一想你认识的一位医生：在诊室里，他是医生；在家里，他还是不是？这两个位子，他是怎么换的？

◆

03

第 3 章

观察者仍是发现学

◆ 一、你一定有过这样的时刻

周老师血压高了多年。每个月，女儿周岚都让他在家量几次，数字记在一个红皮本子上。

家里量，数字大多规规矩矩。可每到社区医院复诊，袖带一绑上，数字就往上跳一截。护士看了一眼，皱皱眉，说再坐五分钟，重量一次。

第二次，还是高。

周老师有点着急，也有点委屈：「我在家明明好好的。」

周岚在旁边没有说话。她是医生，这种事她见得多，知道有个说法叫「白大褂效应」：一见穿白大褂的人，数字就上去了。她也知道，医学上并不把这当成谁在说谎。

可父亲接下来那句话，她一时没接住。

「那你们说，哪个才是我真正的血压？」

你大概也问过类似的话。体检单上的数字和你自己感觉到的不一样，换一家医院换一位医生，结论又不太一样，你就想：总有一个是真的吧？总有一个，是我这副身子本来的样子吧？

这个「总有一个」，是本章要问的东西。

它听上去再自然不过：身子在那里，病在那里，医生的本事就是把它看清楚。看得越准，越接近真相。看得不准，是仪器不够好，或者人太紧张。

这一章要慢慢把这个想法的底托出来给你看。它不是错的，它在很大一片地方管用。可它底下垫着一个东西，这个东西，量子力学的人早就觉得不对劲了；而他们觉得不对劲之后做的那些修补，又偷偷把同一个东西留了下来。

留下来的，就是那个站在一旁、负责看的人。

◆ 二、老看法：病在那里，等人去看

先把老看法说足。它对在哪里，要先讲清楚。

它的意思很简单：病是一件事，医生是另一个人。病在身体里，早在医生到场之前就在了；医生到场，是去把它找出来。找得准，就是诊断；找不准，就是误诊。

这个想法养活了现代医学的大半。

一个人咳了三周，片子上有一块阴影。那块阴影不会因为你换了一位医生就消失，也不会因为你不信它就变小。它在那里，有大小，有边界，有位置。医生看见的，是它；医生没看见的，也是它。

你想想看，如果不是这样，医院还怎么开？化验单、影像、病理切片，一层一层往下查，查的就是「那里到底有什么」。

所以本书先要认下一件事：在很多时候，把病当成一件先在的事来查，是对的，也是有用的。

血压计也是这个想法的好帮手。袖带绑上去，水银柱落下来，读数就是读数。数字高了，是血压高；数字低了，是血压低。要是读数老在变，那就多量几次，取一个平均。

这个想法里，有一个角色，从来不被讨论：量的人。

量的人，被当成一块透明的玻璃。他站在那里，目光穿过去，落在病上，病的样子原样来到他眼里。好医生的标准，就是这块玻璃擦得够干净，不添一点颜色。

这就是本书说的「发现学」的医学样子。用一句话说：东西先在那里，人去发现它。

发现学的医学，也不是没有看见过「量的人会影响被量的东西」。白大褂效应就是一个例子。可它的处理办法，是把这件事记作干扰：干扰要尽量排除，排除了，就回到真正的数字。

周岚读医学院的时候，老师教过一条规矩：量血压之前，让病人安静坐五分钟，背靠椅子，脚放平，手臂和心脏一样高。这条规矩是为谁定的？为的是把「别的东西」挡在门外，让读数尽量只剩下血压自己。

这条规矩是好规矩。它是一代代医生吃了亏之后学来的。没有它，数字真的会乱。

本书不要拆它。本书只想指出，这条规矩背后站着一幅图：有一个干干净净的「血压本身」，所有别的东西，都是要挡掉的杂质。

于是又回到那个问题：哪个才是我真正的血压？

要看这个问题怎么被拆，得先绕一个远路。这个远路，医学自己很少走，可它和医学的这个疙瘩，长得很像。

◆ 三、量子力学留下的一个口子

先说明白：本书不写「量子力学证明了医学」。这样的话既不对，也没人该信。量子力学讲的是极小的东西，医院里的事没有一件能从它推出来。

本书只借它一样东西：它是第一个认真被「量的人」这件事卡住的学问。卡得很深，卡了快一百年，到现在也没有人人都服的说法。

打个家常的比方，请你只当比方听。

你在池塘边。有人问：水里有什么？你可以拿一张网下去捞，捞上来的是一条条鱼。你也可以把手掌平放在水面，轻轻一拍，感到的是一阵一阵的浪。

网捞上来的，是鱼的答案；手感到的，是浪的答案。两样都是水里的东西，两样都真。

在池塘里，这并不奇怪，因为你心里踏实：不论网还是手，水里本来就既有鱼也有浪，你只是挑了一种去碰。

极小的东西麻烦就在这里。你用一种办法去问，它给你一种答案；用另一种办法去问，它给另一种答案；而「它本来既有鱼也有浪」这个踏实的想法，试着算下去，会和实验量到的数对不上。

对不上到什么程度？

有人这样想过：假设每个小东西身上都早就写好了答案，像骰子在杯子底下早已落定，你揭开杯子，只是看一眼。那么，把许多个这样的骰子配起来比一比，应该能算出一个上限。

后来的实验量出来的，超过了这个上限。这一类思路，常称作贝尔不等式（贝尔，1964 年），实验在之后几十年里做了很多次。

别被名字吓住。它要说的，其实只有一句家常话：最直截了当的那种「答案早就写好、只等人去看」，行不通。

注意这句话的分寸。它没有说「是人的眼睛让东西出现」，也没有说「心里想什么，东西就变成什么」。它只说，把「早就落定」当成账本的第一行，这本账算不平。

那么账该怎么记?

物理学家们吵出了好几种记法。有的把整个世界当成一个大波，有的认为答案的确早就写好，只是写在更远的地方；有的干脆说，「记法」不重要，能预言就行。这些吵法本书不替它们裁判，也没有资格裁判。

本书只取它们共同承认的那一点：在实验里，「测量」不是一个旁观的动作，它是结果得以确定下来的那一段过程的一部分。

用家常话说：骰子盒没打开之前，你不能理直气壮地说「那里有一个朝上的面」。打开的那一下，是整件事的一部分，不只是最后的一瞥。

顺便澄清一个流传很广的说法：薛定谔的猫。

很多人听说「箱子里的猫，又死又活，打开才定」，就以为量子力学说的是「看一眼，猫就定了」。这个故事，是薛定谔 1935 年为了说明这套说法有多奇怪才讲的，本来带着几分讽刺的意思。它不是一个「看一眼就改变世界」的证明。更何况，一只猫，一个箱子，早就处在一个到处碰撞的环境里，退相干那一节会讲，不需要谁来看。

所以，凡是有人用猫来说「人的意念能决定现实」，请你把这句话放下。

再说一遍，免得走偏。上面这些，没有一句说「人心让东西改了样」。它们说的是另一件事：在极小的世界里，「问法」和「答案」没法拆成两家。你用什么办法去碰它，它就以那个办法能接住的方式回你。

用池塘来比，鱼和浪都是实在的。可极小的东西像是这样：在你没下网也没拍水之前，你没有资格说「鱼在那里、浪也在那里」。这个比方到这里就该放下了，再往下走它会骗人。

海森堡有一句话，大意是：我们观察到的不是自然本身，而是被我们的提问方式暴露出来的自然（《物理学与哲学》）。这话后来被引得太多，也被用歪得太多，下面几节会一再回到它。

◆ 四、玻尔：「现象」要把装置算进去

在这场争论里，最早把话说得认真的人，是玻尔。

他的想法，很容易说歪，所以要说慢一点。

玻尔不是说「观察者的意识改变了粒子」。他的意思要朴素得多：当你说「观察到了什么」的时候，那个「什么」，必须连同你怎么观察一起说。

他用「现象」这个词，专指在一套指明了的实验安排下得到的观察结果，连这套安排的整体交代都算在里面（玻尔，1949 年纪念爱因斯坦的文章）。

你可以这样想。有人问你：这个房间里有多亮？你说，我拿了照度计，放在窗边，读数是这个。这句话里，「照度计」「窗边」都是答案的一部分。你不能把它们抹掉，只留一个「亮度」，拿去和别人在柜子里测的亮度直接相比。

玻尔做了一件今天读来仍然很有分量的事：他不允许把「被测的东西」和「测它的装置」当成两件事，分开算账。

这是对发现学的第一道裂缝。因为发现学的整套想法，正是靠这两件事分开才站得住：东西在这边，工具在那边，工具把东西照亮。

可是请你注意玻尔没有做什么。

他把装置请进了「现象」，却没有说装置从哪里来。装置是人搭的。搭它的人，选了问位置还是问速度，选了开哪一扇窗。这个「选」，在他的讲法里，是站在现象外面的：实验者决定怎样问，自然给出相应的答。

举个医院里的例子，请你照玻尔的口气听。

一位病人说：「我的胃总是胀。」医生要是只写「胃胀」两个字，这条记录是不完整的。是在什么时候说的？是坐在候诊椅上说的，还是躺在检查床上说的？是

被问「哪里不舒服」说出来的，还是被问「吃饭后怎样」说出来的？问法不同，说出来的「胃胀」就不是同一个东西。

好医生其实都知道这一点，所以病历里才有「主诉」「现病史」「查体」这些栏目。栏目就是问法的记录。

玻尔那句话搬到这里，就是：别把「胃胀」当成一个脱离了问法的东西来传。传出去的，要连问法一起传。

所以在玻尔那里，有两样东西留在了现象的外面：一个是用来划线的人，一个是线划出来之后才有的世界。线内线外的分工很清楚。

玻尔自己很清楚这一点，也常常小心地说：这不等于说主观随意。选什么装置是实验者的事，装置选定之后，出什么结果，不由人说了算。

这个小心，本书要先记下，也要先敬一下。他守住了一件事：不是人想怎样就怎样。要是没有这份小心，后来的人很容易滑到「想什么就是什么」那边去。

可他留下的那一处，是个口子。口子里站着的，是一位划线的人。

◆ 五、巴拉德：关系不在关系项之前，可是「切」谁来切

玻尔留下的口子，后来有人认真去补。补得最用力的一位，是物理学家兼哲学家凯伦·巴拉德。

她 2007 年的书《与宇宙中途相遇》，是这条路上最系统的一本。书里有两个词，对本书很要紧。

第一个词，叫 intra-action，常译作「内部作用」或「内行动」。

它想说的，是这样一件事。平常我们说「互动」，总默认有两个东西先在那里，然后它们碰在一起：病人，医生；被测的东西，测量的装置。先有两个，后有碰撞。

巴拉德说，不对。那两个东西本来就是在这场碰撞里才分得出来的。先没有「谁和谁」，碰撞这件事在先，「谁」和「谁」是它切出来的（大意，见该书导论）。

她举的实验，都是玻尔当年争论里的老实验，比如让一个小东西穿过带缝的挡板，看它在后面的屏上留下什么。她把这些实验重新读了一遍。读出来的意思是：

挡板上的缝开着还是关着，屏固定还是能晃，这些安排不只是「条件」。它们是「谁是被测的、谁是测的」这件事得以分出来的那一部分。

换成医院的话：诊室的格局、挂的是哪个科、病历的栏目怎么设，不只是背景，它们是「谁是病人、谁是医生、什么是病」得以分出来的那一部分。

读到这里，你可以停一下。这句话，和本书第 1 章、第 2 章说的话，几乎是同一个方向：病人不是带着病来的，医生不是先在的发现者。

所以本书对她的态度，先是佩服。她把「关系项不先于关系」讲得比谁都彻底，而且是从实验台上讲出来的，不是从书斋里想出来的。本书的第一编，欠她一份情。

可是她的书里还有第二个词。

那个词叫 agential　cut，常译作「施动切口」或「能动的切」。意思是：在这场内部作用里，总要有一刀切下去，把「被测的」和「测的」分开，把「对象」和「装置」分开。没有这一刀，就没有谁是谁。

她很小心地说：这一刀，不是人手里拿着刀切的。切口是整个物质安排切出来的，是装置、实践、话语一起做成的，不是一个人的主观选择。她还特意说，切口是在现象内部被做出来的，不是从外面落下来的。

这话要认真对待。她没有把人请回台前当主角。她说的「施动」，不是「人在施动」。

可是本书读到这里，还是要多问一句。

「切」这个字，要有「切的」。「施动」这个词，要有「施的」。

她把「施的」放在了整个物质安排上，不放在人身上。这比放在人身上，已经进了一大步。可是整个安排，仍旧是一个「切的」。切口的前面，还是留了一个动作的发动处：一刀下去，两边分开。

王德生博士的看法是：这里，她和玻尔站在同一个地方。

玻尔的口子里站着一个人。她把人请走了，口子里换上了整个装置。口子还在，站在口子里的位置也还在。变的，是站的是谁。

这个判断，请你先放在手边，不急着信。下一节，我们看另一条路上的同一件事。

◆ 六、建构主义：把发现者从幕后请到台前

另一条路，不从实验台来，从人群里来。

二十世纪的社会学和科学研究里，有一个很大的潮流，常叫「建构主义」。它的意思是：很多我们当成「本来就在那里」的东西，其实是人们在一起做出来的。

伯格和卢克曼 1966 年有一本书，叫《现实的社会建构》，是这个潮流里被引得最多的一本。波兰的医生弗莱克，更早，在 1935 年的一本书里，用梅毒的瓦瑟曼试验讲了同一个意思：一个所谓的「科学事实」，是一个思想共同体在一段时间里，一点一点做出来的。拉图尔和伍尔加 1979 年写实验室里的日子，也是这个路数。

放到医学里，这个潮流看见了很多真东西。

一种病，在这个年代被当成病，在那个年代不被当成。有的病名，是一群人开了几次会、投了票之后才有的。有的诊断标准，一改，一大批人从「没病」变成「有病」，或者反过来。你不必争论这些人对不对，只要看见：病名不是天上掉下来的，是人们一起做出来的。

这是一个了不起的看见。它把「医生只是玻璃」这个想法，狠狠地敲了一下。

它说：医生不是玻璃。医生、医院、医保、药厂、病人组织，都在参与「什么叫病」这件事的制作。

本书的第 6 章、第 8 章，会大量借用这条路上的看见。这里要先说清：本书不是反对它。它对在哪里，本书认。

那么，它停在哪里？

请你看一下它的句子。几乎每一句，都有一个主语：「人们建构了」「社会建构了」「共同体建构了」「医学界建构了」。

主语换了，句式没换。

以前是：医生发现了病。现在是：医学界建构了病。

「发现」换成了「建构」，「医生」换成了「共同体」。可是句子的骨头，还是一个先在的东西，对着一个有待加工的东西，做了一个动作。

王德生博士的说法是：**建构主义，只是把发现者，从幕后请到了台前。**

以前，发现者躲在玻璃后面，装作不在场。现在，他走出来，承认自己动了手。这是诚实多了。可是他仍旧是那个动手的人，位置没变：他在前，事在后；他动手，事被做出来。

所以这是发现学内部的一次改良，不是换了一条路。

还有一个更近的例子。哲学家哈金（1990 年代）讲过一种现象，常叫「循环效应」：一类人被贴上了一个名字，这些人知道了自己被这样叫，行为就跟着变。行为一变，这个名字所指的那类人也就变了，名字再跟着改。

放到医学里，这个说法很贴切。一个人被诊断为某种病，他读到了关于这种病的介绍，开始按介绍里的样子理解自己，他的症状、他的日子，慢慢也真的向那个样子靠。

这是个深刻的看见。它让「被看的东西」有了回应，不再是一块沉默的石头。

可是请你再看一次句子：「人被贴了名字，人的行为变了。」人还是人，名字还是名字，一个在前，一个来贴。循环是有了，起点还是一个先在的人。

你不妨这样试一下。问一句建构主义：那个「共同体」是哪里来的？它是怎么成为共同体的？谁来做这个「建构」的动作的人？

它的回答，往往是：共同体是由更小的人群建构的，更小的人群由个人的互动建构的。往下问，永远有一个先在的「建构者」，只是越拆越细。

这和玻尔、巴拉德碰到的，是同一个口子。从实验台走到人群，口子里站着的东西换了名字：叫实验者，叫装置，叫共同体。站在口子里的位置，一直是那个位置。

◆ 七、退相干的教训：不需要意识

到这里，有的读者可能已经在想另一条路：既然观察者参与了结果，那是不是观察者的「心」起了作用？

这条路，要在这里堵上。

量子力学的历史上，的确有过这样的读法。早期有人认为，要把测量的链条追到头，最后总要落在一个有意识的观察者身上，由他的意识让结果落定。维格纳那个著名的「朋友」的思想实验，就是沿着这条路想出来的。

这个读法，后来被一件事狠狠地敲了。这件事叫退相干。

名字难听，意思不难。

想象一杯静水，水面上有两圈涟漪，互相叠着，形成好看的花纹。花纹要保持清晰，水面得非常安静。你往水里扔一把沙子，或者来一阵风，花纹就乱了，两圈涟漪各走各的，再也叠不出那个纹。

极小的东西也是这样。它们那种「两样都有」的特别样子，要靠一个非常安静的环境才保得住。环境里一有碰撞，空气分子、光、热，这个样子就迅速地散掉，变成我们平时看到的那种「是这个就是这个」的世界。泽赫在 1970 年前后最早讲清楚这条路，祖瑞克后来把它讲得更透。

这件事的要害，在于：让「两样都有」变成「只剩一样」的，是环境的碰撞，不需要一个有意识的人在旁边看。

一只猫，一块石头，一间空无一人的实验室，只要环境在碰，样子就散了。没有人醒着，也一样。

所以，把「观察」读成「意识」，在物理的账本上是站不住的。

还有一层，也要说在前面。

有的读者会想：既然「环境的碰撞」就够了，那医院里的「碰撞」，不就是医生的目光、病人的情绪？这样把物理的碰撞，直接搬成人心的碰撞，是又走回了老路。

物理里的环境碰撞，是空气分子、光、热。医院里的「碰」，是挂号、排队、问话、检查、开单、等结果，是一件一件具体的事。本书借退相干，只借一个形状：让一个状态定下来，靠的是一整片环境的相互留痕，不靠某个单独的看者。其余的，本书一概不借。

接下来，请你把这一点牢牢记住，因为它直接管着本书的写法：

本书绝不写「意念影响病情」。

不写「心里想好，身体就好」。不写「相信就会痊愈」。不写「观察者的意识改变了病人的细胞」。这些话，从量子力学借不来，从退相干那里还会被一枪打回去。

也要补一句公道话：退相干并没有解决量子力学的全部问题。「为什么最后落在这一个结果，而不是那一个」，仍有人在争（这是一个至今没有公认答案的问题）。本书不拿它当证明，只拿它当一个提醒：把「观察」读成「有心的人在看」，读窄了。

那观察该读成什么？读成一场碰撞，一场互相留下痕迹的碰撞。碰撞里，谁是被看的，谁是看的，是碰过之后才分出来的，不是碰之前就坐好的。

这话，听起来正是巴拉德的话。是的，本书和她走到了同一个路口。只不过，在路口，本书要多迈一步。

◆ 八、本书的说法：连观察者一起拆掉

多迈的这一步，是什么？

先把前面几家，用一张小小的清单摆开。

玻尔：现象要把装置算进去。留下的：划线的人。

巴拉德：关系先于关系项。留下的：切口，和切的动作。

建构主义：事是人做出来的。留下的：做的人，和做的共同体。

退相干：不需要意识。留下的：环境这个「碰的一方」。

你看，一家一个留下的，可是留下的东西有一个共同的形状：在状态之前，有一个动手的位置。

这个位置，可以由人来坐，由装置来坐，由共同体来坐，由环境来坐。坐的是谁，各家吵得很凶。可「有一个位置先坐在那里」，各家都没动。

本书要做的，就是把这个位置也拆开。

怎么拆？本书用的办法，是回到一件小事上：拉大锯。

两个人拉一把锯。锯口，是哪一头锯出来的？

不是这一头，也不是那一头。这一头往回拉的那一下，是在那一头往前推的那一下里才成立的。锯条在木头里咬出来的那道口，是两头合着发生的。

要是问：是谁在锯？你只能说，是这两个人，和这把锯，和这块木头，在一起锯。要是问：是谁决定了锯口的位置？你会发现，这一句问话本身，就已经把一个「决定者」塞进来了。

医患之间也是这样。挂号单一出，「病人」「医生」「科室」「病名」开始一起显出来。诊室里那场谈话，把一个人变成了病人，把另一个人变成了医生，把一种苦变成了一个名字。这三样不是谁先谁后，是同一场发生里的三个沉淀。

所以，本书对「观察者」的态度是这样的：

观察者不先于观察，被观察的状态也不先于观察；两样都是同一场发生沉下来的东西。

这一句，请你多读两遍。它不是说「没有医生」。医生当然在，血压计当然在，白大褂当然在。它说的是：医生位上的那个人，之所以成为「观察者」，是这场发生的结果，不是它的原因。

也就是说，本书连观察者一起拆掉。拆掉的不是人，拆掉的是「先于互动、发动一切的观察者」这个想法。

王德生博士把这一步放进了一个更大的图里：从量子力学开始，观察者参与状态的发生，这是一个大的看见；可是只要把观察者当成发动者，它就仍是发现学，因为那个位置，被默认成先在的。要走出来，得问：这个位置，是怎么被坐出来的？

这是一个「发生」的问法，不是一个「发现」的问法。它问的是路，是土，不是问谁站在哪。

还有一个问题，本书自己先问了：你说「沉淀」「复合体」，这个讲法，难道不是又一个观察者站在高处，对医患说三道四吗？

问得好。本书的回答是：是的，本书也是一场发生。读它的你，写它的人，王德生博士提出的这个看法，都在一场更大的发生里。本书没有把自己放在外面。

这并不让这个讲法变得无效。就像锯子拉锯，锯子自己也在被拉。一个讲法，只要它能让你在下一次面对血压计、病历、诊断书的时候，多看见一点东西，它就在起作用。它能不能被改、被推翻，在本书附录的「本书自认最弱处与推翻条件」里有写。

到这里，你可能会问：既然观察者不先在，那「谁来负责」？「谁来量」？

放心，这些问题，本书后面一章一章回答。先留一句在这里：负责、追责，都是复合体里的事，不是复合体外面的事。不先在，不等于不在。

◆ 九、只看一端会怎样

这一节，把几种只看一端的结果，摆在桌上。

只看「病在那里」这一端。

医生是玻璃，数字是真相。好处是干脆，可以查，可以对账。坏处是，一遇到白大褂效应、一遇到换医院换结论，就只能说「干扰」「误差」「依从性差」。读数里有一大片东西，被扫到了地毯底下。

这一端的人，常常对病人说：「你别紧张，放松点，量出来才准。」这句话自己就露了馅：它要病人自己把自己变成一块玻璃。

只看「是人做出来的」这一端。

病名是社会建构的，诊断是权力的游戏，疼是文化的产物。这样说，有一部分是真的，可说到头，会让人觉得：那块阴影是假的，疼也是假的。这是不能接受的。一个人胸口压着一块石头似的疼，你告诉他「这是建构出来的」，他听了，除了更孤单，什么也得不到。

这一端的毛病，是只剩下了做的人。做出来的东西，没有它自己的重量，没有它自己不服人摆布的那一面。

只看「心的作用」这一端。

这是最危险的一端。「心态好，病就好」，听上去温暖，实际是一把刀。一个人重病，要是别人对他说「是你的心念不够」，等于把病的责任，整个推到了病人头上。

本书前面已经说过，退相干把这条路堵死了，医学上这条路也没有扎实的证据。这里再加一句：它还会伤人。

三个端点，各自守着一块真地，也各自丢了一块真地。

它们有一个共同点：每一个都需要一个单独的承载者。第一个把承载者放在「病」，第二个放在「人」，第三个放在「心」。

本书的办法，是把承载者换位。换到哪里？换到「复合体」。这是下一章的事。

也许你会担心：这样说下去，会不会变成「怎么都行」？读数都是真的，每个复合体里的读数都对，那医生还要不要判断？病人还要不要治？

要。而且要得更认真。

因为「每个读数都是真的」，不等于「每个读数一样有用」。一个读数，是在什么复合体里显出来的，它能管多远，能不能被另一个复合体接住，这些都要问，都要查，都要比。比的时候，仍然有对有错：一次没按规矩坐好就量出来的数，和一次按规矩量出来的数，不是一回事。

不同的是，错的意思变了。错不再是「它偏离了那个唯一的真数」，错是「它没有在需要它的那个复合体里站住」。前者要找一个看不见的标准来量，后者可以直接在日子里验：照这个数做了，接下来的路通不通。

今天与机器。

这个问题，在今天有了一个新的现场。

一台读片的人工智能，在大量片子上练过，看一张新片子，给出「疑似结节，概率多少」。很多人说：这下好了，机器没有情绪，没有白大褂效应，是真正的玻璃。

真的吗？

机器看的片子，是别人拍的，拍的时候有设备、有参数、有医生的摆位；机器的「标准答案」，是别的医生标出来的；它给出的概率，会被放进一份报告，被另一位医生读到，再被一位病人听到。

玻璃没有变得更干净，玻璃只是变得更长了：从一个人，变成了一整条看不见的人群队伍。

有一个小地方值得留意。很多人愿意相信机器的读数，是因为机器「不知道」病人是谁、医生是谁，看起来没有偏心。可是它不知道的那些，恰好也是读数得以成形的土。一位读片医生看到「他是个抽了三十年烟的老人」，和只看到一张灰白的图，读出来的东西不会一样。哪一种更好，看用在哪里。哪一种都不是「没有观察者」。

所以，机器没有让观察者消失。它让观察者换了一副更难找到的样子。这一点，在第 16 章会专门讲。

◆ 十、一个完整的例子：周老师的两本账

回到周老师的血压。

先看发现学的版本：周老师有一个「真正的血压」，是一个数。家里量的是接近它的，诊室量的是被紧张抬高的。医生的任务，是把干扰去掉，取到那个数。

再看建构主义的版本：「高血压」的标准，是一群专家定下的线。线往下挪一点，周老师就从「正常偏高」变成「高血压」。诊室里的那个数字，是在权力、规范、医患关系里做出来的。

两个版本里，都藏着同一个动作：有一个人，站在这件事的外面，要么在看，要么在做。

现在看本书的版本。

周老师家里量的那个数，是一场发生：一位六十二岁的退休语文老师，坐在自家的藤椅上，袖带是女儿买的，本子是他自己记的，量完要给女儿看。这场发生里，他是一个「在家里被关心着的人」。数字在这样的复合体里显出来。

诊室里量的那个数，是另一场发生：同一条胳膊，一间小小的诊室，一位穿白大褂的护士，后面排着队的病人，一个被叫到名字的人。这场发生里，他是「病人」。数字在这样的复合体里显出来。

两个数，不是一个真、一个假。它们是同一个人，在两个不同复合体里显影的两个读数。

那么哪一个有用？

这是个好问题。有用，要看你拿它做什么。要预测他一天里大部分时间的血压，家里的数更有参考价值；要看他被紧张地推一把时身体会怎样反应，诊室的数也有话要说。医学上后来有「动态血压」「家庭血压」之类的做法，也正是在承认：一个数不够，要看不同场合里的一串数。

不要小看这个「一串数」。它已经悄悄地从「找那一个真数」，转到了「看这个人在不同的复合体里，状态怎样显出来、怎样变」。

也许你会问：那医生在这里算什么？

医生位上的人，当然做了事：他叮嘱了一句「再坐五分钟」，他选了左臂还是右臂，他写下了一个数。这些都是动作，真实的动作。本书不把它们抹掉。

本书只是不把这些动作，当成「观察者对着一个现成的血压，做了一次读取」。它们是在这场复合体里，一次次发生的事。动作和读数一起沉下来，沉成病历上的一行字。这行字，下一次又成了新的一场发生的土。

下一步，本书还要再走一小步。

周岚把家里的小本子带到诊室，一页一页翻给护士看。这时候，诊室里的复合体变了：它不再只是「护士和病人」，它里面多了一本记录，多了一位熟悉他日子的家属，多了一个愿意解释的人。袖带再绑上，读数也许还高，也许不那么高。无论哪样，这一次的数，已经是另一场发生里的数了。

你看，没有人是玻璃。没有哪一个数「穿过」所有的复合体，原样到达医生的眼睛。可是，也没有哪一个数是假的。每个数，都是真实地被做出来的，在真实的复合体里。

再看一个场景，位置换一换。

周岚在自己的诊室里，是医生。她给别人量血压，说「放松，别说话」，语气稳稳的。可是前年父亲住院那几天，她站在病床边，护士给父亲量血压，她盯着那个屏幕，手心出汗，嘴里一遍一遍问：「怎么样？」

同一个周岚，在这两场里，是两个人吗？不是。可她显出来的样子，不同。她是「医生位」，还是「家属位」，不是她随身带着的身份，是这场复合体把她放在了哪里。

这一点，是第 1 章、第 2 章已经讲过的，在这里再一次落地：位子会换。「观察者」这个位子，也一样会换，也一样是被一场场发生坐出来的。

不是量错了，是复合体不同。

这一句，是本章最实用的一句话。读到它，你再碰上「换个医院结论不同」「家里和诊室不一样」「今天好明天差」，不必急着找谁错了。先问一句：这两个读数，是在什么样的复合体里显出来的？

这样问，既不放过该查的问题，也不会把人推进「谁都不可信」的沟里。

还有一件事值得说在这里。周岚当年学的是「怎样把病人身上的信息，干净地取出来」。她后来在门诊里，慢慢学会的，是另一件事：怎样让病人愿意把话说出来。

两件事，很难说哪一件更「医学」。前一件靠的是方法，后一件靠的是关系。可是门诊里的读数，常常是后一件决定了前一件能取到多少。

这也是本章的一个实际结论：取读数的功夫，有一半是造复合体的功夫。

◆ 十一、放回日子里

那天晚上，周岚陪父亲回家。路上，周老师又问了一遍：「那你说，我真正的血压是多少？」

周岚想了想，没有给他一个数。

她说：「爸，你在家的数是你在家的数，在医院的数是你在医院的数。我们都记着。下回复诊，我把你的本子带上，再约个时间，你自己挑个不赶的时候去量。」

周老师哼了一声，说：「你这个当医生的，倒不肯给个准话。」

周岚笑了：「准话是有的。准话是，我们把这两本账放在一起看。」

晚饭后，周老师照例坐到藤椅上，量了一次，写在红皮本子上。这一次，他在数字旁边多写了一行小字：今天去了医院，回来量的。

一个小办法，明天就能试：在下一次量血压（或任何一项你常测的指标）的时候，在数字旁边加一行：在哪儿、谁在旁边、之前做了什么。不要为了凑一个「好看的数」去装平静，只是把场景记下来。过一阵子再翻，你会发现，那些数字不再是一堆互相打架的东西，而是一张你自己的地图。

这个办法不是诊疗建议，只是一种记录的习惯。身体或心里的难处真的大了，请找医生或心理咨询师。

再说一个很小的场景。豆豆七岁，常咳嗽。在家里，妈妈周岚听他咳，说「这是夜里着了凉」；在儿科门诊，医生听他咳，听出了另一个词。外婆在旁边说：「他上课的时候从来不咳。」三个人，三个听法，三个判断。

这个时候，要是有人说「到底谁听对了」，就又回到了老路上。本书的做法，是请这几个听法坐到一张桌子上，各自说清自己是在什么情形里听到的：夜里，门诊，课堂。咳嗽的样子，是在这几个地方一起显出来的，要把它们拼在一起，才是豆豆的咳嗽。

带 走 的 话

不是量错了，也不是谁在骗人；同一个人在不同的复合体里，显出的是不同的读数。

小　账

这一处，开门还是关门：这一章，对「观察者」这个老位置关了一扇门（先在的看者），对读数的多样开了一扇门（不同复合体里的不同显影）。

病放在一个人身上，还是放回复合体里？量的人、被量的人、读数，三样都放回了同一场发生里；既没有怪病人紧张，也没有怪医生不准。

想 一 想

你最近一次拿到两个互相不一致的结果（两家医院、两次体检，或者家里与医院），当时你心里先冒出来的，是「哪个对」还是「它们是在什么情形下量的」？
你有没有在某个地方，当了一回「玻璃」，比如被要求「放松点，别紧张，这样才准」？那一刻，你和对方之间发生着什么？

◆

04

第 4 章

承载者换位：复合体

◆ 一、你一定有过这样的时刻

医生给周老师换了一种降压药。诊室里的话很短：「按时吃，过两周来复查。」

回到家，周老师照例把药盒里的说明书抽出来，戴上老花镜，从头读到尾。他是教语文的，读东西有个习惯，一个字也不肯漏。

说明书的最后一部分，是一长串「不良反应」：头晕、乏力、心慌、恶心。他一行一行读下去，读得很慢。

当天晚上，他觉得有点晕。

第二天早上，更晕了。他对女儿说：「是不是这药不合适？」

周岚回来，先给他量了血压，数字很平稳。她又问了几句，最后拉着父亲在藤椅上坐下，说：「爸，你读说明书，读了多久？」

「大半个钟头。」

「读完以后呢？」

「就觉得……哪儿都有点不对。」

你有没有过这样的时候？读了一篇讲某种病的文章，当晚就觉得自己身上有那个毛病。看了一份体检里的「提示」，之后一个星期，总想去摸摸那个地方。

你也可能有过相反的时候。去看一位你信得过的大夫，还没开药，坐到他对面，聊了几句，心里就松了一半，身上的难受好像也退了一截。

这两种经验，你大概都不陌生。不过想一想，你平时是怎么给它们归类的？

多半是这样：第一种，叫「想多了」；第二种，叫「心理作用」。好像身体的事才是正经事，这些，是正经事旁边冒出来的杂音。

这一章要做的，是请你把这两个「杂音」，从旁边请到正中间来。

◆ 二、老看法：这是要扣掉的干扰

先把老看法说足。它在这件事上，做了一件很漂亮的工作。

现代医学判断一种药有没有用，有个最硬的办法：把病人分成两组。一组吃真药，一组吃外观一样、里面没有药效成分的东西，也就是安慰剂。两组都不知道自己吃的是哪一种，发药的、记录的人也不知道。过一段时间，比一比。

两组的差，才是药自己的功劳。

有一个小故事，常被拿来说这个办法的来历：很久以前，医生们发现，很多「灵验的」疗法，换一批人试，就不灵了。后来才明白，不少「灵验」，是因为试的人和被试的人都盼着它灵。于是有了分组，有了盲法，有了对照。这个故事的细节，各书说法不一，本书不引，可它的大意，医学界是认的：要防的，是人的盼望悄悄改了读数。

这个办法，是医学从「听老师傅讲」走向「拿证据说话」的一大步。它挡住了多少似是而非的疗法，救下了多少本来要被耽误的人，没法算。

在这个办法里，安慰剂是什么？是要被减掉的东西。

吃了安慰剂的人，也有人好转了；也有人觉得头晕、恶心，甚至报告了「副作用」。这些统统要算进「背景噪声」里，从药的功劳里扣掉。

这个想法是对的，而且是必须的。没有这一步，我们根本没办法知道一种药到底在做什么。

本书先认下这一点：为了回答「这粒药本身起不起作用」这个问题，把安慰剂当成要扣除的东西，是一个好办法。

可是你看，这个办法背后，有一幅图：

病人是一个装着病的容器。药是往容器里倒的东西。药的作用，是容器里的病发生的变化。至于病人的期待、医生的口气、药丸的颜色、诊室的灯光，这些是容器外面飘来的风，会吹乱读数，要想办法挡住。

这幅图里，承载者是「病人」。病在他身上，药在他身上起作用，状态是他的状态。

不过，「干扰」是个相对的词。它总是相对于某一个问题说的。

你问「这粒药本身有没有用」，安慰剂的那一份是干扰。你要是问「一个人吃药之后好起来，是怎么发生的」，安慰剂的那一份就是答案的一半。同一份东西，问题一换，从噪声变成了信号。

所以老看法没有错，它只是回答了一个问题。本书要问的是另一个问题。

别的东西，都是外因，都是干扰。

这幅图在很多场合管用。可是一个人被一粒糖片说好了，又被一张说明书说坏了，这幅图就开始吃力：那些被叫作「干扰」的东西，好像一直在做大事。

◆ 三、本书的说法：状态属于复合体

先说「承载者」这个词。它的意思很家常：一个状态，算在谁的名下。

今天很冷。这个「冷」，算在谁的名下？算在空气的名下，温度计会同意。算在你的名下，你缩着脖子，也有理。可是一位刚从北方来的朋友，和一个在这里住了一辈子的老人，对同一个「冷」说的话并不一样。冷，是空气、身体、衣服、习惯、这一天要去的地方，合在一起显出来的。

一般人不会为「冷是谁的」吵架，因为用不着。可是「病是谁的」，吵得很凶，因为这里有钱，有责任，有面子，有命。

本书的做法，是把承载者换个位置。

不是病人带着一种状态，来到医生面前。也不是医生看了病人之后，写下一种状态。**状态属于「医生—病人」这个生命互动的复合体**。

怎么理解？再借一次拉大锯。

两个人拉一把锯，锯口在木头上咬出一道缝。你问：这道缝，是谁的？

不是这一头的人的，也不是那一头的人的，是这两个人加这把锯加这块木头，一起拉出来的。你要是把一头的人换掉，锯口的深浅、走向、毛糙，就会跟着改。你要是一头松了劲，锯就卡住，卡的不是哪个人，是这一场「拉」。

状态也是这样。

周老师头晕，这一回的晕，是在一个很具体的场合里出现的。

场合里有：一位刚被告知要换药的老人；一张列着二十来种可能的不适的说明书；一句「按时吃，过两周来复查」的短话；一个没来得及问的问题；一个有医生身份的女儿；一把藤椅，和一个晚上。

这些东西合在一起，晕出现了。

把这个晕说成「周老师想多了」，是把整个复合体的状态，推到了他一个人身上。把它说成「药的副作用」，是把整个状态，推到了药身上。把它说成「医生交代不够」，是推到了医生身上。

三种说法，各有一点对。不过它们都在做同一件事：在一个复合体里，找一个单独的承载者。

本书要换的，正是这个动作。换成：承载者就是复合体。其余的，都是这个复合体里显影出来的东西。病人位、医生位、药、说明书、病名，都是显影的结果。

还要防一个误会：复合体不是在医生和病人之外，再多出来的第三个人。

它没有头脑，没有意志，不会「决定」什么。它也不是一个比两个人都更大的、更高的东西。它只是一个提醒：当我们说「状态」的时候，别急着给它找一个单独的主人，先看这一场合着发生的事。

注意这不是说话的花样。它会改变你问问题的方式。

旧的问法是：是谁的问题？是药的，还是人的？

新的问法是：这个复合体，现在处在什么状态？它是怎么走到这一步的？哪一处可以松，哪一处可以接？

这和挂号单是同一回事。第一次把挂号单递进窗口的那一刻，「病人」「医生」「科室」「病名」一起开始显出来；此后每一次见面、每一张单子、每一句交

代，都是这个复合体继续发生的一步。状态不是在某一刻被「测到」的，是一步一步走成的。

问法一换，整个医学里被叫作「干扰项」的那一大片，就换了位置。它们不再是旁边的杂音，它们是正文。

◆ 四、安慰剂：不是假的，是复合体在做事

先说安慰剂。

要把它说准，得先清掉两个误会。

第一个误会：安慰剂等于「骗人」，等于「假的」。不是。

吃了安慰剂的人好转，不是他在撒谎，也不是他在假装。他是真的觉得疼轻了，真的觉得恶心退了，有些时候，连可以量出来的指标也有小小的变化，不过这一点争论不小，下面会说。

不过，也要如实说一句：关于安慰剂到底能改变多少，学界一直有争论。早年比彻在 1955 年有一篇很有名的文章，题目就叫《强大的安慰剂》，后来有人把大量研究重新汇总，认为对可以客观测量的结果，影响远没有当初说的那么大；而对疼痛、恶心、疲倦这类主要靠自己感受和报告的东西，影响则比较常见。

本书不打算在这场争论里站队，也不需要。本书只取其中没人否认的那一点：同一粒什么药效也没有的东西，放在不同的场合里给，结果会不一样。

第二个误会：安慰剂等于「心理作用」，等于「意念的力量」。也不是。

前面第 3 章已经把话说在前头了：本书不写「意念影响病情」。安慰剂的效果，不能解释成「病人用意志力把自己治好了」。要是这么解释，等于说没好起来的人，是意志力不够。这不但没有证据，还伤人。

那它是什么？

本书的读法是：它是复合体里发生的一整套事，药丸只是其中最小的一件。

一颗白色的小药片，由一位穿白大褂的人递过来，嘴里说着「这个对你有帮助」。递药的人看你的眼神，诊室里的安静，之前排队等的那一个钟头，你对这家

医院的信任，家里人在门口等着的样子。吃完药后，你被叮嘱「过两天回来看看」。这一整套，是一个仪式，也是一场关系。

这套东西里，每一样都在改变这个复合体的状态。有的让紧绷松下来，有的让注意力转开，有的让接下来的几天有了盼头，有的据说还牵动身体里的一些调节，具体怎样，仍在研究中。

这套东西，细到什么程度，看几个有趣的研究就知道了：同一种没有药效的药片，装在大的、小的、红的、白的瓶子里，效果好像不同；打针的比吃药片的，好像更明显；标着贵价的比标着便宜的，好像更有效（这些结论多来自小规模研究，可靠程度有争议，本书只取其意，不引数字）。

这些发现，哪一条都不能当成定论。可是合起来看，它们指向同一个形状：复合体里的任何一处细节，都在参与状态的发生。包括药丸的大小和价钱。

所以，安慰剂没有「骗」谁。它是把药丸的药效拿掉之后，剩下的那部分复合体，照常在做事。

有一些研究者做过一个更耐人寻味的实验：明明白白告诉病人，这是安慰剂，里面没有药，但是据说对一些人有帮助，请按时吃。结果有人仍然觉得好转了，卡普丘克等人 2010 年在肠易激综合征病人身上做过这样的尝试，人数不多。

这个结果本身还要更多研究来检验。它至少让人想一想：如果「相信那是真药」不是必需的，那起作用的，就不是「骗」。起作用的，是那一整套关系和仪式本身。

那么，在旧框架里被叫作「干扰项」的这一整套，在本书里叫什么？叫复合体的状态发生本身。

◆ 五、反安慰剂：同一套东西，朝另一个方向

安慰剂有一个孪生的兄弟，叫反安慰剂，拉丁文里是「我将伤害」的意思。这个词在 1961 年前后，由一位叫肯尼迪的研究者提出来，用来指：一件本身没有害处的东西，由于场合、话语、期待，让人觉得难受。

周老师读完说明书之后的头晕，很像它。

在药物试验里，吃安慰剂的那一组，也常常有人记下了头痛、恶心、乏力这些「不良反应」（具体比例，本书不引）。这些人吃的是什么药效都没有的东西，他们的不适是不是假的？不是。头痛是真的头痛，恶心是真的恶心。

它怎么来的？还是回到那一整套。

一位医生要是在开药的时候，说得很重：「这个药副作用不小，你要留意。」这句话，是复合体里的一件事。一份说明书上，把不适按照从常见到罕见排成一长串，这也是一件事。一个人从小就听过「是药三分毒」，这又是一件事。这些事叠在一起，身体朝哪个方向调，就有了倾向。

话怎么说，也算一处细节。有一类研究，让不同的人听到同一件事的两种说法：「这种手术，一百个人里有九十个人恢复得很好」，或者「这种手术，一百个人里有十个人恢复得不好」。数字完全等价，听的人的反应往往不同（这是行为经济学里关于「框架」的一般发现，本书不引具体研究）。

医生开口的那一句，已经是在造那个复合体了。

这里有一个要紧的地方：反安慰剂不是病人的错。

病人不是「太敏感」，不是「爱想」，不是「心理有问题」。他是在一个复合体里，得到了一种状态。这个复合体里，医生那一句话、那一张纸、那一个没人回答的疑问，也是它的组成。

这一点，对医生一端有很实际的意思。药物的风险要如实告知，这是底线，不能因为怕病人「想多了」就不说。可是怎么说，什么时候说，说了之后留不留一个可以问的出口，都是在造那个复合体。

如实，不等于一股脑倒出去。如实的意思，是让病人在知道的同时，也知道「出现了我找谁」「哪些是常见的、哪些要马上来」。这样的告知，是把风险放进一条路里，让它有处可去。

这里没有一个万能的说法。有的病人要听全，有的病人听一半就慌。好医生靠的不是一套台词，是在这个具体的人面前，边说边看：他的肩是松了，还是更紧了。看，也是复合体里的一件事。

对病人一端，也有一条：读说明书不是错事，它是你的权利。可是读完之后头晕，不要急着断定「这药不合适」，也不要急着断定「是我想多了」。先把这个

晕，原样告诉开药的医生或药师。是药，还是别的，由他们和你一起看。这里没有替谁决定停药或改药的意思，那是要和医生一起看的事。

◆ 六、医源性疾病：医学自己造成的病

再说一个旧框架里最难摆的东西：医源性疾病。

「医源性」三个字的意思很直白：病的来源，是医疗本身。一次手术之后的感染，一种药引起的肝肾负担，一次检查带来的并发症，一句话说得不当、让一个人此后几年活在担心里。

这一类事，医学里一直有记录，也有专门的人在想办法减少它们。伊里奇在1975年有一本批评现代医疗的书，把这类现象推到了一个很尖锐的位置。他说得是否过头，各人看法不同。可是他把这件事拎到桌面上，这一点是有贡献的。

在旧框架里，医源性疾病是什么？

是不良事件。是「本来不该发生的偏差」。它是整个叙事里的一个意外，要登记、要上报、要改进，但在讲「病是什么」的时候，它不是正文，它是脚注。

为什么只能是脚注？因为旧框架里，病是病人身上先在的东西，医疗是去处理它的。如果医疗自己制造了病，这就不应该，是一个错误。

医学史上有一个常被提起的老故事。十九世纪四十年代，维也纳一家医院的产科，有两个病房，产妇的死亡率相差很大。医生塞麦尔维斯留意到，凡是医生和学生刚从解剖室出来、直接去接生的那个病房，死得多。他让大家在接生前用药水洗手，死亡率明显降了下来（具体数字，本书不引）。

当时，很多同行没有接受。因为这个说法等于在说：病是医生的手带去的。

这个故事里有两层意思。第一层，很明显：医生的手，是复合体的一部分，而且是会带来病的一部分。第二层，很少有人注意：那些不肯接受的同行，并不都是坏人。他们的难处，是旧图里没有地方放「医生也是病的来路」这句话。图放不下，事实就被挡在门外。

本书看这件事，换了一个角度。

医疗，本来就是复合体的一部分。

医生一出手，复合体就变了。开一张单子，复合体变了；做一次检查，复合体变了；下一个诊断，复合体变得更多。这些变，大多数是朝好的方向，有些是中性的，也有些是朝坏的方向。

从这个角度看，医源性疾病并不是医学里掉出来的一块渣，它是医学这种介入方式的一个必然的侧面。有介入，就有介入的后果，好的坏的，都是复合体里发生的事。

举一个虚构的小例子。周老师的邻居老陈，几年前因为胸闷住过一次院，查完，说是虚惊一场。出院的时候，大夫随口说了一句：「你这个心脏，以后要多注意。」

这句话后来跟了老陈好几年。每次爬楼梯，他都先停一下；每次听到电视里讲心脏病，他都放下筷子。一次本来可以不去的急诊，他去了三次。

大夫没有恶意，也没有错。这句话在当时那个场合里，是一句负责任的提醒。可是它进入老陈的日子之后，变成了一个轨道。这个轨道，是出院那一天的复合体，留在后来每一个日子里的东西。

这样的事，不会出现在任何一张「不良事件」报告里。它是医源性的，也不是事故。它是诊室里一句话，走进一个人的生活，慢慢长出来的。

读到这里，请你千万不要得出一个结论：「那医生就没有责任了，是复合体的事。」

不是的。这一点，本书在这一章的第九节还会专门讲，在第 15 章讲得更透：**该追责仍然追责**。操作规范，没按；该告知，没告知；该复查，没复查，这些都是可以问的，也必须问。追责不是对复合体的背叛，它本身就是复合体修复的一部分。

这里只想强调一件事：把医源性疾病放进正文，是为了让它被认真看，不是为了让它被原谅。

还要补一句公道。把医源性疾病当成「个别人的失误」，有它的用处：它让责任可以落到具体的人，让具体的错能被指出、被纠正。这个用处，本书要保住。

本书只是想在这之外，多问一层：这个人为什么会在这个位置上，这样做？

只要还把它当脚注，它就总是被当成「个别人的失误」，不会有人去问：这个复合体里，是哪几处的结构，让这类事情容易发生？是排班，是沟通，是表格，是对话的时间？

换一个角度说，本节说的这些，医学里的好医生都懂。本书不是在告诉他们一件新事，只是在给这件他们早就懂、却一直没处安放的事，找一个能放下的地方。

◆ 七、过度医疗：复合体自己在往前推

接着是过度医疗。

先说公道话。检查、筛查、早发现，救了很多人的命。这一点，没有任何疑问。一个肿块早一年发现，和晚一年发现，可能是两种结局。

可是同样是事实的，还有另一面：有些检查查出来的东西，就算不去查，一辈子也不会让这个人难受；查出来之后，却开始了一连串的复查、穿刺、手术，和一份长久的担心。这类现象，医学里叫「过度诊断」。威尔奇等人写过专门讨论它的书。有的国家的某些癌症筛查，被认为在这方面很有代表性（具体数字，本书不引）。

另外还有一类，叫「防御性医疗」：医生为了保护自己，多开一些其实未必需要的检查。这一类，第 13 章再细说。

旧框架里，过度医疗是什么？

是偏差。是医生太积极，或者病人太焦虑，或者医院想赚钱。总之是某一方的问题。解决办法，是对那一方做教育、做规定。

本书看，换一个角度。

你可以这样想一下它的样子：

一位体检的人，被告知「有个小结节，建议复查」。他回家，开始担心。三个月后复查，医生说「变化不大，继续观察」。他稍微松一口气，半年后又查。每一次查，都是一场新的发生：他是病人，医生是医生，那个结节有了名字，名字带着一个等级，等级带着一个随访计划，随访计划带着一个日子。

这个小结节，没有变成病；这个人，已经被「结节」这个词，装进了一个轨道里。

这个轨道，是怎么成的？不是哪一个人定的。是一次检查，带来一个名字；一个名字，带来一次复查；一次复查，带来下一次需要被解释的东西。每一步，都有它的道理。每一步，都不是恶意。

这就是复合体自己往前推的样子。

没有人想让它到这一步，它还是到了。

再看这条链子里的每一环，各自的理由：

病人想「查清楚才踏实」，医生想「多查一项，心里有底」，医院里有「达标率」「随访率」这样的指标，保险有它的支付规则，机器有它的灵敏度，灵敏度越高，查出的「异常」越多。

这些理由，单看每一条，都说得通。可是它们叠在一起，不是谁定的，却成了一股劲。

你要是只在其中一个位置找问题，你会找到一些，也能改一些。可是整条链子的走向，不会改。要改，得换一种问法：这个复合体，在什么时候，从「看一看」，变成了「停不下来」？它要靠什么，才能不被推着走？

这个问题，一章答不完。第 8 章讲病名怎样回写，第 10 章讲不进入「悬着」会怎样，第 12 章讲怎样让一个复合体可以安全地解散，都是在答它。这里只先把它从「个别人的偏差」，换成「复合体的走向」。

还有一个很小的例子，来自豆豆。

七岁的豆豆咳了半个月，外婆着急，外公急着说「要不要吃点消炎药」。周岚是医生，她知道哪些情况下需要、哪些情况下不需要，可她在家里，是女儿、是妈妈，不是诊室里的周医生。她在家里说「不用」，没人听；同一句话，她在诊室里对别的家长说，大家点头。

这不是谁的话有没有道理。是同一句话，落在两个复合体里，分量不一样。

医生们都有这样的体会：有时候开药，不是因为病人的病需要，是因为这场谈话里，「不开」很难被接住。开了，大家都踏实；不开，大家都悬着。这种压力，不属于某一个医生的品性，它是那一场谈话的气候。

想要少一点不必要的药，办法不只是对医生讲道理、对家长讲道理，也在于让「不开」这件事，在谈话里有一个可以被接住的说法：「我们先观察两天，出现这几种情况，马上来。」这个说法，给了所有人一个可以放心的东西。

◆ 八、今天与机器

这一章的几件事，今天有了一个新的现场。

很多人现在生了不舒服，第一件事不是挂号，是打开一个能对话的机器，把症状写进去，问：「我这是什么病？」

机器很快回答，条理清楚，语气温和，后面常常还加一句：「建议你咨询医生。」

先看一个很平常的晚上。一位三十多岁的母亲，孩子半夜发烧，她打开手机，把体温、症状一条条敲进去。几秒钟之后，一份回答出来了。这个场景，把本章的东西全都带出来了。

机器的回答里，如果把可能性从最常见排到最危险，列了十几项，一个本来只是熬夜后头痛的人，读完会不会开始觉得自己哪里不对？那就是反安慰剂的新样子。

机器的回答要是温和、稳，一句「大多数情况下不用担心」，让一个人睡了个好觉，那是安慰剂的新样子。

要是机器不分轻重，什么都建议「去做个检查」，于是这个人带着一份机器写的清单走进诊室，要求做一堆检查，医生在时间的压力下点了头，那是过度医疗的一条新路。

这些都不是机器「有恶意」，也不是机器「没用」。它是复合体多了一个成员，这个成员说话的方式，也进入了状态的发生里。

第 16 章会把这个成员看作一个新的位子，不是工具。这里只先说一点：别问「机器准不准」，也要问「机器进来之后，这个复合体变成了什么样」。

◆ 九、只看一端会怎样

也许有读者担心：把这些都放进正文，医学研究还怎么做？对照、盲法，是不是都要扔掉？

不扔。对照和盲法，是医学最结实的家底，本书不动它。

本书只提一个很小的建议，叫「把场合写下来」：除了药是什么、剂量多大，也记一记，这些话是谁说的、在哪里说的、说了多久、病人事先被告知了什么。这样记下来的东西，不会让研究变坏，只会让读研究的人，在遇到「为什么换一家医院结果不一样」的时候，多一条线索可以查。

这一节，把承载者放在哪一端，各会怎样，摆出来看。

承载者放在病人身上。

「你是不是想多了」「你要放松」「你的心态要好」「你得配合」。这些话，每一句都是好意，每一句都把状态的重量，放回了病人的肩上。一旦治疗没起效，下一个解释就是「他不配合」。

病人在这样的复合体里，经常是孤独的。他不只是病，还得为自己的病负责。

承载者放在医生身上。

「是医生没看出来」「是医生开错了药」「是医生态度不好」。这样追，有时候是对的，也该追。可是一直只追这一头，医生也会变形：为了不被追，写得越来越谨慎，查得越来越多，说得越来越少。这又回到了过度医疗。

承载者放在病上。

「病就是这样」「这个病没办法」「指南就是这么说」。一种看上去最客观的说法，却把两个人都藏了起来。没有人在这里，只有一个病在那里。这样的复合体，沟通最少。

承载者放在「社会」「制度」上。

这一端，值得多说一句。生物—心理—社会模式，是恩格尔在 1977 年提出的，要把医学的眼光从单纯的身体，扩大到心理和社会。它是医学史上很重要的一步，本书欠它一份情。

它扩大了「病」的范围，承载者，仍然是那个病人：他身上有生物的、心理的、社会的三层。医生是在这三层之外，去看他的。本书的换位，是再走一步：连看的人，也一起放进去。

四个端点，各有一点真，也各自把另外几样放得太远。

最后看一个，医生自己当病人的时候。

周岚去年发过一场高烧。她在自己的医院，挂了同事的号。同事一边量体温，一边说：「你自己是医生，你知道的，多喝水，休息。」

她知道。可是那一刻，她躺在检查床上，想要的不是被当作「知道的人」，是被当作一个发烧的人，被问一句「难受不难受」。

同一个周岚，医生位和病人位，在一天里换了好几回。她站在诊室里，是一个看别人状态的人；躺在床上，是一个被别人看状态的人。她的体会很简单：不是她换了一个身份，是这场发生把她摆在了不同的位置。

这一点，每个医生迟早会懂。懂了以后，他们看自己的病人，常常不太一样。

还要补一句，免得读偏：复合体生病，不等于责任稀释。

这句话如果被读成「大家都有份，所以谁也不用负责」，那就错得厉害了。

拉大锯的两个人，锯口出了偏，一头有一头的责任，不会因为「是我们俩一起锯的」就消失。医生开错药，该追的要追；病人隐瞒了关键的情况，也有他的一份；医院排班把一个人逼得睡不够，管理者也有他的一份。

复合体的说法，没有减少责任，它只是把责任放到了能起作用的地方。因为你要修一把卡住的锯，你得先看清楚，卡在哪一处，是谁的手松了，是木头有结，还是锯齿钝了。

◆ 十、一个完整的例子：周老师的头晕

回到周老师的头晕。

周岚没有说「爸，你想多了」。她很清楚，这句话一说，等于把整个晕，推回了父亲一个人身上。

她也没有说「那就换回原来的药」。她很清楚，这是开药医生的事，不能由她在厨房里替父亲改。

她做的，是三件小事。

第一件：陪父亲把说明书再读一遍，这一回，一起把「常见」和「罕见」分开。大部分字，原来是写给药监部门看的，不是写给他的。

第二件：把父亲今天的头晕，用日期、时间、做了什么，简单记在那个红皮本子上。

第三件：第二天，她给开药的医生发了一条消息，把本子上的三行字拍给他看，问：「这种情况，是不是可以提前复诊一次？」

医生回得很快：「可以来看一下。」

提前复诊那天，诊室里的话比上一次长了一倍。医生问了睡眠，问了读说明书的事，又讲了这类药刚开始吃时哪些感觉是常见的、一般会怎样、什么情况要马上来。周老师点着头，一条一条听。

血压数字，和上一次差不多。这一回，周老师走出诊室的时候，说了一句：「原来是这样。」

他的晕，后来没有马上消失，是慢慢减轻的。至于是药的适应，还是安心的作用，还是两样都有，没人能分清楚，也不必分清楚。

要是换一条路，会怎样？

假如周岚那天晚上说的是：「爸，你就是想多了，药没问题。」周老师多半会闭上嘴，不再说了。第二天的晕，他也不会告诉任何人。他自己心里，却会多一层：这晕，是我不对，又不敢吃药，又不敢不吃。

那样的复合体里，医生看不见这个晕，女儿看不见这个怕，药盒在抽屉里，数字在本子里。表面上，什么事也没有。

差别就在这里：一个复合体，里面的东西能不能流通，晕能不能被说出来、被听见、被放到该放的地方去。能流通，状态就有处可去；不能流通，状态就压在某一个人身上，被当成他一个人的事。

你看，在这场发生里，没有哪一样是纯粹的「干扰」。说明书是复合体的一部分，周老师的怕是，周岚的在场是，医生第一次的短话是，第二次的长话也是，一样都少不了。它们一起，把一个晚上的晕，变成了一次可以谈的事。

再多看一眼那间诊室。第一次，医生的话很短，是因为门外还有二十个人在等。第二次，话长了一倍，是因为周岚的消息让他知道，这次需要多说几句。

你看，医生的话是长是短，也是被这个复合体「说」出来的。他不是一个永远耐心或永远不耐心的人；他是在这场发生里，被排队、被消息、被一本红皮本子，推到了不同的说法上。

这不是替他开脱，也不是替他加分。这是在提醒：想改变一个医生的说法，有时候最省力的办法，不是去要求他变成另一个人，是去改变他面前的那一场发生。

这就是本书说的「状态属于复合体」：晕，不是周老师的，不是药的，也不是医生的，是这个「老人—女儿—医生—药—说明书—日子」的复合体，在某一刻的样子。

要改变它，不是去找谁的错，而是去换这个复合体里的某一处：让一次交代更完整，让一个疑问有地方放，让一次复诊来得更早。

◆ 十一、放回日子里

下一次，你拿到一个新药，或者要做一项新检查，不妨在见医生之前，用三分钟，在纸上写三行：

第一行：我最担心的是什么？

第二行：我希望这个药或检查帮我做到什么？

第三行：上一次我在哪个环节，觉得没被听明白？

然后，带着这张纸去。不用念，只要放在手边。

有的人会说：看病哪有这么多讲究，医生那么忙，我哪好意思拿出一张纸来？

那就不必拿出来，写完自己心里有数就行。写下来这个动作本身，已经让你走进诊室的时候，不再是一团乱麻。你的那一半，先成了形。

这张纸，不是用来「考」医生，也不是用来「说服」医生。它是用来让这个复合体，一开始就多一点可以靠的东西。

如果你是医生，下一次开药的时候，可以试着在最后加一句：「吃了以后如果有什么不对劲，你直接告诉我，我们一起看。」这一句话，不会多占你一分钟，可是它给一个复合体，留了一个出口。

医生这一端，还有一个更小的试法：下一次你写完处方，不要急着说下一位，停三秒，问一句：「你最担心的是什么？」不是为了多聊，是为了知道，你开的这张单子，将要落进怎样的一个晚上。

这两样都只是沟通的习惯，不是诊疗建议，更不是用药指导。身体或心里的难处真的大了，请找医生或心理咨询师。

带 走 的 话

没有哪一样是旁边的杂音；说明书、一句话、一次等待，都是这个复合体在发生。

小　账

这一处，开门还是关门：这一章，对「干扰项」关了一扇门，对安慰剂、反安慰剂、医源性疾病、过度医疗这一整片，开了一扇门：它们从脚注，请进了正文。

病放在一个人身上，还是放回复合体里？晕、好转、被推着往前走，都放回了「医生—病人」复合体的状态里；追责没有取消，只是换到了能起作用的位置。

想 一 想

你最近一次「读了说明书之后觉得哪里不对」，或「见了某位医生就觉得好了一半」，是什么时候？现在回头看，那一刻的你身边，还有哪些东西在一起发生？

如果你是医生，下一次你对病人说的最后一句话，会是什么？这一句话，给这个复合体留了一个什么样的出口？

◆



第　二　编

诊断：
状态发生的开端

编　序

这一编四章，写诊断。第 5 章写诊断之前：一个人说不清哪里不舒服，苦已经在了，形状还没有。

第 6 章写诊断那一刻：病人位、医生位、病名一起出现，病名被写进病历，也被写进日子。

第 7 章回头看一个很好用的说法，「科室就是测量基」。它有力，也有一个暗处，本书把它收回来。

第 8 章看病名落下之后的两条路：有的复合体靠它流通起来，有的被它压住。

这一编要让你看见全书的第二个反差。老看法里，诊断是终点：一路查下来，真相到手，事情说清楚了。本书的说法正好倒过来：诊断是起点。它不是对一副身体的判决，是「医生—病人」这个互动复合体第一次长出形状的那一刻，从这一刻起，复合体才有路可走。

发现学把诊断当终点，发生学把诊断当起点。四章读完，你会发现这两句话的差别不在措辞，在诊断之后的每一个晚上。

05

第 5 章

诊断之前：没有形状的苦

◆ 一、你一定有过这样的时刻

邱敏四十一岁，在一家物流公司管账。

这半年，她总觉得不对劲。可要她说哪里不对，她说不出来。

早上起来，像是没睡过。胸口有一块地方发紧，不是疼，是「压着」。下午三点以后，脑子像蒙了一层布，对不上的数字，要看三遍才看得出来。晚上躺下，身体累得很，人却睁着眼，听见冰箱嗡嗡响了又停。

她去做了体检。抽血、心电图、B 超、胸片，一样一样做下来。几天后结果单发回来，每一页的末尾，都是差不多的一句话：未见明显异常。

她拿着单子去找医生。医生是个和气的人，把单子从头翻到尾，说：「各项都挺好的。可能是压力大，回去多休息。」

邱敏道了谢，走出医院。站在大门口，她愣了好一会儿。

没病，是好消息，她知道。可是那块压着的地方还在。她说不清自己该松一口气，还是该更慌一点。

回家的公交车上，她想起一件小事。上个月，同事问她：「你最近是不是不舒服？」她说：「没有啊，就是有点累。」同事点点头，没再问。其实那天早上，她在楼梯间站了五分钟，才有力气推开办公室的门。

后来她对自己说过一句话：我又不是没有认真做过检查，我到底在怕什么？

这句话，她没有说给任何人听。

你大概也有过这样的时刻。有人问你：「哪里不舒服？」你张了张嘴，答不上来。说「累」，不全对；说「烦」，也不全对；说「哪儿都不太好」，听起来又像是没事找事。

这一章讲的，就是这个「说不上来」。

它不是什么都没有。它是诊断之前，医生和病人这一对复合体的第一个样子。

◆ 二、老看法：症状是病的信号

先说老看法，它对在不少地方。

发现学医学是这样看的。（本书把「病先在身体里，医生去把它查出来」这一路的医学，叫发现学医学。）身体里先有一个病，病会发出信号，信号叫症状。病人把症状报告给医生，医生顺着症状往下查，查到了病，病名就有了。症状是线索，病是真相，诊断是线索走到头的那一站。

这个看法，救过无数人的命。

胸口疼，查出心梗，赶在来得及的时候送进了抢救室。咳了一个月，拍片看见一处阴影，早一步发现了。体检里有一项指标悄悄超了线，当事人毫无感觉，却因此早早知道，早早留意。这些事是真的发生过的。没有「症状是线索」这个想法，没有顺藤摸瓜的检查，就没有今天的医院。

这个看法里还有一门很要紧的功夫：排除。

医生面对一个说不清的难受，头一件要问的是：有没有危险的东西藏在里面？把最要命的几样一一排掉，是对病人负责。邱敏手里那一叠单子，做的正是这件事。「未见明显异常」，意思是：那几样最坏的情形，这一回没有看到。这是一句很有分量的话，不该被轻看。

所以本书不说老看法错了。它在这些条件下完全成立：病已经有了清楚的形状，信号清楚，检查手段够用，要回答的问题是「是不是这个」。

不过邱敏站在医院门口，遇到的是另一种情形。排除做完了，线索走到了头，真相却没有到手。

对这种情形，老看法只有两个说法。一个是：再查。另一个是：没病，是你想多了。

这两个说法各有各的用处。只是它们有一个共同的预设：难受的下面，应该有一个先在的东西，在，或者不在。在，就把它找出来；不在，难受就是假的，或者是自己造出来的。

邱敏的难受，既不是假的，也不是自己造出来的。它是真的，只是还没有长成任何一个能被指名的东西。

医学界对这类情形，有一个说法，英文常叫 medically unexplained symptoms，大意是「医学上一时解释不了的症状」。这个名字很老实，它承认的是：用现有的尺子，量不出一个名字来。本书要往前多问一步：量不出名字，是这个人的缘故，还是「量」这件事本身的缘故？

民间还有一个更家常的说法，叫「亚健康」。人们用它指那种「没查出病，可就是不舒服」的状态。这个词流传很广，也常被人拿去做各种生意。本书不评它，只借它说明一件事：这样的人太多了，多到日子里自己长出了一个词。一个词能长出来，说明有很多很多的人，一直停在这里，没有人接。

◆ 三、本书的说法：一锅粥不是空的

本书给这个状态起了一个家常的名字：一锅粥。

用 SDE 的话说，叫混沌态（什么都在、还没分开的状态）。这三个字里，每一个字都要紧。

第一，什么都在。邱敏那块发紧的地方在，睡不踏实在，下午三点的蒙在，月底对账的压力在，母亲上个月住院的事在，她对「我是不是该再去看看」的犹豫也在。一样不缺，全在粥里。

第二，还没分开。哪一样是「症状」，哪一样是「原因」，哪一样只是「日子难」，现在分不出来。粥里的米和水，还没有各归各位。

煮过粥的人都知道，粥在锅里的时候，你很难说哪一粒米是哪一粒米。米吸了水，水带了米香，汤和饭是一体的。要等凉下来，要等舀进碗里、放上一会儿，米和汤才慢慢分出层来。分不分得开，不取决于你多想分开，取决于它在什么火候、什么时候。

第三，没有方向。没有一条往前走的路，没有一个能说出口的名字，所以也没有一个「该去哪一科」的答案。

老看法的第一个问题，永远是：「是不是病？」本书换一个问法：这件事，正在怎样发生？

前一个问法，要求答案是「是」或「不是」。后一个问法，允许答案是「还在发生，还没有定」。一锅粥的处境，就是后一个问法的答案。

最容易走偏的，是把一锅粥当成「什么都没有」。

不是的。**一锅粥是满的，不是空的。**空碗里什么都没有；粥锅里什么都有，只是没有哪一样先站出来。邱敏的苦，一点也不少，少的是形状。

再往下走一步，这是本章最要紧的一步：这锅粥，是谁的？

老看法的回答是：邱敏的，在她身体里，在她的感觉里。本书的回答要慢一点。当邱敏还没有走进医院的时候，这锅粥只有她一个人在煮，她管它叫「我最近不太好」。当她走进诊室，把这锅粥端到医生面前，「病人位」和「医生位」开始

出现（位子，本书有时也叫「号位」），这锅粥就成了「这一对人」面前的一锅粥。

医生看了，说「未见异常」。这句话，是这个复合体读出来的一个读数。它不是粥的名字，只是说：用这几把尺子，没有量到危险。粥还是那锅粥，复合体停在原处。

所以邱敏走出大门时，那个愣，不是她一个人的愣。医生位交出了排除的结果，病人位没有拿到解释，两头对不上。借本书的总比喻说：这是一把锯，两头的人刚握上手，锯齿还没咬进木头。

这就是混沌态在复合体里的样子。它是复合体的状态，不是某一个人的失败。

还有一句，得趁早说。一锅粥虽然难受，却不是坏东西。

它是后来一切形状的原料。后来的病名，后来的路，后来能说出口的那句话，都要从这锅粥里长。一个人若永远不进入这样的状态，什么都是现成的，什么都是清清楚楚的，那未必是健康，有时只是把粥盖住了。这一点，第 10 章要细讲。

眼下只要记得：粥的难受是真的，粥的价值也是真的。它是复合体最初的、也是最不能省的一站。

邱敏自己，其实也怀疑过自己。那天晚上，她对着浴室的镜子，问了自己一句：「我是不是真的没事，是我在没事找事？」

她问得很轻。可是这一句，是一锅粥在复合体里最典型的回声：当医生那一端说「没有」，病人这一端就开始怀疑自己的「有」。怀疑自己的苦，是一种很孤独的怀疑。

◆ 四、苦里缠着哪几样东西

一锅粥里，到底有些什么？

不妨试着从邱敏那锅粥里舀出几勺来看。只是看，不是要把它们分开。

第一勺，是身体上的。胸口的紧，醒来时的沉，下午的蒙。它们是真的，会让人皱眉，会让人在椅子上换姿势。

第二勺，是睡眠和精力。睡不好，白天就没劲；白天没劲，夜里又更焦躁。这是一个自己会转的圈，哪里是头，哪里是尾，说不出。

第三勺，是心里的。不是「情绪病」那样一个整齐的名字，只是一种说不出的悬：怕有事，又怕没事却一直这样；怕麻烦家人，又怕不说出来更麻烦。

第四勺，是日子里的事。年末的账，母亲的病，孩子的升学，一段说不上来的疲惫的婚姻，或者只是一个人太久没有好好吃过一顿饭。这些事不是「背景」，它们就在粥里煮着。

第五勺，是旁人的话。同事说「你就是太拼了」，朋友说「去查一查」，母亲说「你就是不爱惜自己」。每一句话落进锅里，粥的味道就变一变。

这五勺，没有一勺是单独成立的。你把胸口的紧拿出来，它背后连着睡眠；把睡眠拿出来，它连着心里的悬；把心里的悬拿出来，它又连着账本和母亲的病。

本书把这叫作「缠」。粥的特点，不在东西多，在东西缠着。

中国人对这件事，其实早有自己的家常说法。

邱敏有一回在电话里对母亲说：「妈，我最近老是没精神。」

母亲在那头想了想，说：「是不是上火了？我给你炖点梨水。」

邱敏说：「不是上火，就是，说不上来。」

母亲说：「那就是累着了。你们现在的人啊，不知道自己的身子。」

电话挂了。邱敏拿着手机，坐了一会儿。她没有被说服，不过胸口松了一点点。不是因为「上火」说对了，是因为有人接了她的话，把它放在一个有名字的抽屉里。

你对母亲说「我最近没精神」，她可能回答：「是不是上火了？」你说「心里堵得慌」，邻居可能说：「气不顺吧，出去走走。」你说「浑身不得劲」，有人劝你「别想那么多」，也有人说「是不是湿气重」。

这些说法不精确，也不严格，没有一个会被写进病历。只是它们有一个了不起的作用：它们给一锅粥，临时借了一点形状。「上火了」三个字一出口，说的人和听的人，就都有了一个可以接着往下说的地方。

这是老百姓的诊断之前。它很粗，可是它是通的：话可以说下去，日子可以接下去。

后面几章会看到，医院里的诊断，比「上火」硬得多、准得多，也重得多。形状一硬，路就清楚；可形状一硬，也有压人的时候。这两面，本编后两章都要细说。

在这里先记一句：在贴任何名字之前，苦是一整锅。哪一勺是头，没有人说得准。

◆ 五、没有方向，是什么意思

混沌态里最难受的，也许不是苦本身，而是没有方向。

什么叫没有方向？

你可以拿一件小事试试。你到了一座陌生的城市，下了火车，手机没电了。你知道自己要去一个地方，不过不知道它在哪个方向。你站在站前广场上，四面都是路，每一条看起来都差不多。

这时候你的难受，不是因为累，不是因为饿，是因为没有「往哪边走」。任何一条路，都有可能是对的，也有可能是错的。你迈不出第一步。

诊断之前的苦，常常就是这样。它缺三样东西。

第一，缺一个名字。你没法对别人说「我得了什么」，只能说「我不舒服」。别人听了，除了安慰，没有别的可接。

第二，缺一个位置。该挂哪个科？消化科、心内科、神经内科、心理科？每一科都像是对的，每一科又都像是只对了一半。没有位置，就没有门。

邱敏第一次去医院之前，在手机上翻了二十分钟。胸口紧，是心内科；睡不着，是神经内科或者心理科；乏力，说不定是内分泌。她把挂号页面划来划去，最后挂了一个「全科」。挂号单出来的时候，她其实还是不知道，自己是个什么病人。

这就是挂号那一刻之前的样子。挂号单一出，「病人」这个位子就盖在了她身上，只是盖上的是一个很粗的轮廓，里面的粥，还是满的。

第三，缺一个明天。名字和位置有了，明天才有内容：复查，调整，观察。一锅粥的明天是空的，因为没有一个能接上的动作。

这里要讲清一个容易搞错的地方：没有方向，不等于没有变化。

粥是在动的。邱敏今天比昨天好一点，明天又差一点，下周因为一件事忽然松快了，月底又沉了下去。这些波动是真的。可是在没有形状的时候，波动连不成一条线，它们只是一些散落的点，没有人能说「这是在好转」，或者「这是在变坏」。

所以，「查不出问题但就是难受」的人，常常被两种话夹在中间。

一种话说：别担心，没事的。

另一种话说：你再仔细想想，到底哪里不舒服？

两种话都出自好意。不过两种话都在把一锅粥，当成一个已经有了形状的东西：要么说它不存在，要么催它拿出形状。粥还没有形状，催也催不出来。

形状不是催出来的，是一次一次碰出来的。

中国人很早就懂这个道理，用的是一个寓言。《庄子》里说，南海的帝叫倏，北海的帝叫忽，中央的帝叫浑沌。倏和忽常常在浑沌那里做客，浑沌待他们很好。他们想报答，说：人都有七窍，用来看、听、吃、呼吸，只有浑沌没有，我们替他凿开吧。于是一天凿一窍，七天凿完，浑沌死了（《庄子·应帝王》）。

这个故事可以有很多种读法。放在这里，它提醒的是一件小事：好意催出来的形状，有时会把一锅粥本来的样子凿死。

倏和忽没有恶意，他们是要帮忙。只是他们的帮法，是先认定了「一个完整的东西该有七个窍」，再拿着凿子去凿。「你到底哪里不舒服」「你再想想」「你就是焦虑」，这样的话，有时就是一把凿子。

这不是说，医生和家人就不该问。问是应该的。本书只说：问法有两种。一种是拿着已经想好的形状去凿；另一种是陪着粥慢慢分层，看它先分出哪一块。

前一种，叫催。后一种，叫陪。

这一点，值得写下来。有些人停在一锅粥里，停了很久：半年，两年，更长。他们换科室，换医院，每换一处，多一叠单子，多一次「未见异常」，也多一分疑惑：是我真的有什么没被发现，还是我自己有什么不对？

停在这里的人，不是在装，也不是在躲。他们是被一个没有人搭得上手的状态，困住了。

◆ 六、三种常见的错认

一锅粥最容易被认错。常见的错认，有三种。

第一种，把粥错认成病。

邱敏在网上读到「焦虑」，读到「甲状腺」，读到「更年期前后」。每读到一个，她就觉得「对，是这个」，几个小时以后，又觉得「不对，好像又不是」。她在几个名字之间来回，每一个都套得上一部分，没有一个套得上全部。

这是粥被急着装进了病名的瓶子。瓶子一个比一个小，粥倒进去，总要溢出来。溢出来的那一部分，就成了「查不出来的」。

第二种，把粥错认成空。

「没事的，别想太多。」「年轻人哪有什么病。」「你就是闲的。」这样的话，把粥当成空碗，在说碗里什么都没有。

说的人常常是好意，他想给你松一口气。可是被说的人听到的，常常是另一句：你的难受，我这边看不见，所以它不算数。

这一种错认，会让人把话咽回去。咽回去的粥，没有消失，会在夜里凉下去，凉成一块硬的东西。

第三种，把粥错认成人的脾气。

「你就是这样的性格，想得多。」「你从小就敏感。」这样的话，把一锅粥，一下子装进了「你这个人」里面。

这一种最难拆，因为它听起来像理解。不过它悄悄把一件正在发生的事，变成了一个定了型的人。苦成了性格，性格是改不了的，所以苦也就只能受着。

三种错认，有一个共同的地方：它们都急着给粥一个交代。病名也好，空也好，性格也好，都是在粥还没有来得及自己分层的时候，替它定了位。

一锅粥最需要的，是有人认得它是一锅粥。

认得，不是赞美，也不是纵容。认得，是说：这里有一件正在发生的事，它还没有形状，我们先把它当作一件正在发生的事。

◆ 七、只看一端会怎样

现在回到这一编的总问题：这件事，放在谁身上？

先看只盯着病人这一端，会怎样。

话就变成：这是你的感受，是你的问题。要么是你想多了，要么是你太敏感，要么是你压力大、没调好。邱敏听到这样的话，有两种常见的走法。

一种是回家，努力「放松」，同时偷偷觉得自己无能：连放松都做不好。

另一种是换一家医院，再查一遍，这一回下了决心，一定要查出个名堂来。

两种走法，都把整件事压在她一个人的肩上。第一种是自责，第二种是追查。她的苦没有少，又多了一层：「是我不对」，或者「他们没查出来」。

还有第三种只看一端的看法，常被忽略：只盯检查。

话变成：检查都做了，数字都正常，所以你没事。

这个说法，把「没有量到」当成了「不存在」。只是检查是一把尺子，尺子有它量得到的东西，也有它量不到的东西。血里的指标，量得出血里的事；量不出一个人在楼梯间站五分钟才推得开门的那种沉。

这并不是尺子的错。尺子在做它能做的事。错的是把一把尺子的读数，当成了整件事的全部。

再看只盯着医生这一端，会怎样。

话就变成：医生查得不细，或者医生不重视。这样想，有时是对的，没有认真查的情形，确实有过。可是邱敏遇到的这位医生，查得并不粗。他用的是现成最稳妥的做法：先排除最危险的。他的结论，在他那一端是诚实的。

把一切怪给医生，邱敏会换一个医生，再换一个。每换一个，多一叠检查单，多一个「未见异常」。她的账越积越厚，她的粥还是原来那锅粥。

只盯病人，只盯医生，各有各的道理。不过它们都站在同一幅画面里：先有一个「病人」，先有一个「医生」，原因只能在这两个先在者里面找。

本书换一幅画面。

邱敏和那位医生，是在「未见异常」这一刻，一起停在了一锅粥的面前。病人位想要的是一个解释，医生位给得出的是一个排除。两样东西，都真，都有用，只是接不上。

像两个人拉一把大锯，锯口刚要咬进去，却滑开了。不是哪一头没使劲，是两头对着的，不是同一块木头。

这个说法，不是为了分摊责备，是为了找到修复的地方。接不上，就是修复的入口。病人这一端多说一句什么，医生这一端多问一句什么，什么样的话能让两头对到同一块木头上，这是后面几编要回答的。

眼下先放下一句判断：难受查不出来的时候，出问题的不是邱敏，也不是那位医生，是这个复合体还没有找到形状。

还要补一句，免得读偏。说「复合体还没有找到形状」，不等于说「谁都没有责任」。医生该仔细的地方要仔细，病人该如实说的地方要如实说，该追问的就追问。这些都是在帮复合体找形状。第 15 章会专门讲这件事。

◆ 八、一锅粥里，医生位也在煮

说了这么久邱敏，还有一个人，不该只当作背景：那位说「未见异常」的医生。

他那天上午的门诊，挂了三十多个号。邱敏是其中之一，在他的桌前坐了大约六七分钟。

这六七分钟里，他做的事，其实不少。他看了每一页单子，确认没有漏看哪一项；他问了几句睡眠、饮食、工作；他在心里过了一遍：胸口发紧，要不要再加一项检查；他判断，目前的检查已经足够排除危险的情形。然后他做了一个决定：不再加查，让病人回去观察。

这是一个负责任的决定。他知道，过度检查有它自己的代价：花钱，折腾人，有时还会查出一些与眼前的难受无关、却让人更慌的小毛病。

只是他也知道，那句「可能是压力大」，邱敏听得并不满意。

他的桌子后面，还排着人。他没有办法再坐下来，陪她慢慢把那锅粥舀开。他心里有一点歉意，可是下一个号，已经在门口了。

这就是医生位在一锅粥面前的难处。

医生位上的人，受过的训练，是把症状往病的方向收：排除，缩小，落到一个名字上。这套训练在大部分时候救人；不过面对一锅还没有形状的粥，它的手有点空。能做的，是把最坏的情形排掉，然后说：「回去观察。」这句话，往往是一个医生最大的诚实。

所以，说「复合体停在一锅粥里」，不是在指一个人做得不够。它是在说：病人位带来的是一锅粥，医生位被训练出来接的是一个名字，两头接不上，各有各的难。

还有一层，更值得说。

医生位上的人，自己也常常是一锅粥的一部分。门诊的人流，医院的评价，医保的规定，下一个号的催促，一位医生对「万一漏了什么」的担心。这些东西，不是医生一个人的，它们是这个复合体周围的土，一起压在这六七分钟上。

病人看到的，是一个医生；医生看到的，是一个病人。而那片压着两个人的土，两个人都看不见。

这些，在第四编会细讲。眼下先看一个小的修复动作。有的医生，在说完「未见异常」之后，会多加一句：「如果两周后还是这样，或者出现了某某情形，一定要回来。」这一句，看着不起眼，却是把一锅粥，从「结束」改成了「悬着」。它给下一次碰面，留了一个入口。

这一句话，是复合体的一次松动。它不是治疗，却让粥在原地，没有凉。

◆ 九、今天与机器

今天，一锅粥有了新的去处。

邱敏那天晚上回到家，没有马上睡。她拿起手机，把症状敲了进去：胸口发紧，下午脑子蒙，睡不踏实。她敲得很快，像怕慢了就想不起来。

屏幕上很快出来一长串。有的说可能是焦虑，有的说该查甲状腺，有的说是颈椎，有的说是更年期前后的变化，还有几条，看了让人心里一沉。

她又打开一个会说话的机器，把同样的话说了一遍。机器回答得很有条理：先说几种常见的可能，再说哪些情形需要尽快就医，最后说一句「建议到医院做进一步检查」。

这些回答有用吗？

有。它们把粥舀出来，给了几个名字。邱敏看到「焦虑」「甲状腺」这样的词，心里有了一个能抓住的地方，不再是完全的一团。机器也确实在提醒她：真有危险的情形，别拖。这是好事。

只是这里面有一个暗处，要看清。

这里面最有意思的一点是：她在手机上敲字的那几分钟，其实已经是一次小小的「说」。把一锅粥，一句一句敲成文字，粥就被迫排了先后：先是什么，后是什么。哪怕没有人回应，这个动作本身，也在给粥分层。

一个名字被端出来，粥就有了一点形状。这个形状，在邱敏还没有走进任何诊室的时候，就已经出现了。她抱着这些名字睡去，第二天走进诊室时，已经带着一份预备：「我大概是焦虑」，或者「我可能是甲状腺」。她把这份预备说给医生听，医生位听见的就不再是一锅粥，而是一个已经被谈论过的病名。

这不一定坏。有时这反而让对话快了许多。可是也可能，这锅粥还没来得及自己煮开，就被一个提前到场的名字盖住了。粥里没被舀进去的那几勺，留在锅外面，再没有人提起。

这里不下结论，只留一个提醒：形状来得太早，和形状来得太晚，各有各的代价。到了第 16 章，医生、病人、机器三方同在一处时，这件事还要细讲。

此刻，最老实的一句是：机器可以帮你把粥舀出来看，却没有办法替你的复合体决定，哪一勺先成形。那是你和那位医生，在一次一次的碰面里一起长出来的。

所以，如果你一定要问机器，有一个小办法，明天就能试：别问「我是什么病」，问「帮我把这两周的情况整理成一张时间表」。

把你的事实一条一条说给它：几号几点，什么感觉，吃了什么，遇到了什么事。让它整理成一张清单，标出哪些天重，哪些天轻。拿着这张清单去见医生，你带去的，是一锅分了层的粥，不是一个提前盖好的名字。

这样用机器，它做的是舀勺子的事，不是起名字的事。名字，留给你和医生一起去碰。

◆ 十、一个完整的例子：周老师确诊之前的那些早晨

邱敏的故事讲到了她走出医院的那一刻。再讲一个粥里的故事，它的结尾，我们在下一章会接上。

周老师现在六十二岁。八年前的秋天，他五十四岁，还在带两个毕业班。

那一年他自己说不清是哪一天开始的。

先是早上起来，后脑勺发沉，像戴了一顶小一号的帽子。后来是备课时，字看着看着会飘一下。晚上睡下，被窝里摸得到自己的心跳，一下一下，比平时重。

他对老伴说：「我这几天有点不对。」

老伴问：「哪里不对？」

他想了一会儿，说：「说不上来。就是不对。」

老伴说：「你就是累了，放假歇歇就好。」

他也这样想。他把这件事，归到了「学期末」里面去。

那几周，他的日子还是照旧过的。早上六点起，在阳台上给茉莉浇水，七点出门，路上买一份豆浆。学生交上来的作文，他一篇一篇批，红笔写满页边。只是批到第十几篇的时候，他会把笔放下，闭一会儿眼睛。

老伴看在眼里，没点破。她知道他的脾气：越说他，他越说没事。她只是把晚上的汤，悄悄做得清淡了一点，没有告诉他为什么。

这些事，周老师当时一件都没当作「线索」。它们只是一个家里的日子。

学期末，是个很好用的抽屉。累了，放进去；睡不好，放进去；脾气躁，也放进去。抽屉有了名字，抽屉里的东西，就不用再一样一样问了。

又过了几周，放了假，他歇了几天，帽子还在。爬楼梯时，他会停一下；跟老同学吃饭，别人说笑，他笑得慢半拍。

周岚那时在外地的医院做住院医，隔几天打一个电话回来。她值夜班的时候，会在凌晨给母亲发一条消息：「爸最近怎么样？」母亲回：「老样子，说头沉。」她看了一眼，想再问，被护士站的铃声叫走了。

有一回，她在电话里听了几句，问：「爸，你声音怎么有点哑，是不是没睡好？」

他说：「没事，就是头有点沉。」

她说：「那你去量一下血压。」

他说：「量什么，小题大做。」

电话那头，女儿停了一下，没再劝。她知道他的脾气，也知道自己隔着几百公里，再说下去，只会变成一场争。她只说了一句：「路过药店，你顺便量一下。」

他答应了。他没有去。

我们先停在这里。

这里是一锅粥。后脑勺的沉，字的发飘，心跳的重，学期末的累，老伴的话，女儿隔着电话的那一句，周老师那句「小题大做」。没有一样是病名，没有一个是病人。没有「周老师是个病人」这个身份，没有「周岚是医生」这个位置。

他和老伴是一家人，他和女儿是父女。周岚是医生，可那天的电话里，她只是一个有点担心的女儿。她的医生位，在那通电话里没有显出来；是她一句「去量一下」，才露出了一丝边。

用本书的话说，复合体在那个秋天已经隐隐在了，不过它还没有显影成「医生—病人」。它还是一个家庭饭桌的样子，一部电话的样子。

后来，一个周末的早上，小区门口搭起了棚子。

接下来发生的事，上一编的第 1 章讲过它的一半，下一章要讲它的另一半。在这里，只需要看见：就在袖带绕上手臂的前一刻，周老师没有病，也没有不病。他在一锅粥里。

粥里有他的沉，他的累，他的不肯。粥里也有他女儿那句没说完的话。后来的许多事，是从这一锅粥里，一点一点长出来的。

那天晚上，他在小区里散了一圈步，回到家，对老伴说：「明天要是还沉，我去门口量一下。」

老伴说：「好。」

她没有说「早该去了」。她只是把明天的豆浆钱，放在了门口的鞋柜上。

这一句「好」，也是粥的一部分。它没有名字，没有科室，没有单子，只是它让第二天早上，有了一个出门的理由。

◆ 十一、放回日子里

回到邱敏。

那天晚上，她把手机放下，没有再看，也没有马上睡。她坐在床边，想起医生说的那句话：「可能是压力大。」

她想：压力大，大在哪里？是一件事压着，还是很多件事叠着？

她想了很久，没想出来。她只知道，这个问题，她从来没有认真问过自己。人在累的时候，很少问这个问题；累本身，就把问题吞了。

第二天，她做了一件很小的事。她拿出一个本子，不写病，不写原因，只写事实。像记账一样，一天一行：几点醒的，胸口紧不紧，下午几点开始蒙，那天遇到了什么事，那天跟谁说了什么话。

一周后，她把本子翻开，看了看。

她发现了两件事。一件是，胸口紧，在对账最紧的那两天最明显。另一件是，每个周末下午，她陪母亲去复查的那几个小时，胸口反而松一些。

她没有因此得出一个结论。可是她有了两样以前没有的东西：一句可以对医生说的具体的话，和一点对自己日子的了解。

下一次走进诊室，她没有再说「我不舒服」。她说：「我这两周记了点东西，您看看。」

医生接过本子，一页一页翻。翻到一半，他抬起头，问：「你说的这个对账的那两天，是每个月都这样吗？」

邱敏愣了一下，说：「好像是。」

「那我们再留意一下，下个月的这两天，看看。」医生说，「另外，你母亲复查的时候，你的睡眠怎么样？」

这两个问题，是邱敏从前没有人问过的。她一边想，一边回答，忽然觉得，自己是第一次被问到了点子上。

这个小动作不是治疗，它也没有给粥起名。不过它把这锅粥往前推了一小步：从「什么都在」，推到了「有几样东西，开始有了先后」。

两个人的头一回对话，也就有了一块能一起看的木头。

一个月后，邱敏又去了一趟。本子已经记了四周。医生翻着翻着，指着几行说：「你看，这两天最重，都在月底。你母亲复查的那几天，你也没有睡得更差。」

邱敏说：「那是不是说，是我工作——」她没把话说完。

医生说：「我不下这个结论。我们先看，它和月底的账、和你的睡眠，各有多大的关系。再记一个月，好不好？」

邱敏点了点头。她没有拿到一个病名，但她第一次觉得，有人在跟她一起，看着同一块木头。

这就是一锅粥，被一点一点陪成形状的样子。不是一次就成，是一次一次，慢慢分出层来。

回头看，这半年里最大的变化，不在邱敏的胸口，在她和医生之间。

从前，她是一个拿着一叠结果单、等一个结论的人，医生是一个看完单子、给一个结论的人。结论没有，两个人各自散开。现在，她手里是一个本子，医生手里是同一个本子，两个人的头凑在一页纸上。

胸口的紧，也许还在。可是这个复合体，已经不在原来的地方了。它有了一块可以下口的木头，有了下次再见的约定，有了一个「我们再看看」。这个「我们」，就是粥开始成形的最早的样子。

如果你也有一个说不清的难受，下面三件事，明天就能试：

一，先别急着给它起名。写事实，不写判断，一天一行。

二，下次见医生，不说「我不舒服」，说「这两周，几点，什么情形，持续多久」。

三，也问一问自己：这个难受，最近一次轻一点，是在什么时候，身边有谁，在做什么。

为什么写下来有用？

不是因为本子有什么魔力。是因为写的时候，你在做一件复合体需要的事：把一团东西，变成可以拿给另一个人看的东西。

一锅粥没法端给医生。你说「我不舒服」，医生接到的，也只是一个说法。只是一页记录，一天一行，几点，什么情形，就是一个可以放在桌上、两个人一起指着看的东西。

它是一块木头。有了木头，锯才有地方下口。

如果你是那个旁边的人，比如家人、朋友、同事，也有一件事，明天就能试。

当对方说「我最近不太舒服」，别急着回「你就是累了」，也别急着回「那你赶紧去查」。先问一句：「这几天，是哪个时候最明显？」

这一句话不是在审问，是在陪着粥分层。对方答得出，你就听着；答不出，你就说：「那我们先留意几天，好吗？」

很多时候，一个人最需要的，不是一个答案，是有人愿意跟他一起，在一锅粥面前，再坐一会儿。

这三件事不是诊断，也不替代诊断。它们只是帮粥把自己的先后摆出来，好让下一章的那一刻，更容易发生。

身体或心里的难处真的大了，请找医生或心理咨询师。

带 走 的 话

诊断之前的苦不是空的，是什么都在、还没分开；说不清哪里难受，不是你的错，是这锅粥还没找到形状。

小　账

这一处，开门还是关门：开的是「土」那一扇。苦缠在日子里，它的土，本来就不只在身体里。

病放在一个人身上，还是放回复合体里？「未见异常」那一刻，两头对不上，不是邱敏的病，也不是医生的错，是复合体还停在一锅粥里。

想 一 想

一，你最近一次说不清哪里难受，是什么时候？当时是谁在听你说，又是怎样听的？

二，假如那天有人没有说「没事」，也没有催你「再想想」，只是陪你把事实一行一行写下来，会有什么不一样？

三，你身边有没有这样一个人，正待在一锅粥里？你能做的最小的一件事，是什么？

◆

06

第 6 章

诊断即开题

◆ 一、你一定有过这样的时刻

医生看着单子，停了一下，说出一个名字。

屋里的空气变了。

你可能松了一口气：终于有名字了，原来不是我矫情。你也可能沉了下去：这个名字，我在别人嘴里听过，说的是另一个人。大多数时候，两样都有，一前一后，甚至同时。

接下来的几分钟，你多半没听清医生在说什么。耳朵里只有那个名字，在回响。

等你走出诊室，坐在走廊的塑料椅子上，才发现手里多了几张单子，口袋里多了一个说不清的重量。回家的路上，你可能会不停地想：我昨天还好好的，怎么今天就成了「这个病」的人？

你昨天，其实也没有「好好的」。你的头沉、你的累、你的睡不着，昨天都在。变的不是它们。

变的是：从那一刻起，这些东西有了一个名字，你有了一个位子，对面有了一个人，和你一起面对这个名字。

再换一个场景。豆豆七岁，这个冬天老是咳。外婆带他去看医生，医生听了听，问了几句，在病历上写下一个名字。名字是什么，这里不写，因为要紧的不是它。

要紧的是，回家的路上，豆豆拉着外婆的手问：「外婆，那我是不是不能吃冰淇淋了？」

外婆愣了一下。她还没想到这一步。

你看，一个名字刚落下，七岁的孩子问的第一件事，不是「这是什么」，是「我的日子要怎么改」。孩子比大人更直接地看见了：病名不是一句话，是一把要在日子里使的钥匙。

这一章，讲的就是这一刻。

王德生博士对这一刻有一个判断，大意是：所谓诊断，就是健康发生学的开始。

这句话，初听有点怪。我们都习惯了，诊断是「查出来了」，是找病的最后一步。怎么会是开始？这一章要慢慢讲通它。

◆ 二、老看法：诊断是终点

先把老看法摆足。它对在哪里，值得说清楚。

发现学医学里，诊断是一件很庄严的事。

病先在身体里，医生用问诊、查体、化验、影像，一步一步靠近它，最后把它认出来，叫出它的名字。这个名字，不是随便叫的，它背后是几百年的积累：一种病长什么样，从哪里来，往哪里去，用什么办法对付。医生认出它，就等于把一大片已有的知识，接到了眼前这个人身上。

这件事的功劳，要写足。

第一，有了名字，治疗才有路。同样是胸口疼，是心梗，还是胃食管反流，办法完全不同。名字不对，办法就不对。诊断把「该做什么」这个问题，缩小到了一个可以回答的范围。

第二，有了名字，人才能松一口气。没有名字的难受，最折磨人。名字一出，哪怕是个不好的名字，人也常常觉得：总算有地方可站了。

第三，有了名字，日子里的许多事才有了依据。请假要有诊断证明，医保报销要有病名，药要对着病开，学校对孩子的照顾，单位对老人的体谅，都要有一个说法。

第四，有了名字，医生与医生之间才能说同一种话。一个人从这家医院转到那家医院，病历上的病名，是他随身带的一张通行证。

孔子说过，大意是：名分不正，说话就不顺（《论语·子路》）。这句话讲的是政事，可挪到病床边，也有几分贴切：一个难受，没有名字的时候，说起来磕磕绊绊；有了名字，话才顺得下去。有人把这叫作「命名的力量」。它不是玄的，是日子里的实在。

所以，「诊断是真相到手」这个说法，在这些条件下完全成立。病有清楚的形状，检查手段足够，医生的判断可靠，要做的事，是把一个已经在那里的东西认出来。

可是，请注意老看法里藏着的两个预设。

一个是：病先于诊断。诊断来之前，病就已经在了，诊断只是把它「查出来」。

另一个是：诊断之后，医学的「认」就完成了。接下来是治疗，是执行，是病人听话、按时、遵医嘱。认的那一步，到此为止。

在这个画面里，诊断站在中间，像一座界碑：前面是找，后面是治。过了界碑，找的人和被找的东西，各回各位。

这个画面，在很多时候好用。不过它有一个看不见的缺口。

它没有回答：为什么同一个病名落下去，有的人从此换了活法，有的人什么都没变？为什么同一个诊断，在一家人里变成了一场家庭大事，在另一家人里只是饭桌上多了一句话？为什么有人听完病名，当天晚上就睡踏实了，有人听完病名，从此夜夜睡不着？

病名一样，医生一样，药一样。不一样的，是那个名字落进去的日子。

老看法对这个问题，通常有一个答案：病人的配合度不同。配合的好，不配合的坏。

这个答案不算错，只是它只看了一端。「配合」两个字，把全部的事，推到了病人身上。而病人是不是配合，常常取决于：诊室里那几分钟，有没有人把话说到

他心里；回到家以后，有没有人跟他一起把事做下去；复诊的时候，有没有人把他说的小事，当一回事。

这些，都不在病人一个人手里。

◆ 三、本书的说法：三样东西一起显影

本书的说法是：诊断那一刻，有三样东西，一起出现了。

第一样，是病人位。在这一刻之前，他是一个头沉的人、一个累了的人、一个不想麻烦孩子的人。有了诊断，他又多了一个位子：病人。这个位子，有它自己的一套规矩：要按时复诊，要记数，要改一些吃法，要在别人问起时，答一句「我这个病」。

第二样，是医生位。在这一刻之前，对面坐着的，是一个穿白大褂的陌生人。有了诊断，她成了「我的医生」：下一次复诊找谁，有事问谁，这个名字是谁给的，谁就是那个能回答的人。

第三样，是病名。在这一刻之前，那个数字，那阵头沉，只是一些零散的东西。有了诊断，它们被一个词收拢了，这个词带着一整套的书、药、指南、经验，向这个人走来。

三样东西，一起出现。不是先有了病人，才有医生，才有病名。也不是先有了病名，才派生出病人和医生。

这件事，你在另一个场合见过。一个孩子出生的那一刻，屋里同时多了三样东西：一个孩子，一个母亲，一个父亲。

出生之前，屋里有一个怀着孕的女人，有一个等在外面的男人。他们是两个大人，各有各的名字和脾气。可是「母亲」「父亲」这两个位子，要等孩子出生，才真正落座。母亲的位子，是孩子的第一声哭给的；孩子的位子，是母亲的第一次抱给的。三样东西，没有一样是另一样的先行者。

诊断那一刻，也是这样。病人位、医生位、病名，是互相给出来的。

病人位没有病名，只是一个「不舒服的人」；医生位没有病名，只是一个「听我说话的人」；病名没有这两个位子，只是书上的一个词。三样合在一起，一个具体的、可以往前走的局面，才站起来。

这个局面，是一个复合体：医生—病人这个互动复合体，在这一刻，第一次有了形状。

注意主语。

这一句不是说，医生做出了诊断，病人接受了诊断。那是老看法的写法：一个人做，另一个人受。本书的写法是：复合体显出了一个形状，这个形状里，病人位、医生位、病名，三处同时亮起。医生开口说出的那个词，是这个形状里亮得最清楚的一处，不是形状的发动者。

三处里，亮得最清楚的，是病名；医生那一句话，分量最重。不过别忘了，同一句话，换一个听的人，就不是同一个分量。对一个已经等了三个月的人，它是落地的靴子；对一个什么都没准备的人，它是平地起的一声雷。

话的分量，不在话里，在话落进去的那个复合体里。

用本书的总比喻说：一把锯，两个人各握一头，锯口一直没有咬进木头。诊断那一刻，锯口第一次咬了进去。不是哪一头先咬的；是两头一拉，锯齿就陷下去了。

所以，王德生博士说诊断是健康发生学的开始，意思是：**这一刻不是发现的终点，是状态发生的起点**。从这一刻起，这个复合体才有了「状态」可言：它可以是流通的，可以是卡住的，可以往好处转，可以往坏处转。在这一刻之前，它只是一锅粥。

这一点，是全书最要紧的一个转折。

◆ 四、挂号那一刻

说到这里，要回到全书的总钥匙了。

挂号那一刻。

你站在挂号窗口前，或者在手机上点下「确认」，一张挂号单出来。上面印着你的名字、一个科室、一位医生、一个号码。

就在这一刻，几样东西开始一起出现。「病人」这个词，第一次被盖在你的名字上。「科室」这个词，划出了你的难受大概该往哪里去。「医生」这个词，从一个远处的名字，变成了今天要见的人。

这就是第一次显影。

此刻显出来的，是一个粗粗的轮廓。你是「内科的病人」，对面是「内科的医生」，那个病名还空着，要等医生叫出来。只是轮廓已经有了。邱敏一走进医院，被叫到号，坐在诊室里，那个「病人」的轮廓，就已经盖在她身上了。

所以，挂号那一刻，是一次预显影；诊断那一刻，是一次完整的显影。

一个比方，来自周老师的老本行。学生走进考场，拿到试卷，名字写在卷头：这是预显影，你已经是「考生」了。可是真正的开题，是翻到作文题那一页：题目一出，这篇文章该往哪里写，才有了方向。

挂号，是进了考场。诊断，是翻到了作文题。

在本书的导论里，有一张挂号单，上面只有姓名、科室、医生、号码。那时我们说，这张单子一出，几样东西就开始一起显影。现在可以补一句：那一次，是显了个轮廓；诊断这一次，是把轮廓填成了形状。

这两步合起来，是诊断的全部。挂号让「病人位」和「医生位」第一次落座，诊断让病名第一次落座，三样齐了，题目才有。

这里有一件很容易错过的事。在挂号那一刻，很多人并不知道自己要被写成什么病。邱敏挂的是内科，周老师挂的是心内科，这个选择，已经是一次猜：我大概是哪一类。这个猜，会影响接下来医生先问什么，先查什么。

有时候，这个猜是错的。一个人挂了消化科，听完几句话，医生说：「你这个情况，我建议你去看看心内科。」他拿着单子，又换了一个窗口，重新挂了一次号。

这时候，轮廓被改了：他从「消化科的病人」，变成了「心内科的病人」。对面的医生位换了人，那个还没落下的病名，也换了一片可以长的地方。

所以，挂号那一刻的轮廓不是死的。它会在一次一次的碰面里被改，被收窄，被推翻。它是一个正在成形的东西，不是一张写定的单子。

挂号那一刻的轮廓，与诊断那一刻的名字，是连在一起的。轮廓先给了名字一个可以长的地方，名字再回头把轮廓填实。

有人把科室比作「测量基」：挂了哪一科，就读出哪一科的病。这个比喻有力，却不能当定论，第 7 章要把它公开收窄。现在只记住：挂号和诊断，是同一个显影的前后两步，合起来是复合体第一次有了形状。

◆ 五、病名是第一次回写

形状一出来，马上有一件事跟着发生：它开始回头改东西。

这就是本书说的「回写」：长出来的东西，回头改土、改路。

病名，是复合体的第一次回写。它往两个地方写。

先写进病历。

病历是什么？是一张纸，或者一个电脑页面，上面有姓名、年龄、主诉、检查结果、诊断、处理。它是这个复合体的一份记录。

可它不只是记录。它还会改变后面的事。下一次复诊，这位医生翻开病历，先看见的，是那个病名。她下笔写的下一行，就是在这个名字的基础上写。如果这个人转去另一家医院，那里的医生翻开病历，同样先看见这个名字。

病历把第一次的显影，传了下去。后来的每一次见面，都是在这个名字上接着长。

所以，一个病名落进病历，不是一件「事实已经说清」的事，是一件「后面所有的事，都从它长出来」的事。

再写进日子。

病名写进日子的方式，比写进病历的方式多得多，也软得多。

它写进作息：早晚各量一次，药要按时吃，晚上不要熬太晚。

它写进饭桌：盐要少放，汤要少喝，老同学聚会，别人劝酒，要说一句「我不能喝」。

它写进称呼：自己说「我这个血压」，老伴说「你那个血压」，孩子在电话里说「爸，你血压今天怎么样」。

它写进别人看你的眼神：有人变得小心，有人变得同情，有人在你说累的时候，会加一句「你就是不听话，我早说过」。

它写进你看自己的方式：从前你说「我头沉」，现在你说「是不是血压」。同一阵头沉，原来属于一个累了的人，现在属于一个「有病的人」。

这些改变，不是病名「命令」出来的，是病名落进去以后，周围的人、周围的事，一起慢慢长出来的。它们是回写。

同一个病名，说出口的语气不同，回写也不同。

「你这是高血压。」医生平平地说，像说一件天气。听的人松了口气：原来是这么回事。

「你这是，高血压。」换一种声音，停一下，眉头一皱，听的人心里一紧：很严重吧?

字一个没变，落进去的东西，就是两样。所以，诊断不只是一个词，是这个词连同它被说出来的整个情形：谁说的，怎么说的，说完以后留下了什么空，接着又问了什么。

这些，都是病名的一部分。

请注意一个区别，本书一直强调它：回写，不是存档。

一份病历锁进抽屉，一个病名贴在档案里，库房越堆越多，却不回头改日子的生产线，那不叫回写，那只是存档。病名真正成为回写，是它回头改了饭桌、改了作息、改了称呼、改了下一次医生开口的第一句话。

病名还有第三个去处，常被人忽略：写向医生。

下一次，同一位医生见到这个病人，她的第一句话，已经不是「哪里不舒服」，而是「血压记录带了吗」。她的眼睛先看哪一页，耳朵先听哪一句，都已经被那个病名改过了。医生位上的人，也被这个名字回写了。

所以，回写是双向的：病名既改病人的日子，也改医生的看法，也改两个人下一次说话的方式。

还有一件事，要先说在前头。回写不分好坏。

一个病名落进日子，可能让一个人开始认真照顾自己，开始每天走一走，开始约老朋友喝茶而不是喝酒。这是好的回写。它也可能让一个人从此不敢出门，不敢爬楼，不敢高兴，觉得自己是个一碰就碎的人。这是另一种回写。

同一个病名，两种回写。是什么让它们分开的？第 8 章，专讲这个。

◆ 六、同一个名字，三户人家

回到第二节留下的那个问题：同一个病名，为什么落进不同的日子，长出不同的东西？

不妨看三户人家。人是虚构的，事是常见的。

第一户，就是周家。周老师听到「高血压」的当天晚上，家里的汤淡了一点，父女俩在电话里互相开了一个玩笑，第二天一早，红皮本子写下了「第一天」。病名进了这个家，家里的话还是通的：老伴敢说「淡了」，周老师敢回「也不能一下子这么淡」，周岚敢说「你就是你」。

病名在这个家里，成了一件可以谈的事。

第二户，姓刘。刘师傅五十五岁，开了半辈子货车。同样是听到「高血压」，他回到家，儿子的第一句话是：「爸，你以后别开车了，也别提重东西了。」媳妇悄悄把家里的盐罐换了。亲戚来看他，说话都压低了声音。

没有人说错。每个人都是好意。不过不到半年，刘师傅变了：他不再出门，不再跟老伙计喝茶，觉得自己「是个废人」。他的血压数字并不难看，只是他整个人的日子，缩成了小小的一块。

病名在这个家里，成了一个把人罩住的笼子。

第三户，姓郑。小郑三十出头，在互联网公司上班。体检查出血压偏高，医生开了药，叮嘱按时复诊。小郑点头，转身就忘了。药吃了一阵就断，复诊的时间过了，也没人提。他的同事不知道，家人也不知道，那个病名只存在于一份躺在手机里的电子报告里。

病名在这个人这里，没有往日子里写。

三户人家，同一个名字。

第一户，名字成了路：它让日子有了可走的先后，也让家里的人能一起走。第二户，名字成了笼：它把人罩住，人和日子都缩了。第三户，名字落了地，没有生根：它只是一个存在手机里的词。

注意，这三户的差别，不能说成「周老师的性格好，刘师傅的性格弱，小郑的性格马虎」。那是把差别又装回一个人里面。差别在于：病名落下去之后，那个复合体，怎样接住了它。

周家的复合体，医生位、病人位、女儿、老伴，是通的。刘家的复合体，有一处被好意压得太紧。郑家的复合体，医生位那一头，病人位那一头，根本没有再接上。

这三种情形，第 8 章会专门细讲。这里只留一句话：**同一个病名，不决定它自己的命。决定它的，是它落进去的那个复合体。**

◆ 七、诊断不是判决，是一条路的开端

有了回写这个词，可以回头把「开题」讲清楚。

为什么本章的题目叫「诊断即开题」？

开题，是写作文的第一步。题目一出，写作才算开始。可是，题目不是文章。

周老师教了三十多年语文，对这件事最清楚。他常对学生说：「题目发下来，你别急着写。先审题。」审题，就是弄清楚这个题目问的是什么，边界在哪，从哪里下笔，要避开哪几条路。

他还说过一句话：「最怕的，不是题目难，是还没读懂题目就动笔。」

有的学生拿到题目，一眼扫过去，抓住一个词就写。写到一半，才发现跑了题。有的学生一看题目就慌，觉得这回完了，手一直抖，字都歪了。还有的学生，把题目当作命令，一板一眼，照着字面写，写出来的东西没有一点活气。

三种学生，对待题目的方式，竟然和三种病人对待病名的方式很像：抓住一个词就冲的，被题目吓住的，把它当命令的。

题目本身，没有错。错的是把题目当成了文章。

一个题目发下来，十个学生，十篇不同的作文。题目是同一个，写出来的东西，各不相同，因为每个学生的功底、素材、心思，各不相同。

诊断就像这个题目。

「高血压」，是一个题目。写出来的文章，是日子：周老师今后的每一次量血压、每一次复诊、每一回在饭桌上的取舍、每一次和医生的商量。每一篇都不一样。

如果把诊断当成判决，画面就变了。判决是：你有罪，刑期若干，照做就是。判决之后，没有写的余地，只有服的余地。

很多人听到病名的那一刻，心里想的，正是判决。「我完了」「我这一辈子就这样了」「我不如以前了」。这种感觉，是真的，也是可以理解的。因为我们长久以来，是在判决的画面里理解诊断的。

不过诊断更像题目：它给出了方向，限定了边界，圈出了要对付的东西。它没有写下结局。结局，要在以后的一次一次碰面里，一起写出来。

这就是「一条路的开端」。

路是什么？本书说，路是一串有先后、会修正、会收拢的不同。诊断之后的路，大致长这样：一次，两次，三次复诊；每一次都有新的数字，新的发现，新的调整；上一次说的话，下一次可能被改；今天定下的办法，下个月可能换。

它不是一条直线，也不是一条一下子就能走到头的路。它会拐，会停，会倒回头。

这条路上，医生位和病人位，是一起走的。医生不是「宣布结果」的人，病人也不是「接受结果」的人，两头握着同一把锯，一下一下地拉。

复诊，在这个画面里是什么？

在判决的画面里，复诊是「检查执行情况」：上次说的做了没有，数字合格不合格。

在开题的画面里，复诊是「再审一次题」：上次的题目，现在看是不是还一样；上次写的几句，有哪几句要改；有没有什么新的东西，进了题目的边界。同一个病名，今年的审法，和去年的审法，可以不同。

第 8 章会说到一件相关的事：第二意见和复诊，并不是纠错，是重新起头。

有一点，要说得再老实些。这并不是说，诊断随便怎么定都行，也不是说，病名只是一种说法。袖带上的数字，血管里的变化，该管的就是要管。本书不讲这个。本书讲的是：该管的事情，是在一条路上被管的，不是在一座界碑前面被宣布的。

◆ 八、只看一端会怎样

同样，这一章也要问：只看一端，会怎样？

先看只盯着病人这一端。

话变成：你确诊了，你就是病人了，从今以后，你要这样那样。

病人一端的责任，被说得很重。要按时，要自觉，要克制，要听话。出了问题，是「你没管好自己」。

结果往往是：病人一边承受病名带来的重量，一边承受「是我没做好」的自责。有的人因此隐瞒，有的人因此放弃。

再看只盯着医生这一端。

话变成：医生已经诊断了，说得清清楚楚，你照做就是。

诊断被当作医生一个人做完的事，交到病人手里，像一份作业。复诊变成了「取药」「检查」「看数字」，医生与病人之间，剩下的是核对，不是商量。

这样的诊所里，往往效率很高。只是病名落进日子里的那些事，没有人问：他吃饭怎么吃？她睡觉几点睡？家里有没有一个人，能提醒他吃药？这些问题没有出口，因为在这个画面里，诊断之后的事，不属于医生，只属于病人。

只盯病人，病名变成了一个人的重担。只盯医生，病名变成了一个人的结论。两种画面里，病名都站在一个人那一边。

这就是为什么，同样一句「按时吃药，定期复诊」，有的人听了踏实，有的人听了发憷。同一句话，一个人听到的是「我们一起管着」，另一个人听到的是「你自己管好」。区别不在字面，在这句话是从哪个位子上，落到哪个位子上的。

本书的写法是：病名站在复合体上。它是医生位与病人位共同面对的一个形状，是两头合拉的一把锯。

还有一端，常被忘记：病人身边的人。

家人、朋友、同事，也在复合体的边上。老伴把汤做淡，孩子打电话多问一句，同事把会议挪开让他去复诊。这些都不是医生做的，也不是病人一个人做的，不过病名的回写，大半就写在这些地方。

只盯病人，只盯医生，这些人都不见了。

只有把眼睛放回复合体，才看得见另一些事：病人这边多说一句「我吃了药就头晕」，医生那边就有了可以调整的东西；医生这边多问一句「你家里谁做饭」，病人那边就有了可以说的话。这些话，不是「额外的沟通」，是路本身。

◆ 九、今天与机器

今天，诊断这件事，也有机器来凑热闹了。

有人在体检报告出来后，不等医生解读，先拍照发给一个会说话的机器，问：「我这是什么情况？」机器会列出几种可能，解释几个术语，说哪些需要进一步检查。

有人在医院看完病，回家把诊断证明再拿给机器读一遍，问：「医生说的这个，是什么意思？」机器耐心地讲，讲得有条有理。

这些用法，有它的好处。人在诊室里往往紧张，没听清医生说了什么，回家有一个可以反复问的地方，是实在的帮助。把不懂的词问清楚，也让很多人敢于在下一次复诊时多说几句话。

不过这里有一个地方，要看清。

机器说出一个病名的时候，三样东西里，缺了两样。

它说得出病名，只是它不在医生位上：它不会在下一次复诊时，坐在那把椅子上，翻开你的病历，接着上一次往下问。它也不知道你家的饭桌是怎样的，你的老伴会不会提醒你吃药。

至于病人位，在机器面前也是空的。你向机器提问的时候，你还没有被它「挂号」，没有被它写进任何一份会回头改你日子的记录。

所以，机器给出的，更像是一份文字的题目解读，不是开题本身。开题，要有两个位子同时落座。

还有一件今天才有的事，值得单独说。

很多医院的检查结果，现在会先出现在病人的手机里。报告单上，数字旁边带着箭头，有的箭头朝上，有的朝下，有的标着红色。病人在医生看到之前，就先看到了。

这时候，病名的一部分，已经在没有医生位的地方，提前显影了。病人位亮了，病名亮了一半，医生位却空着。一个人对着屏幕上的红色箭头，从晚上看到半夜，把能搜到的词都搜了一遍。等到第二天走进诊室，他带来的，已经不是一锅粥，而是一个被他自己吓了一夜的形状。

这样的形状，往往比实际的更重。

这不是机器的错，也不是病人的错。它是一个复合体里的位子，没有同时亮起来。三样东西本该一起出现，现在是一样先到了，另外两样迟到。迟到的这段时间，由焦虑来填。

所以，不少医生现在会在检查前就说一句：「结果出来你可能会先看到，别自己下结论，等我们见面再看。」这一句话，是在替那个空着的位子，提前占座。

这并不是说机器没用。第 16 章要专门讲：当机器也成为复合体里的一个位子，三方一起的时候，诊断会长成什么样。眼下只是留一个提醒：一个病名，从机器嘴里说出来，和从「我的医生」嘴里说出来，不是同一件事。

◆ 十、一个完整的例子：周老师确诊那天

回到周老师。第 1 章讲过他是怎样在小区门口被拉住量血压的，也讲过那天走出诊室，「像有一扇门在身后关上」。这里接着往下讲，讲一周后的复诊。

那天是个阴天。他早早到了医院，还是上次那个心内科，还是那位女医生。

检查单已经全回来了，他坐下，把一叠纸递过去。

医生接过来，一张一张翻。屋里很安静，只有纸的声音。翻到最后一张，她抬起头，看着他，说了一个病名，说得很平常，像说「今天有雨」：高血压。

她接着又说了几句。大意是：这个情况，要长期管着；会给他开药，要按时吃；饮食上要有些调整，盐不要多；回去自己备一个血压计，早晚各量一次，记下来；下次复诊，带着记录来。

周老师点头，一下一下点。他有点想问点什么，又不知道问什么。

后来他对老伴说，那一刻他脑子里只有一个念头：这一辈子给学生出过多少题，今天头一回，自己被人出了一道。

他没问出口的那些话，后来是在红皮本子里一点一点问出来的。

其实，这是很多人走出诊室那几分钟的样子：耳朵里装满了刚听到的话，嘴里却一句也问不出。问题是回到家，在饭桌上、在睡前、在量血压的那一刻，才一个一个冒出来的。

所以，诊断那一刻之后，复合体最要紧的一件事，是给这些后来冒出来的问题，留一个出口。下一次复诊，是一个出口；一个能发消息的渠道，是一个出口；一本红皮本子，也是一个出口。出口越多，路越通。

出了诊室，他在走廊的椅子上坐了一会儿。他拿出手机，想给周岚打个电话，拨了一半，又挂了。

回到家，老伴在厨房里问：「怎么说？」

他说：「说是高血压。」

老伴「哦」了一声，手里的菜刀停了停。又问：「严重吗？」

「要长期吃药。」

两个人都没有再说话。

晚饭，老伴做的汤，比平时清淡。他喝了一口，说：「淡了。」老伴说：「医生不是说少放盐吗。」他说：「也不能一下子这么淡。」两个人都笑了一下，笑得有点勉强。

这一餐饭，是病名第一次回写进饭桌。

夜里，老伴睡不着，翻了个身，问：「你睡了没有？」

周老师说：「没有。」

老伴说：「我在想，是不是平时盐吃多了。」

他说：「别想这个。医生说了，不是谁的错。」

这句话，是他在诊室里听来的，转给了老伴。病名落进这个家的第一个夜晚，它先被拆掉了一样东西：「是谁的错」。后面的路，才好走。

那天晚上，他才给周岚打了电话。电话一通，他先开了口：「你猜怎么着，我现在是高血压了。」

他的语气是半开玩笑的，可是电话那头沉默了两秒。

周岚说：「爸，诊断是怎么写的？药是什么？」

她问得很快，很专业，是医生的口气。他把单子上的字念给她听。她听着，「嗯」「嗯」地应着。念完了，她停了一下，换了一种声音：

「爸，这个不是什么大事。不是一件定了的事，是一件要管着的事。你按时去复诊，把数记下来。」

他说：「知道。」

她又说：「你别觉得，从今天开始你就成了病人，你就是你。」

他在电话这头笑了，说：「你这是以医生的身份说，还是以女儿的身份说？」

电话那头，周岚也笑了：「两个都有。」

我们来看这一天。

周老师没有变。头沉的毛病在，字发飘的毛病也在，爬楼梯会停一下的毛病，一点没少。变的是这个家里多了几样东西。一个病名，一个小血压计，一个红皮本子，一句「我这个血压」，一碗清淡的汤，还有一次电话里两头都想把话说得轻一点。

这一天，三样东西一起出现：他成了病人位上的人；那位女医生成了他的医生位上的人；高血压这个词，落进了病历，也落进了饭桌。

更有意思的是周岚那一句「你就是你」。

她没有否认病名，她也没有否认父亲现在有一个「病人位」。她做的是另一件事：让那个位子，别把人压扁。这是复合体里的一次修复，发生在一通电话里，发生在一个女儿与父亲的玩笑里。

她在诊室里是医生。可在那天晚上，她不在那间诊室，也不是那位女医生。同一个人，在不同的互动里，坐在不同的位子上。在诊室里，她是医生位；在父亲的电话里，她是女儿；哪天她自己发烧去挂号，她又是病人位。位子会换，第 1 章和第 2 章都讲过这件事。

第二天一早，他又量了一次。袖带绕上手臂，数字出来，他拿起红皮本子，翻到第一页，用钢笔写下日期、两个数，在旁边多添了一行小字：「第一天。」

他教了三十多年语文，知道一篇文章的第一行，是最难写的。他看着这一行，笑了一下。

那一页的纸，后来越写越满。他后来八年的日子，是从这一页开始长的。

诊断那一天，对周老师来说，没有结束，是开始。

◆ 十一、放回日子里

回到豆豆。

回家的路上，豆豆问外婆：「那我是不是不能吃冰淇淋了？」外婆愣了一下，没有马上回答。

她蹲下来，对豆豆说：「外婆也不知道。我们下次去，问问医生，好不好？」

豆豆点头。他又问：「那我可以把这个问题写下来吗？」

外婆笑了：「可以呀。」

当天晚上，豆豆用彩笔在一张纸上写下他的第一个问题。字歪歪扭扭，旁边画了一个冰淇淋。外婆把这张纸夹进了病历本里。

下一次复诊，医生翻开病历，看见那张纸，先笑了，然后很认真地回答了它。

一个七岁孩子的第一道「审题」，就是这样开始的。

回到你自己的日子。

你可能不是周老师，没有被说出过一个病名。但你一定有过这样的时刻：有人对你下了一个判断，说「你这个人就是那样的人」，说「你家这孩子就是那样的孩子」，说「你这个情况就是这么回事」。

这个判断，是一个题目。它给了你一个方向，也给了你一个边界。

怎么写这篇文章，是你和对面那个人，一起往下写的事。

下面几件事，明天就能试：

一，下次从医生那里带回一个病名，先别急着把它当成结论。回家后，找个本子，写三栏：这个名字是什么意思；它让我今天要改什么；我还有什么想问。

二，复诊前，把本子翻出来。上一次的疑问，这一次问。别把复诊当成「去取药」，把它当成「把题目审一遍」。

三，如果家里有人刚被诊断，先别忙着劝，先问一句：「医生怎么说的？你自己怎么想？」让那个位子，有机会被说出来。

四，如果你自己是医生，或者是家里的那个「懂行的人」，诊断说出口的那一刻，不妨多留半分钟。不是为了安慰，是为了让这个题目，被两个人一起读一遍。

如果你自己是医生，下面这件事也值得试：诊断说出口之后，留半分钟，问病人一句：「刚才我说的，哪一句你最想再听一遍？」

不是为了确认他听懂了，是为了让他的耳朵，从那个名字上，挪回自己的日子。很多病人说，那半分钟，是整个门诊里，最不像被「处理」的一刻。

身体或心里的难处真的大了，请找医生或心理咨询师。

带 走 的 话

诊断不是对一副身体的判决，是复合体第一次翻开的作文题；题目出了，文章才开始，怎么写，是后面每一次见面的事。

小　账

这一处，开门还是关门：开的是「路」那一扇。诊断一落地，往后的复诊、调整、回写，才有了可走的先后。

病放在一个人身上，还是放回复合体里？病名一出，病人位、医生位、病名三处同时亮起，病不属于其中任何一处，它属于这个刚刚有了形状的复合体。

想 一 想

一，你上一次听到一个病名（自己的，或家人的），是什么时候？那个名字落进日子以后，最先改变的是哪一件小事？

二，如果把那个病名当成一道作文题，你和对面那个人，各自会怎么写第一段？

三，谁在你的日子里，曾经对你说过一句「你就是你」？那一句，改变了什么？

◆

07

第 7 章

为什么「科室就是测量基」要收回

◆ 一、你一定有过这样的时刻

阿青三十八岁，在一家公司做会计。年初，她的胃不舒服。饭后发胀，半夜有时会烧一下，早上起来没有胃口，连平时爱喝的那碗粥也咽不下去。

她挂了消化科。医生问了几句，开了胃镜。结果出来，病历上写的是「慢性浅表性胃炎」。她拿了药，记下要忌的口，约好两个月后复查。回到家，她把辣椒酱收进了柜子最里面。这件事有了名字，她心里踏实了一些。

人对没有名字的难受，最没办法。有了名字，至少知道往哪个方向使劲。

到了秋天，胃又不舒服了。这一回，她没有再去消化科。胃镜都做过了，再去也还是那一套，她想。同事听她说起，随口一句：你最近是不是压力太大了？

她想了想，挂了心理科。

心理科的医生没有先问胃。她问的是：睡得怎么样，夜里醒来都想些什么，上班的时候最怕哪一件事。聊了四十来分钟，病历上写的是「焦虑状态，伴躯体症状」。医生还说，这种情况很常见，不用太担心，

那天晚上，阿青把两份病历摊在沙发上，看了很久。

一份说，是胃。一份说，是心。

同一个胃，同一个人，同一年。她忍不住想：到底哪一份是对的。

她给母亲打了个电话。母亲在电话那头沉默了一会儿，说：「胃痛还能是心里的事？你小时候考试前也肚子疼，我就说，别吃那么多凉的。」

母亲这句话，把春天、秋天和小时候的考试连在了一起，可是并没有帮阿青决定，到底该信哪一份。

第二天上班，她在财务室里对着一张对不上的账发呆。一个同事路过，问她怎么了。她说：「两张表，数字都没错，可就是合不到一起。」说完，她自己愣了一下。

这话说的是账，可也像是在说她自己。

你大概也有过这样的时刻。一个身体，换了一扇门进去，出来是另一个说法。你要么怪其中一位医生，要么怪自己，当初怎么没挂对号。

本书这一章，要从这个时刻讲起。不过先交代一句：这一章要收回本书自己的一个说法。

◆ 二、老看法：科室就是测量基

先说一个词，叫「测量基」。

这个词来自量子力学，意思其实很家常。物理学家要测一个粒子的自旋，可以先选好沿着哪个方向去测。沿上下测，读出来的是「上」或「下」；沿左右测，读出来的是「左」或「右」。方向选好了，读数的样子就跟着定了（量子力学教科书里都有讲，这里只取大意）。

这是一个近邻，本书只借它来说话，不拿它当证明。量子力学没有证明什么医学，这一点本书从头到尾都不让步。

有人喜欢把话说大：量子世界里，观察会改变结果，所以医生的目光、病人的意念，也会改变病情。本书不这样说。这样说，一来说不通，二来会让正在难受的人，平白多背一条「是你想多了才病的」。本书只取一点点：在那个世界里，问法和读数是缠在一起的。借来说话，到此为止。

借到医院里，是这样一幅图。

一个人身上有些难受。他走进哪个科室，就等于选了沿着哪个方向去测。消化科的方向，是饭后、胃镜、黏膜的颜色。心理科的方向，是睡眠、担心、量表上的分数。方向不同，读出来的东西就不同：一个读出胃炎，一个读出焦虑。

你在生活里也见过这样的事。一块布料放在裁缝面前，他先拿皮尺量尺寸；放在收破烂的人面前，他先拿秤称斤两。布还是那块布，量出来的却是长宽，或是重量。尺子一拿，话题就定了。

再换一个医院里的例子。一位八十岁的老人摔了一跤。骨科的医生读出来的，是骨头有没有裂；老年科的医生读出来的，是这个人的肌肉、营养和步子是不是整体在往下走；康复科的医生读出来的，是他还能不能自己上楼。三个读数，三个方向。

所以才有这句话：科室就是测量基。科室选定了，读数跟着定。

这个说法在医患之间传得很快，因为它好用。

它先解决了一个老问题：为什么换一家医院，病就变了？不一定是谁看错了。是方向不同，读数自然不同。

它还给了病人一个台阶。阿青手里的两份病历，不必有一份是错的。两份都是真读数，只是沿着不同的方向读出来的。

它也让医生松了一口气。医生被问到「别的医院怎么说得不一样」，用不着急着辩护，也用不着贬低同行。说一句「我们看的方向不同」，话就可以接着往下谈。

你在医院的走廊里，说不定就听过这样的对话。

消化科的老高在走廊里碰见周岚，说起一个共同的病人：「我这边读出来是胃炎，你们那边写的是焦虑，你我谁对？」

周岚说：「都对。你问的是胃，我问的是睡眠。」

老高点点头，各自忙去了。这一句「都对」，让两位医生都不必再争，也让病人少挨了一场夹在中间的难受。它省事，它体面，它在很多个走廊里每天被说上好几遍。

也正因为它这么顺手，它很容易被当成最后的答案。

本书前面讲挂号那一刻时，也顺口用过这个说法。它有力，可不能当定论，本章就来把它收窄。

◆ 三、先说它对在哪

这个比喻不是胡说。它在一个很具体的条件下完全成立，这个条件是：科室已经在那里，像一把磨好的尺子，等着人走进去。

体检中心就是这样。一条流水线，每个项目在哪一间屋、问什么、用什么仪器，都是早就定好的。同一个人这个月走一遍，下个月再走一遍，读数大体差不多。这时候说「方向定了，读数跟着定」，一点毛病也没有。

在一家大医院里，科室的牌子也是挂好的。病人走进某一层楼，哪一间诊室对应哪一类问题，常常一目了然。这时候，这个比喻等于是在描述一个已经成形的样子。

它还至少对了三件事。

第一件，读数不是真相本身。读数是问法的产物。你问饭后，就得到饭后的答案；你问睡眠，就得到睡眠的答案。本书第 2 章讲医生不是发现者的时候，已经站在它这一边了。

第二件，差异不等于错误。同一副身体，换一家医院读出不同的病，常常不是有人看走了眼。这个比喻让读者可以不急着找罪人。

第三件，它说明了为什么大病要多科会诊。一个方向只能读出一种读数，几个方向并在一起看，才不容易把一块地看成一条线。

回到阿青那个晚上。她盯着两份病历，不再追问谁对谁错，开始问：这两份是怎么放到一起的？这一问，就是靠这个比喻才问得出口。

对它公道的话，还有一句。它在医生和病人之间，搭了一座很实用的桥。一个病人如果听得懂「换个方向再看」，他就不太会在第一次没有结果时灰心，也不太会在第二个说法与第一个不同的时候，觉得谁骗了他。这是它的功劳。

想想看，那天夜里的阿青，如果手里没有这个比喻，会怎样。她大概会在两份病历之间选一份相信。信了胃炎，就觉得心理科那四十分钟是浪费；信了焦虑，就觉得春天那只胃镜是白做的。无论哪一种，她都得把自己的一半日子判成「搞错了」。

有了这个比喻，她可以把两份都留下。这是它给的宽。

所以，它不是一个该扔掉的比喻。本书要收回的，是它里面藏着的一样东西。

◆ 四、毛病在哪：谁在选

这个比喻里，有一个动词：选。

「选定测量基」，那就得有一个选的人。他站在测量之外，面前摆着几把尺子，伸手挑了一把。尺子挑好了，才去量那个东西。

你回头看阿青。春天，是谁选的消化科？

她会说：是我选的。可她为什么选这个？因为胃胀、胃烧，人人第一个想到的就是胃。「人人都先想到胃」是谁定的？是这些年的科普、药店的广告、亲戚的口头禅，加上挂号页面上排在最前面的几个字。

秋天，是谁选的心理科？同事的一句话。同事为什么说这句话？因为她前一阵刷到一篇文章，题目叫《你的胃是情绪的镜子》。那篇文章为什么会出现在她手机上？这就扯到平台、热点、时代的口风了。

就连「挂哪位专家」也是这样。

你要是抢过专家号，就知道那个所谓的选择，是在凌晨的手机屏幕前，一边刷新页面，一边看着号源一个个变灰的时候做出来的。能抢到哪一个，不由你定。抢到了，你就说「我选了张主任」；没抢到，你就说「那就李医生吧」。同样一句「我选了」，里头装的是两种完全不同的处境。

再往回追，一直追不到一个站在外面的选择者。追到最后，只有一串已经在发生的事：说法、号源、医保规则、社区转诊、同事的一句话，还有阿青自己那一晚的疲倦。

选，不是一个先于挂号的动作。选，是挂号这件事发生以后，回头给它起的名字。

你也许会说：病人没选，是医生选的吧？医生问什么，用什么仪器，总是医生定的。

不妨去问问医生。消化科的医生会告诉你，他问饭后，是因为他受的训练就这么教；他开胃镜，是因为医院有这台设备，也因为这类情况的诊疗规范这样写。他不是在一排方向里挑了一个，他本来就站在一个方向里。

再往后追，这个方向又是怎么来的？

科室不是天上掉下来的。医院里为什么有消化科、心内科、呼吸科，而不是别的切法？那是很多年里一点一点切出来的。有的因为仪器，有的因为学会，有的因为床位和编制。

法国哲学家福柯在《临床医学的诞生》里讲过，现代临床医学怎样在十八世纪末、十九世纪初成形。医院这个空间、医生的目光和医学知识，是一起改变的，大意如此。该书主要谈那一段历史，本书只取这一点。你不必读他，只要记住一点：科室是切口，切口也是长出来的。

这就把问题推到了最后一步。选之前，阿青的难受是什么样子的？

胀，烧，没胃口。就这几样，没有别的名字。「胃部不适」这四个字，已经是消化科的话了。本章开头，本书写下「同一个胃」，这一笔，替你写错了一个字。它悄悄把一个已经被消化科读过的东西，当成了先于一切读法就站在那里的东西。

这就是毛病。

「选测量基」的说法里，站着三样先在的东西：一个选的人，一份等着被量的东西，一排摆好的尺子。三样都在测量之前就位。

这正是本书一直在拆的那种想法。第 3 章说过，量子力学把观察者留了下来，只是把发现者从幕后请到了台前。「选测量基」的医学版，又把他请回来了一次：这回他穿着病人的衣服，或者医生的白大褂，手里捏着一张挂号单。

仍是发现学。

◆ 五、本书的说法：科室与读数一起显出

换一个看法，会怎样？

先回到总钥匙：挂号那一刻。挂号单一出，「病人」「医生」「科室」「病名」这几样东西，开始一起显影。

注意是一起。不是先出科室，再出读数；也不是先有人，再有尺子。

拿阿青的春天来看。她坐在消化科的诊室里，医生问：饭后疼不疼？她说：胀。医生问：夜里烧不烧？她说：有时候。

你看这一问一答。「饭后」这个词，是医生那一头拉过来的；「胀」这个词，是阿青这一头递过去的。两个词是在同一下拉锯里出来的。拉大锯的时候，锯口不是哪一头锯出来的，是两个人一来一回，一起走出来的。一头松了，锯就卡住；一头换了拉法，锯口也跟着变了样。

到了秋天，坐在心理科的诊室里，阿青说了一句春天没说过的话：「周日晚上，胸口像压了块板子，什么都不想干。」

她春天没有说，不是她藏着。是那间诊室里没有这句话的位置。消化科的诊室不缺这句话，缺的是一个问它的人，和一张写它的表。

不妨再看细一点。春天的阿青，坐下来的时候，说的是「我胃不舒服」。她用了「我」「胃」「不舒服」三个词，这三个词一开口，就已经往消化科的方向倾了。秋天的阿青，坐下来说的是「我最近状态不太好」。同样是她，同一张嘴，这一回从嘴里出来的是另一串词。

没有哪一个词是被谁选的。它们是被那间屋子、那个医生、那张表、那个季节，一起拉出来的。

说到这里，还得把开头那句「同一个人」，再松一松。

春天的阿青，和秋天的阿青，其实也不是同一个。春天，她刚过完一个忙碌的年，做完了年报，身体里还留着一股劲。秋天，她换了新的主管，家里老人刚住过一回院，周日晚上总是睡不着。她的胃，也不是原来那个胃：吃过一阵药，改过一阵口味，被胃镜看过一回，被一个名字叫过一回。

所以「同一个胃，同一个人，同一年」，是一个顺口的说法。仔细看，每一场里的她，都已经是前一场写过的她。

心理科的医生接着问：「你说的这个『状态不好』，像是哪一种不好？」

阿青停了一会儿。她说：「就是……人是在的，可是像隔着一层玻璃。」

医生在病历上写了几个字。这几个字，到了第二次、第三次来的时候，会成为阿青自己描述自己的一个词。她开始说「隔着玻璃」。她的家人也许会学着说。再往后，这个词会成为这场复合体里一个固定的零件，成为下一次问答的起点。

病历上的格子也是这样。「主诉」「现病史」「既往史」，每一个格子都在问一种问题，也在为某一类回答预留地方。一个格子叫「饮食」，阿青就会想起吃了什么；一个格子叫「情绪」，她就会想起那个周日。格子不是中立的容器，它是锯架上的一根横木，锯条要从它旁边过。

这样看，一份病历，从头到尾都是两头一起写的。医生写的每一个字，都是被病人说出来的某句话牵出来的；病人说的每一句话，也是被医生的某个问题引出来的。

连两个人坐的样子，也在这场运行里。

消化科的诊室，往往是一张桌子，医生坐在电脑前，病人坐在桌子侧面，一边说，一边看着医生敲键盘。心理科的诊室，常常是两张椅子斜对着，中间没有桌子，也没有屏幕挡着。这样的摆法，决定了两个人说话的节奏：一个是你答我问，一个是你说我听。

同样一个阿青，坐在这两张椅子上，是两个不同的病人位。她在消化科里，是一位「来看胃的人」；在心理科里，是一位「来说说自己的人」。医生那一头也是：一个是「检查并开方的人」，一个是「陪着听的人」。位置和位置，是一起出现的。

所以不是先有一个叫阿青的病人，再被送到两把不同的椅子上去量。是两把椅子，两位医生，两个阿青，一起坐下来。

所以说，科室不是一把先挑好的尺子。**科室、问法、仪器、病历上的格子、病人说得出口的话，都是同一场医患复合体运行里一起显出来的，读数也一样。**

那「选」呢?

选还在。阿青确实说过：我挂这个科。可这一下选，已经站在一串正在发生的事当中。它是锯口的一部分，不是拿锯的手。事后她回头一看，会说「我选了心理科」。那个「我」，是这场运行沉下来的一个结果。

◆ 六、那木头的纹路呢

读到这里，有人会担心：这样一来，是不是想读成什么就是什么？

不是。锯在木头上走，木头有木头的纹路。

胃镜里那一片红，是红的；睡眠里那几个小时，是几个小时；抽血的结果，该高的高，该低的低。身体的事实不会消失，它们本来就在复合体里，而且是锯口里最硬的那一部分。

本书要说的，只是它们的样子：它们不是「先于诊室就站好、等人来量」的东西。

拿那一片红来说。它在胃里，是一片黏膜的颜色。可是它要成为「读数」，要经过很多步。有人把镜头送进去，有人盯着屏幕。有人用「红斑」「充血」这些词去称呼它，有人在报告上写下「浅表性胃炎」。这五个字又被另一个人拿去对照诊疗的规范，决定下一步怎么走。

每一步，都是一场小小的拉锯。红是红的，可它成为「胃炎」，是这一串拉锯的结果。

放射科的人都知道，一张片子，两位医生有时读得不完全一样。

这不是谁没本事。图像上那一块阴影，要经过眼睛、经验、对照的标准和当时手里的病史，才变成报告上的一句话。有经验的科室，遇到拿不准的片子，会把几个人叫到一起看。他们那一刻做的事，不是去找「片子本来的意思」，而是让几个人的读法互相碰一碰，看这块阴影在这几双眼睛之间，会走成什么样子。

这样看，身体并没有被取消，被取消的只是「身体自己会开口说话」这个想象。身体当然参与了，参与得很重。它是木头，它有纹路，锯到硬节子的地方，锯条会卡，会偏。可是木头自己不会变成一块板子，板子是锯和木头一起做出来的。

还有一个相反的担心：既然读数跟着问法走，那是不是病人说什么医生就该信什么？

也不是。问法也有纹路。医学的训练、规范、器械、几百上千个病例攒下来的经验，都是这场拉锯里很重的那一头。它们不是随便的，也不是谁一句话就能改的。本书拆掉的只是「站在外面的选择者」，没有拆掉医学。

◆ 七、收窄前后两句

按照本书的规矩，判词下宽了，就公开收窄。这里写明前后两句。

收窄前：

> **科室就是测量基：科室选定了，读数跟着定。**

收窄后：

科室不是先被选定的测量基；科室和读数，是同一场医患复合体运行里一起显出来的两面。

两句话之间，丢掉了三样，留下了三样。

丢掉的三样：

一，一个站在外面选尺子的人。

二，一份在选之前就摆好的、等着被量的东西。

三，尺子先于读数的先后次序。

留下的三样：

一，读数跟着问法走。换一个科室，换一套问法，读到的东西就不一样。

二，差异不等于错误。阿青的两份病历可以同时成立。

三，多科会诊有用。几个方向并在一起，复合体才不容易走偏。

收窄也有代价。从前你可以说「挂对科室就好了」，现在这句话说不太响了。本书愿意付这个代价，因为那句话背后站着一个想象中的选择者，而阿青的日子里，从来没有这样一个人。

这一收窄，换掉的也不只是一个说法，还有三个很小的问法。

从前问：该挂哪个科才对。现在问：从哪里起头，比较容易让这一场拉锯走得开。

从前问：这份读数对不对。现在问：这份读数，是在什么样的拉法里出来的。

从前问：这个科室是谁选的。现在问：这一场，是怎么起的头。

三个问句，听起来相差不大，用起来相差很远。前一种问法，让人去找一个对的答案；后一种问法，让人去看一场正在发生的事。

这一收窄，同时在回答第 3 章留下的一个尾巴：观察者被拆掉以后，「选」这个动作去了哪里？答案是，它没有消失，它回到了复合体里面，成了运行的一部分。

最后，照规矩，写明这句新判词怎样才算错。

假如有人能在一次完整的诊疗里，找到一个「裸读数」，那么这一章的收窄要改。这个读数要先于科室，先于问法，先于诊室里任何一次问答，不经过任何一把尺子，就在那里放着。

目前本书没有见到。

◆ 八、只看一端会怎样

这个比喻被收回以后，仍然有三种常见的偏，都是只看了一端。

只看科室这一端。以为科室定了一切，人进了哪个科，就成了哪一种病人。于是有了「消化科的病人」「心内科的病人」，一个人被切成几片，每一片放在一个科室的文件夹里。

三个科室的医生，各自的读数都成立，各自都没错。可是没有一个位置，在问一句：这个人整个的日子，现在怎么样了？

病人常常成了那个来回递纸的人。消化科说，你这个可能要看看心内；心内科说，你这个先去呼吸科排除一下；呼吸科说，要不您去心理科看看。每一句都很客气，每一句都有道理，可是三句话连起来，病人听到的是：这里没有我的事。

他拿着一沓纸，在三层楼之间走了一个上午，手里的号越来越多，心里的底越来越少。

这时候，复合体是卡住了。卡住的原因，不是谁偷懒，而是这个位置没有长出来。第 14 章会专门讲，一个复合体可能卡在哪一维。

只看病人这一端。以为一切要靠病人「挂对号」。于是出现了各种挂号攻略，也出现了一种新的焦虑：我是不是挂错了科，我是不是浪费了医生的时间，我是不是白花了钱。

这样的话，本身就是老看法的回声。它把复合体一起做的事，压成了病人一个人的功课。病人在门口站着，手里捏着号，仿佛这一步选不对，后面全是白搭。

事实上，一个科室没读出来，不等于挂错了。很多时候，那只是这一场运行的第一拍。

只看「总选择者」这一端。看到上面两种偏，有人会想：那就设一个更高明的分诊者，专门替大家选测量基。一位资深的主任，或者一个很聪明的系统。

这一步，是把站在外面的选择者换了一个人来演。他一进场，就成了复合体里的一个位置，不再在外面。他说的话会进入科室，进入病历，进入下一次问答，变成锯口的一部分。他有用，很有用，可他不是站在局外的那一位。

还要说清楚一件事。

「复合体生病」不等于责任稀释。一个科室明明该转诊而不转，一份报告明明该解释而没有解释，一次交班明明漏了关键的一句，这些该追责的，仍然要追。追责是修复的一部分，它让复合体里的某一处，不再继续卡着。

本书拆掉的，是「有一个站在外面的人，全权选了尺子」这个想象。它没有拆掉具体的人在具体的位置上该做的事。

医院的管理者，也常有一种相似的偏：以为把分诊做得更精细，就解决了一切。多设几个导诊台，多做几张流程图，让病人一进门就被送到「对的科室」。这些事当然有用，可是只靠它，是不够的。因为它仍然默认，有一个对的科室，等在那里。

真正省下病人冤枉路的，往往是一个小小的位置：一个愿意把几份读数放到一起，并且有时间的人。

至于医生自己，则容易说一句「我只是按科室走」。这句话在一般的日子里没有错，可是它也让「我」从这场拉锯里退出去了。医生不是站在科室的外面照章办事，他是在科室里面，一头拉着锯。

◆ 九、今天与机器

今天的人，多半是先跟机器讲，再跟医生讲。

你在手机上打开一个问诊的小程序，它问：哪里不舒服？你点一个部位，选几个症状，机器回你一句：建议挂消化内科。

按老看法，这是一件大好事：终于有了一个比人更会选测量基的东西。选择者的难题，交给机器了。

按本书的看法，要换一种方式去看。

先看它的输入框。「请选择不舒服的部位」，这一个格子，已经是一间科室了。它在你挂号之前，就替你把难受切成了「部位」和「症状」。阿青那个周日晚上的「胸口像压了块板子」，在这个框里，要先变成「胸闷」，才放得进去。

再看它的回答。「建议挂消化内科」，这句话不是站在外面的裁判，它是挂号前的一次回写。它进了阿青的脑子，进了她的预约，进了她对医生开口的第一句话。它是锯口的一部分。

所以问题不在于机器选得对不对。问题在于，这次回写，开出来的是门，还是墙。

它可以开门：让阿青带着一个粗略的方向走进去，同时留着一句「如果这里没有读出来，换个方向也很正常」。它也可以关门：让她听了一句「建议消化内科」，等到消化科没有读出什么，就以为自己是「没毛病」，或者「想多了」。

假设阿青第三次不舒服，又打开了那个小程序。这一回，她没有只点「胃胀」，她在自由输入的地方写了一整段：周日晚上，胸口发闷，不想吃饭，睡不着。机器回她：这些情况可能与多个方面有关，建议先到全科或综合门诊，带上之前的病历。

这是一次开门的回写。它没有替她选尺子，它把她带到了一个能把几份读数摆在一起的位置上。同一个机器，同一个小程序，换一种写法，换一种回写，复合体就换了一种走势。

怎么用，更像是怎么把它放进复合体里。本书不教你用哪个软件，也不给诊疗建议。第 16 章会专门讲，医生、病人、AI 三方怎样成为一个复合体。这里只记一句：机器说的第一句话，请当作第一句话，不要当作判决。

诊室那一头，也有机器。有的医院已经让助手在问诊的同时，把病人说的话整理成病历的草稿。医生一抬头，屏幕上已经有了几行字。

这很省力，也很容易出事。病人说的「像压了块板子」，在草稿里，可能已经变成了「胸闷」。医生看着草稿问下去，问题就沿着「胸闷」的方向走了。那块板子，没有谁拿走它，它只是在被整理的时候，悄悄变了形。

好的做法，是让草稿旁边留一格，放病人自己的原话。留下这一格，复合体里就多留了一条路。

◆ 十、一个完整的例子：老肖的胸口

老肖五十九岁，退休前开了三十多年的公交车。

去年冬天起，他胸口发闷。不是疼，是闷，像里头塞了一团棉花。时轻时重，没有规律。

他先去了心内科。医生看了他的心电图，又安排了几项检查。结果回来，医生说：没有大问题，注意休息。老肖听了很不服气。没问题，那我怎么还闷？

他又去了消化科。医生看了看，说有一点反流，开了药。吃了一阵，轻了一些。过了俩月，又闷。

后来他去了呼吸科。呼吸科说，肺没问题。

再后来，有人建议他去心理科。老肖一听就火了：我又不是精神上有毛病，我去那儿干什么？

三个月，四个科室。每个科室拿到的都是一个方向上的读数，每份读数都成立，每份读数都没能让老肖的胸口松下来。他手里的纸，越来越多，人越来越没底。

有一回在公交站台，他碰见从前的同事老王，问起来，老王说：「你这是查到哪儿了？是不是还没碰到好医生？」

老肖点了点头，心里却咯噔一下。他开了三十多年的车，一向相信「路走错了就绕回来」。可是这回，每走一条路都是对的，每条路又都没到地方。

按老看法，故事到这里是：他还没挂对科。得继续选，直到选中那个「对」的测量基。

按本书的看法，故事是这样的：这一路上的复合体，一直是一场场短短的拉锯。每一场拉锯里，科室和读数一起显出来，写进病历，然后就散了。散了以后，没有哪个位置负责把这几场拉锯连成一场。

老肖最后走进的是社区医院的全科门诊。坐诊的，是周岚。

周岚没有一台新的仪器。她做的第一件事，是请老肖把这三个月的纸，全部摊在桌子上。心电图的结论，消化科的药单，呼吸科的报告，并排放着。

她说：「这几份单子，我看都是真的。我们不挑哪一份对，只看看它们放在一起，是个什么样子。」

然后她问了一个别的科室没有问过的问题：「第一回闷，是哪一天？那一天，家里发生了什么？」

老肖愣了一会儿。他说：是老伴住院的那一周。

说句实话，周岚的门诊也并不宽裕。社区医院的号，一个病人排下来不过十来分钟，后面还有人候着。她这一回，是提前跟分诊台打了招呼，给老肖留了一个长一点的时段，又去求了一位同事，替她顶了半小时。

这一点，请你也记在心里。那间屋里长出来的东西，不只是周岚一个人的功劳。里面有分诊台的排号，有同事的半小时，还有医院愿不愿意给全科门诊留一点不赶的时间。复合体的运行，从来不止诊室里那两个人。

周岚没有接着说「所以你是心理问题」。她也没有下任何结论。她只是在病历上写下了老肖那句话，约了两周以后再来，又请老肖下回把老伴也带来。

两周后，老伴陪着老肖来了。老伴一坐下就说：「那一周，他在医院走廊里坐了八个晚上，没怎么合过眼。」

这句话，别的科室的病历里没有，是在这间屋里第一次被说出来的。周岚把它写了下来，旁边又写了一句：「请老肖说说那八个晚上。」

老肖开口说了很久。说到最后，他自己也有点吃惊。

后来的事，不长，说两句。

老肖又来了几次。每一次，周岚都不多说，只是把上一回写下的话读给他听，问一句：「这一阵，有没有哪一天，闷得轻一点？」老肖有时说有，有时说没有。有一回他说：「我老伴出院以后，那几天闷得好像轻些。」周岚把这句话也写了下来。

她没有替他下判断，也没有告诉他该怎么办。她只是让这条线，一次一次地接着往下拉。

你可能会觉得，这个故事没有一个漂亮的结局。是的，它没有。老肖的胸口还会不会闷，什么时候松，本书不替他预言，也不给任何诊疗上的建议。

可是请看，这里面变化的是什么：不是谁终于「挂对了科」，也不是全科比专科更高明。变化的是，复合体里多出了一个位置，让几份读数坐在一起，也让老肖家里的事，第一次有了被写进病历的地方。

科室和读数，在这间屋里又一起显了一回。这一回，显出来的东西，比前面四回更宽。

身体或心里的难处真的大了，请找医生或心理咨询师。

◆ 十一、放回日子里

周老师六十二岁，血压高了多年。

有一天早上，他对女儿周岚说：「我这两天头有点晕，胃里也胀，你说我是挂心内科，还是挂消化科？」

周岚笑了笑，没有马上答。她在社区医院坐了五年诊，这种问题一天要听好几回。

她说：「爸，先挂一个，别想着一次挂对。」

周老师说：「那万一挂错了呢？」

「挂错了也不白去。」周岚说，「那个医生读出来的，是一个方向上的东西。读不出来，也是一个读数。我们接着换个方向，再问。」

周老师想了想，点了点头。他教了一辈子语文，最懂「换个角度再读一遍」的意思。可他还是有点不放心：「那我去了说什么？」

他这一问很实在。周老师有个老毛病，一进诊室就紧张，医生问一句，他答一句，答完又后悔：刚才忘了说头晕是什么时候开始的。出了门，才想起来要说的话，全在走廊上。

这样的事，每个人大概都经历过。进了诊室，十分钟里，你像是被一股水流推着走，该说的话，一半没来得及开口。

周岚说：「去之前，你拿张纸，写三句话。」

这就是本章留给你的一件小事，明天就能试。

去看医生之前，拿一张纸，写三行。

第一行：最难受的是哪一句话。不用写病名，写你自己的话。「像压了块板子」「一到下午就发虚」都行。

第二行：什么时候最重，什么时候最轻。

第三行：你最担心的是什么。

三行字，不是为了让医生「选对方向」，是为了让这一场拉锯，一开始就多带一些东西进去。你写得越是你自己的话，诊室里能长出来的东西，就越多一点。

那张纸，也不要当作考卷。读不出什么来的时候，别怪自己没写好，也别怪医生没读好。那只是第一拍。

周老师第二天去了医院。他把那张折成四折的纸从口袋里摸出来，递给医生。医生看了一眼，说：「您这第一行写得好，『头里像有块湿棉花』，这个我还没听人这么说过。」

接下来的十分钟，诊室里的话，和周老师以往的任何一次都不一样。医生问「湿棉花」是什么时候来的，是早上还是下午，躺下是不是好一点。每个问题，都是顺着周老师自己的那一句话问下去的。

这并不是说，那张纸让医生「选对了方向」。是那张纸，让这一场拉锯，从周老师自己的话那一头起了头。

还有一件事，是给陪家人去看病的你。进诊室以前，先别替他说「我爸是胃的问题」。让他自己开口，用他自己的话。你只在他卡住的时候，补一句你看到的。因为你替他先选了尺子，诊室里就少了一种声音。

带 走 的 话

科室不是谁先选好的尺子；科室和读数，是同一场拉锯里一起显出来的两面。

小　账

这一处，开门还是关门：这一章是收窄，也是开门。开的是「土」那一扇：科室、问法、仪器、病历上的格子，都是推着读数长出来的土。

病放在一个人身上，还是放回复合体里？不放在「挂错了科」的病人身上，也不放在「选错了尺」的医生身上，放回这一场诊疗的复合体里。

想 一 想

一，你最近一次去看病，是怎么决定挂哪个科的？回头想想，这个决定里有多少是你自己的，有多少是别人的一句话？

二，你手里有没有两份说法不同的病历、化验单，或者两位医生的话？把它们并排放在一起，你看见了什么，是对错，还是别的？

三，下次走进诊室之前，你愿意写下哪三行字？

◆

08

第 8 章

通路还是笼子：病名的两种回写

◆ 一、你一定有过这样的时刻

拿到诊断的那天晚上，你是怎么过的？

也许是在体检报告的最后一页，看见一个从没见过的词。也许是医生在电脑前敲了几下，转过头来，用平常的语气说了一个名字。你点点头，走出诊室，在走廊的长椅上坐了一会儿，才发现自己手里捏着的单子，已经被攥出了褶。

那一晚，大多数人都睡不太踏实。

周老师是八年前的秋天，拿到「高血压」这个名字的。那时候他五十四岁，还在学校里教语文，小区义诊上量出数字高，一周后在心内科确诊。医生说，要管起来。他回到家，一句话没说，先把那个新词写在了备课本的最后一页，写完看了一会儿，合上本子，去批作文了。

老林也是在那一年，拿到了同一个名字。

两个人年纪差不多，数字差不多，药也差不多。周岚后来在社区医院坐诊，见过他们两个。她有时候想，这两个人的血压单子，摆在一起几乎看不出区别。

可是他们的日子，渐渐不一样了。

你大概也见过这样的两个人。得了同一个病的人，有的一年比一年活得宽，有的一年比一年活得窄。旁人常说，这是性格不同，心态不同。

周岚在社区医院里，每天都会遇见刚拿到名字的人。有的阿姨拿着单子在门口站着，不肯进来，说：「我就是来问问，这个是不是就算病了？」有的大哥一屁股坐下，先问一句：「我还能不能开车？」有的年轻人什么都不问，只是把手机屏幕转过来，上面是他半夜里搜到的一整页。

她后来慢慢发现，同一个名字，落在不同的人身上，开头的那一问就不同。这一问，常常比名字本身，更能预告后面的日子。

本书这一章想问的，是另一件事：病名落地以后，那个名字，在这个人和他身边所有人的日子里，是怎样被写下去的。

◆ 二、老看法：诊断好不好，看准不准

先说老看法，它有它的道理。

发现学的医学，把诊断看成一件找东西的事。病在身体里藏着，医生用问诊、查体、化验、影像，一层层把它找出来，最后给它一个名字。名字对上了，就是找到了。

按这个看法，一个诊断好不好，只问一件事：准不准。

准，就是对上了。不准，就是误诊，或者漏诊。医院里评价一位医生，医学上评价一种检查，常用的也是这一类问题：它能不能把该找出来的找出来，会不会把不该算的也算进来。

这一条要先说足。准确，在医学里是一条命。

一个不准的名字，会把后面的路都铺偏。

病人吃了不该吃的药，错过了该做的检查，在一条错路上走了一年，才发现方向不对。这样的事，每个行医的人都怕。循证医学把一次次的结果摆在一起，一遍遍地检验哪种判断靠得住，哪种靠不住，就是在给「准」这件事，上一道又一道的保险。

本书不拆这一条，也不轻看这一条。

周岚有一回夜里值班，一位老人胸口疼得厉害，来的时候家属急得团团转。她没有多说什么，先把该排除的一项项排除了。后来她对同事说：「那一晚，我心里只有一个念头：别给我弄错了。」

这个念头是对的。

只是，这个念头有一个看不见的边。它只管到「名字对不对」，不管到「名字落了地以后会怎样」。在发现学的眼里，名字一旦对上，事情就算完成了一大半，

剩下的是治疗，是遵医嘱，是病人自己配合。名字本身，被看成一个透明的标签，贴上去，不会再动。

这个想法很自然，因为在发现学的眼里，名字是后到的。病先在那里，名字只是照着病做的一张标签。标签是不会改变瓶子里的东西的。

病人自己也常常这样想。拿到名字的那天，他最想知道的一件事，就是：「是不是真的？」他怕的是误诊，也怕的是漏诊，他把全部的注意力，都放在了名字准不准上。这没有错。可是等到名字确认了，他会发现一件事：确认了名字，并没有让他松下来。

因为名字准不准，是医生的事。名字之后怎么过，才是他自己的事。

这个看法，在一个条件下完全成立：病名只是一个标签，复合体早已稳定，这个标签贴上去，不会改变这场复合体的走势。比如一位病人长年规律复诊，家里人也早就习惯了他的病，这时候再添一个小小的、不重要的名字，对谁都没什么影响。

可是多数时候，不是这样。

名字一旦出口，就开始往别处写。本书第 6 章里说过，病名是第一次回写，写进病历，也写进日子。这一章要接着往下问：写进日子的，究竟是什么。

◆ 三、病名是第一次回写

先把「回写」这个词讲回家常话。

你在一块软泥上按一个手印，印子留下了，下回再按，手不由自主地落在那个印子旁边。是你的手印出来的，印子又引着你的手。这一来一往，就是回写。

病名也是这样。医生说出一个名字，这个名字有两条路往回写。

一条写进病历。病历是医院内部的东西：它会被别的科室读到，会被下一次复诊翻出来，会决定下一张检查单开什么、下一次约在几周以后。

另一条写进日子。这一条，没有表格，没有签字，却常常更重。

它写在餐桌上：家里人从这天起，往菜里放盐，放得小心翼翼，甚至有人偷偷把盐罐藏起来。

它写在请假条上：单位里有一份病假，有一行诊断，这行字会在人事的档案里待很久。

它写在保险表格上：买不买得了，怎么买，价格是多少。

它写在朋友的聚会上：你说一句「我不能喝」，大家就不劝了，可也有一点点不一样的空气。

它写在搜索栏里：当晚，你把那个名字敲进去，看见一连串的「并发症」「终身服药」「不可逆」。

最深的一条，写在你对自己的称呼上：「我是个高血压病人。」

这些回写，不是一天写完的。

当天晚上，写的是第一层：怕不怕，说不说，告诉谁。一个星期以后，写的是第二层：家里的菜变了，出门的安排变了，药盒摆在了哪里。一年以后，写的是第三层：这个名字，已经成了这个人自我介绍里的一部分。

每一层都压在前一层上头。越到后面，越难改。所以最早的那几天，格外要紧。那几天里说出来的几句话，常常会在后来的日子里，被一遍遍地重复。

这几条路，一条条通向不同的地方。有的把人领出去，有的把人关起来。

本书用两个家常的字，把它们分开：一种叫通路，一种叫笼子。

通路，是名字出口以后，日子里多出了几条能走的路。笼子，是名字出口以后，日子里少了几条原来能走的路，最后连人都缩进了名字里头。

两种东西，用的是同一个名字。名字本身，长得并没有区别。

一个名字是通路还是笼子，不看名字，看它被写成了什么样子的日子。

周岚说，她现在在说出一个名字之前，总要先在心里停一下。不是犹豫该不该说，而是想一想：这个词，到了他家里，会往哪几个地方走。

她说，以前她只想，这个词对不对。现在她还想，这个词出了门，第一个会落在谁的嘴里。

◆ 四、同一个诊断，两种日子

回头看看周老师和老林。

周老师是语文老师，习惯把新词当成课题。拿到「高血压」的当晚，他在备课本最后一页写下这个词，旁边又添了两行：「要管，不是要怕」「问问周岚」。他是那种有了新词就想查个明白的人。

第二天一早，他用家里新备的血压计量了一遍，翻开红皮本子，写下日期和两个数。他又去书店翻了翻几本讲健康的小册子，拣了几句自己看得懂的，抄下来贴在厨房门上。

家里人也跟着变了，可变得很松。女儿周岚周末回家，做饭时会把盐放得少一些，周老师吃出来了，笑着说：「你们这是要把我当病人养。」周岚说：「不是病人，是爸爸。」这个玩笑，后来成了他们家的一句固定的话。

周老师照旧去老年大学讲他的诗词课，照旧每天傍晚沿着河边走一圈，照旧跟老朋友喝茶。本子上的数字，每周记几次，复诊的时候带给医生看。医生问：这阵子怎么样？他会翻出本子，指着某一页，说：「这几天有点高，我想是前两天没睡好。」

他把这个名字，当成了日子里的一个新事。它占了一小块位置，其余的地方，他照旧活着。

老林呢？

老林拿到名字那天，一个人坐在小区门口的凳子上，坐了很久。回到家，对老伴说：「我这下，成病人了。」

老伴心疼他，当天晚上就把家里的咸菜扔了，第二天不让他拎菜篮子，说「你可不能累着」。儿子打电话回来，听说了，在电话里叮嘱了半个钟头，最后一句是：「爸，你以后什么都别操心了。」

老林一开始觉得被人疼着，心里是暖的。可是慢慢地，他发现自己能做的事越来越少。以前他每天早上去公园打太极，现在老伴说天凉了怕风；以前他和老同事每个月聚一次，现在他自己找个借口推了，说「我这身体，去了也扫兴」。

两年以后，老林的日子，缩成了一间屋，一张沙发，一只药盒。他自己也开始说一些以前不会说的话：「我这样的人」「我是个病人」「别管我了」。

他的血压单子，和周老师的差不多。药，也差不多。

本书不去算他们谁的数字好看，也不替他们判谁的药吃得对。那是医生的事。本书要看的是，这两个家庭里，同一个名字，被写成了两种完全不同的东西。

在周老师家，这个名字是一个要管的事。在老林家，这个名字成了**一种身份**。

事，是可以放下又拿起的。身份不行，身份是你走到哪儿都得带着的。

你可以再看一个细节：数字高了的那一天。

周老师有一回早上量，数字比平时高出一截。他拿着本子，对周岚说：「你看，高了。」周岚瞄了一眼，说：「昨晚你是不是又改作业改到十二点了？」周老师不好意思地笑了：「可不是。」他当天没有出门散步，改在家里慢慢走了几圈，第二天又量了一遍。

老林也有数字高的一天。他拿给老伴看。老伴的脸一下子白了，说：「是不是又不行了？」当天，儿子被叫了回来，老林被按在床上躺了一整天。这一天的数字，在老林的心里，成了「病又重了」的证据。

数字是同一种数字。落在两个家里，被写成了两种事。一种是日子里的一个波动，另一种是一次小小的审判。

◆ 五、第二把尺子：通不通

由此可以给诊断，添一把尺子。

老尺子问：准不准。这一把还要，一点不能少。

新尺子问：开出来的是通路，还是笼子。

这一把尺子，看的是三件事。

第一，说得出吗。

这个名字，有没有让那份难受，有了一个说得出口的形状。本书第 5 章讲过，诊断之前，苦是没有形状的一锅粥。一个好的名字，是让这锅粥第一次有了边。你可以对家里人说，可以对同事说，可以在复诊的时候对医生说：「我就是这个情况。」名字让苦可说了，这是通路的第一步。

反过来，有些名字，让人更说不出口。听起来吓人，听起来丢人，听起来不能对任何人讲。名字一出口，人先闭了嘴。

第二，接得上吗。这个名字，有没有接上这个人的日子。他听完以后，知道接下来每天要做什么，什么时候回来，什么情况不用慌，什么情况必须马上来。有路，就有了落脚的地方。

有些名字落地以后，只剩一个字：怕。病人拿着单子回家，什么都不知道，只知道自己有「病」了。

回头说第一条，说得出，有时是小事上的小事。一位大叔，对医生说了半天的头晕，最后才低声补了一句：「晚上还有点……起夜多。」他不好意思，怕说出来显得自己老。医生一句话把它接住了：「这个很多人都有，你说出来，对我很有用。」那一刻，一道原本关着的门，开了一条缝。

第三，回得来吗。日子里发生的事，能不能再传回给医生。药吃了以后什么样，哪天哪里不舒服，家里谁说了什么。这条线通着，复诊就是一次对话；这条线断了，复诊就成了一次核对。

回得来这件事，有时靠一本小本子，有时靠一条微信。有时只是医生在下回见面时，问的那一句：「上次说的那个，后来怎么样了？」一个病人如果觉得自己说的话，真的有人接着听，他就愿意把日子里的细节带回来。他如果觉得说了也没人接，他就不说了。

这三件事，与本书第 14 章要讲的三种卡点，是一对一的：说不出，读不懂，回写不进。通路，就是这三处都没有卡死。

再说笼子，也有三个样子。

一，名字替人说话。「你是病人，这个你别管。」「你这个情况，就不要去了。」一个名字，开始替人做决定。

二，名字封顶。「这病就这样了，不会好了。」把一个正在发生的状态，说成了一个到头的结局。

三，名字封门。「不用再来问了，问了也一样。」「医生都说了。」复诊的路被名字自己堵上了。

要说清楚的是，这个笼子不是哪一个人造的。

不是医生一句话造的，家人一句话造的，病人一句话造的，也不是单位的一张表造的。它是这场复合体里，很多条线一起收紧的结果。在老林家，老伴的心疼、儿子的叮嘱、单位的病假条、老林自己的那句「我这样的人」，一条条都不坏，加起来就成了笼。

笼子不等于坏人。可是有些时候，笼子里确实有该追问的人。比如一位医生，明明病情并不需要，却用一句话把病人的路全堵了；一个单位，明明可以调整，却借病名把人排了出去。这些，仍然该追问。

还有一句要补。通路，不等于轻松，不等于好消息。

一个很重的病名，也可以是通路。只要说得出，接得上，回得来，重，也是一条走得动的路。反过来，一个很轻的名字，也可以变成笼子。轻重和通堵，是两回事。

这三问，也不是用来给谁打分的表。不要拿着它们，去给医生评级，给家人挑错，给自己记账。它们是三个可以随时问一问的问题，问的时候，对着的是整个复合体，不是某一个人。

◆ 六、复诊与第二意见：不是纠错，是重新起头

这就要说到复诊和第二意见了。

在老看法里，这两样东西，都带着一点点不太光彩的影子。

复诊，是「核对」：看看上一回的判断对不对，药有没有用。第二意见，是「找茬」：去别的医生那里，看看第一位医生有没有看错。两个医生的说法不一样，就是一对一错，一个是真的，另一个是假的。

这个影子，常常让病人不好意思。去看第二意见，像是对不起第一位医生。去复诊的时候，不敢多问，怕显得不信任。

医生那一头，也有影子。听到病人说「我还想去别的医院看看」，心里会咯噔一下，像是被问了一句：你是不是不行。

周老师当年第一次拿到名字的时候，也动过去别处再看看的念头。他在诊室里犹豫了很久，才对医生说：「大夫，我想拿着这些资料，再去大医院问问。您看行不行？」

医生愣了一下，随即说：「行啊，应该的。你把检查结果带上，我再给你写一份小结，免得人家重新问你一遍。」

周老师出门的时候，心里是暖的。那位医生没有把第二意见当成背叛，他把它写进了同一场复合体里。后来周老师回来复诊，还特意带了一盒茶叶给他。

把病名看成第一次回写以后，这两件事就可以换一个样子。

复诊，不是核对，是重新起头。第二意见，也不是纠错，是重新起头。

道理很简单。每一次坐下来，都是一场新的挂号，一场新的拉锯，复合体里的病人位、医生位、病名，又一次一起显出来。上一回显出来的东西，当然还在，它们成了这一回的底子。可这一回的锯口，不会和上一回完全重合。

所以，哪怕第二位医生说的和第一位一模一样，也不是白去。同一个名字，被放进了另一个复合体里，写出了另一种日子。

反过来，哪怕第二位医生说得不一样，也不一定谁错了。第 7 章讲过，科室和读数是一起显出来的；第二意见带来的，是又一场新的显影。两份读数，可以同时成立。

这里还有一层，是对病名自己的。

病名也有状态。它可以是「待排」，可以是「疑似」，可以是「已确诊」，也可以是「控制良好」。每一次复诊，都是它挪一挪位置的机会。本书第 9 章会专门讲，名字已立、结局未定的时候，复合体悬着，是怎样的一种状态。

一个病人如果知道，名字可以在复诊时被改写，他对这个名字的态度就不一样了。他不会把它当作一块刻在身上的碑，而是当作一张可以修的单子。

复诊也不该是一场考试。病人不必为了「恢复得好不好」而紧张，医生也不必为了「判断对不对」而辩护。两个人坐下来，把上一回留下的话摊开，一句一句往下接。接得上，就接；接不上，就在接不上的地方，停一停，问一问。

一场复诊如果开头是「你上次让我做的，我没做到」，医生可以不急着训，先问一句「没做到的那一天，是怎么过的」。这一问，常常比一次提醒更有用。

怎么去做，有几件小事，没有一件是诊疗上的建议，都是怎么开口的。

可以对医生说：「我想听听别的医生的看法，您看我带哪些资料去比较好？」这句话，把第二意见写进了同一场复合体里，没有留出一条背着人走的暗路。

医生也可以对病人说：「你要是想再听听别人怎么说，我把检查结果给你整理一份。」这样，两位医生的读数，才有机会互相看见。

复诊的时候，也可以多问一句：「这回和上回比，哪里变了？」不问对错，问变化。

◆ 七、一个完整的例子：豆豆的「哮喘」

下面这个故事，是虚构的。豆豆是本书的一个陪读人物，本书不替任何一个真实的孩子下判断。

豆豆七岁，周岚的儿子，周老师的外孙。他从小爱咳嗽，天一冷就明显，夜里躺下的时候最厉害，跑一阵也会咳。

这个冬天，咳得比往常久了。周岚白天在社区医院里坐诊，每天看几十个病人，轮到自己的孩子，她挂了另一家医院儿科的号。同事问她：你自己不就是医生吗？她说：在诊室里，我是妈妈。

儿科门诊的号很紧，医生给每个孩子的时间不多。那天，周岚抱着豆豆坐在椅子上，医生听了听胸，问了几句，在电脑上敲了几下，抬起头来，说：

「像是哮喘，这个要长期管。」

就这一句话。

周岚是医生，她知道这个词的分量，也知道在门诊十分钟里，一位医生能说出的话是有限的。她点了点头，问了几个关键的问题，接过了单子。

她问得很专业，听得也很专业。可是走到走廊上，她才发觉，刚才那十分钟里，她问的全是「医生的问题」：几次，多久，怎么治。她一个「妈妈的问题」都没有问。比如：他还能不能跟别的孩子一起玩？晚上我该怎么守着他？外婆问起来，我怎么讲？

这些问题，在诊室里，没有一个格子可以放。

可是她走出诊室的时候，觉得腿有点软。她是医生，是这个领域里的人，可那一刻，她不是医生，她只是一个听到了一个名字的母亲。

回到家，名字开始往日子里写。

那天晚上，周岚没有马上告诉任何人。她把豆豆哄睡以后，一个人坐在客厅里，把单子上的字读了好几遍。读到后来，她发现自己没有在想病，而是在想：怎么讲，才不会吓到妈妈，不会吓到孩子。

可是第二天早上，周老师在厨房里问了一句：「医生怎么说？」她还没组织好话，豆豆在旁边接了一句：「医生说我是哮喘。」

七岁的孩子，把那个词说得又轻又顺。他不知道那个词有多重，他只知道它是一个听起来很大人的词。

周老师先听说的。他一听「哮喘」，脸色就变了。他想起一些年前，听说谁家的孩子「有哮喘」，从此什么都不敢吃，什么都不敢碰。他没有问医生怎么说，他把自己听来的那些，一股脑地用在了豆豆身上。

家里的窗户，白天都开得很小，晚上关得严严的。豆豆爱养的那只小乌龟，被周老师悄悄送了人，说是怕「对孩子不好」。冰箱里的冷饮，全部撤了。晚上，周老师在豆豆的床边坐着，听孩子的呼吸，一听就是大半夜。

学校的体育课，周岚替豆豆写了一张请假条，写的时候，手停了一下，还是写上了那个词。

同学们很快知道了。豆豆的一个好朋友问他：「你为什么不跑步？」豆豆说：「我有哮喘。」

那一周，周岚发现豆豆变了。以前他一放学就往楼下跑，现在会先问：「妈妈，我今天能去玩吗？」以前他说「我想踢球」，现在他说「我不能踢球，我有哮喘」。

有一天晚上，周岚在给他讲睡前故事。豆豆忽然问：「妈妈，我是不是哮喘小孩？」

周岚的手停住了。

她听见了那个词。不是一个诊断，是一个称呼。

她这才想起一件事：从那天起，没有任何一位医生，对豆豆说过「你不能踢球」。这句话，是他们这个家，一天一天自己写出来的。

她想起了前一周，班主任给她打过一个电话。班主任很和气，说：「豆豆妈妈，我们会照顾好他的，体育课上，我们就让他在旁边看着。」周岚当时说「谢谢老师」，心里却咯噔了一下，只是没有细想。

现在她想明白了。班主任的话是好心，请假条是她自己写的，窗户是外公关的，冷饮是外婆收的。同学的问话也是孩子们天真的。每一个动作单拿出来，都挑不出毛病。可是它们合在一起，豆豆就成了「那个不能跑的孩子」。

名字，是那位门诊医生说出来的，只有一句。可它被家里人的担心、学校的请假条、同学的目光、豆豆自己的一句话，一圈圈地写成了一个笼子。

周岚是医生，她比谁都明白，这不是任何一个人的错。她没有去责怪母亲，也没有去怪那位十分钟里说了一句话的儿科医生，更没有怪周老师。她只是在那个晚上，轻轻地把故事书合上，对豆豆说：「我们再去看一次，好不好？」

她挂了一个复诊的号，换了一位医生。

新的这位方医生，年纪大一些，坐下来以后，先没有看单子。她问豆豆：「你什么时候最爱咳？」

豆豆说：「晚上。」

「白天呢？」

「跑完会咳。可是踢球的时候不咳。」

「那你最喜欢什么？」

「我喜欢踢球。」豆豆说完，又小声补了一句，「可是我有哮喘。」

方医生没有马上说什么。她让周岚把前一次的资料给她看，又听了孩子的胸。接着问了周岚几个问题：什么时候开始的，晚上是什么样的。家里有没有人也有类似的情况，这一阵家里又做过哪些改变。

周岚把那些改变一样一样说了：窗户，乌龟，冷饮，体育课的请假条。

方医生听完，在病历上写了很久。

后面的事，本书不替方医生下结论，也不评判豆豆到底是不是哮喘，哪个医生说得更对。那不是这个故事要证明的事，也不是本书能做的事。故事里要看的，是别的。

方医生做了三件事。

第一件，她告诉豆豆和周岚：这个名字先放在这儿，不用当成一个永远的称呼。她把它写在病历上，旁边添了一行，说明还需要继续观察。

第二件，她写了一张单子，上面是三栏。一栏写：哪些事，豆豆可以照常做。一栏写：什么情况下，要尽快回来。一栏写：哪些情况，不必慌。三栏字不多，却是周岚在上一次门诊里，一句也没有听到过的东西。

第三件，她约了下次复诊的日子。

这位医生没有说前一位医生错了。她没有给这个名字换另一个名字，也没有把它取消。名字依然在病历上。

变的是它被写下去的样子。从一个封顶的称呼，变成了一件正在观察的事；从一个只让人怕的词，变成了有三栏路标的一张单子；从一次到头的结论，变成了下一次约好的起点。

那天晚上，周岚把方医生的单子贴在了冰箱上。她请周老师来看，周老师戴上老花镜，一栏一栏地读，读到「可以照常做」那一栏，抬头看了她一眼。

过了几天，窗户开得宽了一点。那只小乌龟没有再回来，可是周老师给豆豆买了一条小鱼，放在客厅里。体育课，豆豆去了，跟体育老师说：「我有时候会咳，要是咳了，我就歇一会儿。」

你注意到了吗？他的那句话，变了。

体育老师也有变化。她原先对豆豆格外小心，一见他咳，就让他回教室。现在她手里多了一张单子，上面写着哪些事照常做，什么情况要停下来。她对豆豆说：「你要是觉得不舒服，就举手，我陪你到旁边坐一会儿。」豆豆点点头，再没有被一个人悄悄「送回教室」。

同学们也变了。那个问他「你为什么不跑」的小朋友，后来又问了一次：「你今天跑吗？」豆豆说：「跑，咳了再歇。」小朋友说：「那我陪你。」

从「我是哮喘小孩」，变成了「我有时候会咳，咳了我就歇一会儿」。名字没有变，可是名字在这个孩子嘴里的位置，变了。

这就是病名回写的两种样子。同一个词，一次写成了笼子，一次写成了通路。

身体或心里的难处真的大了，请找医生或心理咨询师。

◆ 八、只看一端会怎样

这一章讲的道理，也容易被只看一端。

只看准不准这一端。以为名字对了，就万事大吉。于是医生把全部力气花在「别弄错」上，名字落地之后的事，当作病人自己的事。结果，一个名字很准的诊断，也能在家里长成一座笼子。

还有一种情形更常见：医生因为太怕「不准」，开始一味地加检查，一味地往重了说，这样将来万一出了事，自己不担责。这是第 13 章要讲的医生端的症状，本章先记一笔：对「准」的唯一崇拜，反过来会伤害复合体。

只看通不通这一端。以为只要让病人轻松、不怕，就是好诊断。于是有人把病名说轻，说含糊，甚至不说。这样的话，听上去是善意，却常常是假的通路。第二天，病人在搜索栏里查到了真相，原本松开的线，一下子绷得更紧。通路不是好听的话，是一条真走得了的路。

还有一种看法，走到了另一个极端：既然名字会变成笼子，那干脆不要名字。

这一条路也走不通。本书第 5 章说过，没有名字的苦，是一锅粥，人在里头更没办法。名字能让苦被说出来，被认出来，被一群同样经历过的人认出来。取消名字，等于把门一起拆了。该做的，不是把名字拿走，是让它出口的时候带着路。

只看病人这一端。以为问题出在病人「心态不好」，劝他「别把自己当病人」。这句话说出口，是把笼子的责任整个压到了笼子里的人身上。老林要是听到「你别老觉得自己有病」，他不会好受一点，只会更觉得自己做错了什么。

笼子是很多条线一起收紧的，不能让一个人去松。

只看医生这一端。以为只要医生会说话，一切都好办。会说话是好事，一位医生如果能把名字说得稳、说得有路，对复合体的帮助很大。可是名字出了诊室，还要进家门，进单位，进手机。医生一句话，管不了后面所有的线。

还有一端，容易被忘：单位和保险。一个病名写进一份表格，往往比医生说的那句话，更长久地留在一个人的生活里。这些，也是复合体的一部分，也该被看见。

最后要补的一句，是关于追责的。

复合体生病，不等于没人负责。

豆豆那一次门诊里，一位医生在十分钟里只说了一句「像是哮喘，这个要长期管」，没有同时说明「先观察」「哪些事照常做」「什么时候回来」。这是可以被追问的。不是追问那位医生的人品，是追问一个问题：门诊的时间安排、说明的流程、书面的小结，能不能让每一个名字，出口的时候就带着几条路。

追问，是修复的一部分。一个只说「谁都有难处」的复合体，是不会变好的。

◆ 九、今天与机器

今天，病名的第一次回写，常常是在医生开口之前，就已经被机器写过一遍了。

你拍一张化验单，传给一个智能助手，几秒钟之内，它给你列出一串解释：这个指标是什么，偏高意味着什么，可能与哪些情况有关。你读着读着，发现自己在读一个还没有被医生宣布的名字。

你把病名敲进搜索栏，短视频平台马上给你推来一连串的内容。有的讲得平实，有的讲得吓人。「终身服药」「不可逆」「并发症」这几个词，一遍遍从屏幕上滑过。

病名在今天，有了无数个回写者。

周岚的一位同事，最近在门诊里试了一件新事：病人走之前，他让助手把今天说的话，整理成一页「家常话小结」。哪个名字，是什么意思，接下来三件事，什么时候回来。病人拿着这一页走，家里的老人也看得懂。

有一位老太太，看了那一页，对儿子说：「原来是这么回事，我还以为是绝症呢。」

那一页纸，没有改变任何诊断，没有增加任何治疗。它做了一件小事：让名字出口以后，往回写的第一笔，是一条路。

这些回写，同样可能是通路，也同样可能是笼子。

一个助手如果能把专业词翻成家常话，把复诊时该问的问题列出来，它就是在开通路。要是它还把「这个指标偏高，不一定就是某种病，请带着结果去问医生」这样的提醒，放在显眼的位置，就更是了。

一个推荐流如果不断把最吓人的几条送到病人面前，因为这些最容易被点开，它就是在织笼子。

这里的问题，仍然不在于机器对不对、准不准，而在于它被放进了怎样的复合体。它是被医生用来给病人整理资料，还是被病人拿来偷偷代替复诊？它说出来的话，有没有一条回到医生那里的线？

病友群也一样。同病的人聚在一起，有人互相提醒复诊，有人分享怎么和家人说，这是通路；也有人天天比谁的并发症多，谁的情况更重，把一群人拴在同一个名字里，越拴越紧，这是笼子。

第 16 章会专门讲医生、病人、AI 三方怎样成为一个复合体。这里先记一句：病名一出口，回写的人比从前多得多。你要看的，是它们加起来，把日子开出了几条路。

◆ 十、放回日子里

周老师那天去河边散步，碰见了老林。

他们很多年没有好好说话了。老林坐在长椅上，手里提着一只药盒，看见周老师，点了点头，说：「我这样的人，就不陪你走了。」

周老师没有讲道理，没有说「你要想开点」，也没有说「你别把自己当病人」。他只是在长椅的另一头坐下来，从口袋里摸出那本红皮本子，晃了晃，说：「我前阵子老想，这玩意儿，到底是我的医生，还是我的管家。」

老林笑了一下。

周老师说：「走一圈吧，就一小圈。你要是累了，我们就坐。」

他们没有走完一圈。走到桥边，两个人就坐下了，看水。老林说了很多话，说老伴，说儿子，说自己那两年，一句话都没敢对别人讲。

回家的路上，周老师想起外孙豆豆的事，想起自己当初悄悄送走的那只小乌龟。他心里有一点愧，也有一点轻。他对周岚说：「这些年，我也在写别人的名字。」

周岚说：「爸，我们都在写。」

几天以后，周岚在门诊里接待了一位刚拿到名字的阿姨。阿姨一进来就问：「大夫，我是不是就成病人了？」

周岚没有先解释名字。她说：「您先告诉我，您平常一天里，最喜欢干的是哪一件事？」

阿姨愣了一下，说：「我喜欢早上去菜场。」

周岚说：「那好。我们今天商量的，是怎么让您接着去菜场。」

阿姨的肩膀，慢慢松了下来。

后来，老林开始每周三下午，跟周老师在河边走。一开始是半圈，后来是一圈。他没有一下子变回从前的样子，他的药还是照吃，血压单子还是照记。只是有一回，他对来看他的儿子说：「我今天走了一圈，不累。」

儿子在电话那头愣了几秒，说：「爸，那你下回再走一圈。」

这一句，和当年那句「你以后什么都别操心了」，只差了几个字。可是它往回写的东西，完全不同。

这一章，留给你三件明天就能试的小事。

第一件，下一次复诊，问医生三句话。

这个名字之后，有哪些事我可以照常做。

什么情况下，我要尽快回来。

什么情况，不用慌。

这三句话，不是质疑，是请医生把名字，接到日子上去。

第二件，是给家里人的。一家人坐下来，约好一件事：这个病名，只在三个地方说，看病的时候，吃药的时候，填表的时候。平常，不拿它做称呼，不拿它做理由。你可以说「爸今天头有点晕」，不要说「爸这个病人今天不舒服」。

第三件，是给病人自己的。试着把「我是 X 病人」，换成「我在管 X」。这不是要你硬撑，也不是要你什么都扛着。名词会把人关进去，一件事，是可以放下又拿起的。

带 走 的 话

同一个病名，可以写成一条路，也可以写成一只笼；好的诊断，不只问准不准，还问开出来的是路还是笼。

小　账

这一处，开门还是关门：这一章问的就是开门还是关门。通路开的是「回写」那一扇：名字出口以后，日子里多出了几条能走的路。

病放在一个人身上，还是放回复合体里？不放在「心态不好」的病人身上，也不放在「一句话说重了」的医生身上，放回名字被写下去的整个复合体里：家里的菜，单位的表，手机里的搜索，还有那句自己对自己的称呼。

想 一 想

一，你或你身边的人，有没有拿过一个病名，后来发现它在日子里的分量，比医生那句话重得多？

二，你家里有没有一个词，被当成了谁的称呼？如果把它换成一件正在做的事，会是什么？

三，下一次复诊或第二次看病的时候，你想对医生说的第一句话是什么？

◆



第　三　编

三态与转换：定型靠一锅粥和悬着活着

编　序

前两编，本书先拆掉三个先在者：病人、医生、观察者，都不在互动之前就站好了。接着又把诊断立成一个开端：挂号那一刻，病人位、医生位和病名一起显出来。可开端只是开端。这一编往下走，问的是开端之后的事：「医生—病人」这个复合体，怎样一站一站地换状态。

先把三个状态摆在桌上。本书说它们，用的是家常词：一锅粥、悬着（也叫正在成形）、定型。

状态	复合体处在哪里	典型现象
一锅粥（混沌态）	苦已经有了，形状还没有；病人位、医生位、病名都还没分开	「查不出问题，但就是难受」；挂号之前的那些夜晚
悬着（介生态，也叫正在成形）	病名已立，结局未定；三样东西都出现了，却还在彼此改	等报告、调药、复诊、「先观察一段时间」
定型（秩序态）	稳住了，认得出，传得下去；复合体有了一套熟悉的做法	「控制得不错」；固定的复诊节奏；病名成了日子里的一个词；也可能是复合体不再被需要，散开了

这一编四章。第 9 章写悬着：病名已立、结局未定的那一段，每一次复诊、调药、等报告，都是一次状态转换。第 10 章写一个反直觉的判断：定型不是终点，它靠一锅粥和悬着活着；从不进入悬着的人，不是健康，是把一锅粥压住了。第 11 章写两种读数为什么不能同时测准：器质性的和心因性的，越追一头，另一头越模糊。第 12 章写最好的痊愈：复合体不再被需要，散开。

这一编要让你看见一个反差。我们总以为，好，就是稳住不动。可稳住的东西，靠的是一直在动：它每天被碰一下，晃一下，又接住。

09

第 9 章

介生态：悬着的治疗

◆ 一、你一定有过这样的时刻

报告单拿在手里，上面有一行字，你读了三遍。

医生说：「先不用太担心，调整一下，两周后回来复查。」

你点点头，把单子折好，放进包里。走出诊室的时候，腿有点软，可又说不出软在哪儿。

接下来的两周，日子照常过。上班，做饭，回消息。不过心里有一个角落，一直亮着。夜里翻身的时候，它亮一下；刷到一个病名，它又亮一下；朋友说「我认识一个人，也是这样」，它亮得更久。

那两周里，你不算病人，也不算没病。你手里有了一个病名，可是没有一个结局。你不是在等医生，你是在等一件还没发生的事。

这样的时刻，几乎人人有过。等一份复查的血检也好，等孩子第二次听力测试也好，等父亲换药后的第一个星期也好。

这种滋味，说不上是病，也说不上是好。本书叫它悬着。

前面几章，一直在写开端：苦怎样走到诊室，挂号那一刻怎样把病人、医生和病名一起带出来。这一章往后走一步，问一件很少有人认真问的事：开端之后，结局之前，那一段悬着的日子，到底是什么？

那一段，医学的书里通常只有几个字：随访，观察，复查，调整。不过对走进去的人来说，那是整个治疗里最长的一段。

你有没有发现，治疗里最难熬的，常常不是被告知病名的那一刻，而是随后那些没有话可说的日子？

那一刻，至少有一个确定的东西落了地。后面的日子，什么都没落地。

家里的人也跟着悬。你妈什么都没问，可她把你爱吃的菜接连做了三顿。你爱人晚上把电视的声音调小了，一句话也没说。孩子问：爸爸是不是生病了？你说：没有，就是去检查一下。

你看，悬着的不是一个人。一张报告单落下来，整个屋子的空气都换了一种密度。

这也是本书一再要说的事：病不在一个人身上。从拿到病名的那一刻起，受影响的是一个连着好几个人的东西，而这些人，彼此谁也不敢先开口。

◆ 二、老看法：病名一立，剩下的是执行

先说老看法，因为它对在很多地方。

发现学的医学是这样想的：病在身体里，早就在那里。医生的工作，是把它找出来、认出来。诊断做完，真相到手，剩下的事就是按方案执行，再看疗效。

在这个想法里，诊断是终点，治疗是终点之后的一条路。路上要走多久，主要看病本身有多重、药有多灵。医生是执行方案的人，病人是接受方案的人。

那么悬着是什么？是空白。是诊断和结果之间那一段等待。等的时候，什么都没发生，只是时间在过。

这个看法有它完全成立的地方。分期、分型、指南、随访安排，把很多人的悬着变得不那么乱。一个病有了成熟的路径，医生和病人都知道下一步在哪儿，这是几代人用命换来的东西。本书不反对它，也不想拿它换什么。

比如血压。很多人吃药多年，每隔一段时间量一次，数字稳，就继续；数字跳，就调整。这套做法让无数人安稳地过日子。

可是，如果你问一个真正在悬着里的人：这段日子里什么都没发生吗？

他大概会摇头。

他会告诉你，那段日子里发生的事，比诊室里多得多。他每天量一次，把数字记在本子上；他开始留意头在什么时候沉；他学会了一句话——「我这个情况，医生说还要看」——并且发现，说这句话的时候，他在家里的位置悄悄变了。

这些，不在方案里，也不在指南里。可是它们是真的。

老看法把这段日子看成空白，是因为它的眼睛一直盯着一个东西：病本身。病没有变，所以看上去什么都没发生。

说句公道话，医生自己也不爱说「先观察」这三个字。它听起来像是什么都没做。诊室里的十分钟，医生想给出一个能放进手里的东西：一个处方，一张检查单，一个预约。「观察」不是一个能放进手里的东西，所以常常被说得很轻，轻到病人听成了「不要紧」，或者「没办法」。

这里没有谁做错了什么。是老看法的镜头只有一个焦点：病。焦点之外的东西，比如日子，说法，家里人的脸色，下一次见面之前的那些夜晚，都在画面外。画面外的东西，不会进入记录，也就很难进入下一次的方案。

所以，老看法最大的缺口，不在它说错了什么，而在它没有一个位置，放「悬着的人」这件事本身。

还有一个缺口，在「平均」两个字上。

指南是很多人的经验磨出来的一条平均的路，它让大多数人少走弯路。这很好。不过悬着的日子，是这一个人、这一个家的路。平均的路画得再准，也画不出周老师家里那条通往菜市场的小巷，画不出一个人只在下雨天才头沉。

指南负责大路，悬着负责小巷。两样都要，缺了哪一样，人都会迷路。

◆ 三、本书的说法：病名已立，结局未定

本书换一个看法。

前面讲过，挂号那一刻，病人位、医生位、病名、科室，是一起显出来的（第 6 章）。它们不是三个各自站好的东西，碰到一起才有了名字。

病名一立，复合体就进入了一个新的状态。这个状态里，三样东西都已经出现了，不过它们还在彼此改。

病名在改。刚听到病名的时候，它只是一行字；过了两周，它成了你在饭桌上说的一句话；再过两个月，它成了你给自己排日程的依据。病名没有变，可它在日子里的分量，一直在变。

病人位在改。一个人从「刚被告知的人」，变成「正在吃药的人」，变成「知道自己该问什么的人」。

医生位也在改。第一次见面，医生面对的是一份检查单；第三次见面，医生面对的是一个他认得出的、讲得出自己日子的人。

三样东西一边出现，一边互相拉扯，谁也没站稳。这个状态，本书叫悬着，也叫正在成形（SDE 称它为介生，指的是同一回事）。

打一个比方。两个人拉一把大锯。刚下锯的时候，锯口还没成线，锯条晃，两头的劲也不齐。慢慢地，一头推，一头拉，锯口越来越深，锯条才稳。

悬着，就是锯口刚开、锯条还晃的那一段。

为什么也叫正在成形？因为这里的形状，是一条从模糊到清楚的光谱。刚听到病名的时候，复合体的样子还很模糊：说不清病人该做什么，医生该看什么，病名意味着什么。过了几个星期，轮廓一点点清楚。清楚到某个程度，就可以说：定型了。

第 8 章讲过，病名有两种回写：成了通路，或者成了笼子。

那一章讲的是结果，这一章讲的是岔路口。通路和笼子，不是在病名立下的那一刻分开的，是在悬着的这些日子里，一次一次分开的。同一个病名，复诊时多问了一句，多答了一句，路就宽一点；复诊时一句话没说，一句话没听，路就窄一点。

所以，悬着不是结局之前的前奏，它是结局的出生地。

这样看，全书一直在讲的那件事，又多了一层。

挂号那一刻，是复合体的第一次显影：病人位、医生位、病名，一起出现。悬着的尽头，是第二次：方案落了地，说法有了形，复合体换成一副新的样子站在那里。两次之间，就是悬着。

诊断是开端，不是终点。开端之后不是一条直路，是一段还在长的路。

锯口不是哪一头锯出来的。它是两头的劲一起磨出来的。这一段，医生的一句话、病人的一个沉默、一张新报告、一次没来的复诊，都在改锯口。

所以，悬着不是空白，也不是等。

悬着是复合体的一个状态：形状已经冒头，却还没有站稳。

一锅粥是什么都有，什么都没分开；定型是稳了，认得出，传得下去。悬着在两者之间：最有可能长成好东西，也最有可能长歪。

这一章要说的话，就压在这里：病名立了，结局还没有写；这一段，是治疗真正发生的地方。

所以，本章的题目叫「悬着的治疗」。

这里的「治疗」，不只是药和手术。在悬着里，治疗还有另外一层意思：让复合体在这一段里，长出一条可以走下去的路。药是路上的一块石头，复诊是路上的一个路标，一句问话是路上的一盏灯。治疗，是把这些东西接起来，让路通。

用这个眼光看，悬着里最重要的治疗动作，常常不是新开一个处方，而是约定下一次。下一次是什么时候，看什么，谁来联系谁。这三样东西定下来，悬着就有了骨头。

◆ 四、每一次复诊都是一次状态转换

悬着不是一个固定的屋子，人住进去不动。它是一连串的小转换。

先说复诊。

你回到诊室。医生翻开上次的记录，问：这两周怎么样？

你说：还行，就是早上起来头有点沉。

就这一句话，复合体换了一次状态。上次出门时，它是「刚调了方案」的复合体；这一句话进来，它变成「调了方案、并且日子里出现了一个新东西」的复合体。医生下一句要问什么，要不要换时间点，要不要让你再多量几天，都从这一句话里长出来。

复诊不是去检查「方案对不对」。复诊是把日子里发生的事，带回诊室，写回方案。本书叫这个动作回写：长出来的东西，回头改路、改土。

再说调药。

一次调整，在发现学的眼里，是医生根据数据改了一个处方。在本书的眼里，它是复合体向日子提的一个问题：换成这样，你的日子怎么说？

日子的回答，才是这次调整的真正结果。同一个处方，落在不同的日子里，回答不一样。有人的日子接得住，有人的日子被它弄乱了。

（本书只谈复合体怎么变，不谈该用什么药、怎么调。身体或心里的难处真的大了，请找医生或心理咨询师。）

最后说等报告。

等报告是最长的一种悬着。它长，是因为这时候没有人在动：医生没有下一句话，病人没有下一个动作，只有一张纸在别的地方生成。

不过这一段，复合体并不是停着的。等的人在改变自己对病名的态度，医生位也在等里面微微后退或前倾。等到报告出来，诊室里那场谈话的样子，早在等的时候就定了一半。

你看，复诊、调药、等报告，三件事不一样，可它们做的是同一件事：把复合体推到下一个状态。

要特别说清一点：状态转换，不等于病情变化。

血压的数字可以一点没变，复合体的状态却换了好几轮。第一次来，诊室里说的是「怎么办」；第三次来，说的是「我们习惯了什么」。数字还是那个数字，可那是两个不同的复合体。

这就是为什么，同一个人、同一个病名、同一套方案，在不同的时间点上，会有完全不同的结局。

还有一种转换，常常被忘记：没来。

约好两周后复诊，你没去。也许是工作走不开，也许是觉得好多了，也许是不想再面对那张单子。没去，也是一次转换。复合体没有因此停下，它换了一个方向：医生位开始闲置，病人位悄悄缩小，病名退回到抽屉里。

也有人在这时去找了另一个医生，要一个第二意见。第 8 章说过，第二意见不是纠错，是重新起头。放在悬着里看，它是复合体把自己拆开，再换一个医生位重新拼一次。

这样看，每一次转换，大致有三个去向。往定型去：锯口成线，大家熟了，复诊成了一种节奏。往一锅粥去：线断了，话散了，病名重新变得陌生。留在悬着里：还在改，没有定论，需要再来一次。

三个去向，都可能是对的，也都可能是错的。要紧的是，别拿其中一个当成「应该」。该往哪里去，要看这一对人、这一个病、这一段日子。

◆ 五、悬着不是半成品

很多人把悬着看成半成品：快要好了，还没好；或者快要坏了，还没坏。好像只要熬过去，就算完事。

本书不这样看。悬着不是半成品，它是整个过程里最有创造的一段，也是最危险的一段。

先说创造。

病名刚立的时候，它是一个外来的词。医生说它，你听它，它不属于你的日子。悬着的这段，病名一点一点被日子改写。它有了你自己的叫法，有了你家里人都懂的说法，也有了自己在日子里的位置：哪一顿饭前吃药，哪一个节日别忘了复诊。

这是一种创造。没有人规定这样做，可它一定会发生。

同时，病人位也在被改写。一个人学会了提问，学会了记下自己的数字，学会了在医生说「观察」的时候，追问一句「观察什么」。这个人，几个月前还只会说「我听医生的」。

医生位也一样。一个医生在悬着的这段时间里，才第一次听见这个人真实的日子，才第一次知道「早上头沉」对这个人意味着什么。医生的做法，也是在这一段里被这个具体的人改出来的。

家里的人也在改。周老师的老伴，原来对血压这件事什么也不管，现在每天早上多问一句「量了没有」。外孙豆豆，有一回看见外公在红皮本子上写字，也找来一支笔，在旁边画了一条弯弯曲曲的线，说是「外公的血压山」。

悬着里，每个位置都有自己的活儿。

病人位的活儿，大致有四样。一是带信：把日子里发生的事，带回诊室。二是守约：下一次说好了，就来，或者说一声不来。三是翻译：把医生的话，翻成家里人听得懂的话；也把自己的感觉，翻成医生用得上的话。四是试错：新方案落进日子，试一试，不行就说。

医生位的活儿，也大致有四样。一是听：听数字之外的那一句。二是定节奏：下一次什么时候，看什么。三是留门：该说「不确定」的时候，说「不确定」，不硬捏一个结论。四是翻译：把术语翻成这个人用得上的话。

两边的活儿，有一样是共同的：翻译。翻译做得好，锯口就顺；翻译断了，哪一头都使不上劲。

这些活儿，没有一样需要「看穿」什么，也没有一样需要「决定」什么。它们都是接。一头递过去，一头接住。

这些，都不在方案里，可是它们一起把「这个病」，慢慢变成了这一家人日子里的一件熟事。

一句话：在悬着里，复合体正在长出自己的路。

悬着的长短，没有一个标准。有的三天，有的三年。有些慢性的病，一个人一辈子都带着一点悬着：数字在稳，可没人能打保票。

这不算失败。很多人把「一直没有定论」当成一件丢人的事，好像治疗没完成。可是长期和一个病一起过日子的人，大都知道：悬着可以很长，长到成了日子的一部分。到了那时，问题不再是怎么熬过去，而是怎么在悬着里过得像样。

像样的意思是：有节奏，有人接话，有一个能放心问问题的地方。

再说危险。

悬着最怕两种掉法。

一种是太早定型。病名一立，大家立刻觉得「就是这样了」。病人说：「我这个病，就这么着了。」医生说：「按方案走就行。」双方都松了劲，锯口还没成线，锯条就被卡住。往后的复诊变成例行公事，日子里再长出来的新东西，没人再听。

另一种是散回一锅粥。悬着的日子太长，没人说话，没有下一个明确的安排。病人开始自己搜，搜到的说法互相打架；开始自己改，改完又后悔；开始对医生说的话半信半疑。形状刚冒头，又糊成一团。

这两种掉法，都不是谁的错。它们是悬着本身的样子：既能长成好东西，也能长歪。

所以，悬着需要被认真对待。不是快点熬过去，也不是随便放着，而是把它当成治疗里的一段正经日子，给它一个落脚的地方，给它一点节奏。

◆ 六、只看一端会怎样

悬着的日子里，出了问题，人们习惯找一个人来怪。

一种说法是怪病人。「他不遵医嘱。」「她不按时来。」「他自己乱搜，把自己搜糊涂了。」

这些话里有一部分是真的。有人确实没来，有人确实停了该做的事。本书不抹掉这一部分。

不过，只怪病人，等于假定：方案是一个现成的东西，病人只是执行或不执行。这样看，病人位就成了一个先在的、能决定一切的人。

另一种说法是怪医生。「他开完药就不管了。」「她根本没听我说完。」「说好两周回来，到时候连个电话都没有。」

这些话里同样有真的一部分。医生没说清楚的，就是没说清楚；该追问的没追问，就是没追问。该追的责，照样追。

可是，只怪医生，同样假定：医生位是一个先在的、掌握一切的人，病人只是被处理的对象。

两种怪法，其实站在同一块地上：都想找到一个「发动者」。

还有第三种怪法，怪病本身：「这个病就是难缠。」「谁让它偏偏落在我头上。」这话有时候只是叹息，叹了反而松一口气。不过它也有一个暗处：把整个悬着交给运气，复合体就没有什么可以做的了。

三种怪法，怪的对象不同，结局相似：悬着里那些小小的转换，都被一个「都是因为」盖了过去。

回到拉大锯。锯口卡住了，你能怪哪一头？一头松了劲，另一头独自拉不动；一头拉歪了，另一头跟着歪；两头都没松，可锯条本身钝了。卡住，是两头加上锯条一起卡出来的。

悬着的日子里出现的问题，也是这样。方案没落地，也许是病人的日子接不住，也许是医生没有把话说成病人能接的样子。也许两头都没问题，而中间那一环断了，比如下一次约定的时间。

本书不取消追责。该问的问，该改的改。追责是修复的一部分。

不过追责要追得对。追的不是「谁是罪魁祸首」，而是「锯口卡在哪一处」。找到那一处，才能松。

举个小例子。一位病人说：医生，我按您说的吃了，怎么还是不舒服。医生说：那您回去再试试。两个人各自说了一句完全合理的话，可锯口就卡在这里：没有人问「不舒服」是哪一种不舒服，也没有人约下一次什么时候再谈。

后来发现，锯口卡的地方很小：只是少了一句「下周三我给你打个电话」。

追责追到这一步，不是为了让谁难堪，而是让下一对人少卡一次。该道歉的道歉，该补上的补上，该约的约上。这些都是修复，也都是治疗的一部分。

还要替医生说一句公道话。

一位门诊医生，一天面前坐着几十个人，其中大半都在某一种悬着里：这个等报告，那个在调药，那个下周复诊。医生位不是无限的。他不可能对每个人的每一个晚上都有回应。

所以，悬着需要被管理，而不是被消灭。管理，是让有限的医生位，落在最需要的地方：约好的下一次，说清的边界，留好的联络方式。这些，是制度的事，也是每一位医生每天的小习惯。

◆ 七、悬着里的时间

悬着的日子，有自己的钟。

那个钟不是墙上的钟。墙上的钟，两周是十四天，一天二十四小时，匀速地走。悬着的钟，不匀速。

刚走出诊室的头两天，最快。你有很多事要做：去药房，告诉家里人，上网查几个词，安排一下手头的工作。时间被塞满，反而没空想。

到了第四、第五天，最慢。事情都做完了，该交代的交代了，可是复诊还早。这几天，每一个小时都有点长。夜里醒的次数，也比平时多。

再往后，一个很怪的现象会出现：你开始忘记。日子照常转，你照常吃饭，有时一整个下午，你没想起那张单子。你甚至觉得：是不是没那么严重？

然后，复诊前两天，它又回来了，比第一次更清楚。

这样一条曲线，很多人走过。它有一个朴素的解释：悬着的人，不是在等一个日期，而是在等一次转换。转换之前，复合体把能做的事都做了，剩下的是一个空档。空档里，注意力一会儿被日子拉走，一会儿被那个日期拉回。

这个空档，如果有人陪着，会好过一些。不是陪着聊病，只是陪着过：一起做一顿饭，一起走一段路，一起看一部什么也不相干的电影。

复诊的日子本身，也值得郑重。它不是一个「到点了去看看」的日子，它是整个悬着里最亮的一个岛：这一天，复合体要换一次状态。去之前做一点准备，去之后留一点时间，这个岛就会更稳。

有人的习惯是：复诊那天，约一个不太着急的下午；看完，不急着回去上班，先坐一会儿，吃一碗热的东西。

这不是矫情。这是给复合体换状态，留一点余地。

◆ 八、今天与机器

今天的悬着，和三十年前不太一样。

以前，报告单是一张纸，别人不给你，你就拿不到。你悬着，是因为你手里什么也没有。

现在，报告在手机上。检验一出，一个小红点跳出来，数字后面跟着一个箭头：向上，或者向下，还有颜色。你比医生先看到它。

医生还没开口，复合体里已经多了一个读者，就是你自己。

还有一个读者在你的口袋里。你把数字发给一台会说话的机器，三秒钟，它给你一段解释：这个指标是什么，偏高可能意味着什么，常见的原因有哪些。

这很有用。很多人因为这样才弄懂了单子上的词。

不过它也改变了悬着的样子。

以前悬一周，现在每隔几分钟刷新一次。以前等医生一句话，现在先有了三个版本的话。以前的悬着是一块整的，现在被切成很多碎片，每一片都有自己的小起伏。

机器没有错。机器给你的解释，大致都是对的。

错在我们很容易以为：读得出来，就等于定得了。

读得出一个数字的意思，不等于这个数字在你这个复合体里是什么意思。同一个箭头，落在周老师这样吃药多年的人身上，和落在第一次拿到报告的人身上，是两回事。机器读的是箭头，读不到「这个复合体的这两周是怎么过的」。

所以，今天的悬着多了一个新任务：别让机器的解释太早替你定型，也别让它把你搅回一锅粥。

医生那一头也变了。医生翻开的病历，越来越多地带着自动生成的提示：哪一项偏离了范围，哪一项该复查。这些提示很有用，它们防止遗漏。

可是医生的十分钟没有变长。多出来的提示，要占用同一段十分钟。有时候，医生看屏幕的时间，比看你的时间还多。

这又是一个卡口：数据多了，听话的时间少了。锯条更锋利，不过两头的节奏更难对齐。

办法不在机器里，在两个人愿不愿意，在这十分钟里，留一句不是从屏幕上来的话。

还有一层，夜里。

很多人是在夜里问机器的。白天的诊室只有十分钟，夜里的机器可以陪你聊一个小时。它耐心，不烦，不看表。你问第五遍，它还是认真答。

这是一件好事。悬着的夜晚，最缺的就是一个能说话的对象。

可是机器爱把话说圆。它总想给一个完整的答案：可能是这几种原因，建议您注意这几点，必要时请就医。圆的话听着安心，可悬着有时候要的不是圆话，而是半截话：「我也不确定，我们再看两周」。

半截话是悬着的原话。把它说圆了，悬着就被抹平了。抹平的不是不安，是不安该去的那个地方：下一次见面。

机器是一个新的位子（复合体里的一个位置，这里是读者位）。它在你的复合体里出现了，可它不是在旁边看的：它读，你就被它读过；你问，它就改了你的问法。这件事，第 16 章再细说。

◆ 九、一个完整的例子

周老师六十二岁，退休前教了三十多年语文，血压高了很多年。

这一年春天，他自己在家量，发现早晨的数字比平时偏高。他在小区门口的社区医院，找到了女儿周岚。周岚是全科医生，不过在诊室里，她不当女儿，也不当家属，她是医生。

诊室里，周岚看了他这两周的记录，说：早晨偏高，我们先换一个方案，两周后回来再看。

周老师回家，把新方案抄在一张便条上，贴在冰箱门上。他又把那本红皮本子翻出来，每天早晨、晚上各记一行。当了一辈子语文老师，他记东西的样子很像批作业，一行一行，规规矩矩。

两周后，他回到诊室。数字好看了。

这时候，如果复诊只是核对数字，故事到这里就可以结束：方案有效，继续。

不过周老师随口说了一句：「就是早上起来，头有点沉。」

这句话本来可以被放过去。数字好了，一句「有点沉」，听起来像是老人的小毛病。不过周岚停了一下，问：「是起床马上沉，还是吃完药以后沉？」

周老师想了想：「吃完药以后。」

周岚看着那本红皮本子，说：「那我们把方案再调一调，再试两周。」

就这样，方案又改了一次。不是因为数字不对，而是因为日子里长出了一个新的东西，被一句话带进了诊室。

可是，不是每一段都这样顺。

到了第二个月，周老师有整整一周没有记数字。起因很小：小区的老人群里，有人转发了一篇文章，说某类药吃久了不好。周老师读完，心里咯噔一下。那一周，他早晚照吃，不过本子合上了，他不想看见那些数字。

复诊那天，周岚翻开本子，看到一整页空白。

她没有说「爸，你怎么没记」。她问：「这周发生什么事了？」

周老师沉默了一会儿，把那篇文章的事讲了。

周岚没有急着反驳文章。她问：「你最担心的是哪一句？」周老师说了。周岚把那一句拆开，说哪一部分是真的，哪一部分和他这种情况不相干，哪一部分她自己也不能保证。最后她说：「这一块，我不能替你打包票。我们这样，下个月多查一项，看一看。」

那一周空白的本子，没有被当成「不配合」。它被当成一次转换：复合体往一锅粥那边滑了一下，被一句问话接住，拉了回来。

第三次复诊，周老师带来的不只是本子，还有一个问题。他问：「我这个病，到底算什么程度？」

这是他吃药多年以来第一次这样问。以前他只会说「我听医生的」。周岚没有马上回答，她把报告拿出来，一项一项指给他看，用他听得懂的话讲了一遍。

三个月后，方案稳下来了，不再每次都换。每个月一次的复诊成了一件日常的事，写进了周老师的日历里，就在「去菜市场」和「给豆豆辅导作业」之间。

整个过程里，没有一个人「看穿」了什么，也没有一个人「决定」了什么。数字没有大变，药也没有换成什么特别的药。变的是复合体：一开始，它是「刚调完方案」的状态；经过两三次回写，它长出了「方案、日子、问法」三样东西互相接住的状态。

这就是悬着的治疗。

再看一眼：每一次转换，都不是医生单独做的，也不是病人单独做的。是一句话进来，一个本子翻开，一个问题问出，复合体的状态才往前挪了一步。

要不要再说一个反过来的例子？

周岚自己也悬过。去年体检，她一项指标偏了，同科室的同事看了一眼，说：「先不用管，三个月后复查。」周岚点头，说好。她比谁都清楚这句话是什么意思，也清楚这个指标大多数时候是怎么回事。

不过那三个月里，她夜里照样醒。

她后来笑着说：「我背得出所有的指南，躺在床上，我背不出来。」

这个小插曲，把一件事讲得很清楚：知道得多，不等于不悬着。悬着不是知识不够，是复合体正在成形。医生位和病人位，那一晚在她一个人身上同时坐着，谁也没有安慰到谁。

后来她做了一件事：去找那位同事，说，三个月太长，能不能到六周的时候，我们先聊一次。同事想了想，说好。

六周的时候，什么也没有改变，指标也没有变。可是那天之后，周岚夜里睡得好了一些。因为悬着有了一个落脚处。

周岚后来说过一句话。她说，在家里她是女儿，在诊室她是医生，可是真正帮上周老师的，是那一刻两样身份她都不用，只是和他一起看着那个本子。

位子会换，这是一家人的福气，也是难处。

女儿的眼睛看见爸爸瘦了，医生的眼睛看见数字好了，两双眼睛要在同一个人身上对上。对不上的时候，锯口就会晃。周岚的办法，是在诊室门关上之前，把话

说成两遍：先按医生的说，再按女儿的说，让周老师知道，哪一句是从哪一边来的。

◆ 十、悬着的专用话

悬着的日子里，诊室里有一批专用的话。

「先观察一段时间。」「目前看问题不大。」「不排除某种可能，我们再做个检查。」「定期复查。」

这些话你一定听过。它们不是谎话，也不是废话。它们是悬着专用的话。

先看「先观察」。它的意思，不是「不管了」，而是「现在下结论，还早」。它把门留着。留门，是医生位对复合体的一份诚实：形状还没出来，不能硬捏。

再看「不排除」。这三个字最让人睡不着。它的意思是：有一种可能，我现在还不能放掉，也不能抓住。对医生来说，这是严谨；对病人来说，这是一块石头悬在半空。

同一句话，在两个位置上，重量完全不同。

还有两句，也是悬着的老熟人。

一句是「回去等通知」。它的意思是：这件事的下一步，不在你手里，也不在我手里，在一张还没出来的纸上。它是实话。不过只说这五个字，等的人就不知道，等多久算正常，过了多久可以打电话问。把「通知大概什么时候来」补上，这句话就从悬空变成了有边的悬着。

另一句是「有什么不舒服随时来」。它是善意，也是门。不过「随时」两个字，常常让人不好意思真的来。把它换成「如果出现这几种情况，就提前回来」，门就有了把手。

所以，悬着的话，要多说一层。医生说「先观察」，可以接一句：「观察的是什么，观察多久，什么情况就提前回来。」病人听到「不排除」，可以问一句：「您说的这个可能，大概有多大把握？」

这样多说一层，悬着就有了一个边。有边的悬着，是可以住的。没边的悬着，才叫人睡不着。

（这里说的是怎么把话说清，不是该做哪些检查。）

悬着的话有一个特点：它们是给下一次见面留的。每一句，都在约下一次。如果一句话说完，没有下一次，它就从悬着的话变成了悬空的话。

◆ 十一、放回日子里

回到开头那个人。

他拿着报告单，走出诊室，腿有点软。

接下来的两周，他不必假装不在乎，也不必每分钟盯着手机。他可以做一件很小的事：给这两周一个落脚的地方。

明天能试的办法，是在复诊前，用三行字写下这两周：

第一行：这两周，我的日子里，有什么和平时不一样。

第二行：我最担心的一件事是什么。

第三行：下一次，我想从医生那里听到哪一句话。

写给自己看就行，不用写得好。复诊的时候，你可以把它拿出来，也可以不拿出来。写下来这件事本身，就是把一锅粥收成一点形状。

这不是诊疗建议，也不替代医生的判断。它只是让你在悬着里，有一样东西可以抓。

如果你是在诊室另一头的人，周岚有一个习惯，复诊快结束的时候，她会多问一句：「这两周，你们家里有什么和平时不一样的吗？」

这一句话，常常能让一次复诊多出很多东西。因为它把日子请进了诊室。

还有一个小改动，她也用得顺手：不问「有没有按时吃」，问「吃的时候，有什么不方便的地方」。前一句像审问，答案只有「有」和「没有」；后一句像邀请，答案里会带来日子。同一件事，换一种问法，锯口的角度就变了。

还有一个办法，给家属。

悬着的人，身边常有一个不知道该怎么办的人。你想帮忙，可又怕说错。有一件事不容易错：陪他问「下一次是什么时候，看什么」。

这一问，给悬着加了一个期限和一个焦点。有期限的悬着，不容易散回一锅粥；有焦点的悬着，不容易被太早定型。

你不必给出答案，你只是陪他把锯口的位置，再确认一遍。

带 走 的 话

病名立了，结局还没写；每一次复诊，都是复合体换一个状态，不是检查方案有没有错。

小　账

这一处，开门还是关门：这一章开的是路。悬着的日子里，每一次复诊、调药、等报告，都在给复合体多开一条路，也都可能把路堵上。

病放在一个人身上，还是放回复合体里？如果把拖着没结局的事，归给「病人不配合」或「医生不作为」，就放错了地方。悬着，是一对人一起悬着。

想 一 想

你最近一次「先观察一段时间」，是什么时候？那段日子里，你和给你下这句话的人，各自做了什么？

如果你家里有人正在悬着，你有没有问过他一句：「这几天，哪里和平时不一样？」

◆

10

第 10 章

秩序态依靠混沌态与介生态

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你听见一句话：「他平时好好的，从来不生病，怎么一病就……」

说话的人把后半句咽了回去。

老郑五十八岁，是周老师退休前的同事，教体育。二十多年没进过医院，同事聚会上他爱说：「我这身体，药店老板都不认识我。」学校每年发体检单，他拿到手，看都不看，往抽屉里一塞。那个抽屉里的单子，叠起来够翻一个下午。

老郑的妻子劝过他几回。他每回都是一样的话：「查出点毛病来，不是自己吓自己吗？」妻子就不再劝了。后来她说，她不是不担心，是怕说多了，两个人连这个话题都没有了。

这一段，你听了也许觉得熟。很多家里，都有一个这样的角落：大家都知道那里有一件事，谁也不先碰。

今年秋天的一个夜里，他醒了，觉得哪里不对劲。他躺着没动，想熬到天亮再说。天亮的时候，家里人看他脸色不对，硬把他送进了医院。

后来的两个多月，他住了院，换了好几个科室的医生。老郑这辈子没见过这么多白大褂。

同事们轮流去看他。回来的路上，每个人都说同一句话：「怎么这么突然。」

也有人说得轻一些：「早知道，平时该去看看。」

这句话，你大概听过，也许自己也说过。

可是这一章想先把它放一放。「平时该去看看」，听上去是一个建议，里面却藏着一个判断：他原来没有病，是他不看，才让病长大了。要不然就是：他原来就有病，只是没查出来，躲在身体里。

这两个判断，都把病当成了一个先在的东西，在那里等着。

本书换一个问法：老郑那二十多年的「从不生病」，到底是什么状态？

它真的是健康吗？还是另外一种东西？

◆ 二、老看法：定型是终点

先说老看法，它有它的道理。

发现学的医学，心里有一条线。左端是病，右端是健康。治疗，就是把人从左往右推；推到右端，就叫痊愈。体检单上「各项指标正常」，慢病门诊里「控制良好」，都是在这条线的右边，是医学能给的最高的话。

在这个想法里，状态是一条往前走的梯子。一锅粥最差，什么都说不清；悬着稍好，正在查、正在试；定型最好，稳住了，认得出，不用再操心。越往后越好，好了就停在那里。

所以，一个人如果一直站在右端，没有离开过，他就是最幸运的人。老郑二十多年没进医院，在这个眼光里，是赢家。

那么，赢家为什么一病就重？

老看法有两个现成的回答。一个叫运气：他倒霉。另一个叫隐患：他早就有病，是查得太晚。

这两个回答，都有人信，也都有它成立的地方。

这两个回答，有一个共同点：它们都在找一个落点。要么落在老郑身上（他不看，他早有病），要么落在运气身上（他倒霉）。没有一个回答，肯去看老郑和他的医生、他的家人、他的日子之间，那些二十年里没有发生过的事。

「没有发生过的事」，是发现学最难看见的东西。它只看得见有的，看不见缺的。

早筛、体检、慢病管理，这些做法是真能救命的。一个本来可以早一点知道的事，被拖到最后一刻才知道，是个大遗憾。本书不反对体检，也不说老郑「活该」。

不过，这条线有一个没有明说的前提：定型是终点，到了就可以放心；悬着和一锅粥，是要尽快离开的地方。

这个前提，在日子里经不起看。

你想想自己。你吃饭、睡觉、上班、吵架、着凉、好了，每一天都有一点点晃。哪有一个人是站在右端，一动不动的？没有。人天天在往回走：今天睡得不好，一小片一锅粥冒了头；明天去药店买点药，又进了一小截悬着；后天好了，又定型了。

梯子没有回头路，日子却天天回头。

老看法把「回头」看成倒退，看成失败。本书要说的，恰好相反。

再多说一句这条线的来历。把病和健康排在一条线上，是一个很顺手的想法：线上有刻度，刻度可以读，读出来的数字可以比。血压多少，血糖多少，三年前多少，现在多少。一条线，让医学可以量，可以管，可以教给下一个人。这是它的力量。

可是线只有一个方向。它没有地方放「我今天有点乏，说不出为什么」。这一句，线上没有刻度，所以读不出来，也就不进入记录。

于是有一类事，在线的体系里天然是隐形的：没有形状的苦，还没成型的担心，夜里才冒出来的那一点点。它们不是不存在，是没有位置。

本书要补的，正是这个位置。

◆ 三、本书的说法：定型靠一锅粥和悬着活着

本书的说法，可以先用一件厨房里的事来讲。

蒸一笼馒头，要先和面。刚和的时候，面和水是一锅粥，什么都在，还没分开。放着，让它发。发的时候，面里一个一个气泡冒出来，鼓起来，软软的，碰一下就陷，这是正在成形。最后上锅蒸，蒸熟了，白白胖胖，咬下去有嚼劲，这是定型。

馒头是定型的。不过，馒头从哪里来的？

从发面来的。发面从哪里来的？从一锅粥来的。

你要是跳过发面，直接把和好的面团扔进锅里，蒸出来的是一个死疙瘩。你要是只发面，不蒸，它会一直鼓下去，鼓到塌掉。

三个状态，缺哪一个，馒头都不是馒头。

这里要特别替一锅粥说一句话。

一锅粥听上去像个坏词，像是乱，像是糟。其实它是原料。所有新的东西，都是从粥里长出来的。一个人第一次对朋友说出「我最近说不上来地难受」，那是粥里冒的第一个泡；一个孩子夜里说「我肚子里有点怪」，也是。

医学里，很多后来有了名字的病，最早都是这样一个说不上来的泡。把粥压住，等于把原料压住。原料被压着，下游什么也长不出来，既长不出好东西，也长不出该被看见的坏东西。

所以，本书不把一锅粥当成要尽快离开的地方。它是起点，要被认真地对待。

回到复合体。秩序态，也就是定型，是复合体的一站：稳住了，认得出，传得下去。可是它不是终点，它是靠下面的一锅粥和中间的悬着，才站得住。本书把这个意思说成一句话：

定型不是终点，它靠一锅粥和悬着活着。

「靠」字，有三层意思。

第一层，定型从哪里来。它从悬着里长出来，悬着又从一锅粥里长出来。没有那锅粥，没有那段悬着，就没有这个定型。

第二层，定型靠什么保持。不是靠焊死，是靠一次次被碰一下，又接住。今天着了凉，明天没睡好，后天跟人吵了一架，每一次，复合体都被拽回悬着一小截，又放回来。定型是被一次次重新定下来的。

第三层，定型坏了怎么办。它只能回到一锅粥，重新长一遍。没有别的路。

举个例子。一个人的血压控制得很好，吃药多年，复诊规律，这是一个漂亮的定型。某一年，家里出了大事，他连着三个月睡不好。这个定型被晃了一下：数字跳了，医生调了药，家里人也多问了几句。过了一阵，日子安顿下来，数字回去，复诊又规律了。

看上去，回到了原来。其实不是。这个定型，现在多了一段「被晃过又接住」的经历。他知道怎么跟医生说睡不好，医生知道这个人在压力大时会怎样，家里人知道要在哪一步提醒他。

所以，每一次被晃，都把定型加固一层。不是定型本身越焊越死，而是它的底下，多了一条路。

所以，一个定型要是长期不被碰、不被晃，不是它特别稳，是它在慢慢变脆。

在这里，先防一个误会。

有人会问：那是不是越晃越好？不是。

晃，要有人接。走路的人每一步都悬着，不过每一步都有地面在下面。复合体的悬着，也要有地面：一个能约下一次的医生位，一个能说话的病人位，一个听得见的家。没有人接的晃，是摔。

所以，本书说的不是鼓励大家去冒险，而是：给悬着一个被接住的地方。

这是这一章要说的反直觉判断：**从不进入悬着，不是健康，是把一锅粥压住了。**

这和上一章是连着的。第 9 章看的是悬着本身：它为什么不是半成品。这一章往后退一步，看全局：悬着和一锅粥，对定型意味着什么。

下面一步步说。

◆ 四、走路：每一步都悬着

王德生博士有一本专著，书名就叫《悬着才成事》。他用走路讲这件事。

他为什么要用走路讲？因为走路是人人会的事，不需要读书，也不需要懂什么术语。你只要在屋里走两步，就能验证他说的是不是对的。

你想想，走路是怎么走的。

你抬起一只脚，身体的重心往前去。那一刻，你其实是在往前倒。另一只脚还没落地，你就悬在半空。脚落下来，接住了，身体又往前倒，又抬另一只脚。

走路，是一连串「倒下去，接住」。每一步，都悬着。

那么站着呢？站着看起来最稳。可是你找个人，让他闭上眼站一分钟，你会看见他的身体在极小地摇，一点点往前，一点点往后，不停地在调。站着的稳，也是在调出来的，不是钉在那里。

按王德生博士的说法（大意），秩序态，也就是定型，要靠混沌态和介生态才能存在；走路只是一个最容易看见的例子。以上是本书对他的转述，只取这两点。

下面是本书顺着这两点，自己往下说的。定型的那只脚，是落地的那一下。落地之前，必须有悬着。而悬着，又靠一个还没有分开的、乱糟糟的整体：身体的重量、地面的硬度、风、鞋、心情，一股脑儿都在里面。

一个人如果要「不悬着」，只有一个办法：站着不动。

可站着不动的人，没有路走。

中国人对这件事，很早就有感觉。《周易》六十四卦，不是收在「既济」（事情做成了）上，而是收在最后一卦「未济」（事情还没做成）上。做成之后，又回到没做成。老子说「反者道之动」（《老子》四十章），大意是：往回返的那一下，正是道在动。

这两句话，本书只当旁证，不和王德生博士的说法混在一起。可是它们提醒我们：把「做成」当终点，不是人类的老办法。老办法，是把「没做成」留在最后。

把这个意思放回医患复合体，就清楚了。

一个复合体的稳，不是「不动」，是「一直在小小地动，又一直接得住」。复诊的节奏，是它的脚步。每次约好下次见面，是它落地的那一下。每次发现一点新的不舒服，说出来，是它往前倒的那一下。

倒下去是可怕的，不过不倒，就走不了路。

有一个细节，值得停一下。

走路的人，不会觉得自己在「倒」。他觉得自己在走。倒和接，被打成了一个动作。小孩学走路的时候，才第一次被分开看见：倒了，又倒了，扶着墙，哭，再试。那一阵子，全家人都围着他，蹲在地上，伸着手。

复合体也是一样。刚进入悬着的时候，每一次倒和接都看得清清楚楚：每一次复诊都紧张，每一次调药都盯着。到了熟练的时候，倒和接合成了一个动作，你不觉得它在悬着，只觉得「日子就是这样过的」。

熟练，不是不悬着了，是悬着被练得看不见了。

这也解释了，为什么有些老病号看上去什么都不在意，那样从容。他们不是不在意，是悬着被他们走成了路。

那么，一个复合体，从来不进入悬着，会怎样？

它就像一个人，二十年来决定只站着，哪儿也不去。看上去稳极了，可是哪天一阵风来，他连第一步都不会迈。

◆ 五、不进入悬着的人，把一锅粥压住了

「不进入悬着」，在日子里有三种样子。

第一种，不去。身体有点不对劲，想着「没事」，盖过去。体检单来了，不看。有人劝，就说一句「我身体好」。

第二种，不回。去了，拿了药或者得了一句话，就不再回去。「医生说没大事」，就当事情结束了。

第三种，不改。复诊也去，不过方案一动不动，日子也一动不动：同样的饭，同样的熬夜，同样的药，同样的话。每一次复诊，都在重复上一次。

这三种看上去很不一样，可它们做的是同一件事：不让一锅粥冒头，不让悬着发生。

拿三个人来看。

小李三十出头，在互联网公司上班，常常加班到深夜。胃有时候不舒服，他吃两片家里的药，压下去，接着干。他是第一种：不去。他的理由很实在：「去一趟医院，一上午就没了。」

陈阿姨六十多岁，去年被告知血脂偏高，医生让她三个月后回来。她吃了一阵，觉得没什么感觉，就不再去了。她是第二种：不回。她的理由也很实在：「又不难受。」

老张五十出头，每年复诊，每年拿同样的药，每年听同样的话：少喝酒，少熬夜。他每年点头，每年原样。他是第三种：不改。他的理由是：「医生知道我什么样，反正也是这样了。」

三个人，三种压法。你看，没有一个人是在对抗医学，每个人都有一个听上去站得住的理由。

（这里只描写人们怎么过，不说该不该吃药。）

他们的共同点，是那锅粥没有冒头的机会。

有一种压，在家里尤其常见：报喜不报忧。

「不想让孩子担心。」「说了也没用，反正他们也帮不上忙。」一个人有一点不对劲，自己扛着，电话里说「挺好的」。孩子也一样，工作上出了事，回家只说「都好」。

这是爱。本书一点也不想把它说成错的。不过爱和盖子，有时候是同一个动作：两边都为对方压住了那锅粥，结果是两头各自一个人，在各自的夜里。

复合体不止诊室里的两个人。家里的这一对，同样是复合体。它也需要悬着，也需要一句「我最近有点不一样」。

你可能会说：不让它冒头，不是更好吗？没有不舒服，没有担心，没有麻烦。

问题在这里：不让它冒头，不等于它不在。

一锅粥是什么？是什么都在，还没分开。身体有一点不对，心里有一点乏，日子里有一点没理顺，这些东西平常都在，只是多数时候很小，小到没有形状。小的时候，它们冒一个泡，破了，就过去了。

「不去、不回、不改」，等于是用一个盖子，盖在锅上。泡冒不出来，粥还在锅里，而且在加热。

这时候，盖子下面的东西，没有变少。它只是被压住了。

这里要小心一个说法。本书不是说，压住的东西一定是坏东西。很多小的不舒服，压着压着，自己散了。人本来就有这个能力。

本书说的是另一件事：压，只能偶尔用。如果压成了习惯，压成了对所有事情的统一回答，复合体就失去了分辨的机会。哪一个泡是该散的，哪一个泡是该看的，没有人再有机会判断。

分辨，是在悬着里才有的事。你给一个小不舒服一个落脚处，它才有机会告诉你，它是什么。

要说清楚，这不是在批评老郑。

每一个压住一锅粥的人，都有他的道理。有人要养家，请不起假；有人家里有过一个很坏的病名，从此听见「医院」两个字就发紧（这一点，第 8 章讲病名的笼子时说过）；有人是真的从小身体好，没有什么需要看的。

也要说清楚另一层：这件事，不能只算在老郑头上。

老郑的复合体里，从来没长出过一个医生位。二十多年里，没有人在诊室里认识他，没有人知道他「平时的样子」，没有人跟他约过「下一次」。他的病人位，也从来没练过：他不知道进了诊室，该怎么坐、怎么说、怎么问。

所以，老郑并不是「一个不爱看病的病人」。他的复合体，根本就没有走过从一锅粥到悬着的那条路。

那条路，不是一个人走的。需要有人在另一头等着。

◆ 六、平时不生病，一病就很重

现在可以回答开头那个问题了。

民间有一句话，很多人都信：「平时不生病的人，一病就很重。」

先说清楚，这是一个观察，不是一条定律。有人平时不生病，一病也就是个小病。有人病来得突然，跟平时怎样过日子没有一点关系。本书不说所有重病都是这样来的。

不过，如果有一类人，确实是「平时不生病，一病就重」，本书想给一个发生学的解释。这个解释，是本书自己的说法，待验。

这句话里，有一部分是「记得清」造成的。平时常生小病的人，大病来了，没人觉得意外，也就没人记住；平时不生病的人一病倒，才被人反复讲起。本书先把这一部分让出来。

第一，压成了一大锅。

小的不舒服，本来一点一点冒泡，一点一点散掉。现在盖子压着，泡冒不出来，攒在一起。到哪一天盖子压不住了，冒出来的就不再是一个小泡，而是一整锅。

一整锅冒出来的东西，没有形状可认。不是一个头痛、一个咳嗽，而是「哪里都不对」。医生面对这一整锅，要花很多力气才能分出头绪。

第二，没有路。

悬着是一条路，要走过才熟。有些人每隔一阵就去看一看，调一调，复诊一次，这条路他走了很多遍：怎么跟医生说话，怎么问，怎么记，怎么在等报告的夜里安顿自己。

老郑没走过。他第一次走，就走在最急的时候。病人位第一次坐下，医生位第一次站出来，病名第一次落下，三样东西同时出现，每一样都陌生，每一样都在最重的分量上。

挂号那一刻，本来是一个温和的开端。他的开端，是在急诊室里发生的。

第三，没有「平时」可比。

医生要判断「这一次比平时差多少」，需要知道平时是什么样。老郑没有平时。没有血压的记录，没有上一次的单子，没有一个熟悉他的人说「他以前不是这样的」。医生手里的东西，都是从零开始的。

这不是医生不用心，是复合体里缺了一段历史。

第四，定型太久没动。

一个很久没被碰过的定型，就像一块放了很多年的干木头。看上去很结实，可是一弯就断。它没有被一次次小小地晃过、接住过，所以它不知道怎样在晃里站稳。

第五，一病就成了全部。

老郑的生活里，除了工作和家，没有第三块地。生病的时候，病名一落下来，就占满了整个视野。他不知道，一个人可以同时「是个病人」和「是个下棋的人」，两样东西互相不挤。

有过小病、慢病经历的人，通常学会了这个本事：病名只是日子里的一块，不是全部。老郑没学过，所以第一次，病名就大得像一堵墙。

还有一层，在老郑身边。

他的妻子和孩子，也是第一次悬着。他们不知道该问什么，不知道可以问谁，不知道「观察」是好消息还是坏消息。一个一直稳定的家，一下子进入了悬着，每个人都在用自己的办法顶着，顶得很累，又不敢对彼此说。

所以「一病就很重」，重的不只是病人的身体。重的是整个复合体，第一次同时要学会很多事。

这五点，说的不是某个人做错了什么，而是一种状态：一个从没有进入过悬着的复合体，在第一次被迫进入的时候，会又重又乱。

反过来说也成立。那些隔一阵就去看看的人，不是因为他们的病比别人多，而是他们的复合体，在小的悬着里，一遍遍练过。真到大事来的时候，路是熟的。

这并不保证不生大病。它只是说：生了，复合体接得住。

要补一句，免得读成另一个意思：本书不是劝每个人天天往医院跑。

进入悬着，可以很小。一次几分钟的问诊，一个记着日期的本子，一次和家人的聊天，说一句「我最近有点不一样」。这些都算。重要的不是去了多大的地方，而是给一锅粥留了一个落脚处，让它有机会长成一点形状。

有的季节悬着多一些，有的季节定型多一些。像呼吸一样，没有哪一口是应该永远留着的。

◆ 七、反过来：一直悬着，也不是活法

讲到这里，容易走向另一头：那就多去看，勤去看，天天查。

这一头同样不对。

有些复合体，是另一种样子：一直悬着，不肯定型。

比如，每一次检查结果「正常」，病人都不放心，要再查一个；每一位医生说「问题不大」，他都想问下一位；一个病名刚放下，又找出下一个病名。复诊像滚雪球，越滚越多，每一次都推翻上一次的结论。

这样的复合体，看上去非常积极，其实很累。它被卡在悬着里，出不来。定型对它来说，成了一件不可能的事。

医生一端也有这样的样子。有些医生，什么都要再查一遍，什么都不敢说「没事」，把每个人都留在悬着里。这个，第 13 章会细说，它叫防御性医疗。

一直悬着的结局，常常是掉回一锅粥：新搜的说法、新换的医生、新的担心，一层一层盖上来，最后谁也说不清，到底是什么在难受。

所以，定型不是敌人，它很有价值。

定型让你可以睡觉。定型让一件事不用再想。定型让一个病名成为日子里的一个词，而不是每天夜里的一块石头。定型让复合体有一套熟悉的做法，让下一个来的人能接着用。

秩序态是一站，不是一个应该躲开的地方。

比如有位母亲，孩子一次咳嗽拖得稍久，她换了三家医院，拿了三个说法，三个说法各不相同。她回到家，把三份单子摊在桌上，更不知道该信哪一个。

这位母亲没有做错什么，她是真的担心。可她的复合体，在不断重启：每一家医院，都是一次新的开端，一次新的「挂号那一刻」。开端太多，哪一个也没有长成过。

这个，不叫勤快。这叫总在起头，没有一个起头被允许往下走。

悬着需要被走完，才能到定型。走完不等于什么都问清楚，而是走到一个「够了，可以先这样」的点。这个点，不是医生一个人定的，也不是病人一个人定的，是两头在锯口里一起摸到的。

那么，什么样的状态才叫好？

不是停在哪一态，是有节奏地进出。像呼吸：吸进来，呼出去。像拉大锯：拉出去，拉回来，锯口才会深。只拉一头，锯条会卡。

一个复合体，健康的样子，是能进悬着，也能回定型；回定型了，还愿意在小小的不舒服出现时，再悬一下。

这样的复合体，不是不生病，而是病来的时候，它认得路。

这样看，「健康」这个词，要换一个读法。

老读法里，健康是一个地方：你到了，就留在那里。新读法里，健康是一种本事：在一锅粥、悬着、定型之间走动，不卡在任何一处。

卡在一锅粥里的人，说不清哪里难受，什么都做不成。卡在悬着里的人，每天都在等一个还没来的结果。卡在定型里的人，什么也不想变，一变就慌。三种卡法，说到底是同一件事：走不动了。

◆ 八、医生那一头，也有盖子

盖子不只在病人一头。

诊室里，医生也有压住一锅粥的时候。一个患者说：「我就是觉得不太对劲，不过说不上来。」医生看了看检查结果，一切正常。医生说：「没事，回去好好休息。」

这句话，大多数时候是对的。结果确实正常。可是，如果患者那个「说不上来」，从来没有被当成一件值得多问一句的事，那么这位医生，也在用同一个盖子。

医生的盖子，有时候是时间。门外排着长队，十分钟只够看结果，没有空隙听「说不上来」。有时候是制度，所有检查都在正常范围，就没有下一步可走。有时候是习惯，把「查不出来」直接翻译成「没有」。

这些盖子，同样不是谁的错。它们是整个诊室长期的样子，医生也被它压着。

可是后果是一样的：这一次的「说不上来」，没有被放进悬着，没有被约下一次，没有被写进记录。它回到了病人的日子里，继续是一锅粥。

一个复合体，两头都盖着盖子，就是最稳的「没事」，也是最安静的「不好」。

反过来，也有医生，会在「一切正常」之后，多说半句：「这个结果是正常的。你说的不舒服，我也记下来了，两个月后我们再看一次。」这半句话，没有开任何药，没有加任何检查，却给那锅粥开了一个口。

这半句话的名字，就是悬着。

◆ 九、今天与机器

今天，有很多东西在帮人保持「定型」的感觉。

手环每天给你一个分数。绿色的，就是好。手机里的健康应用，每周发一个小结：步数达标，睡眠良好，心率正常。看到一排绿色，你心里一松：我是稳的。

这种松，有它的好处。一个人每天看到自己做得不错，会更愿意继续做。

不过，有一个小小的陷阱：绿色是数字的状态，不是复合体的状态。

一个人可以一整个月都是绿的，同时有一团说不清的乏，压在下面。手环读不到它，因为它没有形状。绿色会让你更容易把盖子盖上：数据都好，哪里会有事？

反过来，也有人被红色缠住。手环一发出一个「注意」的提示，他就要查一个晚上，把自己放进一个永远不肯定型的悬着里。

还有会说话的机器。你把一份体检报告发给它，它说：「各项指标均在正常范围内，建议保持良好生活习惯。」这句话，几乎都是对的。

错在我们怎么听它：「均在正常范围」，听成了「我很好」，听成了「我可以不用管了」。

机器没有错。它读的是数字，数字是真的。不过它没有读你这一年的日子，没有读那个在夜里偶尔出现的东西。

家里的老人用这些东西，有时候更是另一回事。孩子给爸妈买了手环，每天看一次数据，在电话里说：「爸，你昨天睡得不太好。」

这样一句话，本来是关心。可是对一个原本觉得自己「没事」的老人来说，它也可能变成一份新的、说不出口的压力：数字在看着我。于是他戴着手环，把它调成静音，什么也不说。

关心要变成一次对话，不能只是一次报告。手环读出来的，是话头，不是结论。

用得好的话，机器其实可以帮人更容易进入悬着。它可以提醒你下次复诊的时间，替你把这两周想问的问题整理成三行，帮你看懂一份你以前看不懂的单子。这些，都是在开门。

用得不好，它会成为一个很漂亮的盖子。

还有一种更隐蔽的盖子：流畅。

机器的回答总是流畅的，没有停顿，没有「我不确定」。流畅会给人一种感觉：事情已经说完了。不过对一个复合体来说，真正重要的往往是那些不流畅的地方。医生欲言又止的那半秒，家人没问出口的那一句，你自己写到一半又删掉的那行字。

不流畅的地方，是悬着在说话。别让一份太流畅的答案，把它盖过去。

分辨的办法很简单：看它是让你多问了一句，还是少问了一句。

◆ 十、一个完整的例子

老郑和周老师，是同一所学校的老同事，爱好差不多：下棋，早上去公园走走。

周老师血压高，有些年头了。他每个月去一次社区医院，有时候是女儿周岚接诊，有时候是别的医生。药换过几次，复诊的日子写在日历上，同事们笑他：「老周又去看病了。」他也不怎么在意。

老郑呢，抽屉里的体检单，一直没拆。

去年冬天，两个人都着了凉。

周老师的样子是：头一天晚上喉咙不对，第二天一早，他去了社区医院。

他跟医生说的是：「我这几年血压在吃药，这次有点发烧，您看要不要调一调药。」医生听完，三句话就问到了点上：什么时候开始的，有没有胸闷，最近药吃得怎么样。周老师答得很快，因为这些问题，他早就在自己的红皮本子上记过。

不到一个小时，事情有了形状：一个普通的感冒，药不用改，三天后再来看看。周老师回家，贴了一张新便条。

老郑的样子是：着凉了，不去。吃了点家里的药，捂着。拖到第五天，烧没退，咳得睡不着，被家人拉去医院。他走进诊室，医生问：「您以前有什么病史？」他说：「没有，我从来不生病。」医生问：「吃什么药吗？」他说：「没有。」医生问：「上一次体检是什么时候？」他想了很久，没有答出来。

诊室里，医生手里什么都没有，老郑自己手里也什么都没有。

医生要从头问起。年龄，吃什么药，家里谁得过什么病，吸不吸烟，睡得怎样。一个一个问题，老郑一个一个答，答不上来的，要打电话问老伴。

这些问题，都是正常的、必要的。可是对一个第一次坐下来的人，它们加在一起，像一场考试。老郑后来说，他那天最强烈的感觉，不是害怕，是陌生：他不认识这个地方，不认识这些人，不认识躺在床上的这个自己。

这两个人的差别，不在谁的身体好。周老师有高血压，比老郑多一样病。差别在复合体：周老师的复合体，走过很多遍从一锅粥到悬着、到定型的小路，这一回感冒，不过是再走一遍。老郑的复合体，第一次走，就走在最陡的地方。

要公道地说，周老师这条路也有代价。他花时间，花钱，每次复诊嘴上喊烦；他有时也犯懒，有一年冬天，整整三个月没去，后来被周岚逮到，被说了一顿。他的复合体，也有压住的地方。

老郑也有他的道理：他忙，他不想把时间花在医院里，他一直觉得，自己好好的。这些都是真话。

所以，不是「周老师对，老郑错」。是两个复合体，在两条不一样的路上，各自走到了今天。

老郑的妻子在走廊里，对周老师的老伴说过一句话：「我是不是该早点逼他去？」

没有人能替她回答。逼过，他也许去了；也许两个人从此连这个话题都没有。这件事，说不清是谁的错。

本书只想说一点：该追问的问，不过别把整个悬空的二十年，只算在一个人头上。那二十年里，缺的是一个能让他安心走进去的地方，一个认识他的人，一个可以约下一次的约定。这些东西，是两头一起才有的。

后来，老郑出院了。他回家第一件事，是把抽屉里那一叠体检单拿出来，一张一张摊在桌上。二十多年的单子，他第一次认认真真地读。

有些项目的数字，年年都有一点点往上走。他看着看着，不说话。妻子在旁边，也没有说「你看，早就……」。她只是把一本新的小本子，放在了那一叠旁边。

这不证明他「早该知道」。它只是说明，平时本来有一个可以被读的位置，没有人去坐。

要说的，只有一句：能进悬着的复合体，在大事面前，有一条熟路。

（身体或心里的难处真的大了，请找医生或心理咨询师。）

◆ 十一、放回日子里

回到豆豆。

豆豆七岁，常咳嗽。每一次咳，家里都有两种声音。一种说：「小孩子咳咳就好了，不用管。」另一种说：「又咳了，赶紧去大医院。」

这两种声音，说的是同一件事：要么压住，要么炸开。压住，是把一锅粥盖上；炸开，是把每一个泡都当成大事，直接推进最重的那一档。

周岚是豆豆的妈妈。她既是医生，也是妈妈。她没有选这两种声音里的任何一种。

她在家里放了一个小本子，贴在冰箱旁边，封面写着「豆豆的小事」。谁发现孩子哪里有点不对，就记一行：日期，加一句话。不写病名，不写猜测，只写看见的事：「周三晚上咳了两声」「周五早上说嗓子痒」。

这个本子，不是为了诊断。它是给一锅粥，找一个冒头的地方。

一个星期后，翻一翻。大多数时候，什么都没有，小泡冒了，破了，过去了。偶尔，翻开本子会发现：这个月，有五次，都在夜里。那就带着本子，去问一问医生。

这就是一个很小的悬着：不压住，也不炸开，给它一个落脚处。

家里的老人也可以用同一个办法。周老师的红皮本子，记的是血压；老郑要是有一个本子，哪怕只记「今天爬楼梯喘不喘」，抽屉里就不会只有一叠没拆的单子。那里会有一张纸，写着他的「平时」，可以拿去给医生看。

平时，是一个很值钱的东西。它不是一个状态，是一段历史。有了它，医生就有了可比的东西，病人就有了可说的话。

明天就能试的办法，只有这一个：家里放一个小本子，谁有点不对劲，就记一行日期和一句话。不用写得对，不用写得全。它会让你们家的一锅粥，有一个出口。

也别把这个本子变成新的盖子。它不是用来「证明没事」的，也不是用来「吓自己」的。它只是一个落脚的地方：记下来，就先放下。下一次翻开的时候，才是它说话的时候。

豆豆自己也参与进来。有一回他指着本子问妈妈：「我今天咳了两声，你写了吗？」周岚说：「你说，我写。」七岁的孩子，从那时候起，学会了一件事：不舒服不用藏，也不用喊，说出来，有人记。

这件小事，给他的复合体，铺了一小段路。

如果你是医生，也可以把这个办法，递给来诊室的人。它不替代任何检查，只是让下一次见面，多一份可以翻开的东西。

医生位一端，也有一个小办法，同样不花时间：在「一切正常」之后，多问一句「除了这些，你自己觉得有什么不一样？」

这句话不会改变检查结果。它会改变的，是这一次「正常」的意思：从「到此为止」，变成「到此为止的这一部分」。

剩下的部分，约一个下次。

带 走 的 话

定型不是终点，是靠一锅粥和悬着一次次托住的一站；从不悬着的人，只是把一锅粥压到了更深的地方。

小　账

这一处，开门还是关门：这一章开的是土。「我没事」是一个常见的盖子，这一章是在盖子上掀开一条缝，让一锅粥有地方透气。

病放在一个人身上，还是放回复合体里？「平时不生病，一病就重」，如果被说成「他不重视自己」，就放错了。老郑的复合体里，医生位一直没有长出来，那是两头的事。

想 一 想

你家里的抽屉里，有没有一叠没拆的单子，或者一件谁也不先碰的事？

你身边有没有一位「从不生病」的人？你觉得他的复合体里，有没有一个人，认得他「平时的样子」？

你上一次小小的不舒服，是压下去了，还是给它留了一个落脚处？

◆

11

第 11 章

不对易：器质性与心因性

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你拿着一叠报告，从医院里走出来。

心电图，正常。彩超，正常。抽血的十几项，箭头没有一个往上翘，也没有一个往下掉。最后一页，医生签了字，写着一行小字：未见明显异常。

你本该高兴。

可你站在门口的台阶上，高兴不起来。胸口那团闷还在，跟进去之前一模一样。

回到家，家里人问：「怎么样？」你说：「没事。」声音有点飘。

这一夜，你睡得比往常还差。因为「没事」两个字，把你放进了一个更窄的地方：身上明明有东西在难受，医学却说它不在。那它在哪儿？是你想多了？还是检查没查到？

你甚至会羡慕那些查出了毛病的人。他们至少有个名字可以说，有张处方可以拿，有个方向可以走。你手里只有一叠纸，每一页都写着「正常」。

有人会说得更直白：「那就是心理问题，放松点。」

这句话，你大概也听过。听完以后，你有没有觉得，自己被人从一扇门里，轻轻推进了另一扇门？推你的人没有恶意，可你心里清楚：那扇门里，没有人信你胸口的那团闷是真的。

周岚在社区医院的全科诊室里，每个星期都要遇到几个这样的人。他们不是装病，也不是闲着没事干。他们是真的难受，而且是真的查过了。

她见过三类人。一类是拿着厚厚一叠单子来的，想让她再看一遍；一类是什么也没带的，进门就说「周医生，我这儿不对劲」；还有一类最安静，坐下来半天不说话，等她先问。

三类人的话不一样，难受却是同一个难受：它没有一个能让别人一眼读懂的形状。

有的人进门第一句话就是：「周医生，我不是来要检查的，我就想有个人信我。」

这一章，把这样的人放在正中间，一半是因为他们人数不少，一半是因为他们让一件平时看不见的事，露出了形状。因为他们站的地方，正好是两个词之间的缝：器质性，心因性。

这两个词，没人问过他们，可他们要在这条缝里过日子。

◆ 二、老看法：身体一半，心一半

先说老看法，它对在哪儿。

医学里有一对用了很久的词。器质性，说的是身体里找得到的毛病：血管窄了，骨头断了，指标超了，片子上有个影子。心因性，说的是找不到那样的毛病，难受是从心事、情绪、压力里来的。

这对词救过很多人。

医生手里的时间有限，检查也有限，先问一句「有没有看得见、摸得着、治得了的问题」，是对的。危险的先排除，可治的先治。胸口发闷、突然消瘦、便里带血、一阵阵头晕得站不住，先去查，从来不是错。

本书从头到尾，不劝任何人少查一次该查的。

这对词还有第二个好处：它让医生和病人都有路可走。查出器质的，去治；查不出的，去谈。分工清楚，谁也不用站在原地发愣。

它的来头也很老。笛卡尔把人分成两样东西：一样占地方的身体，一样不占地方的心（大意如此）。后来的医学没有照搬他的话，可那条分界线，一直留在诊室的墙上：这边是身体的事，那边是心的事。

后来有人觉得这样分太硬。恩格尔提出，医学不能只盯着身体，还要看心理和社会（他在 1977 年《科学》杂志上的那篇文章，题为《需要一种新的医学模式》，大意如此）。这一步很大：心和日子被请进了诊室。

可请进来以后，样子还是三层摞在一起：身体一层，心理一层，社会一层。每一层里有各自的原因，像三个抽屉。

抽屉的好处是整齐。抽屉的毛病是：它仍然默认，东西本来就在抽屉里放着，医生只要把它们一个个拉开看一眼。

于是留下一个几乎没人怀疑的想法：一份难受，总能分出「器质占几成，心因占几成」。

查不出来，要么是器质那几成太小，仪器还够不着；要么是它全是心因，身体里本来就没有东西。

医学院里的训练，也把这份谨慎刻得很深：先排除危险的，再谈别的。一位年轻医生如果漏掉了一个本可以查出来的毛病，他会记很多年。这份记性是好的，它是整个行当守住底线的方式，本书没有一个字想动它。

中国人对这件事，有自己的老话。「心病还须心药医」，说的是有些难受，药片够不着。「形与神俱」（《素问·上古天真论》，大意如此），说的是身体和精神本来就不分家。这些话比任何一套分类都老，也都在提醒我们：把人切成两半来看，是后来才有的习惯。

这对词还带着重量。不是医学上的重量，是日子里的。

一份难受，被写成「器质性」，旁人通常会点头：哦，是真的病。请假有理由，家里人让着你，同事问一句「好点没有」。

同一份难受，被写成「心因性」，旁人的脸色常常就微妙了：哦，是心情的事。请假要多解释两句，家里人说「想开点」，同事的问候里多了一点小心翼翼。

在不少地方，这对词不只是分类，还在分配：谁的难受值得被认真对待，谁的要先打个折。

病人对此心里有数。所以，很多人宁可被查出一个小毛病，也不愿听到「没有毛病」。

这个想法的底下，有一个没说出口的预设：这两样东西，在医生到来之前，就已经躺在身体里了，只等人来量。

如同两条鱼，早就在水缸里游着，医生要做的，是拿网把它们捞出来，各自称一称。

老看法的底下，是两样先在的东西。

◆ 三、先穿袜子，还是先穿鞋

换个说法，先从你的脚说起。

早上穿衣服，你先穿袜子，再穿鞋。反过来，先穿鞋，再穿袜子，会怎样？袜子套在鞋外头，一出门就让人笑。

两个动作都做了，次序一换，结果就换了。

物理学里管这个叫「不对易」：先做 A 再做 B，和先做 B 再做 A，不是同一回事。

量子力学里的不对易，比袜子和鞋厉害得多。海森堡在 1927 年提出，一个粒子的位置和它的动量，没法同时量得无限准（不确定性原理，大意如此）。这不是仪器不够好，是这两样东西的关系就是这样。

用一件家常事来看。

你拿手机拍一只正在跑的小狗。快门调得很快，狗被定在半空，四条腿清清楚楚，可你看不出它跑得多快。快门调慢，照片上是一道拖开的影子，速度有了，可它到底在哪一格，糊了。

清和快，不能同时要。你越追一头，另一头越糊。

这就是「不对易」最家常的样子：不是两样东西各自躺着，各量各的；是两种问法，抢同一块地方。

再看一个：称体重和量身高。这两样就不一样，它们互不相干。你先称还是先量，数字都一样。这样的两样，叫「可对易」。

不对易，是另一类：你的做法一变，另一头就跟着变。

先把边界划清楚。

本书借它，只当近邻，不当证据。身体不是量子的，医生也不是在量粒子。物理学里的不对易有精确的数学，这里没有数学，只有一个看法的形状。

那为什么还要借？因为日常的话，很难把这个形状说清楚。大家习惯说「一边是这个，一边是那个」，仿佛两样东西可以同时拿在手里；而诊室里的事实是，你拿起一样，另一样往往就从手边滑开了。

第 3 章说过，量子力学留下了观察者，本书连观察者一起拆。这一章也一样：借它的形状，不借它的发动者。

借来的形状只有两条。

第一条，次序会改变结果。第二条，追一头，另一头会糊。

其余的，一概不借。

还有一位更近的邻居，要提一下。玻尔在 1927 年提出「互补性」（那年秋天他在意大利科莫的会议上讲了这个想法）。大意是：描述微观世界，有两种图景，比如波和粒子。各自有用，可没法在同一次实验里同时用上（大意如此）。他后来也谈到，这样的思路也许可以用到生命和心理上。

这一步，比不对易离诊室更近。「器质」和「心因」，好像正是两套互补的图景。

本书的态度是：形状对，位置不对。

玻尔的互补，仍然默认了一个先在的对象，对象只是用两套话来说。本书连这个对象也不要：没有一个先在的「那个病」，等着被两套话各说一半。有的，是复合体在两种互动里，显出两种读数。

互补，是发现学里最聪明的一次让步。本书想再往前走半步。

◆ 四、两种读数，越追一头，另一头越糊

把这个形状，放回诊室里。

医生手里其实有两种读法。

第一种，读身体。看指标，看片子，看体征。问的是：哪里不舒服？什么时候开始？吃什么好一点？再查一项什么？

第二种，读日子。看睡眠，看心事，看家里的事，看单位的事。问的是：最近怎么样？这事是什么时候起头的？那前后，发生过什么？

两种读法都是正经读法。各有各的问话，各有各的坐姿。读身体的时候，医生位往前探，病人位把一副身体递过去；读日子的时候，医生位往后靠，病人位一点一点把自己打开。

听一听两种诊室里的话，差别就出来了。

读身体的诊室，话是短的。「疼不疼？」「按这儿呢？」「深吸一口气。」每一句有一个答案，答案可以写进表格。

读日子的诊室，话是长的。「后来呢？」「你那时候怎么想的？」「家里人知道吗？」每一句都带着一段故事，故事写不进表格，只能慢慢听。

再看一个小场景。

小莫二十九岁，在一家设计公司上班，这个月总说胃胀。她走进周岚的诊室。

周岚先读身体：「胀在哪儿？饭前饭后？有没有反酸？」小莫一一回答。周岚按了按她的上腹部，问疼不疼。小莫摇头。

然后周岚把椅子往后挪了一点，换了一种问法：「这个月，上班怎么样？」

小莫愣了一下，说：「这个月在赶一个项目。」

「赶到什么时候？」

「到下个星期五。」她顿了顿，「我这几天吃饭，都是对着电脑吃的。」

两个人都没有说话。

周岚没有写「焦虑」，也没有写「功能性」。她在本子上写了两行，一行写身体读到的，一行写日子里读到的。

你看，这一次，周岚做了两件事，中间有一个停顿。第一件事让身体那头亮，第二件事让日子那头亮。她不是同时做的，是一前一后做的，并且让小莫知道：这是两次问，不是一次判。

一间诊室，一次十分钟，两种话，没法一样多。

要紧的是，这两种读法，没法在同一次互动里，同时做到最准。

你往身体那头追：下一项检查，再下一项，再换一家更大的医院。追得越狠，病人位越缩成一具要被检查的身体。日子那头，被一层层挤到边上，越来越模糊。

你往日子这头追：多问几句，多坐一会儿，谈谈压力。追得越深，身体那头的难受越容易被说成「情绪的影子」。病人一听「是不是压力大」，反而会把身体那头抓得更紧，好证明「我是真有毛病」。

追一头，另一头退下去。退下去的，往往不是消失，是在暗处变得更响。

这有点像夜里的钟。白天你听不见它，夜深了，满屋子都是它的声音。

本书把这叫做两种读数的不对易。

注意，说的是「读数」，不是「原因」。

读数是复合体在某一次互动里显出来的样子。它不是躲在身体里的两样东西，被医生分别称出了斤两。

◆ 五、不是两样东西，是两种显影在互相挤占

说到这里，老看法最想问的那一句出来了：那到底是器质，还是心因？各占多少？

本书的回答是：这句话，问错了地方。

问「各占多少」，等于先认下一件事：有一个先在的身体，里面早就有两样东西，一样叫器质，一样叫心因，医生的任务是把它们分开称。

打个比方。有人问你：这碗汤的咸味，几成是盐给的，几成是水给的？

你会笑。咸味不是盐一个人的，也不是水一个人的；它是盐在水里化开以后才有的。你没法把它拆成两份，再各自称一称。

再换一个。两个人拉一把大锯，锯口深了。有人问：这道口子，是左边那个人锯出来的，还是右边那个人？问这话的人，已经把锯口当成了两个人各自带来的东西。

身体的难受，也是这样。它在医生和病人这把锯上，一来一回，才有了深浅。

发生学不这样看。

第 1 章说过，进诊室之前，只有不适和苦。第 6 章说过，挂号那一刻，病人位、医生位、病名一起显影。读数也是这样来的。

甚至更早。你在挂号窗口前，说一声「我挂心内科」，还是说一声「我想挂个全科」，科室和读数，是一起显出来的，不是先选好了科室、再去读哪一头。第 7 章讲过这件事。

器质的读数，出现在一种互动里：医生位拿着检查，病人位递出身体。心因的读数，出现在另一种互动里：医生位坐下来问，病人位说起日子。

两种读数，不是称出来的，是两种状态的显影。

这两种显影，互相挤占。

挤占，不是谁抢了谁。复合体每一次的力气，只有那么多：医生的十分钟，病人的注意，一家人的耐心，一间诊室的灯光。投在哪一种读法上，哪一种就亮；另一种，就退到暗处。

不是身体里藏着两样东西，是复合体的两种状态显影，一边亮，另一边就暗。

这就是本书和老看法的分界。

读到这里，你可能有三个追问。一个一个答。

第一问：这么说，难受是假的?

不是。每一次难受都是事实，发生过的就是发生过。本书只是不再问「它藏在哪一层」，改问「它在哪一种互动里显出来，又在哪一种互动里被盖住」。

第二问：这么说，想法能让病变好变坏?

这种话，本书不说，也不需要。第 3 章讲过，观察者不必有意识，状态的发生也不靠意念。本书只说：同一个复合体，在不同的互动里，亮出的东西不同。

第三问：这么说，器质的那一头，就不重要了?

恰恰相反。器质那一头，是复合体最该守住的底线。检查要做，危险要排。本书说的只是：别以为排完这一头，另一头就自己清楚了。

读到这里，你大概要问：那该怎么办?

不对易没有解法，它只有安顿的办法。本书能想到的，有三个。

第一个，轮换。今天追过身体，下一次就留出时间问问日子；这一回问了日子，下一回就把该补的检查补上。两头谁都不扔，也不指望一次做完。

第二个，留痕。像老常那张白纸，把两头摆在同一页上。纸本身不属于任何一种读法，所以它不会偏向哪一头，只会让两头都留在眼前。

第三个，把次序说明白。「我们先把身体这边查到这一步，然后再一起看看日子里的事。」这一句话让病人知道，后面还有一步，不至于把前一步听成「就这样了」。

三个办法都很朴素，都不需要新的仪器。需要的，是复合体里的每一个位子，都知道自己手里拿的是哪一种读法。

这样一改，「查不出问题」就换了一个样子。

它不再是「身体里的问题太小，仪器看不到」，也不是「问题只在脑子里」。它是：复合体一直在亮其中一种读数，另一种，一直没有被点亮。

◆ 六、只追一头，会怎样

先看只追身体这一头。

一个人胸口闷，查了心电图，没事；查了彩超，没事；有人说，再做个增强的，更保险。做了。报告上多出一行：某处有个很小的偶然发现，建议随访。

这一行字，是新的东西。它算不上病，可它让下一次检查有了理由。一次随访，带出一项新指标；新指标偏了一点点，带出一个新的名字。

名字多了，病人位坐得更稳。日子被检查的时间表一格一格占满。

每一步都有道理。每一步，都往身体那头多追了一点。合起来，复合体离「日子」那头越来越远。

最后，一个人手里有了一叠厚厚的资料，却说不清自己过的是什么日子。

家里人也在这个形状里。老常的太太一开始每天问：「今天闷不闷？」问了三天，老常就开始数着时间等这一句，一到下午三点，胸口那块湿毛巾，好像就等不及了。

太太没有恶意，她是真的担心。可这一问，把身体那一头，天天点亮一次。

再看只追心事这一头。

一个人头晕，医生翻了翻前两次的记录，说：「你这是焦虑，回去调整一下作息。」话没错，也许确实有焦虑。可这个人听到的，是另一句话：你说的这些，我不当真。

于是他不再来了。下一次真正的身体问题出现时，他是最晚去医院的人。

或者，他换了一家又一家，每一家都想找一个肯说「你这儿真有问题」的医生。这样的医生，终于有一天出现了；可他想要的，只是被信，不是被查。

两头都是危险。

只追身体，复合体被检查的单子拖着走；只追心事，复合体被一句轻飘飘的话关上了门。

本书要提醒的是：这里没有哪个人糊涂。没有谁偷懒，也没有谁装病。是复合体在两种读法之间，被推着走，推它的是惯性。

惯性没有恶意。可惯性也不会自己停。

再看三件家常事。它们里头，都有这个形状。

第一件，疼。一个人腰疼，他越盯着腰，越觉得疼。他一天摸二十遍，每摸一遍，就把那一处从身子的背景里拎出来一次。很多人都有过这样的经验：被人叫去干别的事，忙了一个下午，忽然发现，腰好像没那么疼了。

注意，本书没有说这是「心理作用」。疼是真的，发生了就是发生了。本书只说：注意力投到哪里，哪里的读数就亮。

第二件，睡。睡不着的夜里，你越想「我要睡着」，越睡不着。你盯着睡意，睡意就跑。直到你放弃了，想着随它去吧，它倒悄悄来了。

睡意不是一件你能直接伸手去抓的东西。你一伸手，它就换了样子。

第三件，量。周老师在诊室里量血压，是一个数；在家里坐着量，是另一个数。这不是谁的仪器坏了。是两种互动里，两种读数。一个是「坐在白大褂面前」的血压，一个是「坐在自家沙发上」的血压。

三件事的形状一样：你拿起一种问法，那一头就亮；另一头，就从手边滑开。

再说说医生这一头。

医生也被这个形状推着走。读身体，有现成的项目，有现成的表格，十分钟读完一张单。读日子，要坐下来，要听，要等对方说到哪一句忽然停住。这样的话，写不进表格，也很难算进十分钟里。

这跟哪个医生懒不懒无关，是不少诊室里的时间和单子，早就排成了一种形状：读身体顺手，读日子费力。

于是，复合体在没有人决定的情况下，朝身体那一头倾斜。倾斜久了，医生位和病人位都以为：这就是看病本来的样子。

身体或心里的难处真的大了，请找医生或心理咨询师。

◆ 七、「查不出问题」的人，卡在哪里

现在可以回头看那个站在台阶上的人了。

他卡住的地方，有三种样子。

第一种，在身体那头打转。他从心内科转到消化科，从消化科转到神经内科。每一科读出一小块，每一科都说「这一块没事」。没有一科读出整个人。第 7 章讲过，挂哪个科，读出哪种数，科室和读数是一起显出来的。

第二种，被推到心事那头。有人说「去看看心理科吧」。他听到的却是：我被扔出来了。这个转诊本来可能是一扇门，到他耳朵里，成了一扇关上的门。

第三种，两头来回弹。星期一，医生说没事；星期三，他在手机上搜到一种可怕的病，对上了号；星期五，又去挂号。

周老师有个老同学，姓吴，就是第三种。他一年里要换三四回医院，每回回来，都跟周老师说：「这家的大夫说话实在，我要是早点碰到他就好了。」可过不了俩月，他又说：「那家也不行，没说到点子上。」

他没有挑剔，他是在找一个能同时看见他身体和他日子的地方，而每一家医院，都只给了他其中一半。

这三种样子里，病人心里各有一句话。

在身体那头打转的人，心里说：再查一项，就清楚了。

被推到心事那头的人，心里说：他们不信我。

来回弹的人，心里说：谁能给我一句准话？

三句话都合情合理。三句话合在一起，是一个人在两条路之间的原地踏步。

三种样子，说的是同一件事：这个复合体，一直找不到一种能落脚的状态。

还有一件小事，值得单独说，就是次序。

先做完一圈检查，再提起日子里的事，病人容易听成：查不出，所以是你心里的事。先聊了日子，再安排检查，病人又容易听成：你不信我身上真有东西。

两句话里的内容一样，只是先后换了，听到的意思就换了。

摆在一起看。

第一种次序，诊室里是这样的：

「检查都出来了，没有发现问题。」医生翻着报告，停了一下，「你最近压力大吗？」

病人说：「还行。」可他心里想的是：压力大，所以是我的问题。

第二种次序，是这样的：

「你最近压力大吗？」医生放下笔，「说说看。」病人讲了十分钟。医生点头，说：「好，我们再安排两项检查，把能排除的排除。」

病人说：「好。」可他心里想的是：他是不是觉得我没事，只是想多了？

同一位医生，同样的两句话，同样的检查，换了次序，病人的心里就换了一个句子。

谁的话都没说坏，是这两种读法，本来就不能随便换先后。

这两种听法，在诊室里常常发生，本书不拿它当统计，只拿它当提醒：先问哪一头，后问哪一头，结果不一样。这正是不对易。

医学里已经有一些名字，给这样的难受留了位置。「功能性」的毛病，「躯体症状」，「暂时解释不了的症状」。名字有用：有了名字，复合体就有地方站。

可名字也有它的坏处，第 8 章讲过，名字有时是通路，有时是笼子。

另一边，第 5 章讲过，苦刚开始的时候，是没有形状的一锅粥。「查不出问题」的人，常常就停在这锅粥里：苦是真的，可它没转成一个能让别人读懂的形状。两种读数各自读了一半，都没读到那锅粥的全貌。

这里先记住一句：

「查不出问题」，不是没有问题，是两种读数轮流亮、没有一次同时亮的复合体，还没找到落脚的状态。

◆ 八、今天与机器

今天，两种读数都比从前多得多。

先说身体这头。手环每分钟报一次心率，血压计一键存档，血糖仪一天几十个数。数字随身带着，一个人一天里可以读几十次自己。每读一次，身体那头亮一下，日子那头，暗一点。

很多人并非不关心日子，只是数字太近，日子太远。

再说机器。你把症状打给一个会说话的机器，它回你一大段：可能是这个，也可能是那个，也可能与压力有关，建议就医。

这段话很周到。它同时点亮了两头。

可是，同时点亮，不等于同时看清。人读到的常常是：哪一种都有可能。两头都亮了一点，两头都没站稳。人拿着这段话，转身又去搜，再问一遍。

机器不嫌烦。它可以陪一个人，把身体那头一遍一遍问下去，永远不累。这个本事，对医生位是难得的，对复合体却要小心：无限地追身体，是不对易里最快的一条路，通往日子的一团模糊。

还有一种新的聚集。病友群里，几十个人说着同一种症状。有人说，我也这样；有人说，我吃了什么好些了。

这样的群，能给人很大的安慰：原来不止我一个。可它也有另一面。一个人每天读到的，是别人的身体读数。读得多了，自己的那一头越来越亮，日子那一头越来越远。

医生手里也有机器。有的诊室里，机器已经能在医生说话的同时，把谈话整理成病历。这件事听起来是小事，却可能改变不对易的比重：医生不必再一边问一边打字，眼睛可以从屏幕上抬起来，看一看对面的人。

读日子，最费的是眼睛和耳朵，手倒在其次。能把手腾出来，读日子那头就多亮一点。

机器也可以反过来做好事。比如，它能记下你每天的症状和每天的事，摆在同一张纸上，让你自己看。这一点，下一节的老常会用到。

AI 算不算复合体里一个新的位，第 16 章再讲。

◆ 九、两个完整的例子：老常的胸口，季阿姨的腿

第一个例子：老常的胸口

老常四十八岁，在一家货运公司管调度。三个月前，他在办公桌前忽然觉得胸口发闷，像有人在外面压了一块湿毛巾。

他去了医院。心内科，心电图，没事。过了两周，又去，挂了号，做了动态心电图，没事。第三次，他自己要求做了心脏彩超，没事。

三次，三张「未见异常」。

他的闷还在。更糟的是，他开始琢磨：连这么大的医院都查不出来，会不会是最麻烦的那种?

他以前可不这样。他是那种连感冒都不爱去医院的人，觉得睡一觉就好。这一回，他破了例，一半是因为难受，一半是因为怕。

怕什么，他自己也说不清。只是那块湿毛巾，每到下午，就又压上来了。

他夜里躺着，手不自觉地按在胸口上，数自己的心跳。数着数着，心跳好像真的快了。他下意识地把数得快了当作证据，天一亮又去挂号。

这个循环，老常自己不觉得是循环。他觉得是一步一步的认真。

第四次，他没有再去那家大医院。他走进了离家近的社区医院，坐在周岚的诊室里。

候诊的椅子是蓝色的，老常坐了二十分钟。他手里捏着那叠报告，纸边已经卷了。

周岚的诊室很小，一张桌子，两把椅子，窗台上一盆绿萝。

周岚翻了翻他带来的一叠报告。她没有再开一张新单子。

她也没有说「你没事」，没有说「你该去看心理」。

她说：「这三个月，你做的检查，我都认。该排除的危险，排到了这一步。今天我们先不往那头再走了。你的闷，我信。」

老常的肩膀，松了一点点。

周岚停了一下，问：「它什么时候最明显？」

「下午三四点。」老常想了想，「开完调度会以后。」

再往下问了几句，他说起这个月公司调了班，货车一路晚点，一天要被追着打十几个电话。

周岚没有说「就是这个」。她知道，一说「就是这个」，老常听见的就是：你看，果然是心理的。

她拿出一张白纸，从中间划了一道线，左边写「闷」，右边写「那天的事」。

「回去两个星期，闷的时候记一笔，不闷的日子也记一笔。写完你拿来，我们一起看。」

两个星期后，老常带着那张纸来了。有几天，闷得厉害，右边写着：被老板点名，货车爆胎。有几天，一点不闷，右边写着：去了趟老家，吃了碗面。也有几天，右边什么事也没有，左边却写着：闷。

他和周岚一起看，谁也没有下结论。

「这几天没事，也闷。」老常指着纸，有点不好意思，「那是不是别的事在闹？」

「是不是，我们不急着定。」周岚说，「先记着。有些日子闷，有些日子不闷，这张纸就有用了。」

先说周岚这几次没有做的事。

她没有说「你没事」。她没有说「你该去看心理」。她没有保证「很快就好」。她也没有一口气把所有检查都再安排一遍。

她做的，只是让两头在同一页上相遇。

可有一件事变了。这张纸，既不属于「身体这头」，也不属于「日子这头」。它把两头摆在了同一页上。

三个月来，老常的复合体第一次有了一个可以坐下的东西。

闷没有马上消失。周岚也没有保证它会消失。她只留下一句话：要是哪天闷得和从前不一样了，别等，回来找她。

判断落在哪里？不落在周岚身上，也不落在老常身上。三个月里，这个复合体一直在追身体那一头，今天，它第一次让两头同时在场。

不对易没有消失；它只是不再逼着复合体二选一。

一个月后，老常又来了一趟。这一回，他没有拿纸，空着手。

「周医生，我这几天忘了记。」他说，「也不是好了，就是没顾上。」

周岚点点头：「忙着什么？」

「儿子要中考了，在家里闹。」老常笑了一下，「吵了两天。」

他没有再说闷。

周岚也没有追问。她把那张写满字的纸，夹进了他的病历里。

故事不能只讲一头。下面这个，是反过来的。

第二个例子：季阿姨的腿

季阿姨六十二岁，说这阵子腿发沉，上楼没劲，夜里睡不踏实。她去过一家医院，医生听她说完，翻了翻她的情况：儿子刚出国，老伴去年走了。医生温和地说：「您这是想孩子，心里空，身上也跟着没劲。多出去走走。」

季阿姨点点头，回家了。

她回家以后想：也许真是这样。可是腿沉的感觉，一天比一天明显。她又不好意思再去，怕被人说矫情。

三个月后，她来到周岚这里。

周岚听她说完，没有急着说「想孩子」。她知道，这个故事里，有很多地方可以被读成心事。可她也知道，日子那头亮得太满，身体那头就暗了。

她请季阿姨抽了几项血，把那些最基础的、最常被漏掉的，补查了一遍。

结果回来，有一项偏离得明显。再往下查，原因也找到了。后面的治疗，是另一个故事，本书不写。

后来，季阿姨的腿一点一点有了力气。她来复诊的时候，周岚问起儿子，她说，前两天视频了，孩子在那边一切都好，就是时差难倒了他。说这话的时候，她的脸上有了光，像是谁把一盏灯调亮了一格。

周岚没有因此觉得先前的医生错了。她只是想：那位医生读到的日子，是真的；漏掉的，是另一头。两头都在，才是季阿姨。

季阿姨的腿沉，不全是「想孩子」，也不全是「那一项偏离」。她儿子出国，是真的；她老伴走了，是真的；她血里那一项数，也是真的。

这几样，在她身上同时发生，在不同的诊室里，被不同的读法，各读出了一半。

这个例子，补上一块：不对易有两个方向。老常那一头，是身体追得太多，日子被挤暗；季阿姨这一头，是日子读得太满，身体被挤暗。

方向不同，机制一样。

对复合体来说，要紧的不是哪头对，而是它能不能在一次次的互动里，轮换着去照亮那一头暗着的。今天追过身体，明天问问日子；今天问了日子，下次再回头补一项该补的检查。

不对易，不是让你放弃其中一头。是提醒你，别以为一次就能把两头都量准。

◆ 十、这一章最弱的地方

诚实地说，这一章有三处靠不太稳。

第一处，不对易只是一个近邻。物理学里的不对易有精确的数学，诊室里没有。本书借它的形状，是为了说清「次序会改变结果、追一头另一头会糊」。如果

有人指出，某一种具体的诊疗方式，能在同一次互动里把两种读数同时读准，本书的说法就要收窄。那时的说法会是：不对易，只在某些情形下成立。

第二处，「病人听成了什么」，本书没有数据。前面说的两种次序，是常见的情形，不是统计出来的结论。要不要拿它做成研究，是以后的事。〔待验〕

第三处，「复合体的两种状态显影」是本书自己的说法。它想替代的，是「身体里有两样东西」的老想法。可这个替代能不能让医生在诊室里多做对一件事，要靠日子来验。本书只能先说：如果它没有，它就还不够用。

这三处写在这里，并非客气。

一本说「观察者也是发生出来的」的书，不该把自己的说法，写成一个站在发生之外的结论。

◆ 十一、放回日子里

回到周老师。

周老师血压高了多年，每天早晚各量一次，写在一个红皮本子上。最近他量得勤了，一天五六次，数字也跟着抖：下午这个高，晚上这个又低了。

周岚回家吃饭，他把本子递过来：「你看，下午这个又高了。」

周岚接过本子，没有先看数字。她问：「爸，下午你干什么了？」

周老师愣了愣：「跟楼下老李下棋，输了两盘。」

两个人对着看，笑了。

周岚没有说「别量了」，也没有说「是下棋气的」。她知道，父亲量血压，是为了让自己心里有底，这份心里有底，是真的。她只是把本子翻到新的一页，在每个数字旁边，留了一小格。

那个晚上，红皮本子上，多了一列字：棋，赢；棋，输；睡得好；睡得浅。

周老师忽然说了一句：「我这个人，原来是在跟数字下棋。」

周岚没接话。她看着父亲，心想：这句话，比任何一项检查都准。

你明天就能试的，是这个。

如果你或你身边的人，是「查不出问题」的那种人，别在同一句话里，同时问两头。一句问身体：哪儿难受，什么时候。停一下。另一句问日子：这几天，家里和单位，有什么事。

两句分开问。别问「是不是想多了」。

对医生位的人，也有一句：先说，你的难受，我信。再说下一步。

说「我信」，不是说「我同意你的病名」。是说：你告诉我的，是真的发生过的。这一句话不花钱，也不占时间，却能让对面的人不必再抬高嗓门，证明自己。

再有一句，给陪着病人的家里人：别急着替他下结论。「你就是太紧张」和「你肯定有大毛病」，都是一头追到底的话。

对病人，还有一句可以带进诊室：「我想先把身体这边查清楚，也想找个时间，说说最近的日子，可以分成两次吗？」

这句话把两种问法摆在桌面上，让医生位知道你要的是什么，也让你自己知道，这两头你都没打算放弃。

对自己，也有一句：量完数字，隔一会儿，再问问自己，这几个钟头做了什么。

再看一个小场景。豆豆七岁，夜里咳了几声。周岚听见，起身进了儿童房。

她先做的，是医生位会做的事：摸了摸额头，看了看喉咙，听了听呼吸。孩子没有发热，呼吸平稳。

然后她换了一个位子。她坐在床沿上，问：「今天在学校，有什么事吗？」

豆豆想了想：「今天换座位了，我挨着小宇。小宇说他不跟我玩。」

周岚没有说「是不是因为这个才咳的」。她只是握着豆豆的手，说：「那你今天，一定挺难受的。」

豆豆没有再咳。

可周岚第二天，还是带他去做了她该做的检查。她心里清楚：今晚的安静，不是诊断。

一个人在同一个晚上，换了两个位子，问了两头。先后有次序，每一头都没有扔。这就是本章要说的，在日子里的样子。

回到开头台阶上的那个人。他手里的报告，仍然写着「未见异常」。这一次不同的，是他知道了一件事：这几个字，说的是身体这一头已经读到了哪里，不是整个人读到了哪里。

另一头，还有一个明天可以去读的日子。

带 走 的 话

身体与心事不是两样东西，是复合体的两种读数；追一头，另一头会糊，所以别二选一。

小　账

这一处，开门还是关门：开门。「不对易」这个形状，把「到底是器质还是心因」的死问，换成了「这一次，哪一头亮着、哪一头暗着」。

病放在一个人身上，还是放回复合体里？放回复合体。胸口发闷的，不是老常一个人，是「追身体、不问日子」的整个惯性；腿沉的，也不是季阿姨一个人，是「只读日子、漏掉血里一项」的惯性。

想 一 想

你最近一次说「我查过了，没事」，是什么时候？那一次，有没有哪一半的自己，没被问到？

如果让你给医生写一句开场白，让「身体」和「日子」都能进门，你会写什么？

◆

12

第 12 章

解散：最好的痊愈

◆ 一、你一定有过这样的时刻

最后一次复诊，医生翻了翻你的记录，抬起头说：「恢复得不错。以后不用再来了。」

你应该高兴。

可你坐在椅子上，没有马上站起来。你手里还捏着那张挂号单，像捏着一张还没用完的车票。

你问了一句：「那要是又不舒服呢？」

医生笑了笑：「那就再来。」

你点点头，走出诊室。走廊还是那条走廊，护士站里还是那几个人，可你忽然觉得，这个地方，和你的关系变了。昨天你还是这里的人，今天，你只是路过的人。

这种滋味，说不上好，也说不上坏。有点轻，也有点空。

豆豆七岁，那年冬天咳了很久。周岚带他去儿科复诊了三次。第三次，儿科的陈医生摸了摸他的背，说：「好了，下个月不用来了。」

豆豆想了想，问：「那陈医生以后还是我的医生吗？」

陈医生愣了一下，蹲下来：「还是。你要是不舒服，随时来找我。可要是你不来，就说明你很好。」

豆豆似懂非懂地点头。出了门，他拉着妈妈的手问：「我不来，陈医生会不会想我？」

周岚没有答，笑了。

另一种时刻，你也许更熟悉。药盒里最后一板药吃完了，医生说可以停。你把空药盒放在桌上，看了半天。停，还是不停？你不敢。每天吃药的那几秒，原来也是日子里的一个钉子。

病好了，到底是什么意思？

周老师听女儿讲起这件事，沉默了一会儿，说：「我教了一辈子书，学生毕业那天，我也是这个滋味。」

周岚问：「什么滋味？」

「高兴，又有点空。」周老师说，「可要是学生毕业了还天天回来问作业，我才该着急。」

这一章，要回答的，就是这个问题。答案会有点出人意料：病好的最后一站，不是病人好了，而是医生—病人这个复合体，不再被需要了。

◆ 二、老看法：病好了，就是病没了

先说老看法，它对在哪儿。

在发现学的医学里，病是一个东西。它躲在身体的某个角落：一个细菌，一块肿物，一条出了问题的血管。医生的工作，是把它找出来，然后拿走，或者压住。

病没了，人就好了。

这个说法，大多数时候是对的。肺炎治好了，片子上的影子消了，退了烧，能吃饭，能睡觉。这是一件实实在在的喜事，没有人该去怀疑它。

本书从头到尾，也没有一句话，想让这样的喜事打折。

老看法还留下了一整套好用的东西：治愈率，复查指标，出院标准，临床终点。有了这些，一家医院才知道，一个病人是不是该出院；一个新办法，才知道它有没有用。这些，本书都认。

可老看法有一个小小的盲点：它只量「病」这一头。

病没了以后，那位医生呢？那个「病人」呢？一个人从「病人」变回「人」，要经过什么？这件事，老看法认为不用管，也没法管。因为在它那里，病人是病的

载体，病走了，载体自然恢复成人。医生也是一样，是发现病的人，病没了，他就去发现下一个。

两头，都是一次性的。

可是你有没有留意过一件事：有的人，病早就好了，却一直是「病人」。

他每年做一次大检查，每次做完，要紧张好几天。他听见别人谈某种病，心里会咯噔一下。他在表格上填「既往病史」，笔会停一停。

病没了，那个「病人」却没有走。

有的人，病明明没有好，却已经不再是「病人」了。他每天按时吃药，该复诊就复诊，剩下的时间，去买菜，去接孙子，去下棋。

这说明，「病好了」和「不再是病人」，不是同一件事。

老看法把这两件事捏在一起。本书要把它们分开。

老话说「三分治，七分养」。这句话的意思，其实早就把医学的边界画出来了：三分在诊室里，七分在日子里。

可是后来的医学，几乎只记住了前面那三分，把后面的七分，交还给了病人自己。

你看一份出院小结就明白了。小结上写的，是入院诊断、做了什么、出院时的情况、出院后的建议。每一项，写的都是病。

没有一栏，写「这位病人从哪一天起，可以重新做回一个人」。

小结没有写漏。在发现学的医学里，这件事不属于医学：病没了，医学就完成了；至于一个人怎样回到日子里，那是他自己的事。

本书不这么划线。

◆ 三、复合体最好的秩序态：不再被需要

换一个说法。

前面说过，病不在病人身上，也不在医生眼里，在医生—病人这个复合体里。复合体是被「需要」撑起来的：因为有一份难受，需要被读懂；因为有一个人读不懂，需要另一个人来读。

需要在，复合体就在。

那么，需要消失的时候，复合体会怎样？

它会散开。

用拉大锯的比喻说，最清楚。两个人拉一把大锯，一人一头，你推我拉。这把锯，是为了锯开一根木头。木头锯断了，两个人松手，锯子放下，各自走开。

锯完了，锯子还在，两个人也还在。可「拉大锯」这件事，没有了。

没有人会说，锯完以后两个人还站着不动，才叫成功。

诊室也是这样。第 9 章讲过，复合体的状态是在一次次复诊里转换的；第 10 章讲过，秩序态靠一锅粥和悬着活着。现在把这条线拉到头，会看到一件事：

复合体的一种秩序态，是它不再被需要。

这个秩序态，也是定型。可它属于日子，不属于病房。它定下来的，是一件事：病人位、医生位、病名，一起退场，日子重新成了主语。

这就是本章的判断：**解散，是复合体最好的一种定型。**

注意，这里说的是「复合体」，不是「医生」，也不是「病人」。

说病人「康复了」所以离开，说医生「治好了」所以放手，都把决定放在了某一个人手里。其实做决定的，是整个复合体，它在一次次互动之后，走到了一个状态：不再需要继续拉这把锯。

两个人都走开了。谁也没有赢，谁也没有输。

中国人对「收场」这件事，向来很讲究。婚事有仪式，丧事有仪式，开业有仪式，毕业也有仪式。仪式的意思，是让一件事有头有尾，让人知道它是怎么结束的。

病，却是少数几件有头没尾的事之一。

有一件小事，值得在这里想一想。

挂号那一刻，是整个复合体的起点（本书的总钥匙）：挂号单一出，病人、医生、科室、病名，开始一起显影。医院里有挂号这个动作，每一个人都经历过。

可你有没有经历过「销号」？

没有。没有哪一个窗口，会在你病好的那一天，收走你的挂号单，对你说：「从今天起，你不再是这里的病人了。」

复合体怎么起头，我们有一个明确的仪式；怎么散，却没有。大多数时候，它是悄悄散的，或者干脆没有散，只是慢慢变稀，拖在那里。

没有仪式的事，容易变成没有人负责的事。

这一章想做的，就是替「销号」补上一个说法。

还要补一句，免得读成「封死」。

第 10 章说过，从不进入悬着的状态，不是健康，是把一锅粥压住了。解散也是这样：散得好的复合体，不是把一切都盖上盖子，而是留下一个口。日子里再出新的难受，这个口还能打开；打开以后，是一次新的起头，不是旧账重翻。

所以，好的解散是松的，门还留着缝。

像一间收拾干净的屋子，门没有锁，灯也没有关，只是暂时没有人坐在里面。

还有一点，值得单独说。

有人会问：那医生岂不是没事干了？

不会。一位医生，把一个人还给了日子，诊室里就腾出了一把椅子，下一个真正需要的人，可以早一点坐上去。散得好的复合体，不是医疗的损失，是医疗里最有效的一种流转。

这样的解散，不是「消失」。锯完那根木头，木头上有锯口，锯子上有木屑，两个人手上有茧。解散以后，复合体留下了什么，下一节再说。

◆ 四、解散不是失败，也不是告别

先说两个误会。

第一个误会：解散是失败。

有人会说：病人不来了，是不是医生没留住他？这话，用在商店里，也许说得通。用在诊室里，是倒过来了。

一位医生，让一个病人不再需要他，这是他最漂亮的活。就像一位老师，教到学生不再需要他讲，是教得最好的时候。

换到医生那一头看，这件事更清楚。一位医生每送走一个恢复得好的病人，候诊的椅子上就多出一个空位。这个空位是真实的：他的门诊量少了一个数字，他的忙碌少了一份被需要的证明。可一个行当如果只记得「忙」，忘了「好」，它就把自己最大的成绩，当成了一笔损失。

当然，解散不了的，也不一定是失败。有的难受，本来就要陪很久。这一点，后面会说。

第二个误会：解散是告别。

告别，是两个有名有姓的人，各自说一句「再见」。里头有情绪，有舍不得，有一点伤感。

解散不是这一类事。解散，是位子撤了。医生位撤下，病人位撤下，病名从日子的主语，退回病历里的一行字。两个人还是两个人，可「医生」和「病人」这两个位子，没有了。

豆豆那句话问得好：「陈医生会不会想我？」

答案是：陈医生还是陈医生，豆豆还是豆豆。他们可以在路上遇见，打个招呼。可「医生—病人」这个复合体，不在了。

它不在，因为它完成了该做的事，跟谁忘了谁无关。

还有一件事要说清楚：不是所有复合体，都能散。

有些病，要陪一辈子。有些病，走到最后，是另一种结束。到了那里，复合体的秩序态，不是「不再被需要」，而是「陪到最后」。这一类，本书不在这一章里讲，也不拿「解散」去套它们。

对这样的人来说，「最好」另有说法：这个复合体在最后的日子里，仍然互相读得懂。

大致说，散不了的，有三类。

第一类，慢病。血压、血糖、关节、一些要长期照看的毛病。这样的复合体，不是散，是缩：见面的间隔拉长，话变短，大部分时间，日子自己运转。这是「部分的散」。

第二类，需要长期照护的人。年纪很大的，或者身体有长期困难的。这里的复合体，常常要有一个稳定的医生位，也要有一个稳定的家人位。散，不是目标；稳，才是。

第三类，走到生命的尽头。这一类，本书会在别处认真说。在这一章里，只想请你记住一件事：别拿「解散」去量它们。

那几类复合体的好，是另一种好。

所以，本章的话，要这样说才准：

对那些能散的复合体，散，是最好的定型。

对那些散不了的，也有「好」的定型，只是名字不同。

◆ 五、解散的三个动作

解散不是一天里发生的事。它像天色暗下来，一格一格地换。

大概有三个动作。

第一个动作，病人位撤下。

一个人走进诊室，是「病人」；他出院那天，名字还叫这个，可称呼要换了。

怎么换的？他不再用「我是个病人」来开头。他说「我最近有点咳」的时候，是一句日子里的话，不是一份病历里的话。

有人病好了很久，嘴边还是「我这个人身体不好」。这句话是病人位没有撤的痕迹。

有人去新单位报到，表格上有一栏「既往病史」。他握着笔，停了好一会儿。写，还是不写？写了怕被另眼相看，不写又觉得心虚。

他停下来的那几秒，就是病人位还在日子里、没有退档的几秒。

还有一个位子，常常被忘记，就是陪病人的家里人。

病人病得重的时候，家里人也跟着进了这个复合体：陪着挂号，守着输液，记着吃药的时间。病好了，病人位撤了，家里人那个位子，常常撤得更慢。他们还是会盯着饭菜，盯着衣服，盯着那一声咳嗽。

这份盯着是爱，可它也是一根线，一头牵着家里人，一头牵着那个已经好了的人。线不松，复合体就没散干净。

三个动作，不一定同时发生，也很少同时发生。

常见的是错位。医生位撤了，病人位没撤：何老师（后面会讲他）就是这样。病人位撤了，医生位没撤：医生还在不停地叮嘱，病人早已不太听了。病名退了档，可日子里的人，还在用它称呼自己。

错位久了，复合体就散不干净，像一场散了席，还有人坐在桌边。

撤得好的人，是这样说的：「我前年动过一次手术。」后半句不是「所以我身体不好」，而是「所以我知道那个滋味」。

第二个动作，医生位撤下。

医生位撤，说起来不容易。

一位医生，把一个病人从危险里拉出来，心里是有牵挂的。下一次见到他，眼睛会往他的脸色上看。这是一种职业的敏感，也是一种温暖。

可如果这种牵挂变成了「必须继续盯着」，复合体就散不开了。医生位撤下，意思不是不关心，是说：关心可以放在心里，不必放在复诊单上。

好的医生，有一个本事：在适当的时候，把一个病人，还给他的日子。

周岚有一个习惯。每次看完一个恢复得不错的病人，她会在病历最后写一行小字：「可拉长间隔。」写完，她会对病人说：「下次不用这么早来。」

这一行字，别人看不见，可她知道，那是她自己的医生位，在往后退一步。

起初她也不习惯。退一步，等于少一次见面，少一次被需要。她心里有一点空。

后来她明白了：这点空，正是做医生该付的那一份。

第三个动作，病名退档。

病名是第一次回写（第 6 章），它写进病历，也写进日子。解散的时候，病名要从日子里退出来，回到病历里，成为一行记录。

「高血压」「胃炎」「抑郁发作过一次」，这些字还在，可它们不再是一个人的主语。

退档，要留着底。

病历里的记录是真的，发生过的事不会被抹去。它留着，是为了万一哪一天，需要重新挂号，复合体可以从一个有记录的地方，重新起头。第 8 章讲过，复诊不是纠错，是重新起头。

好的解散，不是把门关死，而是留一条可以回来的路。

有一件事，要说清楚：

停药，什么时候停，怎么停，是医生和你一起定的事。本书不给用药建议。这一章说的，是复合体的状态，不是教你怎样停药。

身体或心里的难处真的大了，请找医生或心理咨询师。

◆ 六、解散之后，复合体留下了什么

解散不是清零。

一个复合体走完了它的路，会留下四样东西。

第一样，一份记录。病历里有病名，有日期，有怎么处理的。这份记录不再是日子的主语，可它是一条真实的线：哪一年，哪一个月，这个人曾经走过这一段。

第二样，一种读法。一个人经过这一遭，学会了读自己的身体。哪一种累是睡眠不够，哪一种疼要尽快去看。这种读法，是医生没法直接塞给他的，是一次次互动里，他自己长出来的。

第三样，一条回来的路。第 8 章讲过，复诊不是纠错，是重新起头。一个散得好的复合体，会让人知道：万一，还可以再来。这条路就像家门口那盏灯，不亮着，可知道开关在哪儿。

第四样，一点信任。不是对某位医生，是对「有人会好好听我说」这件事。这份信任，在下一次出现难受的时候，会让一个人早一点，而不是晚一点，推开诊室的门。

这四样东西，都是回写。

回写不是库房里越堆越多的旧资料，是回头改变了土和路的东西。一次好的诊疗，把土改了：这个人的日子里，多了一点对身体的熟悉，多了一点对医生的信。

所以，解散不是什么都没留下。恰恰相反，它留下的，是复合体里最有用的那一部分。

只是它不再需要两个人，天天坐在一起。

◆ 七、解散不了的复合体：两头都离不开

现在看反面。

有些复合体，该散，却散不了。它们有两个方向：病人这一头离不开，医疗这一头也离不开。

一头：离不开医生、离不开检查的人

先看这一种：离不开医生的人。

有一位大叔，姓顾，五十多岁。几年前他做过一次大手术，恢复得很好。医生说：以后每年复查一次就行。

他每年复查。可他不止每年复查。他每个季度，找一个借口去医院。有时候是「最近总觉得有点累」，有时候是「想再确认一下指标」。每一次，报告都是正常。他拿到报告，当场松一口气，回去的路上，脚步是轻的。

三个星期以后，那口气又慢慢泄了。

下一次，他又来。

本书不会说他「依赖」，更不会说他「疑病」。这样的话，把毛病放回他一个人身上，是老路。

本书说：这个复合体，是靠「安心」撑着的。每一次检查，给他一点点安心；每一点安心，保质期都不长。保质期一到，复合体需要再来一份。

于是，复合体越来越离不开检查，检查越来越离不开复合体。

这是一把拉不完的锯：木头早就断了，两个人还在拉。

再看另一种：离不开检查的人。

这种人，不一定离不开某位医生。他离不开的是「被检查」这件事。体检单上多一个箭头，他的一周就沉了；体检单上全是正常，他也没能轻多久，因为他知道，明年还要再查。

查，成了一种日子的节拍。

有位女士，姓梁，四十出头。每年春天，她都给自己和丈夫订一份「全面体检套餐」，一项不落。去的前一周，她开始睡不好；拿到报告的前三天，她开始心慌。

报告出来，一切正常。她当天晚上，睡得特别香。

然后，大概两个月，她会慢慢又想起：去年正常，今年正常，明年呢？

她不觉得自己有问题。她觉得，这是对身体负责。

这话没错。可她的春天，已经被一份报告安排好了。

注意，这里没有谁是坏人。检查没有错，关心身体没有错，医生愿意再看一遍，也是好意。

问题在于：这样的复合体，没有一条撤出的路。它每一次互动，都在加强下一次互动的理由。

第 11 章说过，只追身体一头，日子那头会越来越暗。这里是同一件事的另一面：只追身体的复合体，最后会走到一个地方，那里的日子，是被下一次检查排好的。

还有一种离不开，要放轻一点说。

有一位老太太，姓冯，七十八岁，独居。她每个月都来社区医院一两次，量血压，说说话。血压总是平的。周岚知道，她来，不是为了血压。

那间诊室，是这个月里，唯一一个有人听她说完整句话的地方。

这样的复合体，如果硬说「该散了」，是残忍的。它的「需要」是真的，只是需要的不是医生，是有人听她说话。

所以，散不散得开，要看一件事：别的地方，有没有接得住这份需要。

要是有一个老年活动室，一个愿意聊天的邻居，一个每周来一次的社区志愿者，这个复合体就可以慢慢缩小。要是没有，医生位就还得在那儿，直到别的位子出现。

这是解散的一个条件：医生想散还不够，日子里得先有别的地方，能把人接住。

怎么看一个复合体是不是散得开？

有三个迹象，可以留心。

第一个，见面的间隔在拉长。从每周到每月，从每月到每季，没有谁刻意去拉，是需要自己在往后退。

第二个，话题在变。从头到尾都是症状和指标的复合体，是紧的；开始聊起孙子、聊起天气、聊起上个周末去了哪里的复合体，是在松。

第三个，说话的主语在换。病人从「我这个病」，变成了「我最近」；医生从「你这个情况」，变成了「你这阵子」。主语换了，位子就开始松动。

这三个迹象，不是考核表，只是看一个复合体有没有在往日子那边走的几个角度。

还有一个小办法。问一句：这个复合体里，有没有人说过「什么情况下，我们可以不见面」？

如果谁都没有说过，那就要小心。

另一头：离不开病人的医疗

再看另一头。

前面说的，是病人那头离不开。还有一种，是医疗那头离不开。

先说清楚：这里说的，是一种排法，跟哪位医生的人品无关。

一家医院，要运转，要有人来。门诊量，复诊率，检查量，床位周转，都是要看的数字。这些数字，各有各的用处：看哪个科室忙，哪个科室闲，哪台机器该买，哪个岗位该补。

可数字有一个脾气：它们爱涨。

当一家医院用「来得多」算好，用「复诊多」算忙，用「检查多」算做得到位，它就会不知不觉地朝一个方向走：让复合体不要散。

没有谁有意，排法就是如此。

再说药。有些药，要长期吃。这是医学上的事，没有什么好说的。可当「长期」变成「习惯」，当「需要吃」变成「不敢停」，谁来问一句「现在还需要吗」？

这一问，要有人来问。可问的人，常常不在这个排法里。

周岚所在的社区医院，设想过一个很小的办法。每个季度，把复诊最勤的十位病人的病历拿出来，在例会上只问一个问题：这位病人，最近一次见面，是为了什么？

有几位，答案是：为了血压。有几位，答案是：为了开药。还有一位，答案是：没有什么，他想来坐坐。

这样的例会，没有人受罚，也没有人被表扬。只是让大家都看见，这个复合体，现在靠什么在撑着。〔虚构的做法，仅作示意〕

医生这一头，还有另一种离不开：不敢放手。

第 13 章会细讲医生端的症状：防御性医疗，指标焦虑。其中一条，就是「多查一项，以防万一」。这是医生位对自己的保护：万一出了事，我至少做过了。

这一句话，每一个字都有它的道理。可合起来，复合体就慢慢长成了一个，很难散的东西。

这里有一个提醒。

「复合体生病」，不等于责任稀释。该追责的，仍然要追责：该做的检查没做，该说的话没说，该守的规矩没守，这些，第 15 章会专门讲。追责，是修复的一部分，不是和解散对着干的事。

可也要看到另一面：一个只靠追责来修复的医疗，会进一步往「防御」那一头走，走到后来，更难散。

再往外看一步。今天，有些健康产品，用「订阅」「会员」「长期管理」来留住人。这些产品里，有的确实有用，有的只是把「需要」变成了一个月一收的生意。

没有谁一定是坏人。可当一个服务的账，要靠「人不好」才算得清，它就很难心甘情愿地，把一个人还给日子。

这就是「离不开病人」的另一个样子：舍不得的不是某个医生，是账本。

所以，离不开病人的医疗，不是靠骂出来的，是靠把排法重新想一遍。

比如，记一笔「这个复合体，有没有走到可以不再见面的那一天」。

比如，让一位医生，因为「把病人还给日子」而被看见，而不是因为「让病人回来」。

有人也许会问：「出」的指标，怎么记?

可以想到的有几种：一个病人，从多久复诊一次，变成多久一次；一位医生，让多少人拉长了间隔，而没有出事；一个科室，有多少人，在恢复以后，明确知道了「什么情况下该回来」。

这些都是想法，不是做法。能不能行，要靠医院自己去试，去验。〔待验〕

这些，本书替医院做不了决定。本书能做的，是把这个盲点指出来：当一个系统只有「进」的指标，没有「出」的指标，它就会长出一种很难解散的复合体。

◆ 八、今天与机器

今天，有一个新来的成员，值得单独说一说：能随时回答的机器。

它永远在线。凌晨三点，你睡不着，打开手机问：「我这个症状严重吗？」它马上回答。你问一遍，它答一遍。你再问一遍，它不嫌烦。

这对一个深夜里的人，是一份真实的安慰。

可对「解散」，它是一道新题。

一个复合体，因为「需要」才存在。当「再问一句」不花钱、不排队、不看脸色，需要就更容易被一次次续上。于是，问的次数越来越多，每一次都有回答，每一次的回答，都给下一次的问，留下一个口子。

这样的深夜很常见。一个人躺在床上，屏幕的光照着脸，手指在输入框里打字，删掉，再打。他并不是真的想要一个答案，他想要的是，此刻有谁在。机器在，而且永远在，所以他一次又一次地回来。

机器没有错，错也不在使用它的人。是这个复合体，缺了一个会说「差不多了」的位子。

反过来，也可以设计成另一种样子：机器会说，「你这个问题，我们已经看了三遍，答案没有变。你今天的难受，更像是睡眠不够。要不要明天再说？」

一个好的新成员，不只是会回答，也会收手。

再有一层。机器能记得你问过的每一句话，能随时翻出三个月前的症状。这份记性，对一个想「收手」的人是好事：他可以看到，自己已经问了多少遍。

对一个想「继续」的人，它是一座越来越大的仓库。仓库里全是问，没有一个「完」。

一个复合体，需要有「完」的时候。

这件事，第 16 章再细说：医生—病人—AI，三方复合体，什么时候散得开，什么时候散不开。

◆ 九、一个完整的例子：何老师的膝盖

何老师六十五岁，是周老师从前的同事，教了一辈子物理。前年，他做了膝关节手术。

术后的头几个月，他是个标准的病人：按时复查，按时做康复，医生交代什么，他记在小本子上，一条一条做。

半年以后，康复师说：「可以了，您能上楼了。」

一年以后，骨科医生拍了片子，看了看，说：「恢复得很好。以后每年来拍一次就行，哪天觉得不对劲，随时来。」

何老师回家，把复诊单收进抽屉。

那天晚上，他吃完饭，坐在沙发上，老伴在厨房洗碗，电视里放着新闻联播。

他的手，却不自觉地摸到了膝盖。老伴从厨房探出头来，看了一眼，没有说话，只是把毛巾搭在肩上，笑了笑。

她也在这个复合体里待了一年多。她记得每一次换药的日子，记得什么时候不能让他提重物。她比他自己，更早知道这条腿该撤了。摸了一下，又摸了一下。

第二天早上，他起床，第一件事，是先弯一弯膝盖，试试有没有异样。

第三天，也是。

一个月以后，他对周老师说：「我这膝盖，医生说好了，我自己总觉得它不踏实。」

周老师想了想：「你这是医生位撤了，你自己的病人位还没撤。」

何老师笑起来：「你这话说得有点怪，可有道理。」

那天，他想了一件事。膝盖手术以后，他每一天的日子，都是围着「膝盖」转的：怎么上楼，怎么下楼，怎么蹲，怎么起。现在，医生走了，膝盖不再需要被围着转，可他的日子，还留着那个形状。

他做了一件小事。

他把复诊单从抽屉里拿出来，在最上面，用笔写了一行字：「下次复查：明年三月。」写完，又放回去。

然后，他去楼下，找老李下棋。

走在楼梯上，他没有先弯一弯膝盖。

走到一半，他才发现。

再从医生那一头看。

何老师的骨科医生，姓宋。那天他看完片子，说「恢复得很好」，说完以后，在病历上写了一行：「随访：每年一次。」

他其实可以多写几行。多写一行，多一次复查，多一份保险。可他没有。他知道，何老师是一个按本子办事的人，只要给一个明确的日子，他就能放心。

宋医生后来对周岚说：「我最怕两种病人。一种是不听话的，一种是太听话的。太听话的，你说三个月，他就来三个月，你不说停，他一辈子不敢停。」

所以，他在病历上写的，不只是下次什么时候来，还有这一句：「无不适，可自行安排活动。」

这是一个医生位，把自己轻轻放下。

第二年三月，何老师去复查。

片子拍完，宋医生看了一眼，说：「还好。」

何老师坐在椅子上，没有立刻问「那我以后要注意什么」。他问的是：「宋医生，您看我明年还需要来吗？」

宋医生抬起头：「您想来吗？」

何老师笑了：「说实话，不太想。」

「那就看您自己。」宋医生说，「我给您的建议是，每两年来一次。您要是觉得不对，随时来。」

何老师点头，站起来，伸了伸手。

宋医生也站起来，两个人握了一下手。

这一握，不是告别。是两个位子，轻轻放下了对方。

这个例子里，有三个地方，值得看。

一，医生说「恢复得很好」，只是复合体的一半散开。另一半，在何老师的日子里，要慢慢撤。

二，撤的办法，不是靠劝他「别想了」，而是给他一个「下次什么时候再见」的明确日期。有了这个日期，病人位才敢往后退一步。

三，病名退档，留着底。那张复诊单还在抽屉里。它在那儿，所以他才放得下心，去走楼梯。

判断落在哪里？不落在何老师「想开了」上，也不落在医生「治好了」上。这个复合体，在一次次互动里，走到了一个可以散开的状态：一半在诊室里完成，另一半在日子里完成。

再补一个细节，给好奇的人。

周岚后来问过陈医生，那个冬天，他是怎么知道豆豆「可以不用再来了」的。陈医生想了想，说，靠的不是哪一项指标，指标只是一个理由。真正让他放心的，是豆豆进门的样子：那天孩子是自己跑进来的，没有被妈妈牵着，也不用谁哄着张嘴。

他说：「孩子身上有一种东西，叫作『忘了自己是病人』。看到这个，我就知道差不多了。」

这句话，比任何标准都更像一条判断：复合体里的每一个位子，开始忘了自己的名字。

◆ 十、这一章最弱的地方

诚实地说，这一章有三处靠不太稳。

第一处，「不再被需要」不好量。医生说好了，病人说好了，也许只是双方都累了。真正的散，是日子里的人不再靠这个复合体撑着，这一点，没法用一张表来量。本书只能给出几个看的方向，不能给出一个分数。

第二处，这一章很容易被读歪。读歪的一种是：少看病，少复诊，就是好。本书没有这个意思。该查的要查，该来的要来，本章讲的是：来的理由消失以后，复合体要有一条体面的出口。

读歪的另一种是：医疗机构借「解散」之名，把本该提供的服务减掉。这是对本章的滥用，也该被追问。第 15 章会讲，不管哪一种复合体，追责都不取消。

第三处，「解散是最好的痊愈」，是本书的说法，不是一个已经被验证的结论。它要被日子检验：如果有人发现，某些人明明已经散开了，却没有变得更好，反而更孤单，本书就要把话收窄。〔待验〕

第四处，这一章的例子，都是比较容易散的。何老师的膝盖，豆豆的咳嗽，都是有头有尾的事。真正难的，是那些没有头尾、纠缠在日子里的难受，它们怎么散，或者能不能散，本章没有讲透，留给第四编去接着想。

这四处写在这里，是因为一本讲「回写」的书，要先让自己被回写。

◆ 十一、放回日子里

回到豆豆。

那个冬天过去，春天来了。豆豆不咳了，有一天，他在院子里跑着追一只猫，跑得满头是汗。

周岚站在窗口，看着他，忽然想起陈医生那句话：「你要是不来，就说明你很好。」

她心里有一点什么东西，轻轻放下了。

那天晚上，她把豆豆那本病历册子，从抽屉里拿出来，翻了翻。里面夹着三张处方，几张化验单，一张挂号单。她没有扔，也没有再看第二遍，把它们放回了抽屉。

周老师呢？他血压高了多年，药要吃，不能说散。可他最近发现，自己每天量血压的次数少了。红皮本子上的字，也不再只有数字。

周岚跟他说：「这也算一种散。」

「怎么说？」周老师问。

「复合体变小了。」周岚说，「以前是天天围着数字，现在是数字围着日子。」

周老师沉默了一会儿，说：「这个『散』，我喜欢。」

还有一个小场景。

周岚的诊室里，有一块小黑板，写着本周的门诊时间。有一天，她在黑板底下，添了一行小字：「恢复得好的，请告诉我。」

起初没有人看。后来，有位病人，在复诊的时候，从包里拿出一盒自己做的糕点，说：「周医生，我下个月不用来了。」

周岚接过糕点，笑了：「好。那下个月，你来吃糕？」

那人也笑了：「不来，来了你该嫌我烦。」

两个人都笑了。

周岚后来把那盒糕点分给了候诊的人，一人一块，说是一位好起来的病人送的。

候诊的人吃着糕，心里大概都在想：这位医生，是真的希望我们好起来。

这一幕里，没有告别，没有眼泪，也没有谁赢了。是一个复合体，轻轻地，散了。

你明天就能试的，是一个很小的问句。

下一次去看医生，快结束的时候，问一句：「下一次，什么情况下，我可以不来了？」

如果你是医生，也可以主动说：「你这个情况，大概到什么时候，我们可以拉长间隔。」

如果你是陪着病人的家里人，也有一句可以说：「你这阵子恢复得不错，我们是不是该把复查的日子，也跟医生商量商量？」这句话把「散」说成一件两个人一起商量的事，而不是谁在催谁。

还有一句，留给医生位的人，也留给每一个自己的病人位：「我们把话说在前头，今天这一页翻过去，不是门关上了，是路换了一条。」

这个问句，不是赶人。是给复合体一条撤出的路。有了这条路，复合体才敢往前走；没有这条路，它只能一直拉着锯，不敢松手。

最后，回到拉大锯。

锯完了，木头断成两截，锯子靠在墙边，两个人拍拍手上的木屑，各自回家吃饭。路上遇到，也许点个头，也许聊两句今天的天气。

这是诊室里最好的一幕。它没有掌声，也没有谁被记住，只是日子里少了两个位子，多了两个人。

带 走 的 话

好的复合体，是知道什么时候该散的复合体；病好了，不只是病没了，是「病人」这个位子，也轻轻放下了。

小　账

这一处，开门还是关门：开门。「解散」这个词，打开了老看法里没有的一扇门：病好以后，位子也要撤，日子才算还回来。

病放在一个人身上，还是放回复合体里？放回复合体。离不开医生的，不是顾大叔一个人的毛病；离不开病人的，也不是哪一家医院一个人的毛病。是「只有进、没有出」的整个排法。

想 一 想

你最近一次看完病，有没有一个人跟你说过，什么时候可以不用再来？

你身边有没有这样一个人：病早就好了，他还一直是「病人」？你觉得，他缺的是一个什么？

◆



第　四　编

复合体的病与修复

编　序

这一编四章，写复合体生病，也写它怎样修。

第 13 章写医生端的三种症状：倦怠，指标焦虑，多开的那张单。过去它们都算医生的私事，这里看作复合体的症状。第 14 章借「痛则不通」这句老话，问复合体卡在哪一维：说不出，读不懂，回写不进。第 15 章问责任在哪里：追责一点不少，只是修复的点要重新找。第 16 章写新来的一位，AI。医生、病人、AI，三方坐到了同一把锯上。

这一编要让你看见一个反差。只修病人端的医疗，修得再好，也修不好复合体。药开对了，话讲懂了，锯子另一头还在发烫，锯条照样卡。反过来也一样。前三编讲复合体怎样发生，这一编讲它怎样卡住，又怎样重新通。

13

第 13 章

医生端的症状

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你在候诊区坐着。叫号屏上，名字一个接一个滑过去。门开了，一个人进去，三四分钟后出来，下一个人再进去。

轮到你。医生没抬头，问：「哪里不舒服？」手还在键盘上敲。

你把想了一路的话说了一半，他已经在点打印。你拿着单子出来，心里有点堵：他连看都没看我一眼。

这一幕，你大概有过。很多人回家以后，会把这口气记在那位医生头上。

现在把门换一头走进去。

周岚三十四岁，在一家社区医院做全科。周二上午，她七点四十到，号已经排满了。这一上午有几十个号，一个一个往下压。她早上喝了半杯水，到十一点还没去过洗手间。

前面几个号都顺。一位来开药的，一位量血压的，一位孩子咳嗽的家长。她说话越来越快，句子越来越短，自己都听得出来。

第 31 个号是一位老太太。老太太坐下，开口讲的是血压，讲了不到一句，就拐到了儿媳身上。

「她从来不做我爱吃的，上回我说血压高，她倒好，汤里放了一勺酱油。」

老太太讲了四分钟。周岚听明白了：病不全在血压里，有一半在这四分钟里。

可候诊椅上，还坐着十几个人。

她开了一张常规化验，其实用处不大。她说：「先查一下，下周再来看结果。」老太太点点头，慢慢站起来。周岚没再看她的脸。

不是不想看。是怕多看一眼，自己就松了，后面的人就等不起了。

门外的人看见的，是一个没抬头的医生。门里的人，是一个怕松的人。

这一章写的，是锯子的另一头。本书不控诉任何人，也不替任何人开脱。

如果你是病人，读到这里，不必急着替谁说话。只请你先记住门里的这个样子：同一个上午，门外和门里，是两个故事。这一章要把它们并排放在同一张桌上。

◆ 二、老看法：这是医生自己的事

医生端的这几样难处，老看法有一个现成的位置：放在医生个人身上。

倦怠了，是心理素质不够，要学会调节。焦虑了，是不够从容，要多读书、多休息。多开了检查，是怕事，是责任心里掺了私心。反过来，也有人说：医者仁心，仁心够了，这些都不是问题。

医院的管理者有他们的版本：培训，考核，评优，把表现好的人树起来。媒体有媒体的版本：一个医生冷冰冰，一个医生暖，两张脸并排放在版面上。

这些版本，句子不同，位置一样：问题在一个人身上。

先说它对在哪儿。

个人确实有差别。同一间诊室里的两位医生，一位到下午还能留住一口气，一位上午就熬干了。休息、同伴的支持、有人听你说一说，对一个人的倦怠确实有用。有一种做法叫巴林特小组：一群医生定期坐下来，只谈那些让自己心里发堵的医患关系，不谈药和指标。它起于 20 世纪 50 年代前后的伦敦，由精神分析师米夏埃尔·巴林特带着全科医生做起来（大意如此）。这样的小组能让人松一口气，是真的。

追责也确实该有。该查没查、出了事，不能一句「大环境如此」就放过去。

关于倦怠，心理学家马斯拉赫（Christina Maslach）和同事有一个常被引用的说法。倦怠大致有三样表现：情绪耗竭，对人变得冷淡疏离，觉得自己做的事没有用（Maslach & Jackson，1981，大意如此）。后来世界卫生组织在疾病分类里，把倦怠写作一种「职业现象」，不算病（2019 年，大意如此）。

这些说法都有用。它们把医生端的苦，认真当成了一件事。

可是这套看法有一个没有说出口的前提：有一个先在的医生，带着他的心理素质和责任心走进诊室，诊室只是他演出的地方。素质好，演得稳；素质差，演砸了。

这是发现学的医生：先有一个人，再有他做的事。

本书要问的是，这个前提站得住吗？

同一个周岚，在社区医院的周二上午，说话越来越快；在周日的家里，给豆豆讲故事，一个字一个字地读。她的素质，一个周末就变了吗？

一个人的素质，在一把锯上能拉多久？

还有一句话，值得单独拿出来看看：「医者仁心」。

这四个字好听，也有分量。不过它在日子里，常常变成一个暗中的要求：你既然是医生，就该一直有劲，一直有耐心，一直不出错。

这个要求本身没有错。错在把它交给一个人去满足。

一个人满足不了的要求，只能靠透支去满足。透支久了，仁心不是没有了，是没有地方放了。

所以「仁心」这件事，本书不否认，只想换个位置。不是医生一个人要有仁心，是复合体里要有让仁心能落地的土。没有土的仁心，像一把握在手里的种子，再好，也长不出东西。

◆ 三、本书的说法：这是锯子另一头的热

打个比方。两个人拉一把大锯，锯一根粗木头。拉到后来，锯条发烫了。

这时候，你不会说：左边那个人的手出了问题。锯条的热，是两头一起拉出来的，也是两头和那根木头、那把锯一起拉出来的。木头太硬，锯齿钝了，对面的人时紧时松，都在里头。

本书把医生端的三样东西，放在这个画面里看：

倦怠，指标焦虑，防御性医疗。

它们都不是医生一个人带进诊室的东西。它们是「医生—病人」这个互动复合体，在某一段时间里的状态。状态里总有一处会先露出来，这一次，露在了医生位上。

为什么偏偏先露在这一头？

因为复合体的土里有些东西，是压在这一头最重的。每个号能有多少时间，是外面的规则切好的。月底那张表上的数字，是外面的考核盯着的。出了事谁来担，也是外面的土定下的。病人那头的期待和害怕，一层层压过来，最后也要由这一头接住。

这些东西没有一样是周岚自己挑的。她走进诊室那一刻，医生位这一头，已经是这个样子了。

这片土，大致有三层，不妨一层一层摸一摸。

第一层是时间的土。一个号几分钟，不是周岚定的，是号源、人手、病人的数目，一起排出来的。时间被切成薄片，话就只能挑最要紧的说。

第二层是读数的土。血压、血糖、签约率、随访率，每一样都有一条线。线本身没有恶意，可它们站在那里，眼睛就会往它们身上落。

第三层是担责的土。出了事，病历是证据，沟通是证据，连一句「已告知」也是证据。人在这一层土上，脚步会放轻，手会收紧。

三层土叠在一起，医生位这一头，就是这样被压出来的形状。

还有一个细处，要放进第 10 章的话里看。第 10 章说过，秩序态要靠一锅粥和悬着活着，一间从不留悬着的地方的诊室，看上去最稳，其实最脆。

周二上午的诊室，就是很稳的：号排得整整齐齐，流程一环扣一环，每一个动作都有名字。可是稳得没有一点缝，老太太的四分钟儿媳、老程的「我哥就是这个年纪走的」，都没有地方落脚，只好被压成一张化验单。

稳，是定型。定型本身不是坏事。坏的是，它把该悬着的那一小块也封死了。

再说一句要紧的。医生位本身，也不是先在的。第 2 章说过，医生不是带着「医生」的身份走进诊室的，医生位是在互动里一起显出来的。那么，医生位上的倦怠，也不是一个人带来的症状；它是复合体的状态，在这一头露出的样子。

这是本章的第一句判断：

医生端的症状，是复合体的状态，在医生位上先露出来的那一处。

不是说医生没有份。是说这件事的承载者，不是医生一个人。

承载者换了位，修的办法也就换了位。这是本章往下要走的路。

还要交代一个词。本章说「症状」，没有说「病」。

症状是一个状态里露出来的那一处，像发烧是身体的状态露出来的一处，不等于发烧就是病本身。倦怠、指标焦虑、防御性医疗，是复合体的状态露出的三处。找到露出来的地方，才好顺着往里找，看是哪一条路不通、哪一块土干了。

下面三节，一样一样看。

◆ 四、第一个症状：倦怠，回写进不来

先看倦怠。

按本书的说法，复合体里本来有一条回头路：病人好了一点，医生得到一点「这事有用」的感觉，这一点感觉回头给医生位添一点土。这条路，本书叫回写。

回写通着，医生再累也有一口气接得上。

回写断了呢？

周岚有位老病人，叫老孙。老孙每个月来开药，每个月说一样的话：

「睡不好，没劲，老毛病。」

周岚也每个月说一样的话：

「按时吃药，少盐，多走走。」

两个人都很客气。两个人都说得很对。

不过半年过去，锯口纹丝不动。

老孙觉得：又是这几句。周岚觉得：又是这几句。劲使出去了，没有一点东西回来。

这就是倦怠的形状。力气不是白白花光的，是花出去以后，没有任何回写。木屑不下来，锯口不开，两头越用力，越累。

你可以回想一下自己干过的一件活：连着做了三个月的方案，没有一个人说一句「用上了」。累不累，不在做了多少，在有没有任何东西回来。

马斯拉赫说的第二样，对人变得冷淡疏离，也能这样读。周岚有一天在病历本上，把老孙写成了「高血压，复诊」。她不是不关心老孙。是在回写断了的地方，「老孙」这个人的一路，先缩掉了，剩下一个病名。

注意，缩掉的是复合体里的一路，不是周岚的良心。

第三样，觉得自己做的事没有用。这一样最容易被当成「心态不好」。可是看看周岚一天里，有多少个号是这样结束的：她说了，病人点头，下个月原样回来。「没有用」不是她想出来的结论，是日子一次一次给她的读数。

晚上八点多，周岚到家。周老师在厨房问：「吃了没有？」

「吃了。」其实她只在门诊啃了半个面包。

她在沙发上坐下，手机刷了 20 分钟，什么也没看进去。豆豆跑过来，趴在她腿上问：「妈妈，你今天累不累？」

「不累。」说完，她自己也觉得这两个字不对。

倦怠的难，在于它不下班。白天用出去的劲没有回来，晚上也没有地方去补。医生位上的那一口气，是跟着人一起回家的，它进了客厅，进了饭桌，进了一个七岁孩子的问话里。

这时候有人说一句「你要学会调节」，是对的，也是轻的。轻在哪里？它把一整天的回写断裂，说成了一个晚上的心态问题。

老孙这头也一样。久病的人，常说一句：「我知道，我都知道。」这句话里有一种累，叫又来了。他也在倦怠，只是没有人给它起名字。

回头再看巴林特小组为什么有用。它不是在教医生怎么调节自己，而是请医生把一个具体的号带到桌上，讲给同行听：那个让我心里发堵的病人，到底发生了什么。

这是在把一个被压在医生位里的东西，重新放回复合体里看。一个人讲，一群人听，讲完了，那个号不再是「我的失败」，成了「这样一种卡法」。

有用的地方，正是把症状从一个人身上，请回了一把锯上。

所以倦怠不是医生一头的事。它是复合体的回写，断在了某一处。断在哪一处，下一章会细说，叫「回写不进」。

这里先记住一点：倦怠这个词，说的是医生，指的是整把锯。

再给回写一个正面的样子，免得它只剩一个抽象的词。

有一个星期五的下午，老孙进门，没有先说「睡不好」，说的是：「医生，昨天我在公园走了 20 分钟，没歇，也不喘。」

周岚抬起头。这一天剩下的几个钟头，她的话比平时多，笑也多。

那 20 分钟，是她三个月前随口说的「多走走」，在老孙的日子里长出来的。它回头进了她这里，成了她一整个下午的劲。

回写通的时候，医生位这一头不需要谁来鼓励。事情自己会回来。

这也是第 9 章说的悬着。一个方案开出去，结果还没回来，医生是悬着的。悬着是难受的，不过悬着也是有劲的，因为下一次复诊有一个等着看的东西。

回写断了，悬着就变成了空着。空着，没有东西等；没有东西等，劲就泄了。倦怠不是悬着太多，是悬着没有了。

◆ 五、第二个症状：指标焦虑，读数替了人

第二样，指标。

周岚的医院，月底有一张表。上面是几行数：血压控制得怎样，随访做了多少，签约的人有多少，一个月接了多少人次。（这家医院和这些数字，都是为说明而设的。）

先说指标对在哪儿。

没有指标的医疗，是凭感觉的医疗。感觉好的医生，救人；感觉差的医生，也害人。有了规范、有了统计，才能知道哪些做法真的有用，哪些人被落下了。很多人的命，是规范救回来的。

所以本书不反对指标。

可是指标有一个脾气。流传很广的一句话是：一个读数一旦变成要达到的目标，它就不再那么好读了（常被称作古德哈特定律；今天流传的这句措辞是后人转述的，大意如此）。

周岚就在这个脾气里。

这一天，她给一位中年人量血压，数字刚好卡在表上那条线外面一点点。她眼睛盯着屏幕，嘴里说：「再测一次。」那位中年人说，他早上赶过来，走得急。她点点头，眼睛没离开屏幕。

「那就歇五分钟，再来一次。」

五分钟以后，数字落回了线里面。她松了一口气，在表上点了一个勾。

没有人做错什么。不过那五分钟里，她心里想的是那条线，不是这个人为什么走得急，早上有没有吃饭，这半年是不是一直这样赶。

她不是在看他。她是在看那条线。

读数替了人，是这样发生的：不是某一天，医生决定不看人了；是一个个小动作，把眼睛从脸上挪到了屏幕上。

再往深处看一层。表上的数据越录越多，可是库房堆得再满，不回头改这一回的看，也就不是回写。数写进了表，没有写进老孙的日子，也没有写回周岚的手上。这是一种假的回写：账记得很全，生产线没有动。

指标焦虑，也是一种状态。读数一占前排，两个人之间的话，就没处坐了。

还有一层，常被忽略：病人那头，也有一份指标焦虑。

老孙回家以后，每天早晚量两次血压，把数字记在小本子上。数字高一点，他一晚上睡不着；数字低一点，他高兴半天。本子越记越厚，人却越来越紧。他不是不信周岚，是周岚每次都盯着那个数，他就学会了：这个数，比我说的话要紧。

读数就这样，从诊室里长出来，长进了家里。两头都在看同一条线，两头的眼睛，都离开了人。

月底最后三天，还有一件事：随访要补齐。

周岚在一个下午，打了四十个电话。

「您好，我是社区医院的周医生，想问问您最近血压怎么样？」

「挺好的，挺好的。」

「按时吃药吗？」

「吃的，吃的。」

「好的，谢谢您，有不舒服随时来。」

一分钟，一个勾。四十个电话，四十个勾，表上的数补齐了。

其中有一位老爷爷，在电话里停了一下，说：「医生，其实我有件事。」周岚看了一眼桌上那摞名单，还有十几个没打。她说：「您下次来的时候，当面跟我说，好吗？」

老爷爷说：「哦，好。」

这四十个勾，每一个都是真的。随访做了，数字完成了。不过随访是不是发生了，是另一回事。有一个人，差一点把一件事说出口，这件事停在了那个「好」字后面。

读数完成了，路没有走。

这四十个勾，还有一个后话。

月底，周岚的随访完成率是百分之百。院长在会上念了一遍，大家鼓了掌。周岚坐在后排，觉得那个掌声，像是在给另一个人鼓。

她心里想着那位停在「好」字后面的老爷爷。

这就是指标焦虑最难受的地方：指标是完成了，可是完成它的人，知道它没有完成。这种「完成了，但没有」的感觉，日复一日，就成了倦怠。

◆ 六、第三个症状：防御性医疗，多开的那一张单

第三样，最容易被骂的一样：多开的检查。

人们管它叫防御性医疗。大意是，医生为了防漏诊，也为了万一出事时能说一句「该查的我都查了」，多开检查，多留观察，多转诊。学界常把它分成两种：一种是多做，一种是回避高风险的病人（Studdert 等人，2005，对美国一个州高风险专科医生的调查，大意如此）。

先说对在哪儿。

漏诊是真的，后果是真的重。怕担责，不是胆小，是对一个会出事的行当的清醒。有的家属还会主动要求：「全做一遍吧，万一呢。」医生不是总在往外推检查，有时是被两头拉着，不得不开。

这一幕，周岚也见过。一位母亲抱着三岁的孩子，发热两天，进门第一句话就是：「医生，抽个血，拍个片，你们给查清楚。」

周岚检查了孩子，说：「孩子精神还好，先不用做这些，观察一下。」

母亲的眼睛红了：「万一呢？」

这一句「万一呢」，不是无理取闹。是一个母亲，两个晚上没睡，抱着一个发烫的孩子，面对一个说「不用」的陌生人。她要的不是片子，是一个她能抓住的东西。

周岚说「不用」，是她的判断。不过在这一头，她同时听见另一个声音：要是真有事呢？要是这位母亲回头去了别家，别家查出来呢？

一张单子，两个怕，在桌子中间撞了一下。

那天下午，来了一位中年人，头痛三天。周岚做了该做的检查，没有发现要紧的东西。她心里觉得，多半不用做影像。

可是她想起去年，邻近一家医院的同行被投诉过漏诊，那几天院里每个人说话都变轻了。

她开了单子。

病人拿着单子去排队，花了钱，等了几天结果，这几天里，他每晚都在想：是不是有什么没告诉我。周岚这头，病历里多了三行「已告知风险」。

本书不评这一张单该不该开。那是医学的事。

本书想问的是，这张单是谁开的？

不是周岚一个人。病人那头有一句「万一呢」，医生这头有一句「万一出事」。两头互相防着，各自攥紧，锯条就绷成了一根弦。再往外，是纠纷怎么处理，是网上转得最广的是哪几起，这些也是土。

所以多开的那张单，是复合体开的。

这里还有一个慢慢养成的循环，值得看一眼。病历越写越长，因为每一句都可能被翻出来读。医生越写越长，就越没时间听。听得越少，病人越觉得没被看，信任就薄一分。信任薄一分，下一次门诊，病人的「万一」更响。「万一」更响，病历写得更长。

一圈接着一圈，没有谁是故意转的。

它的账，也是复合体在付：钱，时间，几个睡不好的晚上，还有信任。信任少一分，下一次两头防得就多一分。

另一种防御更不容易被看见：不开单，只是不接。遇到风险高的、说不清的病人，客气地转走，说一句「去上级医院看看」。这也是防御，也是复合体的动作。被转走的人，感到的是被推开；转走的人，感到的是松了一口气。两头各有各的苦，没有一头知道对方的。

周岚也转过这样的病人。一位反复说不清哪里不舒服的中年人，来了五次，查了五次，每次都「未见明显异常」。第六次，她写了转诊单。

她心里是这样想的：我这里条件有限，上级医院的设备更好，该去的就该去。这个想法本身，一点不假。

不过她同时知道，另外还有一层：这位病人没有一个明确的病名，下个月考核，他是一个「管不住」的名额。

两层想法，一样真，缠在一起。哪一层占的分量多，她自己也说不准。

这就是为什么，防御性医疗很难靠「医生要诚实」来解决。诚实的医生，也说不清自己那一刻，有几分是为了病人，有几分是为了不出事。因为那一刻，病人的利益和自己的安全，本来就在同一个动作里。

追责在这里没有消失。该查没查，仍然要问；查得过了头，也可以问。只是问的时候，要问到复合体那里去，不能只停在一只手上。

◆ 七、今天与机器：读数更近了

今天的诊室，和二十年前不一样的地方，不少在屏幕上。

电子病历让一切留痕，这是好事：谁开了什么，几点开的，一目了然。留痕的另一面，是每一句话都要想想「将来别人怎么读它」。医生写病历时，有两个读

者：一个是下一位接手的医生，一个是万一出事时翻到这一页的人。第二个读者，悄悄改了很多句子的写法。

提示框也是。你开一种药，屏幕弹出一个框，写着可能的风险，要点一下才能关。每一个框都有道理，一个上午弹出几十个，人就学会了不读，只点。

病人那头也有自己的机器。手机里查一查症状，搜出来的是一排「可能」，每一条都带着最坏的那种。他带着这些走进诊室，两头的怕就更对得上了。

机器没有错。它只是让读数离得更近，让「万一」说得更响。

再说一件很小、却很管用的东西：屏幕摆在哪里。

你下次进诊室，看一眼桌子。医生的屏幕，多半在桌子的一角，侧着或正对着医生。你坐的位置，看得见他的脸，看不见屏幕；或者看得见屏幕，看不见他的脸。两个人之间，隔着一块发光的东西。

这块屏幕的位置，是谁定的？多半不是周岚。是装修时就定好了的，是为了方便接线，是为了让病历系统的一个口子对得上。

可是它每天都在决定：谁看谁，谁的眼睛朝哪边。

土，有时候不是抽象的规则，是一张桌子的摆法。

有些地方开始试着让机器把问诊录下来，自动整理成病历，各地做法不一。这也许能让医生的眼睛从屏幕上抬起来一点。不过它有没有把读数挪出前排，要看那张表还在不在。机器可以帮忙减负，也可以把同一套规矩，更快、更密地贴到每一个号上。

本书先把话说到这里。医生、病人、AI 三方怎样坐到同一把锯上，是第 16 章的事。眼下只记一句：机器进来以后，锯子上的力，不会变少，只会变得更细、更快。

◆ 八、一个完整的例子：一张单子走完它的一天

把三样症状，用一张单子串起来，看看它们怎样互相咬着。

周三早上，周岚面前坐着一位五十出头的男人，叫老程，说是胸口闷了两天。她问了，查了，没发现明显的问题。老程说：「医生，我怕。我哥就是这个年纪走的。」

周岚听见了这句话。她知道，老程要的不全是一张单子，是有人告诉他：别怕。

可是这一天她已经看了二十多个号。她知道，要让老程不怕，得坐下来，聊他哥，聊他这两天睡得怎样，至少要 20 分钟。她没有 20 分钟。

她开了心电图，开了抽血，说：「先查，查清楚，你心里踏实。」

这一句，对，也不对。

对：查清楚，是真的会踏实一点。不对：她心里明白，老程的怕，不会被一张心电图带走。

老程做了检查，结果大致正常。他拿着结果回来，周岚说：「没事，放心。」老程说：「那为什么还闷？」周岚没有答案，说：「那再观察。」

两头都不满意。老程觉得：查了，没事，还是闷，到底什么意思？周岚觉得：查了，没事，我还要怎样？

这一张单子，走了一整天，花了钱，用了人，两边的怕却一点没少。

现在拿三个词来读它：

老程的怕，是一锅粥（本书叫它混沌态），没有分开，没有形状。周岚没有时间让它长出形状，用一张单子把它压住了。这是指标和号源的土在推。

单子开出去，是防御：对老程的「万一」，也对自己的「万一」。

单子的结果回来，数字正常，不过回写没有发生：老程的怕没有变，周岚的「有用」也没有来。这是倦怠添的一笔。

三样症状，在一张单子上咬在一起。你拆不开它们，也找不出是哪一样先动的手。

这就是「复合体的症状」。它不是一个症状叠着一个症状，是一个状态，在三处露了出来。

现在把那个周三，换一种过法。

假设那天上午，门诊少排了两个号，周岚多出 10 分钟。（这只是假设，用来看状态怎样换。）

老程说：「我怕。我哥就是这个年纪走的。」

周岚把笔放下，问：「你哥那时候，是什么样的？」

老程愣了一下，慢慢讲：四十九岁，晚上，什么征兆也没有。他是第一个赶到的。

讲了大约六七分钟。讲完，老程的肩膀松了一点。

周岚说：「你的闷，我先查一查。你的怕，我们另外记一笔。」

她还是开了心电图，还是开了抽血。单子一张没少。

可是这张单子和刚才那张，不是一回事了。刚才那张，是压：用一张纸，把一锅粥盖住。这一张，是看：怕已经长出了一个形状，叫「哥哥」，叫「四十九岁」，叫「没有征兆」，这个形状可以被放在桌上，被认真对待。检查结果回来，老程听到的，也不只是一个「正常」，是有人替他的哥哥、替他的怕，一起看过了。

单子一样，状态不一样。

这里要停一下，说一个容易误会的地方。

有人读到这里，会想：那医生多花 10 分钟就好了。事情不是这样简单。10 分钟谁来给？这 10 分钟，会不会挤掉后面一位病人的 10 分钟？如果每个人都要 10 分钟，这家医院一天要接多少人？

这些问题，本书回答不了，也不替任何人回答。本书想说的只是：在一个固定的号源里，10 分钟的位置怎么分，是一个复合体层面的问题，不是某一位医生「肯不肯」的问题。有的号需要 10 分钟，有的只要三分钟。制度里要是没有地方让医生按需要来分，每个医生每天就得偷偷地、带着愧疚地，从别处挪时间。

挪来挪去，倦怠就在这里长出来。

要看清的是，这 10 分钟，不是周岚多了什么本事，是复合体的土挪出了一小块。月底的表还在，那条线还在。不过在这 10 分钟里，路能走一步，回写能进一点。

这也是为什么本书一直说，状态是可以转换的。

三个月后，老程又来了一次。他不是来看胸口的，是来拿药的。他进门，随口说了一句：「医生，我那天说我哥的事，你还记得啊？」

周岚说：「记得。」

老程笑了笑，说：「那天回去，我跟我老婆讲了。讲了一晚上。」

就是这么一句话，没有任何指标可以记录。可是这是一次真实的回写：那 10 分钟里长出来的一个形状，回头走进了一个人的家里。

◆ 九、只看一端会怎样

三样症状放在一起，你会发现，各种办法大多只抓住了其中一端。

第一种，只修医生。给医生开减压课，教冥想，倡导奉献。这些都有用，能让一个人少受点苦。不过课上完，他回到同一间诊室，同样的号，同样的表，同样的提心吊胆。人是松了一点，土没动。

第二种，只盯医生。每出一件事，就追问这个人哪里没做好。追问是应该的，可是当追问成了唯一的办法，医生为了不被追问，单子开得更多，字写得更满，话说得更少。盯得越紧，防御越厚。这不是谁的恶，是锯子又绷紧了一圈。

这个循环，从外面看，像是「医生越来越不负责任」；从里面看，是「医生越来越怕」。同一件事，两种读法，决定了你会去修哪一头。

第三种，只劝病人。「请理解医生」，「请多一点耐心」。这也是只看一端，只不过换了方向。它把另一头也当成了要修的那一端，两头都被要求自己改。

病人其实也是被叫号的人。他清早排队，抽一个号，坐在一排椅子上，听一块屏幕念自己的名字。他进门的时候，已经等了一两个小时，心里的话在椅子上反复排练过。门开了，三分钟。

他有没有不耐烦？有。他知道医生也累吗？多半知道。不过知道，改变不了他排了一个多小时的队。「请体谅」三个字，对一个刚排完队的人，是一个很重的要求。

第四种，只改制度。把表改一改，把号放一放。制度是土，土要动。可是只改土，不看两头在这块土上养成的习惯，新的表发下来，旧的怕还在，新的数字很快又变成新的线。

有人把这一种看得最重，觉得制度一改，全盘皆活。制度确实是大头，本书不轻看它。只是习惯有它的惯性：一个人在旧土上走了很多年，换了土，手上还留着旧土的力道。改制度和养习惯，是两只脚，缺了哪一只，都走不快。

四种做法有一个共同点：都先假定，问题在一处。

问题在一处，就修这一处；问题在复合体里，就要找复合体里的回写——哪一条路断了，哪一处土被抽干了，哪一个读数占了不该占的位子。

这不是说个人层面的帮助没用。有用，只是不够。修医生那一头，要同时问另一头：病人的那一头，在这个门诊里，能把什么交出来？

还有一种更容易被忽略的只看一端：只等一个好医生。

新闻里总有那么一两位，几十年如一日，有耐心，有温度，被写成榜样。榜样值得敬，不过一个行当不能靠榜样活着。每一个榜样的背后，都有一小块别人没有的土：多一点时间，多一点信任，多一位肯替他分担的同事。把榜样当成标准去要求所有人，是把一块特殊的土，当成了人人都有的土。

◆ 十、不写成控诉：三句要说在前面的话

写到这里，有三句话，要说在前面。

第一句：追责仍在。复合体生病，不是责任稀释。有人失职，就要问；有人受了伤害，就要认。追责本身，是修复的一部分。

追责的样子，也值得多说一句。有的追责是往前走的：这件事怎么发生的，哪一处能改，下一次怎么不再这样。有的追责只是往回指的：是谁，该罚谁。前一种追责，把复合体整个拿来看；后一种，只抓住一只手。两种都叫追责，修复的力气，差得很远。第 15 章会专门谈这件事。

第二句：不替谁开脱。说医生端的症状是复合体的症状，不等于说医生什么都没做错。本书只是说，仅凭「他做错了」，还不够把事情说完。

第三句：医生也是病人。

周岚去年发过一次高烧。她没去自己的医院，去了隔壁的一家。她挂号，排队，进门，医生问：「哪里不舒服？」手在键盘上。

她差点脱口而出：「你先看我的血象。」

后来她自己也笑，这句话，正是平时病人最让她头疼的那一种。可是在那一刻，她要的东西和每一个病人一模一样：要被看见，也要快一点。

位子是会换的。同一个人，在诊室里是医生，在父亲病床前是家属，发烧的那天是病人。如果「医生位的毛病」是医生这个人身上的东西，那她换个位子，毛病该跟着走。不过不是，她换了位子，那种急，那种怕，一起换了位子。

这就是状态：它属于那一把锯，不属于抓着锯的那只手。

这里还可以顺手分清两种话。

一种话是控诉：「医生就是这样的人。」它给一个人定了性，然后把他放到一边。

另一种话是描述：「在这样的号源、这样的表、这样的怕里，医生会这样做。」它没有给任何人定性，却把能动的地方，一处一处点了出来。

控诉让人解气，描述让人有处下手。本书写的是后一种。解气是一时的，下手是长久的。

还有一层，是写给医生看的。你要是医生，读到这里，也许会觉得被理解了一点。请不要停在这里。被理解只是第一步；第二步是看看自己手里，有没有哪一个动作，正好把锯条绷紧。

也有一层，是写给管理者看的。你要是管着一家医院、一个科室，读到这里，也许会觉得，本书是在说你。本书不是。表要不要，线怎么画，你比谁都清楚它背后的难处。本书只想提一个问题：这张表上的每一行，有没有一行，是用来回写的？也就是说，它的数，有没有一次，回头改过诊室里的一个动作？

没有回写的指标，是账。有回写的指标，才是路。

管理者的难处，本书也不绕开。表是上面要的，上面也有上面的表。一家医院夹在中间，往往只有两个选择：照表做，或者不被表认。没有人愿意落到后一个选择里。

所以这一层，也是复合体——只不过比诊室更大的那一个。第 15 章会接着走一步，看看修复的点，到底可以放在哪些地方。

◆ 十一、放回日子里

回到周二的上午。

第 31 个号，那位讲了四分钟儿媳的老太太。如果让你替周岚做个决定，你会怎么做？

本书不替周岚决定。一个人的一个上午，改变不了月底的表，也改变不了谁来担责。复合体的修，是往后三章要谈的事，不是一个上午的事。

但有几件小事，明天就能试。

你是病人的时候：进诊室前，在手机里打一行字，「今天我最想让医生知道的一件事」。进门第一句，就说它。不是为了体谅医生，是给复合体一个能抓住的开头。

你是医生的时候：每天挑一个号，在眼睛移到屏幕之前，先看病人的脸两秒。只试一个，不用天天都做。

你是一家人的时候：下次家里有人说「医生不负责任」，先停一下，问一句：「他那天，大概有多少个号？」不是为了替谁说话，是把那根锯条的热，看见。

那天傍晚，周岚回到家，豆豆趴在桌上写作业，周老师在厨房煮粥。她在门口站了一会儿，忽然想起老太太汤里那一勺酱油。她给老太太的社区随访本上，补了一行字：下周来，先聊儿媳。

她没有改变月底的表。可是那一行字写进去，下周的第一句话，有了一个开头。

还有一件事，她也试了。

第二天下班前，她在护士站，跟同科的小陈说：「今天最难的一个号，是第 31 个，一位讲儿媳的老太太。我没处理好。」

小陈说：「我今天也有一个。」

两个人站在走廊里，各讲了三分钟。没有谁给谁出主意，没有谁说「你应该」。讲完，两个人各自回去。

这就是一个最小的、没有名字的巴林特。它没有改变那条线，不过那个让人发堵的号，不再只压在一个人肩上。

最后一句，说给所有人。

身体或心里的难处真的大了，请找医生或心理咨询师。医生自己的倦怠重了，也一样：找人说，别一个人扛。

带 走 的 话

医生端的倦怠、焦虑和多开的那张单，是一把锯两头互相绷紧时，医生这头先冒的热。

小　账

这一处，开门还是关门：开门。把医生端的症状从「医生的私事」里拿回来，修复才有地方放；若只当成素质问题，门就关了。

病放在一个人身上，还是放回复合体里？放回复合体。倦怠是回写断了，指标焦虑是读数占了前排，多开的单是两头互相防着，三样都不属于哪一只手。

想 一 想

你最近一次对一位医生生气，是在什么时候？如果把那一刻，换成「他那天有多少个号」，你的气会往哪里走？

你干的这一行里，有没有一张「月底的表」？它有没有替你看过人？

下一次你走进诊室，在说第一句话之前，能不能先看一眼桌上的那块屏幕：它摆在谁的那一边？

◆

14

第 14 章

痛则不通：复合体卡在哪一维

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你从诊室出来，手里捏着一张方子，心里还有一句话没说出口。

不是忘了说。是你在里面的时候，那句话还没有长成一句话。它只是一团东西，堵在胸口。医生问你：「哪里不舒服？」你说：「就是……不太对。」医生又问：「疼，还是晕？」你想了想，说：「也不算疼。」

后面还有人在等。你把话咽回去，拿了方子，走了。

回到家，药放在床头柜上。第一天你吃了，第二天你记得，第三天你忽然想：这药，吃的到底是我那团东西吗？

这样的事，周老师也有过。

周老师六十二岁，教了一辈子语文，如今退休在家，血压高了多年。那天他去社区医院，坐在女儿周岚同事的诊室里，说：「头里面有点不对。」

「头晕？」医生问。

「不是晕。」

「头痛？」

「也不是痛。」周老师想了想，「就是像……像下雨前的屋子。」

医生笑了笑，没有恶意：「这个我得查一下。」他开了单子。

周老师拿着单子出来，在走廊的长椅上坐了一会儿。他教了几十年语文，一辈子在帮学生找「准确的词」，轮到自己，一个词也没找到。

他觉得有点丢人。可他也说不清，是自己没说好，还是那间屋子里，根本没有一个地方，能放下「下雨前的屋子」。

这一章要问：这句话卡在了哪里？

那天晚上，周老师没跟女儿说。他想，说了也是添麻烦：周岚在医院里一天听几十个人说话，回家还要听父亲说「像下雨前的屋子」，像什么话。

周岚这头，也有她的一份没说出口。她看见父亲回来时没有平时那种话，她想问，又想：他自己会说的。

一个屋子里，两个人，各自没说。

这是一个很小的卡。小到没有人会把它叫作「问题」。可复合体的痛，多半从这么小的地方开始。

◆ 二、一句老话：痛则不通

中医里有一句老话：通则不痛，痛则不通。常有人说它出自《黄帝内经》，不过原书里并没有这句现成的话，只有讲同一类道理的篇章；这句话的明确说法，一般追到明代李中梓的《医宗必读》（大意如此）。

意思说起来不难。一个地方堵住了，淤住了，不流了，就痛。流通了，就不痛。

先说老话对在哪儿。

身体上的堵、淤、卡，确实是痛的一种常见的样子。民间的话也这样说：疏通了，就舒服了。这是一个看了几千年的形状。

本书借它的形状，不借它的药。本书不谈任何一味药、任何一种手法，只借这句话里的一个看法：痛，是流不动。

王德生博士把这句话，从身体搬到了复合体上。身体会痛，因为身体里有一处不通。「医生—病人」这个互动复合体也会痛，因为复合体里有一处不通。

复合体的痛，听上去不像痛。它听上去是这样的：

病人说：「我都说了，他怎么还不明白。」

医生说：「我都讲了，他怎么还是不照做。」

两头都在说「我都说了」「我都讲了」，两头都觉得自己已经尽力。这句话，就是复合体痛的声音。

为什么说这是复合体的痛，不是一句比喻？

因为痛有一个特点：它是一种读数，读的是「这里不流了」。身体上的痛，读的是身体里哪一处不流；复合体里的痛，读的是两个人之间哪一处不流。两头都能读到，两头都觉得难受，而且难受的样子，很像：都觉得委屈，都觉得对方没出力。

一个人觉得委屈，可以是他自己的事。两个人同时觉得委屈，而且委屈的话几乎一样，那就不是各自的事了，是这把锯卡了。

痛则不通。那么，是哪里不通？

先把「通」字说清楚，免得读成别的意思。

通，不是一团和气。两个人吵得清清楚楚，把话都摊在桌上，是通的。两个人笑眯眯，什么都不说，反而是不通的。

通，也不是快。流得慢的水也是通的，慢的是水势，不是水路。

通，是东西能从这一头走到那一头，又能从那一头走回来。

本书的回答，借用前面几编已经用过的三个词：形状、路、土。复合体在三处最容易卡：

第一处，说不出。病人的苦，没有长成一个能被读的形状。

第二处，读不懂。医生手里的知识，没有接上这具身体走过的路。

第三处，回写不进。方案开出来，没有在病人的日子里发生。

三处卡，三个场景，三件明天能试的小事。下面一处一处看。

◆ 三、本书的说法：一条要走通的路

先把整条路画出来。

复合体想要通，要走三段：

病人的苦，先要长成一个形状，能说出来；这个形状，要被医生读懂，接到这具身体自己的路上；读懂之后开出的方案，要走回病人的日子，在那里发生。

三段，哪一段断了，复合体都会痛。

借拉大锯的画面说，这三段是一来一回。

锯往前去的时候，是苦变成形状，形状被读到。锯往回来的时候，是读到的东西变成方案，方案走进日子。去的时候，锯齿要咬住木头，咬不住，就是说不出、读不懂。回的时候，锯末要能退出来，退不出，锯口就堵，就是回写不进。

一去一回，是一整个来回。少了哪一半，锯都拉不动。

这和老看法不一样。老看法里，这条路是单向的：病人把症状交给医生，医生把方案交给病人，各管一头。哪一头没做好，就怪哪一头：病人说不清，是病人表达差；医生读不懂，是医生水平低；方案没做，是病人依从性差。

三个「差」，各放在一个人头上。

本书的看法是：这条路上的每一段，都不是一个人走通的。

苦长成什么形状，一半看病人怎么说，一半看医生怎么问、怎么听；同一团东西，遇到不同的问法，会长成不同的话。读懂与否，一半看医生，一半看病人交出了多少这具身体的来路。方案能不能发生，一半在方案，一半在日子，而日子里的东西，只有病人知道，只有病人和医生坐在一起，才能放进方案里去。

所以每一段，都是两头一起拉的。哪一段卡了，卡的是锯口。

这是本章的第一句判断：

复合体的痛，是三处不通：苦没有转成可读的形状，知识没有接上这具身体的路，方案没有在日子里发生。

注意，这里没有「谁的错」。有「哪一处卡」。找到哪一处卡，才知道从哪里下手。

再交代一句三个词和三处卡的对应，免得绕。形状，是一件东西从模糊变清楚的样子；路，是一先一后走出来的次序；土，是让路能走、让形状能长的那片地，方案要在日子里发生，靠的正是土。所以：说不出，是形状没长出来；读不懂，是路没接上；回写不进，是土没收。

为什么说「三处」，不说「三种」？因为它们不是三种并排的毛病，是同一条路上的三个位置。一次门诊，三个位置都要走过。

◆ 四、第一处卡：说不出

先看第一处，说不出。

美国精神科医生、人类学家凯博文（Arthur Kleinman）在《疾痛的故事》里分出过两个词。一个是病人经历到的难受、苦楚，一个是医生用医学概念写下的疾病（The Illness Narratives，1988，大意如此〔核：大意〕）。前者是活在日子里的，后者是写在病历上的。两样东西，常常不重合。

周老师的「下雨前的屋子」，是前一种。医生要的「晕」「痛」「麻」，是后一种。

要从前一种变成后一种，中间有一座桥。桥的名字叫「说」。

可是这座桥，不是病人一个人搭的。

看看周老师那天的对话。医生问：「晕？痛？」两个选项，周老师都不是。他本来想说的话，像一团湿棉花，医生这一问，棉花被切成了两块：晕块，痛块。他找不到属于自己的那一块，就只好沉默。

不是周老师不会说，是那间屋子里，没有一个问法，能接住那团东西。

再换一头看。周岚在诊室里对病人说：「这个有点炎症，开点药，消一消。」在她嘴里，「炎症」是一个有边有沿的词。不过听的人听成了：「又是发炎。」「炎」是个什么东西？在哪里？为什么总是它？这个词，在听的人那里，是一团新的、没有形状的东西。

所以说不出，不只是病人的事。医生也有说不出的东西：那些看到了、知道了，却没转成病人听得懂的话的东西。

有一次，周岚给一位年轻人看体检单。单子上有一行字，是医学上很常见的一个词，听上去比它实际的意思重得多。年轻人盯着那行字，脸色一点点变了。

周岚说：「这个很常见，不用太担心。」

可是「不用太担心」这五个字，对一个已经被吓到的人，是没有形状的。他听进去的，只有那行字。

周岚后来想明白了：她没有把「为什么常见」说出来。她知道，不过她没有把知道的东西，转成一个年轻人能拿在手里的形状。比如：它大致是怎么回事，常出现在哪些人身上，什么时候才需要再看。

她那一刻说不出，不是因为不知道，是因为门外还有人在等。

两头都有一团，两团东西隔着一张桌子，谁也读不到谁。

这里有一个细处，容易被漏过去。

「说不出」的时候，人往往不是真的没有话。他有一大堆话，可是每一句拿出来，都觉得不对。你替他说「是不是胸闷」，他说「也不是闷」。你说「是不是乏力」，他说「比乏力还多一点」。他不是在为难你，是那团东西本来就没有现成的名字。

所以真正的第一步，常常不是「找到准确的词」，是允许那团东西，先以不准确的样子说出来。「像下雨前的屋子」，不准确，不过它是一个起点，从这里，才能问出下一句：什么时候来？几点最重？

不准确的形状，比没有形状好。

还有一个细处：门诊的第一句话，往往就是「哪里不舒服」。

这句话很自然，可它悄悄设定了一件事：难受是有「地方」的。你一问「哪里」，病人就去找一个「哪里」。周老师那样的「下雨前的屋子」，没有地方，只有天气，被这一问拦在了门外。

换一种问法，会引出另一种形状。比如：「这几天，是怎么个不舒服法？」或者：「你最想让我知道的是什么？」问法一换，同一个人说出来的话，就不一样。

所以形状不是病人一个人长出来的。一半长在他嘴里，一半长在医生的问法里。

这就是第一处卡。苦没有转成可读的形状。

明天能试的小事：三句话。

进诊室之前，替自己的难受想三句话：像什么？什么时候来？什么时候走？不用是医学的词。「像下雨前的屋子」，也是一句好话。「每次吃完饭就来，躺下就好些」，也是一句好话。

如果你是医生，可以试着倒过来：把你要说的结果，用一个比喻说一遍。「这个数字，像水管里有点积垢」。不求准确，求听的人，手里有个东西可以拿。

举几个例子，看看三句话怎样用。

一位总睡不好的阿姨：像什么？像脑子里有一台关不掉的收音机。什么时候来？夜里一两点最响。什么时候走？天快亮的时候，才慢慢小下去。

一个总咳嗽的孩子的家长（比如豆豆的妈妈）：像什么？像嗓子里有一根小羽毛。什么时候来？睡下去以后，躺平就咳。什么时候走？起来坐一会儿，就轻一点。

一位说不清哪里难受的中年人：像什么？像胸口压着一件湿衣服。什么时候来？开会前，或者堵车的时候。什么时候走？回到家，换了鞋，就松了。

这些句子，不是医学的词，也不是诊断。可是它们是形状：有边有沿，可以被问下一句。医生拿到「躺平就咳」，比拿到「咳嗽」多了一条路；拿到「开会前或堵车的时候」，比拿到「胸闷」多了一块土。

三句话的用处，不是替医生做诊断，是替那一团东西，先搭一座小桥。

◆ 五、第二处卡：读不懂

第二处，读不懂。

读不懂，不是医生不聪明。是医生手里的知识，和这具身体走过的路，没有接上。

医生的知识，是人群的路：成千上万的人，走过什么样的路，大致到哪里，最常出什么事。指南、药典、教科书，写的都是这个。这是很宝贵的东西，没有它，医生什么也做不成。

不过每一具身体，也有自己走过的路。

周老师的路，是这样的：血压高了八年，换过几次药。有一次吃了一种药，嘴里干得厉害。他没有跟任何人说，悄悄换成了女儿从另一家药房带来的。这件事，他女儿周岚也是前阵子翻抽屉才知道的。

这件事，病历上没有。

所以医生看到的，是一份「高血压多年，控制尚可」的记录。他看见的是人群的路，他读不到这具身体的路。

同一个数字，放在不同的路上，意思是不一样的。一个人一直是一百三，忽然到了一百五，和一个人一直一百六，今天一百五，说的不是同一件事。（这里只讲读法，不涉及怎么看数字，更不涉及怎么用药；药怎么吃，听医生的。）

有一个学科方向，叫叙事医学，是哥伦比亚大学的丽塔·卡伦（Rita Charon）提出的（2000 年代前后，大意如此〔核：大意〕）。她说医生要学会「听故事」：听病人怎么讲自己的病，从哪里讲起，漏掉了什么，用什么词。这些，不是闲话，是这具身体的路。

可是门诊只有几分钟。

周岚有时候想：我也想问「之前呢」，不过我一问，后面就多一个人等了。

所以读不懂，不是读的人偷懒。是复合体的土里，没有留出让路被走出来的那一段时间。

有意思的是，周岚读不懂自己的父亲。

她是医生。她知道血压、药、指南。可是她在父亲换药这件事上，整整瞒了几个月才发现。父亲不是不告诉她，是他觉得，女儿是医生，这种小事，说了像是在质疑她的医嘱。

她手里有一整套知识，不过没有接上父亲这一条路。她读得懂人群，读不懂他。

这一点很值得停下来想：读不懂，不是知识不够。知识再多，没有接上这具身体走过的路，就是一张没有标注的地图。

反过来，周老师有他自己的路，却没有一张能把路画出来的纸。他没有想过要把换药这件事写下来，递到谁手里。他的路，只存在他自己的记忆里，一旦记忆里的那一天过去了，就没有人知道。

两头各有一半。一半是地图，一半是路。要对上，得把两半放在同一张桌子上。

读不懂，还有一个相反的方向：病人也读不懂医生。

周老师有一回听医生说：「你的血压控制得还可以。」他回家对周岚转述：「医生说我还可以。」周岚听了心里咯噔一下。「控制得还可以」的意思，是一直吃着药、一直在盯着，数字才在这个位置。在他嘴里，却成了「我还可以」，仿佛一件事已经过去了，可以放松了。

同一句话，医生的路上走过去是一个意思，病人的路上走过来，成了另一个意思。

所以读，是两头一起读：医生读病人的路，病人也读医生的话。医生说完一句，如果能问一句「这句话，你听下来是什么意思」，就把对不上的那一点，提前摸了出来。

这就是第二处卡。知识没有接上这具身体的路。

明天能试的小事：

病人这一头：带一张纸，纸的名字叫「我的路」。上面写几行：这几年吃过什么药，哪一次不舒服，哪一次自己停过什么，什么时候开始的。不求全，三五行就行。这张纸不是替代医生的判断，是把你的路，递到他手上。

医生这一头：在开口说方案之前，问一句：「之前呢？」只问这一句，听三十秒。

路断的地方，还有一个常见的位置：换了地方看病。

从社区医院到大医院，从这位医生到那位医生，病人每换一次地方，都要重新讲一遍自己的路。每一次重讲，都会丢掉一点：哪一年吃过什么药，哪一次住过院，哪一次自己悄悄停了药。讲到第三遍，故事已经短成了一行病历摘要。

这就是为什么第二意见、复诊，在本书看来不是纠错，是重新起头（第 8 章）。每一次起头，都是路被重走一遍的机会。要紧的是，别让路在转手的时候被剪短。

一张「我的路」，就是替这条路，留一份底稿。

◆ 六、第三处卡：回写不进

第三处，回写不进。

方案开了。纸上写得清清楚楚：每天饭后走一走，少放盐，按时吃药。病人点了头：「好，我记住了。」

三个月后复诊，原样。

老看法有个词，叫「依从性差」。意思是，病人没有照着做。这个词听上去，像是在说：问题在病人身上。

先说它对在哪儿。有时候，确实是病人没做。病人说「我会做」，其实心里没打算做，或者做了三天就放下了。这样的情况，不能只怪环境。该负的那一份，病人要负。

医生这一头，也有一个相应的习惯：宣教。该交代的都交代了，一条条念完，让病人签字。这是对的，也是一种保护。可是念完不等于发生。念得越完整，越容易让两头都觉得：我已经尽到了。

「我已经尽到了」，是复合体痛的另一句声音。

不过看看周老师的日子。

早上，他要送豆豆到校门口。回来买菜。中午午睡一小时，这是多年的习惯，睡不够下午会头昏。下午，周岚下班前，他要把晚饭备好。晚饭后，豆豆要写作业，他在旁边看着。

医生说：「饭后走一走。」

饭后，他在陪豆豆写作业。

方案是写在纸上的，日子是长在土里的。纸，写不进土。

周老师头两天试过。吃完晚饭，他把碗一放就出门，在小区里走了 20 分钟。可是豆豆的作业没人看，周岚下班回来，发现孩子趴在桌上睡着了，本子上留着半页没写完的字。

第三天，他就不走了。

他没有跟任何人说为什么。下次复诊，医生问：「有没有每天走？」他说：「没有坚持下来。」

这一句话，在病历上会被读成什么？「依从性差」。

不过它真正的样子是：一条方案，撞上了一个外孙的作业，撞上了一个下班晚的女儿，撞上了一个老人心里「孩子比我重要」的排序。这些，都是土。方案是写在纸上的，纸上没有这些。

要写进去，得有一个入口：这一条方案，放在他一天的哪一个缝里，不拆掉别的东西？没有人问过他。方案是在医生的桌上写完的，日子是在他家里过着的，中间没有一个人，把两样东西拿到同一张桌子上。

入口这个词，要多说一句。一条方案，像一把钥匙，日子像一扇门。钥匙再准，也要对着锁孔。这一把钥匙应该对着一天里的哪一个孔，只有住在那扇门里的人知道。

医生可以告诉他，钥匙长什么样；只有他，可以说出锁孔在哪里。

回写这条路，还有它的另一头：医生怎么知道，方案去了哪里？

多数门诊里，方案开出去，就像一封信投进了邮筒。下次见面，医生看到的是几个数字，不知道信有没有拆开、拆开以后撞上了什么。

一个小办法，是复诊时的第一个问题，不问「怎么样」，问「上次说的那一条，后来是怎么样的」。「怎么样」是个大口袋，谁都可以答「还行」。「上次那一条」，指向一个具体的东西，病人只能答一件具体的事：做了，没做，做了一半，换了个做法。

这一句答案，就是回写。有了它，下一轮的方案才不是凭空开的。

这就是第三处卡：回写不进。复合体里最后一段路，从方案走回日子，断了。

断在这里的一个后果是，医生看不到方案去了哪里。他下次见到的，是一个「没有变化」的数字。他会觉得：我说了，他没做。病人会觉得：我也想做，可是做不到。两头都带着一点委屈。这一点委屈，又回到第 13 章那条路上，成了倦怠的一部分。

明天能试的小事：

把方案里的一条，钉在日子里已经有的一件事后面。不要「饭后走一走」，要「送完豆豆回来的路上，多绕一段」。选一条，不求多。

医生这一头：说完一条方案，问一句：「这一条，放在你一天的哪个位置？」让病人说，你听。有时候他说的位置，比你想的好。

医院里常有印好的健康教育单页，一页纸，条条清楚：饮食怎样，运动怎样，几点吃药。这样的单页，有用，也有它的限度：它是写给「人群里的一个人」的。拿到手里的那位，有自己的早晨和自己的外孙。

所以单页发下去以后，最缺的不是第二张单页，是医生手里那一句追问：这一条，在你家里，会撞上什么？

病人说的那件事，才是真正的方案入口。

◆ 七、三处卡是连着的

三处卡，不是三个独立的故障。它们连在一起，像一根管子上的三个弯。

说不出，读不懂。病人没说成形状，医生读不到这具身体，只能按人群的路去读。

读不懂，回写不进。没读到这具身体的路，开出来的方案，就按人群的日子写；人群的日子，不是周老师的日子。

回写不进，又倒回去让下一轮更说不出。病人试过一次，没有用，下次来，他连试着说的力气，也没有了。

所以复合体一旦卡住，往往不是卡在一处，而是三处互相拉着。

大致说来，初次来看的时候，常卡在前两处：话还没成形，路还没接上。病拖得久了，天天吃药、月月复诊，常卡在最后一处：说了，读了，方案也开了，就是进不了日子。（这是粗略的观察，不是规律，〔待验〕。）

所以同一个病人，不同的阶段，疼的位置会换。今天疼在这一处，明天未必还在。

那么从哪里下手？

三处，哪一处都可以起头。本书给一个办法：起头的地方，就是最痛的那一处。

起头不用大。比如这一次门诊，只试一件：问一句「之前呢」，或者听一句「下雨前的屋子」。小到当天就能结束，才容易在第二天再来一次。

复合体的通，不是一次大修出来的，是很多次小小的、没有人注意的通，一点一点攒出来的。

如果你最近一次，心里想的是「我已经说了很多遍了」，那是第一处。如果你想的是「他怎么就是不明白」，那是第二处。如果你想的是「我都开了方案，他不做」，那是第三处。

从最痛的那一处，找那件明天能试的小事。

有一个小小的诊断办法，不用任何仪器，只用你自己的一句话。下次从诊室出来，或者在诊室里坐下之前，听一听自己心里冒出的第一句话：

「我还有一句没说出来。」是第一处。

「我不确定他懂没懂我。」是第二处。

「回家我可能做不到。」是第三处。

三句话，各指一处。冒出哪一句，就是哪一处在疼。

医生也有自己的三句话。

「他没说清楚。」是第一处。

「我讲了，他好像没听进去。」是第二处。

「我都开了，他不做。」是第三处。

注意这几句的主语。每一句里，都有一个「他」，和一个「我」。可复合体的痛，不在「他」身上，也不在「我」身上，在「他」和「我」中间的那一段没有流过去。

还有一件事，要说清楚。通了，不等于病好了。「痛则不通」这句话，不能倒过来读成「通了就没有病」。本书说的通，只是复合体里的东西，又能流动起来：话能说成形，路能被读到，方案能走进日子。身体上的病，还是要由医学去治。

◆ 八、一个完整的例子：下雨前的屋子，复诊那一天

回到周老师。

那天回家，他没有跟周岚说医生开了什么。他说了一句别的：

「我今天，在医生面前，一句话也没说准。」

周岚一听就愣了。她当医生这么多年，每天听到病人说「我也说不清」，从来没有想过，自己的父亲也会这样。

「爸，那你想说什么？」

「下雨前的屋子。」周老师笑了，「闷，低，窗子都关着，人在里面，什么事也没有，就是不想动。」

周岚没有反驳他。她拿出一张纸，写下来：

闷，低，像下雨前。

什么时候来：下午三四点，午睡起来之后。

什么时候走：晚上陪豆豆写完作业，就轻一点。

周老师看了一遍，说：「就这样？」

「就这样。」周岚说，「你拿给医生，不用解释。」

两周以后，复诊。周老师把那张纸递过去。医生看了，问：「这个下午三四点，是睡醒起来就这样，还是起来以后一会儿才这样？」

周老师说：「起来以后一会儿。」

医生又问：「之前呢，这几年有过类似的时候吗？」

周老师犹豫了一下，说起了那次换药，嘴干。他第一次把这件事说给医生听。

医生说：「这件事很重要，我给你记下来。」

接着医生问了一个问题，是周老师没有想到的：「我开的这些，你一天里准备放在什么时候？」

周老师说：「早上送完孩子之后吧。」

医生点点头，在方案上改了一行。

就是这样。三处卡，各松开了一点，没有谁多了不起的本事，只有一张纸，一个「之前呢」，一个「放在哪里」。

这一次门诊，也没有比平时更长。多出来的，是三句问话，大约两分钟。

再往后的三个月里，周老师的日子，起了一点点变化。

「送完豆豆绕一段」这条，他做到了。不是每天，一周里有四五天。有两天下雨，他没去，也没觉得自己做错了什么。因为医生那天说过：「做得到的天数，比一天不落更要紧。」

他再去复诊，医生说：「你这个『下雨前的屋子』，最近有没有变？」

周老师想了想，说：「变了一点。不是没有了，是屋子的窗开了一条缝。」

医生在病历上，没有把这句话翻译成别的词，原样写了下来。

周岚把这件事，也记在了心里。

那个周日，她问父亲：「爸，你上次换药的事，我后来想了很久。你当时为什么没跟我说？」

周老师沉默了一会儿，说：「你是医生。我怕你觉得，我不信你。」

周岚的眼睛热了一下。她没有说「爸，你应该」，她说：「下次你嘴里不舒服，先跟我说一声，不用管我怎么想。我不会觉得你不信我。」

「好。」周老师说。

这一句「好」，不是承诺，是一座小桥，刚刚搭上去一块板。以后会不会走，要看下一次。

三处卡，一次松一点。没有一次松到底。不过松开的每一点，都是复合体里，一条路又能走一步了。

这一页病历，就和以前不一样了。前面是数字，后面跟着一句周老师自己的话。

下一个医生翻到这里，读到的就是这具身体自己的路。

话说回来，这个故事没有圆满收场。

半年后的一个秋天，周老师有几天不太舒服，他没有跟任何人说，心想：老毛病，扛一扛就过去了。等周岚发现的时候，已经拖了五六天。

她没有怪他。她坐下来，问：「爸，这几天，像什么？」

周老师说：「像下雨前的屋子，不过这次，窗子关死了。」

两个人对视了一下，都没有笑。

三处卡松开过一次，不等于永远松着。卡，是会回来的。所以「通」不是一个终点，是一个要一次次接着走的状态。第 9 章说的悬着，在这里也一样：路通着的时候，是悬着；通了就放手，反而会重新锁死。

那天，周老师去了医院。身体上的事，交给医生。

这不是说，复合体一次就通了。通，是一次次的复诊里，一点点松开的事。本书第 9 章说过，复诊是状态一次次转换，这一次，转换往松的方向走了一步。

◆ 九、只看一端会怎样

三处卡，各有一种只看一端的修法。

只教病人表达。办「如何向医生描述症状」的讲座，发一张症状清单。有用，可是它把「说不出」当成了病人的技术不足。周老师教了一辈子语文，他的表达不差。他卡的，是那间屋子里没有位置，放他的「下雨前的屋子」。

只教医生沟通。学话术，学共情的三句模板。也有用，不过它把「读不懂」当成了医生的技巧问题。话术学完，门诊还是几分钟，路还是没有时间被走出来。模板用多了，病人听得出来，那是模板，不是在读他。

只盯依从性。给病人发提醒，装应用，打电话催。提醒是有用的。可是它把「回写不进」当成了病人的记性问题，却没人问方案和日子能不能对上。提醒响了，周老师还是在陪豆豆写作业。

再举一个小场景。有一家医院请来一位培训老师，教医生「五步沟通法」：问候，倾听，共情，解释，确认。医生们学得认真，回到诊室，一一照做。

病人听到「我理解您的感受」的时候，眼睛里闪了一下，又暗下去。他听出来了：这是第三步。

话术用得不对吗？没有不对。只是话术假定了一个前提：问题在医生的嘴上。嘴改了，土没改。听话的人，是在土里听的。

三种做法，各抓了一头，各解了一点。不过三处卡连在一起，只松一头，另两头会把它拉回去。

这不是说，这些做法该停。它们都该留着，只是要知道它们各自松开的是哪一处，另外两处，还要有人去松。

更要紧的是，这三种修法有一个共同的习惯：都把一个人放在「要被改的位置」上。教病人表达，是改病人；教医生沟通，是改医生；盯依从性，是改病人。三种做法里，没有一种问过：这张桌子，这间屋子，这几分钟的门诊，要不要改？

还有一种更深的只看一端：把三处卡全算在「沟通不良」头上。沟通，这个词太大了，装得下一切，也就什么都没指出来。本书不用它，用三处卡，因为每一处，都能对上一件明天能试的小事。

◆ 十、今天与机器：给苦找形状的人

今天的病人，进诊室之前，多半已经先找过一遍。

他拿着手机，把「头里面有点不对」打进去，出来一排结果。每一条都有一个名字，每一条都带着一个最坏的版本。

医生看见这一幕，容易觉得被挑战：病人拿着搜出来的东西，来质问我。

可是换一个角度看，这是病人在给「说不出」找形状。苦没有形状的时候，人最难受；搜到一个名字，哪怕是错的，也算有个东西可以抓。这是病人替那一团东西做的一次努力，是一次他一个人做的转形状的尝试。

问题是，那个形状是别人的。是人群的，是机器按人群的路给的，不是周老师的「下雨前的屋子」。

所以机器进来以后，三处卡不会自己松，只会换一种样子卡：说不出，变成了「说成了别人的话」；读不懂，变成了「读成了别人的路」；回写不进，变成了「照着屏幕做，不照着日子做」。

机器是新来的位子还是工具，是第 16 章的事。眼下只记一句：病人手机里的那个名字，可以当作开头，不要当作结论。医生可以问一句：「你搜到的这个，哪一条最像你？」

这样问的好处，是把机器搜来的东西，变回了病人自己的事。他会开始说：「这个像，不过我没有那个。」「这个不像，我是下午才这样。」一问一答之间，别人的形状被修改成了他自己的形状。

机器给的是一件现成的衣服。医生那一问，是让病人把衣服试一试，哪里不合身，哪里就是他自己。

◆ 十一、放回日子里

回到那张纸。

周岚把「闷，低，像下雨前」那张纸，夹进了父亲的复诊本里。她没有教父亲怎么表达，也没有教医生怎么倾听。她只是把一团东西，写成了三行。

后来她也在自己的诊室里，试了一次「之前呢」。那天的第 12 个号，是一位总说「睡不好」的阿姨。周岚没有问睡几个小时，问了一句：「之前呢，是什么时候开始睡不好的？」

阿姨愣了一下，说：「是我老伴走了以后。」

那是周岚上午最长的一个号，比平时多了五分钟。后面的人等得有点久。

可是她知道，这五分钟里，有一个形状，终于被说出来了。

阿姨后来又来了一次。她没有再说「睡不好」，说的是：「医生，上次讲完，我回去哭了一场。」

周岚没有说「别难过」，也没有开什么新的东西。她只是说：「哭了，好些吗？」

阿姨想了想：「好些。」

那一刻，苦有了形状，路被走到了，日子里也有了一点点变化。三处卡都还在，可是它们之间，有一条细细的线，通过去了。

把三件小事，并排放在这里，明天挑一件试：

一，进诊室前，替自己的难受想三句话：像什么，什么时候来，什么时候走。

二，带一张「我的路」：这几年吃过什么，哪次不舒服，自己停过什么。

三，说定一条方案以后，问或被问一句：这一条，放在一天的哪个位置？

不用三条都做。从你最痛的那一处，挑一件。

最后，说一句关于这一章的边界。

这一章写的是理解，不是办法大全。三处卡，三件小事，都是帮复合体多通一点的方式，不替代任何一次诊断，更不替代任何一次用药的决定。小事能做的，是让话说得更成形、路被读得更准、方案落得更实。病本身该怎么看、怎么治，仍然是医生的事。

通了的复合体，是一个更适合治病的地方，不是治病的替代。

身体或心里的难处真的大了，请找医生或心理咨询师。

带 走 的 话

复合体的痛是三处不通：苦说不成形状，知识接不上这具身体的路，方案写不进日子；挑最痛的一处，先通它。

小　账

这一处，开门还是关门：开门。把「沟通不良」拆成三处具体的卡，每一处都有一件明天能试的小事；若只说沟通不良，门就关上了。

病放在一个人身上，还是放回复合体里？放回复合体。说不出、读不懂、回写不进，每一处都要两头一起拉才通，不是病人差，也不是医生差。

想 一 想

你最近一次说「我都说了他怎么还不明白」，是在哪一件事上？卡的是说不出、读不懂，还是回写不进？

你有没有一句话，一直没找到合适的词？如果现在写三行（像什么、什么时候来、什么时候走），你会写下什么？

◆

15

第 15 章

复合体生病，责任在哪里

◆ 一、你一定有过这样的时刻

周岚在一场继续教育的讲座上，听到一句话：病不在病人身上，也不在医生眼里，在医生和病人这个互动的复合体里。她点了点头，笔记也记了。

散会往回走，她越想越不踏实。

上个月，科里出过一件事。一张药单上，剂量的小数点抄错了一位。药师核对时看出来，把单子退了回来。药没有发出去，人也没有事。

可是那天下午，整个诊区的空气像进了冷库。主任要一份说明。抄单子的年轻同事脸色发白，只说了一句：「我当时太赶了。」

有人在旁边小声说：「一个下午八十几个号，换谁都赶。」另一个人接了一句：「再赶，也不能抄错。」

两句话都对。周岚站在走廊里，两句都挑不出毛病。

她又想起讲座上那句话。如果病在复合体里，这张单子的错，算谁的？谁都不必担了吗？只要说一句「这是系统的问题」，大家就可以回家吃饭了？

她心里有一个很清楚的答案：不是。可她一时说不出，为什么不是。

这一章要答的，就是这个问题。

本书先把话说在前头，免得你读到后面才发现走岔了：「复合体生病」不取消任何人的责任。该追的仍然追，该认的仍然认。它改变的，只是追到哪里为止。

◆ 二、老看法：找出那个有错的人

先说老看法，因为它对在不少地方。

发现学的医学，追责的路数很干净。出了错，就去找：错发生在哪一步，是谁的手、谁的判断。找到了，这个人要认，要改，该受处分的受处分，该赔的赔。找不到，事情就悬着，所有人都不安心。

这条路有它的道理，至少有三条。

第一，它让受害的人有地方站。一个人因为别人的疏忽受了损失，他需要一个名字、一个说法，需要有人对他说「这是我们的错」。没有这一步，他的委屈无处安放。

第二，它让专业有边界。医生之所以被信任，是因为有一些事，他必须做到，做不到就要担。这条边界一松，谁都可以说「我尽力了」，信任就空了。

第三，它让下一次更小心。人知道自己要负责，手上就会多一份稳。

所以本书不说老看法错了。它在一个很具体的范围里完全成立：当错处确实出在某个人的某个动作上，找到这个人、让他认账，是对的，也是必要的。

那张抄错的药单，就在这个范围里。抄的人要认，要知道自己错在哪，要被提醒，该有的规矩要走。这一点，本书不让半步。

可是，老看法还有后半句，在这后半句上，它停住了：找到了那个有错的人，事情就算完了。

这半句话，是发现学的味道。它预设了一件事：错，是一个人身上的东西，像一颗坏牙，拔掉就好。人找到了，错就找到了；人处理了，错就处理了。

你想一想，那个下午八十几个号，那张赶出来的单子，那个没有人核对第二遍的习惯。把年轻同事处理掉之后，这些东西去哪了？

它们还在原地，等着下一个人。

还有一层，要补在老看法后面，免得它被人说成只会挑刺。

老看法里的追责，有一份很难得的郑重。它认为，医生手里的事，是人命关天的事，所以每一个动作都值得被认真对待。本书完全同意这一点。不同的只是：这份郑重，不应该只落在一个人的手上，也应该落在那个人手所处的环境上。郑重要分到每一处该担的地方，不要全压在最后一个动手的人身上。

最后一个动手的人，常常是离事故最近的人，却不一定是离原因最近的人。

◆ 三、本书的说法：追到人，也追到锯口

本书用拉大锯来讲这件事。

两个人拉一把大锯，锯口不是哪一头锯出来的。一头用力，一头松劲，锯就会卡住；一头歪了，两头都别扭。锯子卡住的时候，你可以问两个问题。

第一个问题：谁的手歪了？

第二个问题：这个锯口，为什么在这里卡住？

发现学只问第一个。它找到那只歪了的手，说一声「你歪了」，换一个人来拉，就算处理完。可是换了人，锯口还是那个锯口，木头还是那块木头，新来的人拉到同一个地方，十有八九还会卡。

本书的说法是：两个问题都要问，而且两个问题不互相取代。

追到人，是问那只手：这一步该怎么做，他是怎么做的，差在哪里，他要不要认，要认什么。

追到锯口，是问复合体：这个状态是怎样一步步发生的？是哪一维卡住了？是说不出，是读不懂，还是回写不进（第 14 章说过这三处）？

两个追问合在一起，才叫完整的追责。

把这个说法放回药单上：抄错的那个动作，是一件事；那个下午八十几个号、没有第二道核对、一个人同时管三件事，是另一件事。前一件事，追到人。后一件事，追到复合体里卡住的那一处。

追到人，也追到复合体卡住的那一维：这才是发生学的追责。

这里要特别说一句，因为它最容易被读歪。追到复合体，不是把责任往复合体身上推，让它去背。复合体不会认账，不会道歉，不会赔偿，也不会被开除。能认账的，永远是具体的人，是具体的科室、具体的医院、具体的制度制定者。

所以，「追到锯口」的意思，是追到那些能对锯口负责的人：定排班的人，定核对规矩的人，管着八十几个号怎么分的人。复合体不是一个躲藏的地方，它是一张更大的账，上面本来就写着更多人的名字。

发现学的追责，账上只有一个名字。发生学的追责，账上有一排名字，每个名字后面写着他对哪一处负责。

把这个说法拆开，是三个动作，一个接一个。

第一个动作，叫认账。事情是怎么回事，谁做了什么，错在哪一步，说出来。认账认的是事实，不是情绪，不用赌咒发誓，也不用把自己说成罪人。一句「这一步我们做错了」，比十句「深表遗憾」有用。

第二个动作，叫修锯。认账之后，一起去看锯口：话怎么没说出来的，规矩怎么没接上的，改了什么才能让下一个人不再卡在这里。修锯不是认账的替代，是认账的下一步。认了账不修锯，是空话；修了锯不认账，是糊弄。

第三个动作，叫复工。两头重新拉起这把锯。受过伤的一头，不会因为一次道歉就回到从前，可是锯子总要有人再拉，哪怕拉的是另一个医生、另一家医院、另一张挂号单。复工的意思，是让新的一轮相遇，踩在更稳的地上。

三个动作合起来，才是整个追责。少了任何一个，都是半截。

◆ 四、三种读歪的读法

「复合体生病」这句话，很容易被读歪。本书先把最常见的三种摆出来，免得你替它背黑锅。

第一种读歪：没有人需要负责了。

这是最危险的一种。读的人听到「是复合体的问题」，心里松了一口气：原来不是我。说的人更方便：「这是系统性的问题。」一句话，把所有的名字抹掉。

本书不认这个读法。把每一个名字都抹掉的「系统」，不是复合体，是一个空壳。真正的复合体是由一个个具体的位置撑起来的：医生位、病人位，还有科室、排班、核对、病历、费用。每一个位置后面都站着人。说「是复合体的问题」，是要把这些位置一个个点出来，一个个问，不是把它们打包扔掉。

第二种读歪：责任全在病人，病人「不配合」。

这个读法听上去像是从本书里长出来的：既然复合体里有两头，病人这头也要负一半。

不对。本书说的是「两头都在锯子上」，不是「两头平分责任」。责任不按人头平分，它按能力分，按位置分，按谁手里握着什么分。医生位握着专业判断、握

着处方、握着解释的机会；病人位握着自己的日子、自己的身体感受、自己是否回来复诊。两边都有要担的，可是担的不是同一样东西，也不是同一个分量。

而且，「不配合」这个词本身，就要打一个问号。本书在第八节细讲。

第三种读歪：医生也是受害者，所以医生没有错。

这个读法在医生群体里很常见，也最让人心疼。八十几个号，没有休息，指标压着，病人焦躁，家属录视频。这些是真的，本书在第 13 章写过，医生端的症状，是复合体的症状。

可是「医生也在受苦」和「医生没有要担的」是两句话。一个人可以同时是被压着的人，又是手里握着专业的人。前一句让我们心疼他，后一句让我们对他有要求。两句都要说。

这三种读歪，有一个共同的毛病：都想用一句话，把一件两面的事压成一面。「谁都不用负责」「全是病人的」「医生没错」，都是在找一个能让人松口气的位置。

本书不给这个位置。本书给的是一个更累一点、也更靠得住的做法：每一处，问一遍，这一处，是谁的手，是哪一维。

◆ 五、只追一端，会怎样

下面把三种只追一端的做法，各摆出来看后果。

只追医生。

出了事，一概追医生，这是最常见的。追的力度越大，医生端越缩。你在第 13 章已经看到了它的样子：防御性医疗。多开一项检查，多留一份记录，多问一遍「你确定要这样吗」，不是因为病人需要，是因为万一出事，自己有个交代。

这个缩，是复合体的症状，它写回到病人身上：检查多了，花费多了，等待长了，医生的话越来越像免责声明。病人觉得「他不把我当人看」，医生觉得「我不这样做就是在冒险」，两头越缩越紧，锯口越卡越死。

医生该被追责，这一点不动。要说的是，只追医生一个人的追责，常常追出一个更不敢做事的复合体。出了错，该认的认了，可下一次，没有人敢在模棱两可的地方做一个有担当的判断。

只追病人。

病人没按时复诊，没照着做，隔了三个月才来，一来就说「怎么这么严重」。医生心里一句：你不配合。

这句话出口的那一刻，诊室里发生了什么？病人位被写成了「不合格的病人」，医生位松了一口气：不是我没做好。复合体里本来要问的那些问题，一个都没有被问出来：他为什么没来？是没听懂？是来不了？是上一次来，被说了一句什么，就不想再来？

只追病人，追出的是一个更沉默的病人：下一次，他会少说真话。他怕再被说一遍。

只追制度。

还有一种，是把一切都推到制度、体制、环境上。这个说法的好处是没人受伤，每个人都是受害者，每个人都可以叹一口气。

可是它有一个很重的代价：没有人能动。制度是个大词，大到没有任何一个人的手够得着它。一件事推到「制度」那里，就成了一件所有人都知道、所有人都不用做的事。

三种只追一端，各有各的后果，可是它们长着同一张脸：**把一个正在成形的状态，当成了一个已经定型的东西来处理。**医生、病人、制度，都被当成一个先在的、固定的责任体，错，就是它们身上的一块污点，擦掉就行。

可复合体里的错，不是这样。它是一步一步发生的，每一步都有一个人在走，每一步又都被前一步和周围的土推着。追责要追出这个「发生的过程」，才算追到了。

还有一点，只追一端的人自己常常没有看见：被追的那一端，会把追的力度，原样换成另一种东西还给你。

追医生追得狠，医生还回来的是躲。追病人追得狠，病人还回来的是瞒。追制度追得狠，制度还回来的是一份又一份没有人读的文件。每一种还回来的东西，都不是故意的，是复合体里的力，找到了出口。

锯子也是这样：你在一头使劲压，另一头就会往回顶。顶得越厉害，锯口越歪。

所以，好的追责有一个特点：它让两头都有地方站。被追的人知道自己要担什么，担完了可以放下；追的人知道自己要什么，要到了可以松手。没有地方站的追责，只会越追越黑。

◆ 六、追责本身，是修复的一部分

到这里，有一个你也许没想到的说法：追责不是修复的对立面，追责本身就是修复的一部分。

怎么说？回到前面三个维度。复合体卡住，常常卡在三处：说不出、读不懂、回写不进。

一次医疗差错出现之后，复合体的状态变了。病人位被伤了，医生位被伤了，两边之间有一道缝。这个状态要发生转换，需要几样东西。

第一样，是认账。有人站出来说：这一步，是我们做错了。不绕，不拖，不用「可能」「或许」把话泡软。认账这件事，会把那团一锅粥似的东西，变成一个能被说出口的形状。没有这个形状，受了伤的那一头，一辈子都说不出口自己到底受了什么伤。

第二样，是说明。到底发生了什么，一步一步，用对方听得懂的话讲。这一条，对应的是「读不懂」。很多追责走不下去，不是因为没有人认错，而是因为说明说得让人听不懂，或者干脆不说。

第三样，是改变。认了账、说清了，接下来要在日子里发生一些不同：流程补上，核对加上，下一个人不再走进同一个坑。这一条，对应的是「回写不进」。账认了，如果没有任何东西改变，那是一场表演，复合体的状态没有转换。

第四样，是补偿。该赔的赔。这不是俗气，是把一份实实在在的损失放回实实在在的日子里。

你可以看出来，这四样，没有一样是「找到那个人，处理他」可以代替的。处理一个人，可以是认账的一部分，却不是全部，更不能代替说明和改变。

反过来也一样。如果追责的方式本身是坏的，也会让复合体更糟。比如：

追责只为了找出人，找完就散，复合体什么也没改。

追责变成审判，被追的人从此什么都不敢说，下一次的差错，他会藏起来。

追责拖了三年，两头都在等一句话，等到彼此只剩下恨。

所以，追责怎样做，也是复合体的状态。它是下一次医患相遇的土。一个出了差错之后，认得清楚、说得明白、改得下去的医院，它下一个病人走进来时，踩着的是更稳的地。一个出了差错之后，互相推诿、层层封口的医院，下一个病人走进来，踩着的是上一个人没吭声的那一段。

这就是为什么本书说，追责是修复的一部分。它不是修复完了才来的，也不是修复的反面。它是修复本身的一条路。

追责还有一个时间的问题，常被忽略。

差错刚发生的头几天，复合体是一锅粥：谁也说不清到底怎么回事，情绪比事实跑得快。这时候，最要紧的是先稳住人，先说清楚已经知道的，不急着下结论。

过了几周，形状慢慢出来了：事实理清了，该认的话说了，该查的查了。这时候，要紧的是把话说完整，让受伤的人听见，让改变开始。

过了几个月甚至几年，事情要么定型成一个让两头都能放下的样子，要么定型成一个谁也解不开的结。这个结，往往不是差错本身造的，是中间那几周几个月里，没说的话、拖着的事、互相躲着的人造的。

所以，追责不只是一个动作，是一段时间。每一段时间有每一段的活：头几天稳，中间几周说，往后几个月改。这个顺序不乱，复合体就有机会在某个时候，走到一个可以松手的地方（第 12 章写过，复合体的一种好结局，是它不再被需要）。

反过来，一场追了五年的纠纷，两头都不肯放，每一次开庭都把旧伤撕开一次。那个复合体，早就不是在处理差错，是在处理「我们谁也不信谁」。这时候，再去问谁对谁错，常常已经问不到根上。

◆ 七、受了伤的人，为什么要一个名字

有一件事，写这一章的时候要放慢。

一个人在医疗里受了损失，他最想要的是什么？很多人以为是钱。钱当然要，可是在钱前面，还有两样东西：一个说法，和一个名字。

说法，是想知道：到底发生了什么？是我命不好，还是有人没做好？名字，是想知道：这件事，有没有一个人，肯站到我面前说一句「是我们的事」？

没有名字的伤，最难受。它像一件落在地上没有人认领的东西，你不知道该冲谁生气，也不知道该向谁讨。这时候，别人跟你说「这是整个医疗系统的问题」，你只会觉得被打发了。

所以，本书对「追到复合体」这句话，一定要加一个脚注：先给名字，再谈锯口。

顺序是这样的：受了伤的一头，先要听到有人认账。认账完了，才轮到一起坐下来看，这件事是怎样发生的。倒过来，先讲一大篇系统和环境，再最后才说一句「我们也有责任」，听的人只会觉得，这是在找借口。

这里有一个很小、可是很要紧的区别。

「这是系统的问题」，如果是认账之前说的，它是推脱。如果是认账之后说的，它是交底：我们错了，错在这一步，而且我们知道，这一步为什么会错。后一种话，会让人觉得他们认真，前一种，会让人觉得他们圆滑。

同样一句话，放在不同的位置，是两种东西。这就是复合体里的事：话不是孤零零的一句，它落在一个正在发生的状态里，状态不同，话的分量就不同。

再说道歉。

很多医院、很多医生，怕说「对不起」。怕它被当成证据，怕它变成赔偿的口实。这个怕，是真的怕，不是胆小：在只追一个人的追责里，一句道歉，真的可能变成压在头上的石头。

可是，一个只追一个人的追责，恰恰逼出了一个不肯开口的复合体。医生不敢说「我很遗憾，这件事没有做好」，病人和家属听到的，是沉默，沉默被读成了「他们在躲」。事情本来可以在一场谈话里说开，结果在沉默里拖成了一场更大的冲突。

把追责放回复合体里，这个结就有机会松一松。如果追的不只是那个人的手，也追那个让他不敢开口的锯口，那么「怎样做，才能让认账和说明不再是一件可怕的事」，就成了一个要认真回答的问题。这是医院要回答的，是定规矩的人要回答的，不是一个站在诊室里的医生一个人能回答的。

道歉怎么个说法，各家有各家的规矩，本书只谈理解。你只需要记住：一句好的道歉，往往不是在结案的时候说的，是在复合体里还没有变僵的时候说的。

◆ 八、医生端的怕，是怎样长出来的

现在换到医生这一头。

前面说，医生被追，追得多了，会缩。这个缩，值得多看一眼，因为它直接连着追责的做法。

先看一个年轻医生的第一年。他带着一腔热，走进诊室。前三个月，他做的每一个决定，都要多问一句上级。半年之后，他发现，自己开始在病历里多写几行，不是为了病人，是为了「万一」。一年之后，他对某些模棱两可的病人，已经学会了一种说法：「你最好去大医院再看看。」这句话没有错，可有时候，它不是在帮病人，是在帮他自己。

是谁教他的？没有人教。是诊室里的土教他的：他听过的每一个案例，看过的每一次通报，听同事说的每一句「当心」，一点一点，沉成了他手上的一层薄壳。

这层壳属于复合体，是它在医生手上长出来的，与品性无关。

追责的方式，就是浇在这片土上的水。如果每次出了差错，都只问「谁干的」，那么土里长出的，就是「千万别是我」。如果每次出了差错，问的是「谁的手」「卡在哪里」「怎么改」，那么土里能长出的，才可能是「出了事，我们能说」。

有一些行业，已经在做这件事：出了差点出错的事，不追个人，鼓励大家讲出来，把它当成改进的材料。这类做法的名字和细节，本书不展开。要紧的是它背后的道理：你想让一个复合体少出错，最有效的办法之一，是让里面的人敢说「我差点出错」。

可是这里又要小心，别读歪。

差点出错的，并非不用负责；错了的，也并非一概不追。而是说，追责要分层：对「差点」，侧重的是看见、讲出来、改；对「已经发生并造成了伤害的」，认账、说明、补偿一样不能少；对故意的、明知故犯的、弄虚作假的，该怎么处理怎么处理，没有任何一句「复合体」可以替他挡。

这三层是不同的，不要混成一锅粥。把差点出错的事当成犯罪来追，会吓住所有人；把真正造成伤害的事当成「大家的问题」，会寒了受害者的心。

所以，本书给追责画了一张小小的名册，每一行是一个位置，后面写它对哪一处负责：

医生位：对自己的判断、动作和说明负责。

病人位：对自己的感受如实说出、对自己的日子里能做到的事如实说出负责。

科室与医院：对排班、核对、流程、能不能说真话的环境负责。

定规矩的人：对规矩本身压出了什么，负责。

写下病名的那一支笔：病名一旦写进病历，也写进日子，对它的回写，负责（第 6 章、第 8 章说过）。

名册上每一行都有人。没有一行是空的，也没有一行写着「大家」。

◆ 九、一个完整的例子：那张剂量不对的单子

现在回到周岚科里那张单子。故事是虚构的，人物也是；放在这里，是为了把前面的话走一遍。

事情是这样的：一个下午，诊区八十多个号。年轻的同事小何，在抄一位老人的降压药单时，把剂量的小数点点错了一位。药师在核对时看了出来，把单子退回。药没有发出去，老人没有受到任何影响。

第二天，科里开了个小会。

如果会开成发现学的样子，大概会是这样：主任问，是谁抄的？小何站起来，说，是我。主任说，下次小心，写个说明。会散了。小何回到座位，手心还在出汗，往后每抄一张单子，都要多看五遍，动作比从前慢了一半，下午的号更排不开。别的同事看在眼里，各自在心里记一笔：这种事，千万别摊在自己头上。

没有人说出「那个下午我们自己也差点抄错」。也没有人提，下午八十几个号，原本该不该有这么多。

如果会开成本书说的样子，会是另一种走法。

先是小何说清楚：我当时看错了哪一位，是怎么看错的。这一步是认账，也是说明。他不是被审的人，他是在讲一件发生过的事。

然后药师讲：我是在哪一步看出来的。这一步，让所有人知道，核对这一道，是怎么挡住了一次错。

再然后，是追问锯口：那个下午，八十几个号，是怎样排出来的？这张单子从开出来到核对，中间有没有第二个人看过？抄写和开方，本来就该分在两个人手里吗？

最后，有人拿起笔，把这些东西改成明天就能做的事：下午的号，重新排一排；单子，多一道换人再看的工序。

你看，这个会里，小何有他要担的：他看错了，他要说清楚。排号的人也有他要担的：他把号排得太密。定工序的人也有他要担的：这个环节，本来就该有一道保险。每个人担的，是自己那一块。

小账会很清楚：这一次，是人错了，也是锯口卡了。人要认，锯口要修。两件事不互相抵。

会后，小何还是会难受。可是他的难受，和上一种会后的难受不一样。前一种，是「我一个人闯了祸」。这一种，是「我错了一步，这一步现在补上了」。后一种难受，是能放下的。

再往下，还有一个角度值得说。

小何那天之所以能在会上说清楚，是因为他的上级先说了一句：「这一单，药师挡住了，说明我们的核对是有用的。我们来看，下次怎么让它更有用。」这句话，是复合体里的一股土。它没有替小何免责，也没有给他加罪，它把一件事放回了它该在的位置：这是一次差错，也是一次被挡住的差错，两样都要看。

有这样的上级，是一个科室的运气。没有这样的上级，一个科室就要靠规矩，规矩要有，不能靠运气。

至于那位老人，他什么也不知道，药照常拿到。这是对的：没有发生损害，是不是需要告知，要看各家医院的规矩。本书只谈理解，不谈规矩的细节，这一处，请以医院和当地规定为准。

可如果这张单子真的发出去了，老人真的受到了影响，那会怎样？那就是另一个会了：认账、说明、补偿、改变，一样都不能少，而且要先对老人和家人说，再对自己人说。这一条，本书不留一丝余地。

◆ 十、「不配合」这个词，要先问三句

现在回过头，讲病人端。

病人有没有责任？有。

病人位上的人，握着一些别人替不了的东西：自己的身体感受，自己的日子，自己说不说真话，自己回不回来。医生再好，也替病人说不出「我其实一直没吃」，也替病人走不进复诊的门。这些是病人端要担的，本书不回避。

可是，「不配合」这个词，要小心用。

它是一个读数，算不得原因。就像体温计上的三十九度，它告诉你有事，不告诉你为什么。医生说一声「不配合」，其实是把一个还没有问清楚的状态，直接当成了病人身上的一个性格毛病。

本书建议，听到「不配合」，先问三句，正好对着前面说的三个维度。

第一句：说得出吗？

病人没来复诊，也许是因为那天的诊室里，有一句话他没敢说。比如他吃了药之后一直犯困，而他的工作是开车。他怕说出来，医生会把药加重，或者让他别开车，于是他就不吭声，悄悄停了药。这不是不配合，是他的苦没有找到一条说得出口的路。

第二句：听得懂吗？

医生说了三遍「要规律服用」，病人点了三次头。回家之后，他把「规律」理解成「想起来就吃」。这不是不配合，是医生的话，没有接上他这具身体的路，没有接上他的日子。

第三句：做得到吗？

方案是好方案，可它要求他每天早上七点前吃饭，而他的活儿早上六点就要开工。方案没有办法在他的日子里发生。他试了两天，放弃了。这不是不配合，是医生开出的东西，没有地方可以落脚。

举一个虚构的例子。周老师吃降压药吃了很多年，有一回复诊，血压比上次高了。年轻医生翻了翻记录，问：「是不是又没按时吃？」周老师答：「按时吃的。」医生没再追问，只是说：「那我给你调一下。」

回家之后，周老师心里很不痛快。他确实停过几天药。那几天，他在看外孙学校的事，忙乱里漏了几顿，后来想起来，不好意思讲，怕被说「老同志，这点事都记不住」。

这一幕里，谁不配合？

周老师没有说实话，这是他那一头要担的。可医生那一句「是不是又没按时吃」，带着一个「又」字，它在诊室里挂出了一块牌子：这里不欢迎说实话。两头都在锯子上，一头松了，一头也没用上劲。

如果医生问的是：「这个月有没有哪几天漏过？很多人都会漏，说说看，我好判断。」周老师多半会说。同一个医生，同一个病人，同一种药，换一句话，复合体的状态就不同。

本书不要求医生永远温柔，只请你看见：一句话，是一个位置发出来的，也是对另一个位置的邀请或关门。「不配合」常常诞生在这样的小地方。

这三问问完，仍然有一种情形：病人明明说得出、听得懂、做得到，就是不肯。那也有，也是真的。这时候，问题才落到病人端自己身上。可是要先问完前三句，再走到这一步，才算公平。

本书不替病人开脱，也不替医生开脱。这是一个很朴素的做法：先问清楚，再说责任。先把状态读准，再谈谁来担。

还有一层，你也许想过：医生口里的「不配合」，常常是医生位自己卡住的信号。三句问下来，发现病人说不出，是因为诊室里留给他说话的时间只有三分钟；发现病人读不懂，是因为解释的话被切得太碎；发现病人回写不进，是因为医生没有问过他的日子长什么样。

这时，「不配合」就不再是病人的毛病，它成了一面镜子。镜子里照出来的，是一个复合体，是两头一起拉出来的卡。

当然，并非所有「不配合」都是医生的错。要说的是，在判定「是谁」之前，先判定「是哪一维」。这一个顺序，不能反。

身体或心里的难处真的大了，请找医生或心理咨询师。

还有家属。

周老师住院那一回，女儿周岚在病床前，不是医生，是家属。她盯着输液袋，数着滴速，看护士每次进来，心里都紧一下。她忽然明白，家属也是复合体里的一个位置，而且是一个常常没有被写进名册的位置。

家属握着什么？握着病人的日子，握着病人没说出口的那些话，握着一遍遍提醒病人的力气。家属也会有要担的：把听到的话带回家，把病人的难处带回诊室。家属也会有被冤的：医生没解释清楚，却问家属「你们怎么不早点来」。

三句问法，同样适用于家属：他有没有说出来？有没有听懂？有没有做到？这一问，常常能把一场家属和医生的对立，变成两个人一起看同一件事。

最后，把三问换成诊室里能说出口的话，因为书里的话和嘴里的话，不是一回事。

医生可以这样问：「这一阵，哪一步最难坚持？」这是在问说得出不。

医生可以这样讲：「我刚才说的，你按自己的话复述一遍给我听，我看有没有讲清楚。」这是在问读得懂不。

医生可以这样收尾：「回家以后，哪个时间点最容易忘？我们把方案往那个点上挪一挪。」这是在问回写进不。

三句话，都不是审问，是把锯子递过去。病人要是也肯回一句，「其实有两天我漏了」，这就是认账，是病人那一头的认账。两头的认账，是互相给的，不是单方面逼出来的。

◆ 十一、放回日子里

如果你是管事的人，是科室主任，是院里分管的人，这一章要先对你说一句。

你手里有两样东西：排班，和规矩。这两样东西，决定了一把锯子的锯口朝哪边开。排班太密，锯口就朝「赶」开；规矩只追人，锯口就朝「躲」开。你不一定能改掉所有的错，可你能改的，是错发生之后，大家说话的难易。

让说真话变得容易一点，是一个科室最便宜的修复，也是最容易被忽略的一件。

回到周岚。

那天晚上，她把讲座上的话，又在心里过了一遍。她终于明白，自己为什么一时说不出「为什么不是」。

因为那句话只讲了一半。「病在复合体里」，是对的，可它是讲状态的话，不是讲账的话。状态要往复合体里看，账要一笔一笔记在具体的人名下。两件事放在一起，才是整个故事。

第二天，她做了一件小事。

科里开会，她没有发表任何大道理。她只提了一个办法：以后每次出了差错，不管大小，会上先问三个问题，一个一个问。

第一，这一步，是谁的手，他要说清什么？

第二，这一步，卡在哪一维：话没说出来，话没听懂，还是做的东西没在日子里落下？

第三，要改什么，谁来改，下周几之前改完？

一共三句。一张便利贴就写得下。

小何那天第一次听到这三问，愣了一下。他本来准备好了挨一顿说。

这是你明天就能试的做法，不管你是医生、护士、病人，还是家属。下一次，遇到一件让人不舒服的事，先别急着问「谁的错」，也别急着说「大家都有错」，先问那三句。

问「哪一步，是谁的手」，是不放过人。问「卡在哪一维」，是不放过复合体。问「谁来改，几时改完」，是不放过日子。

三样都不放，才叫追责。

最后留一句，给下一章。

这一章里，所有的追问，都默认了一件事：复合体里，是两头在拉锯，医生位和病人位。可今天的诊室里，已经不止两头了。病人在挂号之前，先问过一个会说话的机器；医生在写病历的时候，旁边也坐着一个。出了差错，这个新来的，算谁的？

追到人，也追到锯口，这个做法还管不管用？下一章接着说。

带 走 的 话

复合体生病，不取消问责；追到那只手，也追到锯口卡住的那一维，两样都不放。

小　账

这一处，开门还是关门：这一章关了一扇「找到人就完了」的门，开了一扇「追到人，也追到复合体」的门。

病放在一个人身上，还是放回复合体里？放回去了，可是没有借此把人从账上抹掉：每个名字后面，仍然写着他对哪一处负责。

想 一 想

你最近一次说或听到「这是他的错」，是在什么事上？如果同时问一句「这件事卡在说不出、读不懂、回写不进的哪一处」，你会多看见什么？
你身边有没有一次差错，认账之后，什么也没有改？那一次，追责停在了哪一步？

◆

16

第 16 章

医生—病人—AI：三方复合体

◆ 一、你一定有过这样的时刻

周老师睡到半夜，觉得头有点晕。

他躺着没动，心里数了数：血压药今天吃过了，晚饭没多吃盐，白天也没累着。他想叫女儿，又看了看钟，两点十分，算了。

他摸到床头的手机，打开那个外孙教他装的软件，一个字一个字地打：「头晕，血压高多年，晚上突然晕，怎么回事？」

几秒钟后，屏幕上出来一长串话。分了几条，有「可能的原因」，有「需要警惕的情况」，最后一行写着：建议尽快就医。

周老师把那几条从头看到尾，越看越清醒。刚才只是有点晕，现在他觉得，自己大概哪里要出大事了。

第二天一早，他挂了社区医院的号。进诊室之前，他已经带着一肚子话：「医生，我是不是脑子里有问题？」

诊室里，年轻的值班医生一边听他说，一边在电脑上敲病历。她手边的屏幕上，有一个助手在把她和周老师的对话，一句一句整理成病历的雏形。她抬头看看周老师，又瞄一眼屏幕上的那段字，轻轻皱了一下眉：「周老师，昨晚是不是上网查了？」

周老师有点不好意思：「就问了一句。」

这一幕，你大概一点也不陌生。你自己、你的父母，也许都有过类似的一个夜晚。

这一章要问的是：这个夜里的手机，和诊室里的那块屏幕，算什么？如果你的回答是「工具」，那它在这间诊室里，究竟干了什么？

本书的回答，要从上一章结束的地方说起。上一章说，复合体生病，追责要追到人，也追到复合体卡住的那一维。可是今天的诊室里，复合体的样子，已经不是上一章默认的两头了。

◆ 二、老看法：AI 是一件工具

先说老看法，它有它的好处。

老看法说，AI 是一件工具，和听诊器、显微镜、化验单没有分别。医生拿它读片、写病历、查文献；病人拿它查症状、问药名、看不懂的词让它翻成大白话。工具好用不好用，在人。用得对，是助手；用得不对，是添乱。

这个说法让人安心，至少有三个原因。

第一，它守住了责任。工具没有手，没有名字，不会认账。出了差错，找用工具的人。这一点，和上一章的追责完全接得上：该追人还是追人。

第二，它守住了专业。医生的判断仍然是医生的判断，AI 给的只是参考，签字的仍是医生。病人的就医决定仍然是病人的决定，AI 给的只是信息，走进医院的仍是病人。

第三，它不吓人。一件工具，用得上就用，用不上就放下，不会改变人是谁。

所以本书先把话说在这里：在一个很具体的范围里，老看法完全成立。当医生用一个软件把血压数据排成表，或者病人用一个翻译软件把外文说明书读懂，这个软件就是工具，没有多余的话好说。

可是，请你回头看周老师的那一夜。

那个软件，只是把他的问题，查了一遍吗？

它没有只查。它回了一长串话，用了「需要警惕」这样的词，在一个两点十分的夜里，把一个只有一点晕的老人，变成了一个觉得自己「大概要出大事」的人。进诊室之前，周老师的苦已经有了形状，那个形状是一串他自己并没有写下的话。

工具是不会做这件事的。听诊器不会在你还没挂号的时候，先给你一个「可能」。

再看诊室里那块屏幕。助手整理出来的病历雏形，里面有哪些话被留下了，哪些话被改写了，哪些被排在最前面？医生在最后签字之前，会不会逐字重读？她读到的，是周老师说的话，还是机器听起来像样的话？

这些问题，说明有一件事，老看法没法说清：这个新来的东西，不只是被人拿着，它也在把人变成别的样子。

◆ 三、一个新位：诊室里的第三方

本书的说法是：**诊室里，来了一个新的位。**

在前面十五章里，医生—病人复合体里有两个位：病人位，医生位。它们是挂号那一刻一起显影的（见导论）。两个位互相推着，一起成形，像拉大锯的两头。

现在，AI 也在这把锯上。

要把这句话说准，需要先讲清楚三件事，因为它最容易被读歪。

第一，说 AI 是一个位，不是说 AI 有意识、有情感、有心。

本书不碰这个问题。位，是复合体里的一个地方，是一个状态赖以成形的一头。判断一个东西是不是一个位，不问它有没有心，问它在这个复合体里，有没有推过状态，有没有被它改变。

用这个标准看：周老师那一夜，AI 推了他的状态，他进诊室时的样子，和没有那一问之前，不是一个样子。诊室里，AI 整理出来的病历，推了医生接下来要问的话，也推了病名是怎么写进日子的。它推过，也被改过：医生不满意的地方改了，它下一轮的样子也不同。这就够了。

第二，说 AI 是一个位，不是说医生位、病人位被取代了。

位不是座位，你坐了，别人照样有得坐。三个位并存，是一个更大的复合体，里面每个位的样子都在变。医生位还是医生位，可它不再是从前那个医生位：它的一部分工作，现在是和 AI 一起完成的。病人位也是，病人带进诊室的，已经不是一个干干净净的「我不舒服」，而是和 AI 一起磨过的一个版本。

王德生博士用过一个很简单的比方：人坐上车，走路的就不只是腿，是腿加车的整体。（大意）一个人坐在车里，我们不会问「是腿在走还是车在走」，因为这个问法已经问错了；该问的，是这个腿—车的整体，往哪里去，走得顺不顺。

医生—病人—AI 三个位合在一起，也是这个道理。

第三，说 AI 是一个位，不是说它和另外两个位一样重。

三个位，各有各的分量，各有各的责任。这一点，本章后面细说。眼下先记住：位，是从复合体怎样发生来说的，不是从谁大谁小来说的。

好，现在再看周老师那一夜。

屏幕亮了，他打字，AI 答。这一刻，并非「一个叫周老师的人在查资料」，而是一个新的小复合体发生了：周老师位，AI 位，和夹在中间的一串话。这串话不是周老师写的，也不是 AI「想出来」的，它是两边一起拉出来的。周老师怎么问，决定了 AI 怎么答；AI 怎么答，又决定了周老师接下来会怎么想。

这个小复合体，早在挂号单出来之前，就已经发生了。它给后面的大复合体，铺了一层土。

◆ 四、挂号之前：AI 先到场

接着看这一层土，是什么样的土。

第 5 章讲过，诊断之前，是没有形状的苦。第 6 章讲过，挂号那一刻，病人位、医生位、病名一起显影。如果你还记得，会知道，那一章里有一个默认：苦，是在进诊室的时候才第一次被整理成形状的。

现在，这个默认要改。

很多人的苦，在进诊室之前，已经先被另一个位整理过一遍。可能是 AI，可能是一个搜索框，可能是一个短视频里的科普，只是现在，它说得更流畅、更像人话、更像是针对你的。

这有两面。

好的一面是：说不出的苦，有了一条路。

回想第 14 章讲的第一种卡：说不出。很多病人的苦，从来没有找到过合适的话。头不是疼，也不是晕，是一种「沉」；胃不是痛，是一种「堵着」。他们到了诊室，三分钟的时间里，往往不知道该从哪一句说起。

现在，有人可以在夜里，不怕打扰任何人，一点一点地把这块没有形状的东西，打成字。AI 会追着问：是在什么时候？什么动作之后？有没有别的伴随？一问一答间，病人把自己的苦，说成了一段有头有尾的话。第二天，他拿着这段话走进诊室，医生三分钟里听到的，比从前多得多。

这是实实在在的好处，本书不装作没看见。

另一面是：苦，被过早地定了形。

病人在没见到医生之前，已经有了一个「可能的诊断」的名单。名单里的词，很多是吓人的。他带着名单进来，诊室里的第一句话，已经不是「哪里不舒服」，而是「我是不是得了什么大病」。

前面说过，诊断是状态发生的开端。可是病人的状态，在医生开口之前，已经朝一个方向走了一段。这一段路，医生看不见，因为她没有在场。她只看见一个比平时更紧张的病人，和一个已经有了许多「自己想法」的人。

这就好像，戏还没开场，台上已经布好了景。景布得好，戏容易开；景布得偏，戏要先拆景。

所以，本书对「先问 AI 再挂号」这件事，既不骂，也不夸。它是复合体的一个事实：苦，现在有了第二条出生的路。

这一条路上的话，有几个特点，值得知道。

第一，它是流畅的。流畅的话，听起来都像对的。不管它对不对。

第二，它是顺着你问的方向走的。你怕什么，它的回答里，往往就多一点那个方向。你问得越焦虑，答得越长。

第三，它没有后文。你关掉手机，它不会知道你后来怎么样了。一次问答，是一个断了线的头。医生不同，医生有复诊，有记录，有「上次你说过」。

三个特点，并没有哪一个是坏的。只是这三个特点合在一起，会让「先问 AI」这一步，成为一片土，土里能长出安心，也能长出惊吓。

还有一层，常被略过：病人这一头的家人，也成了复合体里的人。

周岚就是这样。她白天是医生，晚上回家，父亲拿着手机问她：「这个说的对不对？」她在这一刻，是女儿，也是医生，还是 AI 回答的审稿人。三个身份压在她一个人身上，她常常答得比平时更急。

这种事，在很多家里发生。家里有一个懂医的人，AI 的答案最后都会回到他那里去核对。这个人，成了三方复合体的又一个接口，他承担了一份没有人给他记账的活。

把这个接口看见，是对这个人的一份公道。

◆ 五、诊室里：读片，写病历

再看诊室里面。

今天的诊室里，医生用 AI 的方式，大概有几种：让它读影像，提示可能的异常；让它把对话整理成病历；让它查最近的文献；让它起草给病人的说明。

这些事，每一件看上去都是工具的活。可是，把它们放回复合体里看，每一件都在改变状态是怎么发生的。

先看读片。

AI 在片子上标出一个小小的圈：这里，值得再看一眼。医生看到这个圈，再去看片子，看到的就不再是一张干干净净的片子，而是一张「已经被提示过」的片子。

这是好事，也是一个新的变量。好处是，一个疲惫的下午，医生少漏一个小地方。变量是，医生的眼睛，也会被这个圈牵着走。有圈的地方看得更仔细，没有圈的地方，看得会不会比原来更快、更松？

这里说的，不是 AI 好还是坏。是医生位的样子变了：从「自己读」，变成了「读一个已经被读过一遍的东西」。读的活儿，分成了两半。

再看写病历。

病历，在前面的章节里，是病名第一次回写的地方（第 6 章）。病历上的字，不只是记录，它会跟着病人走很多年，会影响下一个医生怎么看他。

现在，病历的第一稿，可能是 AI 写的。它把一段对话，变成了几行整齐的字。整齐是它的长处，也是它的陷阱：对话里那些没说完的话、犹豫、停顿、一句「也不是疼」，在整理的时候，很容易被抹平。

抹平之后，病历上留下的是一个干净的病人，一个比真人更好懂的病人。

下一个医生看到这份病历，看到的，就是这个更好懂的版本。

你可以看出来，这里发生的事，和上一章的追问直接相连。病历里有一句话写偏了，是谁的？是 AI 写的，是医生没改，是医院采购了这个软件，是软件公司训练它的方式。一条链子，每一环都有一只手。

追到人，也追到锯口：这个办法，在这里仍然管用，只是名册要加长一些，多了两行。本章后面再写。

最后看一个小细节。

医生一边听病人说话，一边看屏幕，屏幕上有字在走。病人的眼睛，看到的是医生低头；医生的眼睛，看到的是屏幕。第 14 章讲到的「说不出」「读不懂」，在这里多了一个很具体的东西：眼神。

一个有 AI 在的诊室，医生的眼睛往哪里放，比从前更要紧。因为那块屏幕，不只是工具，它也是诊室里的一个在场者。

再往细处看，诊室里的疲倦，也是复合体的一部分。

一个看了六十个号的医生，眼睛已经有些发涩。这时候，屏幕上的圈、整理好的病历，对她来说，不是锦上添花，是实实在在的一口气。本书没有资格劝她不要用。

可是，同样是这口气，也可能让她少看一眼。疲倦和 AI 加在一起，常常产生一种新的状态：她自己也说不清，这个判断，到底有多少是自己看出来的。

这样的状态，在上一章的名册里要记一笔：让医生每天看八十个号，又给她一个能帮她的 AI，这两件事合起来，会把什么压到她的签字上？那是排班的人和采用工具的人，要回答的问题。

◆ 六、所有问题，都要重新问一遍

写到这里，需要把视线拉远一点。

王德生博士这两年反复讲一条线：AI 时代，所有的问题，都要重新问。重新问的办法，不是问「AI 会不会取代人」，也不是问「人该怎样用好 AI」，这两种问法，都预设了人和 AI 是两样先在的东西，要么对抗，要么配合。

他的问法是：一个新的复合体，如何发生？

这是什么意思，用一个例子说。

一个人在写作业，旁边有一台能写作业的机器。老问法问：他会不会抄？该不该让他用？新问法问：「这个孩子—机器」这个新的复合体，是怎样成形的？它的哪一维卡住了？它长成之后，是一个什么样的东西？

老问法里，孩子是一个已经固定的孩子，机器是一件已经固定的东西。新问法里，两样都是正在成形的，它们是在互相推的时候，一起变成各自的样子的。

在这条线上，许多时代的焦虑，都被他读成同一件事：主体性在重新发生。人在这个新的复合体里，不再是原来那个位置上的人，所以会焦虑。焦虑不是因为 AI 太厉害，是因为「我是谁」这件事，正在被重新写。（大意）

把这条线放进诊室，问题变成了：

不是「AI 会不会取代医生」，而是「医生—病人—AI 这个三方复合体，是怎样发生的」。

不是「病人该不该先问 AI」，而是「病人先问 AI 之后，复合体的第一步是怎样走的」。

不是「医生该不该信 AI」，而是「医生位和 AI 位一起读出来的东西，是谁的读数」。

这三句，都是同一类问题。问法换了，路就换了。

前面三编里，本书一直在拆三个先在者：先在的病人，先在的医生，先在的观察者。现在，来了第四个先在者的诱惑：先在的 AI。很多关于 AI 的讨论，是在悄悄地把它立成一个先在的、固定的东西：它有能力，它有边界，它有偏见，它会出错。这些话可以说，可是它们和「病人先在」「医生先在」是同一种说法，都站在发现学里。

发生学的问法是：AI 位，也是在这间诊室里，一次次被推出来的。同一个模型，在周老师的手机里，和在年轻医生的屏幕里，是不同的 AI 位。不是因为它变了，是因为它所在的复合体，不是同一个。

这一点，要记牢，因为后面的追责，就靠它。

◆ 七、三方之后，卡点怎么变

现在把三个位放在一起，回头看第 14 章的三个卡。那一章说，复合体卡在三处：说不出，读不懂，回写不进。在三方复合体里，这三处，各有新的样子。

说不出，变了。

有 AI 帮忙，很多人更容易说出来了。这是好事。可是，说得出来，不等于说的是真的。一个病人在 AI 的追问下，把苦打成了一段流畅的话，那段话里，有多少是他真正感觉到的，有多少是 AI 的问题引他说出来的？

AI 问：「胸口有没有压迫感？」他想了想，说：「好像有。」

「好像有」，是他的，还是问法的？

要看见的是：说，本来就是在问答之间一起发生的（第 1 章说过，病人不是带着病来的）。在医生面前是这样，在 AI 面前也是。所不同的，是 AI 的问法，以不以病人的苦为中心，还是以「列出所有可能」为中心。

读不懂，也变了。

从前，读不懂是医生的话病人听不明白。现在，多了一种读不懂：医生读不懂病人带来的那段话。

病人拿来一份 AI 整理好的症状清单，条条是对的，字字是通的，可医生看了半天，抓不到哪一条是他最难受的。清单是平的，苦是有轻重的。AI 能把话说得工整，却不一定知道，这个人最怕的那一件，是哪一件。

另一个方向的读不懂是：医生用 AI 生成了一段给病人的说明，每一句都标准，每一句都准确，可是它没有接上这个病人的日子。病人看完，点点头，等于什么都没有听进去。

回写不进，更要小心。

上一章讲到，病名写进病历，也写进日子。方案要回到日子里发生，才算数。

AI 在这里有一个很特别的角色：它可以同时在两头回写。它可以帮医生把方案写成病历，也可以帮病人把方案变成提醒、变成每天的小事。如果用得好，这是回写的一条新路：方案不再只活在诊室的三分钟里，它跟着病人回家。

如果用得不好，AI 提醒了，病人也照做了，可是没有人问一句：这样做，对这个人的日子，合不合适？一条被 AI 管得整整齐齐的日子，也可能是一条被压住的日子（第 8 章说过的「笼子」）。

除了这三处的变化，三方复合体还多了几个新的卡点，值得单独点出来。

第一个，叫两个说法顶牛。

病人带着 AI 的说法，医生有医生的判断，两个说法不一样。这时候，诊室里发生的，常常不是两个说法比较，而是两个位置的较劲：医生觉得病人在质疑她，病人觉得医生不把他查来的东西当回事。这不是说法的问题，是锯子的两头，都想往自己这一边带。

好的做法，是不分输赢，把两个说法都摆在桌上：「你查到的这几条，我们一条一条看。哪一条跟你的情况对得上，哪一条对不上。」这是把 AI 位请进来，当作复合体的一部分，而不是敌人，也不是权威。

第二个，叫流畅的错。

AI 说错话的时候，常常不像错，它说得很顺。顺，让人放松了警惕。这一点，对医生和病人都一样。所以，三方复合体里，需要一个新的习惯：越流畅的地方，越要多看一眼。

第三个，叫谁在最后签字。

最后签字的，仍然是医生。这一点不能含糊。AI 位推了状态，可是 AI 不会认账。所以，签字的那一刻，医生位不能被 AI 位悄悄绕开。那一笔，不能只是对着屏幕点个确认，它要真的是医生的判断落了地。

这一点，和上一章连起来看，就是：三方复合体里，追责的名册要加两行，一行是「选用 AI 的医院和科室，对它在这间诊室里怎么用负责」，一行是「做出这个 AI 的人和机构，对它的边界和说明负责」。AI 本身不在名册上，因为它没有账可认，可它背后，每一环都有人。

◆ 八、出了错，名册上多了两行

现在要回到上一章的老问题。三方复合体里，AI 出了错，责任在哪里？

先设一个虚构的情形。一份病历里，一句话被 AI 整理时改了意思，医生签字时没有发现，几个月后，另一位医生读到这句话，沿着它做了一个不必要的检查。病人多跑了一趟，多花了一笔钱，心里还多添了几天担忧。

这是一次差错。按上一章的办法，我们先问三件事。

第一件，追到手。这一环上，每个人的手，各自做了什么？

医生签字，没有对原话，这是医生那一头要认的账。病人自己，没有机会看到病历里写了什么，所以这一处，病人没有要担的，可病人有权要求看。后一位医生，沿着病历做了判断，这是正常的职业动作，她要担的，是此后她在发现情况有出入时，要如实说明。

第二件，追锯口。这个差错，是卡在哪一维？

说不出？病人当时说的是对的，不是这里。读不懂？病历被读成了另一个意思，是这里。回写不进？这句话一旦写进病历，就回写到了后面每一位医生的眼睛里，是这里，而且是最重的一处。

锯口是：整理的工序里，没有一步保证病人的原话还在；签字的流程，容易变成点一下确认；后面的医生读病历时，没有办法知道哪些句子是 AI 整理的、哪些是人写的。

第三件，名册。这一件，要加长。

医生位：对签字负责。这一点，不因为 AI 的参与而减轻。

科室与医院：对「采用了一个会整理病历的软件，却没有设置对原话的一步」负责。

提供这个软件的机构：对它的边界、它的提示、它可能出错的地方有没有说明清楚负责。

定规矩的人：对「病历里 AI 参与的部分是否要标明」这样的规矩负责。各地对这件事的具体规定不同，本书不涉及，请以现行规定为准。

AI 本身不在名册上。这不是为它开脱，是因为名册是用来认账的，认账的只能是人和机构。它没有账可认，但它背后的每一环，都有。

你会发现，这张名册和上一章的名册，是同一种东西，只是多了两行。**追责的办法没有变：追到手，追到锯口，两个都不放。**

不过，AI 的出现，带来了一个特别的新难处，值得单独说一句：「看不见的一环」。

从前，一份病历，是谁写的，一目了然。现在，一份病历里有一部分是人写的，一部分是机器整理的，一部分是医生改过的，混在一起，后来的人很难分辨。责任要追，先要看得见。所以，三方复合体里的追责，有一件事必须先做：让每一环可以被看见。哪些是人写的，哪些是机器写的，哪里改过，谁改的。

看得见，是追责的前提。看不见，一切追问都落空，最后总会落回那句最没有用的话：「大家都有责任。」

反过来，这件事也要小心：不要因为 AI 的参与，就把一切错都推给 AI。「是机器写的」，和上一章的「是系统的问题」一样，是一种很顺口的推脱。一个能签字的人，在签字的那一刻，选择了相信那段话。这一选，是他的。

所以，在三方复合体里，追责要比从前更仔细，不是更松。有一个位在，就多一行要问的话。

还有一件小事，值得在这里说，因为它最能看出 AI 位是怎样「发生」的，而不是先在的。

同一个问题，今晚问一遍，明早问一遍，换一个软件问一遍，答案的长短、语气、先后，常常不同。你再追一句「会不会很严重」，它的口气，又会跟着你的口气变。

这并非它在骗你，也并非它没有主见。每一次回答，都是在这一次问答里发生的，它不是从一个仓库里取出来的、早就写好的东西。

这个特点，对三方复合体意义很大。它提醒医生：病人带来的那段话，只是那一晚那一问里发生的一次，无须当成 AI 的「定论」去驳。它也提醒病人：你问出什么，和你怎么问有关。你若连问三遍，得到三种说法，软件没有出毛病，复合体本来就这样。

所以，会用 AI 的人，常常是会提问的人；会用 AI 的医生，常常是会追问的医生。追问，是把这个位，拉回到一个可以对话的状态。

◆ 九、一个完整的例子：那一夜之后

现在回到周老师。故事是虚构的，人物也是。

那天早上，周老师带着「是不是脑子里有问题」的疑问，坐在社区医院的诊室里。值班的医生姓林，三十出头。

林医生没有立刻回答。她先做了一件事：把周老师手机里那段对话，请他念了一遍。

周老师念的时候，慢慢听出了一点不一样。那一串「需要警惕的情况」，有好几条，跟他自己的情况，其实根本对不上。他念着念着，肩膀放松了一点。

林医生接着问：「你昨晚晕的时候，是转的，还是发飘？」

周老师想了想：「发飘。像是刚起床的那种。」

「起床的时候，有没有起得很猛？」

「好像是的，起夜。」

林医生没有马上下结论，她让护士量了血压，又问了他这几天的药、睡眠、吃饭。屏幕上的助手一直在整理，她偶尔瞟一眼，有一处她停了下来：助手把「起夜」写成了「夜间多次起床」，这和周老师的原话不一样，意思也差了一点。她改回去，在旁边补了一句周老师的原话。

这一改，要几秒钟。可是这几秒钟，是医生位没有被绕开的几秒钟。

诊断是什么，本书不谈，也不给任何建议。这只是一个虚构的故事，要看的，是三方复合体怎样走。

这一次，复合体走得顺，有几处可以看。

第一，林医生没有把 AI 位当敌人。她请周老师把它的话念出来，这是把一个看不见的位，请到了台前。

第二，她没有把 AI 的话当结论，也没有当废话。她用它当作一个切口：「你查的这几条，哪几条跟你对得上？」周老师一条一条对，对着对着，自己把惊吓放下了一半。

第三，她在 AI 整理的病历里，保住了病人自己的话。

第四，她没有只看屏幕，她看着周老师。屏幕上的字在走，她眼睛的重心，一直在人身上。

换一个走法呢？

如果林医生说：「你不要上网查这些，会吓着自己。」周老师会点头，也会闭嘴。下次他还是会查，只是不会再告诉她。这个复合体里，AI 位被推到了暗处，在暗处，它的话更有力，因为没有人可以对它说「这一条不对」。

如果林医生完全信了助手的病历，没有看见「起夜」被改了，那一行字就会跟着周老师，在以后的每一次复诊里被人读到。几年之后，另一位医生翻到这份病历，看到的是「夜间多次起床」，再往下想，就想到别的方向去了。

这两条路，都是复合体卡住的路。哪一个位出了问题？三个位都有份：病人的夜里没有人可以讲，医生的屏幕太会整理，AI 的答案太会说。每个位担每个位的事，每个位的背后，都有具体的人。

好的走法也没有什么神奇。它只是把三个位都放在桌面上，一个一个看。

三方复合体的健康，大概是什么样？本书不敢给一张标准表，只描一个轮廓。

三个位，都有自己的话可以说，也都有人可以问一句「这一条是怎么来的」。

AI 位说出的话，没有被当成结论，也没有被当成废话，它被放在桌上，对一对。

医生位的签字，每一次都是一次真正的判断落地。

病人位带进来的苦，还留着自己的样子，没有被谁抹平。

追责名册，长到了可以容下这三个位背后的所有人，没有一行写着「大家」。

这样的复合体，可以出错，也会出错。它与别的不同，是出了错之后，它知道怎样回到一把正常拉的锯子上。

◆ 十、第一个可落地、可验证的行业样本

写到这里，你也许会问：这套说法，是不是又一个听上去有道理、却没法检验的大话？

本书不愿这样。所以这一节，要把它说得可以被推翻。

王德生博士的立论线是：AI 时代，所有的问题要重新问，重新问成「新的复合体如何发生」。这是一个很大的判断，大到不容易检验。大判断需要一个落脚的地方，一个样本。

本书选医疗，选的理由有三个。

第一，医疗里的位是清楚的。病人位、医生位，从挂号那一刻起就有名有姓，AI 位加进来，也容易数清：它在哪一步进来的，对谁说话，说了什么，被谁改了。别的行业，位是糊的，这里是清的。

第二，医疗里的读数是现成的。复诊，会不会回来，隔了多久；方案，有没有落进日子；病历，有没有被改写，改写了什么；病人对诊室的信任，复诊时说不说真话。这些东西，有的已经在医院的记录里，有的可以用很小的办法问出来。

第三，医疗里的代价是明摆着的。出了错，要付的钱，要担的伤，谁都看得见。一个说法在这里站得住，比在别处站得住，更有分量。

所以，本书说：健康发生学，是人—AI 复合主体这条立论线的第一个可落地、可验证的行业样本。

可验证，就要有可检验的话。这里写出本书愿意被检验的几条，都标明是待验的，不是已经证明的结论。

其一〔待验〕：同样是病人先问 AI 再挂号，诊室里第一轮对话，如果医生位把 AI 的话请到台前来对一对，病人在后续复诊中，说真话的可能，比医生把 AI 的话挡回去的，要高。这条可以用很小规模的记录来比。

其二〔待验〕：医生用 AI 写病历的科室，如果在签字环节有专门的「对原话」一步，病历里被改写的意思，会少于没有这一步的科室。这条也可以数。

其三〔待验〕：出了差错之后，追责名册里把医院的采用方式和 AI 的提供方一并列入的，后续同类差错的重复，会少于只追到个人的。这条要时间，但可以追。

这三条，哪一条被反过来证明了，本书就要相应收窄。本书的底线是母题：医学研究的不是人的病，而是医患复合体的状态发生。三方复合体是母题往今天的延伸，延伸若被推翻，母题还在；母题若被推翻，延伸也就没有了。

还有一点要老实交代：本书写的是理解，不是研究报告。这三条待验的话，是给愿意做检验的人留的门，不是说本书已经做过。

◆ 十一、放回日子里，回到挂号那一刻

回到周老师。

那天回到家，周老师把那个软件，放到了手机的第二页。不是删了，是放到第二页，不那么顺手。他对女儿说：「半夜查那个，越查越怕。」

周岚听完，没有说什么大道理。她拿起手机，坐在他旁边，说：「爸，你下次半夜想查，先把你想问的话写下来，也写一句：我现在最怕的是什么。写完，第二天挂号的时候，念给医生听。」

这是你明天就能试的一个小办法，不管你是病人，还是病人的家人。

把这个办法拆开，其实只有三步，每一步都对着本章说的一处。

第一步，写下你最怕的是什么。这是对着「说不出」：怕，是苦的一部分，AI 的答案里常常没有它，可医生需要。

第二步，把 AI 说的话带去，不要藏。这是对着「两个说法顶牛」：说法放在桌上，才能一起看。

第三步，听完医生的话，用自己的话说一遍。这是对着「读不懂」和「回写不进」：能用自己的话说出来，才说明它能在你的日子里落脚。

如果你是医生，另有三步：把病人带来的话请到台前；签字之前，把病人的原话对一遍；眼睛多落在人身上。

这六步，没有一步是在跟 AI 作对。它们要的，只是让三方复合体里，每一个位，都站在自己的位置上，被看见，被问一句。

现在，请你把目光收回到全书的第一张纸上。

那是一张挂号单。单子出来的那一刻，「病人」「医生」「科室」「病名」一起显影，一把锯被拉起来了。今天，这张单子出来之前，还有一个位已经在了；单子出来之后，还有一个位坐在旁边。锯子上，从两头变成了三头。

可是母题没有变。医学研究的，不是人的病，而是医患复合体的状态发生。复合体从两个位变成三个位，是这个状态发生的新章节，不是另一本书。诊断依然不是终点，是开端，只是这个开端，今天比从前多了一重：在医生开口之前，已经有一个位先说过话了。

病不在病人身上，不在医生眼里，也不在那块屏幕里。它在这把越拉越长的锯子上，在锯口卡住的那一处。

找到那一处，是三个位一起要做的事。

带 走 的 话

诊室里已经是三方了，AI 不是一件工具，是复合体里一个新的位；追责追到人，也追到它卡住的那一维。

小　账

这一处，开门还是关门：这一章开了一扇门，让 AI 位从「工具」的暗处走到台前，被问、被改、被追；关了一扇门，「用得好就行」那扇。

病放在一个人身上，还是放回复合体里？放回去了，而且放回的是一个正在多出一个位的复合体，三个位各担各的，没有一个被抹掉。

想 一 想

你最近一次向机器问自己的身体，是在什么时候？那一问之前，你的苦是什么样的？那一问之后，它变成了什么样？

如果下次去看医生，你把那段对话带进诊室，你觉得医生的第一句话会是什么？你希望她说什么？

你所在的行当里，有没有一个新来的位，正被大家当成工具？如果换成「它是一个位」，你会先问它什么？

◆

结语

再拉一遍那把锯

◆ 一、一年以后

一年以后的一个冬天早晨，周老师又去社区医院。

还是那条路，还是那台挂号机。周岚今天不当医生，她请了半天假，陪着父亲排队。豆豆跟在后面，书包里装着一只小水壶，嗓子有点哑，隔一会儿咳两声。

挂号单从机器里吐出来。薄薄一张纸，上面有日期，有科室，有一个号码。

周老师捏着它，像捏着一张车票。

候诊椅上，豆豆把两只手叠在一起，前后推拉，嘴里哼着老儿歌：「拉大锯，扯大锯，姥姥家门口唱大戏。」

周岚听着听着，忽然笑了一下。

她想起一年前读过的一本书里说，两个人拉一把锯，锯口不是哪一头锯出来的。一头松了，锯就卡住。锯完了，两个人各自走开。

她看了看手里父亲的挂号单，又看了看走廊尽头那间诊室的门。

那扇门后面，有一个人今天坐在医生位上。门这头，有一个人今天坐在病人位上。两个位子，一个小时以前都还是空的。

这本书从一张挂号单开始，也想在一张挂号单上结束。

◆ 二、那一刻到底发生了什么

先把导论里的那一幕再放一遍，慢一点。

挂号单出来之前，周老师有头晕，有后颈发紧，有半夜醒来睡不着的一段难受。这些东西是真的，没有人说它们是假的。可是它们还没有名字，没有科室，也没有哪个人负责听它。那是一锅粥。

挂号单一出，几样东西一起冒了出来。

「病人」冒了出来。「医生」冒了出来。「心内科」或者「全科」冒了出来。过一会儿，病名也要冒出来。

它们没有一个一个排着队来，也没有哪一样先到、哪一样后到。它们像一张底片泡进药水里，轮廓一起浮起来。

本书把这件事叫做复合体的第一次显影。

这里最容易出错的，是回头去找一个「先在的」人。一个先已经是病人的周老师，一个先已经是医生的周岚，一个先已经站在旁边、看着一切的观察者。

第一编花了四章，就是要把这三个先在者请下台。

病人不是带着病来的，他带着苦来。

「我是病人」是挂号以后才有的位子，不是出生时就贴在身上的标签。医生也不是一个站在岸上的发现者。同一副身体，换一个医生、换一家医院，读出的东西常常不一样。这不是谁出了差错，是复合体不同。观察者呢，量子力学把他请到了台前，本书再往前走一步，连他一起拆掉。

拆完以后，剩下什么？剩下一件正在发生的事：一个医生—病人的互动复合体，在一个具体的早晨，开始有了状态。

◆ 三、母题，再说一遍

全书的脊梁只有一句话。现在它不再是一句要被论证的话，它是前面十六章一起长出来的东西。

医学研究的不是人的病，而是医患复合体的状态发生；诊断不是发现的终点，而是状态发生的开端。

这句话有两半。

前半是承载者换位。过去问：这个人得了什么病？现在问：这个复合体，此刻处在什么状态，它是怎样来到这个状态的？

后半是诊断换位。过去的诊断是一场搜查的收网，真相到手，案子结了。现在的诊断是一场对话的开篇，复合体第一次有了形状，往下怎么走，才刚刚开始。

你要是只记住这一句，就够用了。

◆ 四、四编，各压一句

十六章，四编。每一编，压成一句话，抄在本子上。

第一编，拆先在者。**病人、医生、观察者，都不先于这场互动；他们是互动沉下来的位子。**

第二编，讲诊断。**诊断不是谜底，是第一次显影：病人位、医生位、病名一起出现，并且一起写回日子里。**

第三编，讲三态与转换。**定型靠一锅粥和悬着活着；从来不悬着的稳，往往只是把一锅粥压住了。**

第四编，讲病与修复。**卡住的是复合体，所以修复也要落在复合体上；该追的责照追，追责本身就是修复的一段路。**

四句话连起来读，就是一条路。先把三个先在者放下，再看诊断怎样开题。开了题，看状态怎样走。最后看走不动时卡在哪里、怎样松开。

要是你想再细一点，下面是十六章，一章一句。

第 1 章：病人不是带着病来的，他带着苦来；「病人」是挂号以后才有的位子。

第 2 章：医生不是发现者；同一副身体换医生、换医院，读出的不同，来自复合体不同。

第 3 章：观察者被请到台前，仍是一个先在的发动者；本书连他一起拆。

第 4 章：状态属于复合体；安慰剂、医源性疾病、过度医疗，从干扰项变成正文。

第 5 章：诊断之前，有一锅粥；查不出问题，不等于没有苦。

第 6 章：诊断即开题；病人位、医生位、病名一起显影，并一起写回日子。

第 7 章：科室与读数一起显出，没有一个先在的测量基。

第 8 章：同一个病名，有的复合体流通，有的被压住；复诊与第二意见，是重新起头。

第 9 章：病名已立、结局未定，这一段悬着，是治疗的主场。

第 10 章：从不悬着的稳，可能只是把一锅粥压住了。

第 11 章：器质性与心因性不能同时测准；追一边，另一边就模糊。

第 12 章：最好的痊愈，是复合体不再被需要。

第 13 章：医生的倦怠与防御，是复合体的症状，算不到医生一个人头上。

第 14 章：痛则不通；卡的地方有三处，说不出、读不懂、回写不进。

第 15 章：复合体生病，责任仍在；追责之后，修复点要重新找。

第 16 章：机器是新位子，算不得工具；医生—病人，变成了医生—病人—机器。

◆ 五、这本书欠谁的

一本书说「别人都停在半路」，是很容易的事。本书要先把账摆出来。

量子力学的前辈们，把观察者从幕后请到了台前。没有这一步，本书连「拆观察者」都无从谈起。玻尔说现象要连同整个实验安排一起说，巴拉德把这条线索接下去，讲到物质与意义是在具体的做法里一起成形的。这些，本书都接着用。

恩格尔在 1977 年提出，医学不能只盯生物这一层，心理与社会也要进来。

这扇门是他推开的。福柯讲临床的凝视怎样一点点长成现代医学的眼睛，让人看见「医生看病」这件事本身有历史。叙事医学的人坚持，病人的故事不是病历的装饰，是医学的一部分。循证医学的人要求，每一个决定都要问一句：证据在哪里。

这些都是本书的邻居，也是本书的老师。附录一把每一家走到了哪里、留下了什么、本书接着走哪一步，列成一张账。账的末尾，每家各有一段公道话，请你翻到那里看。

本书自己的账，也同样要记。附录四写着本书自认最弱的几处，以及什么样的事实出现，就该把这本书的某个判断收回。一本讲状态发生的书，自己也是一个状态，也要留着被改的口子。

◆ 六、有了机器以后

十六章里，最后一章是写给今天的。

会说话的机器进了诊室，也进了家里的手机。夜里两点，一个人对着它问：我这样是不是病了？

本书的说法是：这个故事，和多了一件工具的老故事不同。医生—病人的复合体，正在变成医生—病人—机器的复合体。多出来的这个位子，会参与状态的显影，也会参与回写。

所以「机器说得准不准」只是半个问题。另外半个问题是：有了它以后，这个复合体的苦，说得出来了吗？说出来的东西，读得懂了吗？读懂了的东西，回得到日子里去吗？

这三问，下面会再用一次。

还有一件事，值得提前说。机器进来以后，最容易发生的误会，是把它当成一个「更好的医生」或者「更快的搜索框」。这两种看法，都还把机器放在复合体的外面，当成一件递过来的东西。

本书的看法是，只要它参与了你怎样说、怎样听、怎样把方案带回日子，它就已经在复合体里面了。它不是发动者，也不是旁观者，它是一个新位子。位子是新的，老问题没有变：说不说得出，读不读得懂，回不回得去。

◆ 七、拉大锯，错在哪里

总比喻用了一整本书，到了结语，要把它错的地方说出来。一个只说好处的比喻，会骗人。

它对的地方很清楚：锯口不是哪一头锯出来的，是两头合起来锯出来的；一头松了，另一头也跟着卡住。这条，是本书全部的重量。

它错的地方，有三处。

第一处，两头一样重。拉大锯的两个人，手上的劲差不多。可是诊室里的两头，一头有多年训练，有处方权，有熟悉的环境；另一头带着疼，带着怕，常常连词都找不全。两头的力气、知识、处境都不对等。这种不对等，是复合体的一部分，不能被「锯子两头」的画面抹掉。

所以，说「两头都得出力」是对的，说「两头出一样的力」是错的。医生那一头，要多出一份：多听，多解释，多留一个口子。

第二处，锯完各自走开。拉大锯有头有尾，锯断了木头，事情就结束了。可是很多病，不是一锯就完的。慢性病、反复复诊、长期用药，是两个人每隔一阵再拉一次，一拉就是几年。第 9 章写的悬着，第 12 章写的解散，就是在补这一处：锯子不总是锯完就放下，有的会一直挂在墙上，等着下一次。

第三处，只有两个人。真实的复合体，常常站着第三方、第四方：陪诊的家属，管着排班的科室，规定着时长的医保，还有现在手机里的那台机器。第 16 章把机器写成一个新位子，正是因为锯子旁边，已经不止两只手了。

比喻错了三处，不必扔掉。拿着它，同时记着它错在哪里，正好是读这本书的好办法。

◆ 八、这本书没有回答的

写完了，要说说没写到的。

本书没有回答，一个复合体到底该由谁来「召集」去修复。第 15 章说了要重新定位修复点，可是在一家医院里，在一个家里，具体由哪一个人先动手，要看那个地方的情形。书里给不出一张通用的表。

本书也没有回答，制度能不能为这样的看法让出空间。门诊时间、医保规则、考核指标，这些都是锯子本身的形状。锯子的形状，不是两个拉锯的人一个晚上能改的。本书写到制度，只写到「看见」为止。

还有一件，本书只留了一个口子：同一个复合体，在不同的文化里，是不是一样。书里的例子，大多取自中文世界的日子，取自挂号、排队、陪诊、红包这类很具体的东西。别的地方的人怎样拉这把锯，本书不敢替他们说。

没有回答的东西，并非没有答案，下一本书、下一个读者，会接着去找。

◆ 九、「复合体生病」不是「没有人负责」

有一种读法，本书要在这里再挡一次。

有人听到「是复合体生病了」，就想：那就是说谁都没有错，谁都不用负责。

不是这样。

复合体是一张网，网上的每一个结，都有自己要接的那一份。医生有医生的职责，医院有医院的制度，家属有家属的分寸，病人有病人的权利和能做的事。哪一处失职，就是哪一处的事，该问就问，该担就担。

「复合体」这个词，不用来把责任稀释成一杯温水。它是用来回答另一个问题：追完了责，复合体还卡在那里，接下来怎么办？

追责告诉你哪一个结松了。修复要做的，是让整张网重新能走。

两件事都要做，缺了哪一件，锯都拉不动。

◆ 十、三处替换，和三问回验

读完十六章，回头看，全书其实只做了三处替换。

第一处，承载者。过去说：这个人得了病。现在说：这个复合体处在这样一种状态。人没有消失，病也没有消失，它们换了一个放法：它们是复合体显影出来的位子和读数。

第二处，观察者。过去说：有一个看的人，在看一样东西。量子力学把这句话改成：看的人也参与了东西的样子。本书再改一次：看的人和东西的样子，是同一场互动一起沉下来的。没有谁在幕后发动，也没有谁在台前发动。

第三处，诊断。过去说：诊断是终点，真相到手，往下是执行。现在说：诊断是起点，复合体第一次有了形状，往下是一路的转换。

三处替换，没有一处要把旧东西扔掉。人、病、医生、诊断，都还在，都还要认真对待。变的只是一件事：它们站在哪里。

再回到那三问。第 14 章说，一个复合体痛则不通，卡的地方有三处，说不出、读不懂、回写不进。用在周老师家，就是三个很小的场景。

说不出：周老师半夜醒来的那种难受，他一直说成「没睡好」。直到有一天，他对周岚说，是后颈到肩膀这一片，像压了一块湿毛巾。苦有了形状，复合体才有东西可接。

读不懂：诊室里说的那几个词，他点头，回家以后跟老伴说不清。周岚发现以后，没有重新讲一遍，而是请他先讲他听到的。听到的那一版，和医生说的那一版，中间有一段空。空在哪里，路就缺在哪里。

回写不进：方案定了，日子没动。早上的那几件小事，该在什么时候做，没人写下来，也没人问过。方案躺在纸上，没有在日子里发生。

三问不用背。下一次挂号，随手拿它们问一问就够了。

◆ 十一、给想反驳的人

读到这里，要是你心里有一句「我不同意」，请不要压下去。

这本书是一把锯，不是一堵墙。你拉过来，它会动。你拉不动，它也会告诉你，哪一处卡住了。你的不同意，可能正好指出的是，附录四里还没写到的那第八处。

反驳的办法，也最好是具体的：给一个人，一次就诊，一句话。越具体，越能把这本书推到更远的地方。

◆ 十二、给三种读者的一句话

给病人和家属：你不用先弄懂一切才有资格开口；苦先说出来，形状就会一点点出来。

给医生：你的每一句话，都在给这个复合体添一块砖；病名那一句，尤其重。

给做制度、做研究、做产品的人：别只盯着一个人的数据；也看一看，这个人和他的医生之间，那一段是怎样走的，谁在那里走不动。

要是你只能记住一件事，请记住这一件：**挂号以后发生的，不是一个人被查出了什么，而是一个新的复合体开始了它的状态。**

它会怎样走，一部分取决于两头的人，一部分取决于锯本身，也取决于脚下那片土。这些，你都能看见，也都能动一动。

◆ 十三、明天能做的一件事

一本书读完，要落到一件小事上，不然它只是读过。

明天，要是你家里有人要去医院，或者你自己要去，请在挂号以前，花五分钟，在本子上写三行。

第一行写：**这一次，我最想让他听见的一件事是什么？**写得越具体越好，比如「这个月头晕都在早上起床时来」，比这样写好：「我不舒服」。这一行对的是「说得出」：苦要先转成一个别人接得住的形状。

第二行写：**我最怕听不懂的一个词是什么？**到时候就当场问一遍，哪怕问到第二遍。这一行对的是「读得懂」：知识要接上这具身体的路，才算真的到了你手里。

第三行写：**不管今天定下什么，回家以后的第一个晚上，我们谁做哪一件小事？**这一行对的是「回写得进」：一个方案，要在日子里发生一次，才算数。

如果你是医生，明天可以只改一句话。在说完病名以后，再多问一句：「这个名字，放进你的日子里，你觉得会是什么意思？」

问完停三秒，听。

这样做，不是在给谁添礼貌。是在给这个复合体多留一个口子：让病名不只写进病历，也有机会写进两个人对这件事的共同理解里。

本书只谈理解，不给诊疗和用药的建议。身体或心里的难处真的大了，请找医生或心理咨询师。

◆ 十四、那天晚上

那天晚上，周老师回到家，把挂号单放进了那个装血压本的抽屉。

不是因为它重要，是因为它是这一天开始的地方。

周岚在厨房洗杯子，水声哗哗的。她想起书里的一句话：诊断不是终点，是开端。今天的诊室里，没有人宣布什么大事。医生问了几句，周老师答了几句，医生又问了一句：「这几个月，早上起床的时候，哪一段最不舒服？」

这一句，让周老师愣了一下。他很久没有被人这样问过。

他想了想，说：「起身那一下。」

那一下，是他一直没找到词的东西。词找到了，复合体就多了一条能走的路。

豆豆从房间里探出头，问：「外公，你还拉大锯吗？」

周老师笑了：「拉啊。两头都得出力。」

◆ 十五、最后一个画面

再回到早上。诊室的门开了，护士叫了号。

周老师站起来，周岚扶了一下他的胳膊，又松开。豆豆还在哼那首儿歌，手一前一后，一前一后。

门里面，那个今天坐在医生位上的人抬起头，看了一眼走进来的人。

这一刻，没有谁遇见谁。是一个复合体，开始了它这一天的状态。

锯子已经架上了。

接下来，要看两头怎么拉。

参考书目

书目分四类：量子力学与测量问题；医学哲学与医学社会学；叙事医学与医患沟通（含循证医学）；SDE 发生学。每类按初版年份排列。年份一般取初版年份，中译本以通行版本为准，本书没有逐一核对中译本，所以不列译者。

每一条的作者、题名、年份、出版社或刊物，都已逐条核过；对不上的，宁可不列。本书正文引到这些著作，一律转述大意，不作逐字引文。

一、量子力学与测量问题（按初版年份）

1. von Neumann, J.: Mathematische Grundlagen der Quantenmechanik, Springer, 1932。（英译本 Mathematical Foundations of Quantum Mechanics，Princeton University Press，1955。）
2. Bohr, N.: Atomic Theory and the Description of Nature, Cambridge University Press, 1934.
3. Einstein, A., Podolsky, B., Rosen, N.: "Can Quantum-Mechanical Description of Physical Reality Be Considered Complete?", Physical Review 47, 1935.
4. Bohr, N.: "Discussion with Einstein on Epistemological Problems in Atomic Physics", in P. A. Schilpp (ed.), Albert Einstein: Philosopher-Scientist, Library of Living Philosophers, 1949.
5. Heisenberg, W.: Physics and Philosophy: The Revolution in Modern Science, Harper & Brothers, 1958.
6. Wigner, E. P.: "Remarks on the Mind-Body Question", in I. J. Good (ed.), The Scientist Speculates, Heinemann, 1961；后收入 Symmetries and Reflections, Indiana University Press, 1967.
7. Bell, J. S.: "On the Einstein Podolsky Rosen Paradox", Physics 1, 1964.
8. Wheeler, J. A., Zurek, W. H. (eds.): Quantum Theory and Measurement, Princeton University Press, 1983.
9. Fine, A.: The Shaky Game: Einstein, Realism, and the Quantum Theory, University of Chicago Press, 1986.

10. Rovelli, C.: "Relational Quantum Mechanics", International Journal of Theoretical Physics 35, 1996.

11. Zurek, W. H.: "Decoherence, Einselection, and the Quantum Origins of the Classical", Reviews of Modern Physics 75, 2003.

12. Barad, K.: Meeting the Universe Halfway: Quantum Physics and the Entanglement of Matter and Meaning, Duke University Press, 2007.

13. Schlosshauer, M.: Decoherence and the Quantum-to-Classical Transition, Springer, 2007.

二、医学哲学与医学社会学（按初版年份）

1. Fleck, L.: Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache, Benno Schwabe, 1935。（英译本 Genesis and Development of a Scientific Fact, University of Chicago Press，1979。）

2. Canguilhem, G.: Le normal et le pathologique，初为 1943 年博士论文；增订版 Presses Universitaires de France，1966。

3. Parsons, T.: The Social System, Free Press, 1951。（其中有「病人角色」一章。）

4. Szasz, T. S., Hollender, M. H.: "A Contribution to the Philosophy of Medicine: The Basic Models of the Doctor-Patient Relationship", AMA Archives of Internal Medicine 97, 1956.

5. Balint, M.: The Doctor, His Patient and the Illness, Pitman Medical, 1957.

6. Foucault, M.: Naissance de la clinique: Une archéologie du regard médical, Presses Universitaires de France, 1963。（英译本 The Birth of the Clinic，1973。）

7. Freidson, E.: Profession of Medicine: A Study of the Sociology of Applied Knowledge, Dodd, Mead, 1970.

8. Illich, I.: Medical Nemesis: The Expropriation of Health, Calder & Boyars, 1975.

9. Boorse, C.: "On the Distinction between Disease and Illness", Philosophy & Public Affairs 5, 1975.

10. Engel, G. L.: "The Need for a New Medical Model: A Challenge for Biomedicine", Science 196, 1977.

11. Sontag, S.: Illness as Metaphor, Farrar, Straus and Giroux, 1978.

12. Kleinman, A.: Patients and Healers in the Context of Culture, University of California Press, 1980.

13. Starr, P.: The Social Transformation of American Medicine, Basic Books, 1982.

14. Cassell, E. J.: "The Nature of Suffering and the Goals of Medicine", New England Journal of Medicine 306, 1982.

15. Kleinman, A.: The Illness Narratives: Suffering, Healing, and the Human Condition, Basic Books, 1988.

16. Emanuel, E. J., Emanuel, L. L.: "Four Models of the Physician-Patient Relationship", JAMA 267, 1992.

17. Gadamer, H.-G.: Über die Verborgenheit der Gesundheit, Suhrkamp, 1993。（英译本 The Enigma of Health，Stanford University Press，1996。）

18. Good, B. J.: Medicine, Rationality, and Experience: An Anthropological Perspective, Cambridge University Press, 1994.

19. Hacking, I.: The Social Construction of What?, Harvard University Press, 1999.

20. Mol, A.: The Body Multiple: Ontology in Medical Practice, Duke University Press, 2002.

21. Moerman, D. E.: Meaning, Medicine, and the Placebo Effect, Cambridge University Press, 2002.

22. Mol, A.: The Logic of Care: Health and the Problem of Patient Choice, Routledge, 2008.

三、叙事医学、医患沟通与循证医学（按初版年份）

1. Cochrane, A. L.: Effectiveness and Efficiency: Random Reflections on Health Services, Nuffield Provincial Hospitals Trust, 1972.

2. Mishler, E. G.: The Discourse of Medicine: Dialectics of Medical Interviews, Ablex, 1984.

3. Evidence-Based Medicine Working Group: "Evidence-Based Medicine: A New Approach to Teaching the Practice of Medicine", JAMA 268, 1992.

4. Frank, A. W.: The Wounded Storyteller: Body, Illness, and Ethics, University of Chicago Press, 1995.

5. Stewart, M., Brown, J. B., Weston, W. W., McWhinney, I. R., McWilliam, C. L., Freeman, T. R.: Patient-Centered Medicine: Transforming the Clinical Method, Sage, 1995.

6. Sackett, D. L., Rosenberg, W. M. C., Gray, J. A. M., Haynes, R. B., Richardson, W. S.: "Evidence Based Medicine: What It Is and What It Isn't", BMJ 312, 1996.

7. Sackett, D. L., Richardson, W. S., Rosenberg, W., Haynes, R. B.: Evidence-Based Medicine: How to Practice and Teach EBM, Churchill Livingstone, 1997.

8. Greenhalgh, T., Hurwitz, B. (eds.): Narrative Based Medicine: Dialogue and Discourse in Clinical Practice, BMJ Books, 1998.

9. Silverman, J., Kurtz, S., Draper, J.: Skills for Communicating with Patients, Radcliffe Medical Press, 1998.

10. Charon, R.: "Narrative Medicine: A Model for Empathy, Reflection, Profession, and Trust", JAMA 286, 2001.

11. Charon, R.: Narrative Medicine: Honoring the Stories of Illness, Oxford University Press, 2006.

12. Howick, J.: The Philosophy of Evidence-Based Medicine, Wiley-Blackwell, 2011.

13. Greenhalgh, T., Howick, J., Maskrey, N.: "Evidence Based Medicine: A Movement in Crisis?", BMJ 348, 2014.

四、SDE 发生学与本系列

1. 王德生：《发生学的发生：发现学内部的碰撞、自组织与涌现》，德麦国际出版社，2026。

2. 王德生：《发现的发生学》，德麦国际出版社，2026。

3. 王德生：《懂的发生学：路在你这儿接着走》，德麦国际出版社，2026。

4. 王德生、胡敏：《器官发生学导论》，德麦国际出版社，2026。

5. 王德生：《国家发生学导论》，德麦国际出版社，2026。

6. 王德生：《晕痛苦》，德麦国际出版社，2026。

本书第 14 章讲「痛则不通」，第 16 章讲人—AI 复合主体，立论各有来处，可参看上面几本。

读书建议：书目很长，从哪里读起？给想接着读下去的人，一条小路。先读恩格尔 1977 年那篇论文，不长，是整个故事的入口。再读夏龙的《叙事医学》，看病人的话怎样变成医学的一部分。然后读福柯的《临床医学的诞生》，看「医生看病」这件事本身怎样有了历史。想弄懂量子力学一侧的争论，从巴拉德的书和祖雷克 2003 年的综述读起，一本讲观察者被请上台，一篇讲为什么不需要意识。最后回到这本书，回到你自己的下一次挂号。

附录

附录五件，供查、供对、供练、供读。

读正文时碰到一个近邻的名字，想知道本书到底接了他什么、没接什么，翻附录一。想查本书的四条承重命题是谁在什么时候说的，翻附录二。听别人谈起这本书，觉得哪里不对劲，翻附录三。想知道这本书哪里可能站不住，翻附录四。读完想动手试一试，翻附录五。

附录一

近邻与敌人对账表

本书说的「敌人」，不是对手，是最近的邻居。越是走得近的人，越容易在最后一步上分道。把这一步看清，两边才都有路。

这一张账，只记一件事：每一家已经走到哪里，给后来的人留下了什么先在者，本书接着走的一步是什么。

「先在者」的意思是：某个被当作理所当然、先于互动就已经在那里的东西。

近邻	已走到哪里	留下的先在者	本书接着走的一步
玻尔	现象要连同整个实验安排一起说，测量不是旁观	仍有一个选择实验安排的实验者	实验者与安排一起，是复合体显影的结果
巴拉德	物质与意义在具体的做法里一起成形；「切口」不是先有的	「做切口」的那个动作，仍像是由某个行动者在做	连「做」也不当作发动者，只当作互动沉下的样子
恩格尔	医学要看生物、心理、社会几层，不能只盯一层	仍是「一个人」，几层都装在他身上	承载者换成医患复合体，几层是它的几种读数
福柯	临床的凝视有历史，医生的眼睛是长出来的	凝视的权力仍有一个可指认的一方	凝视与被凝视，在同一次显影里一起出现，并一起被改写
叙事医学	病人的故事是医学的一部分；听与写是临床的功夫	「故事」仍像先在于叙述，等着被听见	故事也是在这场互动里成形的，听的位子与说的位子一起生成
循证医学	每个决定都要问证据，不靠权威和感觉	证据所说的「总体」，被当成同一个先在的人群	证据要落到这一个复合体上，落的过程本身是状态发生的一段

下面是每一家的一段公道话。

用这张账，有一个小办法：读到任何一家，先问自己，他为什么会走到这里。每一家的路，都是被他当时面对的难题逼出来的。玻尔面对的是实验结果拒绝服从旧图景；恩格尔面对的是医学把人拆得只剩器官；福柯面对的是一个被当作天然的

眼睛；叙事医学面对的是被检查单挤出去的话；循证医学面对的是靠资历说话的诊室。难题不同，停下的地方也就不同。

— 玻尔

公道地说，没有玻尔，今天没有人会认真问「观察者在不在里面」。他最硬的一条是：谈一个量子现象，不能把它和产生它的整套实验安排拆开。

这条放进医学里，几乎可以原样使用：谈一个「病」，不能把它和产生它的整套问诊安排拆开。本书要向他学的，就是这份不肯偷偷省掉安排的老实。

他停下的地方，在于总有一个人决定用哪一套安排。本书说，那个「决定者」也是安排与读数一起沉出来的位子。这是接着他走，不是推翻他。

再补一句。玻尔的著作很难读，他的话常常半是物理、半是哲学。本书引到他，都只转述大意，凡涉及具体表述处，请以原著为准。

假如玻尔来辩护，他大概会说：实验总要有人来做，这不是形而上学，是物理学的日常。这话对。本书不否认实验里有人。本书只说，把「有人」当成解释的终点，就少问了一步：这个人是怎样成为实验者的。

— 巴拉德

巴拉德把玻尔往前推了一大步。她说，边界、切口、意义，都不是先有的，是在具体的物质做法里一起生成的。她的书名叫《Meeting the Universe Halfway》，意思是：宇宙与我们，在半路相遇。

这个「半路相遇」，离本书的复合体已经很近。公道地说，她比多数建构主义者做得彻底。

可是「做切口」这个动作，读起来仍像有人在做。本书只多走一步：连这个「做」，也不算发动者，只算互动沉下来的样子。至于她会不会同意，本书不替她回答。

还有一层要说清楚。巴拉德讲的是物理与物质，本书讲的是诊室里的人。从一边走到另一边，中间隔着一段没有人替本书走过的路。所以本书只拿她的思路作近邻，不拿她的结论作证据。

假如巴拉德来辩护，她大概会说：她的「施动」本来就不是一个先在主体的施动，而是物质与话语之间的施动关系。这个辩护有分量。本书的回答是：这正是本书想走的方向，也许两家走到同一处。差别只在于，本书把它用在诊室里，并且明说了要放下哪些医生位、病人位的旧说法。

— 恩格尔

恩格尔 1977 年那篇文章，是医学这一边最重要的一扇门。他要求医生别只看病，还要看人，看人的心，看人的家和社会。今天医学院里讲的「生物—心理—社会」，源头在这里。

他的功劳无法抹去。后来所有说「别把人当器官」的话，都站在他的肩上。

本书想补的只有一点：他的「人」，仍是一个先于就诊就在那里的个体，几层都装在他一个人身上。本书说，装它们的是医患复合体。这样一来，医生的倦怠、指标的焦虑，也能进入正文，而不是被当成干扰。

他当年写文章，针对的是医学只认生物这一层的偏窄。今天读来，那场争论的大半已经赢了。本书接着往下问的，是赢了之后还剩下的那个问题：几层装在谁身上。

假如恩格尔来辩护，他会说：他从来没有说过几层都「装在」一个人身上，他只说了要同时看几层。这个辩护也对。本书的补充是：同时看几层之后，下一个绕不开的问题就是，这几层的「汇合处」在哪里。本书说，汇合在互动里。

— 福柯

福柯在《临床医学的诞生》里讲，现代医学的「看」是一点一点造出来的：病人躺在床上，医生的眼睛学会穿过身体，去看器官和组织。这是一个历史，不是天然。

公道地说，读过他的人，再也不会觉得医生的眼睛是一块干净的玻璃。

他留下的先在者，是权力的两头：看的一头与被看的一头，似乎各自清楚。本书说，两头是同一次显影里一起出现的，也会一起被改写。要谈修复，就不能只改一头。

福柯的书是一段历史，不是一份诊疗指南。读他的人，容易从「看」的批判，一路滑到「医生都在行使权力」。本书不走这一步。医生的眼睛是长出来的，长出来的东西，可以长得更好。

假如福柯来辩护，他大概会说：他不是在给医生开药方，是在把一个看起来天然的东西，还原成有来历的东西。这话也对。本书的回答是：还原之后，修复要有落脚处，而落脚处，是一个具体的复合体。

— 叙事医学

夏龙等人把一个朴素的道理立了起来：病人的话不是病历的装饰。听，是临床的功夫；把听到的写下来，是临床的功夫。这一派救回了很多被检查单挤出去的东西，值得认真对待。

可是「故事」这个词，容易让人觉得它先已经完整地躺在那里，只等一个好耳朵去接。本书说，故事也是在这场互动里一边说、一边成形的。同一个苦，对不同的听者，说出来的是不同的故事。

这不为批评听的功夫，是想让这门功夫的要求更高：听不只是接，也是在和说的人一起把它做出来。

叙事医学这一路，教学的传统很深，训练的办法也很具体：细读、平行病历、反思写作。这些办法，本书很愿意借用。只是请读的人记得，细读的那个人，也在这场阅读里被改了。

假如叙事医学的人来辩护，他们会说：谁说故事先于叙述？临床里的叙述，本来就是共同完成的。这个辩护，本书完全接受。本书要补的只是，这一点要成为这一派自己的出发点，而不只是一个提醒。

— 循证医学

循证医学的初衷，是不让权威和感觉替代证据。在一个偏信「老经验」的世界里，这是一次真正的清理。不夸张地说，今天许多人少受的罪，是靠它换来的。

本书不反对证据，一点都不。本书想问的，是证据落地的那一步：研究里的「总体」，和诊室里这一个复合体，中间隔着一段。这一段怎么走，不是证据本身能回答的，它是状态发生的一部分。

好的循证医学早就知道这一点，才会说要把证据、经验和病人的价值放在一起用。本书做的，是给这句话一个更清楚的承载者。

证据等级、随机对照、系统综述，这些东西，本书一概承认它们的价值，也不主张在诊室里把它们放到一边。要问的只是：等级最高的证据，是不是已经替这一个复合体回答了所有问题？这个问题，好的医生比谁都清楚答案。

假如循证医学的人来辩护，他们会说：证据、经验、价值三者合用，早就是这一派的教科书写法。本书的回答是：太好了。本书想做的，只是给「合用」这一步，起一个能说清楚的名字：状态发生。

— 六家，各压一句

每一家，压成一句，格式照本系列的体例：前半是他看见的，后半是他留下的。

玻尔：**他看见了测量不是旁观，却留下了那个选实验安排的人。**

巴拉德：**她看见了切口不是先有的，却让「做切口」读起来仍像有人在做。**

恩格尔：**他看见了人不只是器官，却把几层都装在了一个人身上。**

福柯：**他看见了医生的眼睛是长出来的，却让看与被看仍像各自清楚的两头。**

叙事医学：**它看见了病人的话是医学的一部分，却容易让故事看起来先于叙述。**

循证医学：**它看见了决定要靠证据，却容易让证据所说的总体，替代了眼前这一个复合体。**

这六句，是附录一的核心。读完上面的表和公道话，如果只想带走一点，带走这六句。

记一家的账，本书遵守三条规矩。一，先写他看见了什么，写足，写到他自己读了也点头。二，再写他在哪里停下，用他自己的材料指出来，不拿本书的概念去压他。三，最后写本书接着走的那一步，并且写明这一步还没有被证明。

这三条规矩，也适用于读者。你要是想给本书记一笔账，请照同样的办法记。

— 补记：莫尔

账上只列了六家，还有一位邻居，要补一笔：荷兰学者安娜玛丽·莫尔（Annemarie Mol）。她在《The Body Multiple》（2002）里考察一家荷兰医院里的动脉粥样硬化，讲同一种病在诊室、化验室、手术室这些不同的做法里，被不同地「做」出来，所以「这一种病」不止一个。（转述大意）

公道地说，她离本书很近：她也不让病先于做法而在。本书想问她的，是「做」这个词，是否又悄悄请回了一个做的人。这一问，和问巴拉德的是同一个。

把她放在补记里，不放进表，是因为本书对她读得还不够细，不敢下太满的判断。读者若熟悉她的书，请指教。

一 六家对三个先在者，一眼看过

三个先在者，是第一编拆的三样：先在的病人，先在的医生（观察者），先在的「下切口的那一处」。下面一张表，是本书对六家的粗略概括，只作路标，不作定论。

近邻	病人（被看者）先在吗	医生（看者）先在吗	本书的回应
玻尔	被测的对象不能脱开安排谈	实验者仍在	实验者与安排一起显出
巴拉德	对象与意义一起成形	「施动」仍待说清	连施动也是沉淀
恩格尔	是一个完整的人	是一个应当更完整的医生	完整的是复合体
福柯	被凝视的身体是被造的	凝视的眼睛是长的	两头同时长
叙事医学	有自己的故事	应当学会听	故事与听一起成形
循证医学	是证据所说的总体中的一个	是证据的使用者	使用的过程是状态发生

表里每一格，都是一句话的缩写。缩写的好处是看得清，坏处是容易失真。请读者对着附录一的公道话，一格一格地核。

一 各家的入口

想亲自读一读这些邻居，下面是从哪里下手比较容易的建议。

读玻尔，先读他 1949 年回应爱因斯坦的那篇长文，再读别人写的导读。读巴拉德，先读她书的导论，不必从头硬啃。读恩格尔，一篇论文，比什么都清楚。读福柯，先读《临床医学的诞生》的前言和第一章，其余可以慢慢来。读叙事医学，先读夏龙 2001 年的那篇文章，再看她的书。读循证医学，先读 1996 年那篇「它是什么、不是什么」，短，而且是那一派自己写的辩护。

每一家，都先读他自己怎样说自己，再读别人怎样说他。这条规矩，本书对自己也这样要求。

附录二

口述命题登记

本书的四条承重命题，由王德生博士于 2026 年 11 月 3 日口述。以下四条与口述原文一字对齐，只在记录处加了日期。

命题一　不是病人生病了，也不是医生看病，而是「医生—病人这个生命互动复合体」生病了。这是健康发生学。（王德生，2026-11-03 口述）

本书怎样用：第 1 章至第 4 章拆三个先在者，第 4 章把承载者换成复合体。这条命题不等于「医生和病人各有一半的病」，也不等于「病是两个人合出来的幻觉」。它说的是，状态属于这对互动，不属于其中任何一头。

命题二　这是量子力学「系统状态的发生里有观察者的参与和建构」的延伸——但观察者仍然是发现学。「观察者参与建构」只是把发现者从幕后请到台前，仍有一个先在的发动者（建构主义是发现学的内部改良）。本书连观察者一起拆掉：观察者与状态都是发生的沉淀。（王德生，2026-11-03 口述）

本书怎样用：第 3 章是主场，第 16 章再用一次。这条命题不等于「量子力学证明了医学」，更不等于「意识影响病情」。量子力学在这里只是近邻：它把观察者请到了台前，本书要问的是，请到台前以后，还有没有一个先在的发动者。

命题三　所谓诊断，就是健康发生学的开始。发现学里诊断是终点（真相到手），发生学里诊断是起点（复合体第一次显影：病人位、医生位、病名一起出现）。（王德生，2026-11-03 口述）

本书怎样用：第 5 章写诊断之前的一锅粥，第 6 章写诊断那一刻，第 8 章写病名写回日子以后的两种走向。这条命题不等于「诊断不重要」。恰恰相反，它说的是诊断重要到了不能只当作终点。

命题四　精确说法是：「医生—病人」互动复合体的状态发生学。健康与病不是两样东西，是同一复合体的状态；要问的是状态怎样发生、怎样转换。（王德生，2026-11-03 口述）

本书怎样用：这是书名的来历，也是第三编的总纲。它的好处，是不再把「健康」和「病」放在两个抽屉里，而是看同一个复合体怎样从这个状态走到那个状态，以及它在每个状态里是靠什么撑着的。

四条命题，分别在书里承重的地方：命题一贯穿第一编，尤其是第 4 章；命题二见第 3 章，并在第 16 章再用；命题三是第二编的总纲，集中在第 6 章；命题四是第三编的总纲，也是书名的来历。

登记的作用，是把「谁说的」和「谁在写」分开。判断归口述者，文字由协作者执笔，哪里写偏了，责任在文字，不在命题。

四条命题在全书里的地图，列成一张表。

命题	主场	再用	它对着谁说话
一　复合体生病	第 4 章	第 13 章、第 15 章	恩格尔的「一个人」
二　观察者仍是发现学	第 3 章	第 16 章	玻尔、巴拉德
三　诊断是开端	第 6 章	第 8 章	福柯的凝视、循证的终点
四　状态发生学	第 9 章至第 12 章	全书	叙事医学的「故事」

表里「对着谁说话」一栏，是本书为了读者方便而加的，不是口述的内容。

如果读到哪一条，觉得与口述的原意有出入，请以王德生博士的口述为准，本书据此改。

一　口述之外：本书自己的几条解释

除了上面四条口述命题，书里还有几处是本书自己的解释，不是口述，标作「待验」。登记在这里，免得被当成口述的内容。

第一，「科室与读数一起显出」，来自第 7 章。口述命题只给了「复合体第一次显影」，把科室也放进这个显影，是本书的发挥。

第二，「病名是第一次回写，写进病历也写进日子」，来自第 6 章与第 8 章。这是本书对诊疗日常的概括。

第三，「器质性与心因性不对易」，来自第 11 章。这是一个比喻性的借用，附录四有专门的说明。

第四，「解散是最好的痊愈」，来自第 12 章。这是本书对「秩序态」的一种读法。

第五，医生端的症状、痛则不通的三处、医生—病人—AI 的三方复合体，来自第四编。这些是本书把口述的框架用到具体问题上的结果。

以上五处，哪一处写偏了，责任在本书的文字，不在口述者。

附录三

十大常见误读

听人转述这本书，常见十种误读。逐条说一说。

— 误读一　「病是假的」

不对。头晕是真的，疼是真的，指标异常也是真的。本书没有说病不存在，说的是：病总是在一个具体的复合体里，以一种状态的样子出现，而不是挂在一个孤零零的人身上。

你要是正在难受，请不要因为这本书而怀疑自己的感觉。那份难受，医生需要听，家人也需要听。

— 误读二　「怪医生」

不对。「复合体生病」不是把账记到医生头上，也不是反过来记到病人头上。承载者是整个复合体，该追哪一处的责，仍然追哪一处。第 15 章写过：追责是修复的一部分。

同样，也不要把这句话读成「怪病人」。一个复合体里卡住的地方，要一处一处找，找到哪一处，就在哪一处动手。

— 误读三　「量子玄学」

不对。本书不说「量子力学证明了医学」，也不说「意识改变病情」。量子力学在本书里只做近邻：它留下了观察者，本书要拆掉这个留下来的东西。至于「不需要意识」，连退相干的研究也这样说。

如果有人拿这本书去讲「心想事成」，请告诉他，这本书里没有这个意思。

— 误读四　「不用治了」

不对，而且是最危险的一种。本书讲的是怎样理解，不是要不要治。该吃的药、该做的检查、该动的手术，请听医生的。身体或心里的难处真的大了，请找医生或心理咨询师。

一本讲理解的书，不能替代一次门诊。读完这本书以后，该挂的号还是要挂。

— 误读五　「病人没有责任」

不对。病人位上的人，有他要接的那一份：把苦说出来，把没听懂的问出来，把定下的事带回日子里。本书只是说，这一份不是「病人这个身份」自带的，是复合体里一个位子上的活儿。

这一点放宽了看，对病人反而是好事：既然是一个位子的活，就可以和别人分担，不必一个人扛。

— 误读六　「医生的诊断都只是主观的」

不对。诊断有证据，有指南，有训练。本书不说诊断是随便的，只说诊断不是故事的结尾。诊断那一刻，有东西被固定下来，也有东西被打开。

被固定的，是病名、分类、下一步的检查。被打开的，是两个人此后怎样一起面对这件事。两样都是真的。

— 误读七　「换医生就能换病」

不对。第 2 章里写过，同一副身体换医生、换医院，读出的东西常常不同，这说明复合体不同，不是说病可以随手挑。第二意见的价值，在于重新起头，不是找一个更合心意的答案。

有人会借「换医生」去一直找，直到听到想听的那一句。这种找法，本书不鼓励；它容易让复合体一再从头开始，却一次也没有走完。

— 误读八　「这本书是反对循证医学」

不对。附录一里写得清楚：循证医学是一次真正的清理。本书只追问证据怎样落到这一个复合体上。落的那一步，也要认真做。

证据说的是平均，诊室里坐的是一个具体的人。认真对待这个差，就是对证据的尊重，不是对证据的冒犯。

— 误读九　「痊愈就是病没了」

不对。第 12 章说，复合体的一种好的秩序态，是它不再被需要，也就是「解散」。病没了，常常是解散的一个原因，也可能是一个结果，两者不总是一回事。有些人带着病名，也过得很松。

这样说，不是在降低对治好病的期待。是提醒我们，除了「病有没有」，还有「这个复合体还需不需要这样紧紧地抱在一起」。

— 误读十　「这是一种新疗法」

不对。这是一种看法，不是疗法。本书不给疗法，也不替任何疗法背书。你能带走的，是几个更好的问题，以及一两件明天能做的小事。

如果有谁拿这本书去向别人推荐某种疗法，那是他自己的主张，不在本书的意思之内。

误读为什么出现，其实有迹可循。多数是因为一个词被抽掉了前后文。「复合体」一词，被读成「大家都有份」；「状态」一词，被读成「不是真病」；「发生」一词，被读成「凭空而来」。

遇到这样的转述，请问转述的人一句：书里这句话的前一句是什么？

另外还有三种小一点的误读，顺手说说。

有人说，「复合体」不过是折中：医生一半，病人一半，各打五十大板。不对。折中是把两个先在者拼起来，复合体则是问先在者是怎么来的。

有人说，「状态发生学」就是心理学。不对。心理学可以研究复合体里的一部分，可是状态发生学问的是整个复合体怎样显影、怎样转换，范围比心理要宽，也比心理要具体。

有人说，这不就是中医的整体观吗。两者在「不把人拆成零件」这一点上，确有相通之处；可是本书不依托中医的理论，也不替中医作论证。是否相通，留给熟悉两边的人去说。

附录四

本书自认最弱的几处与推翻条件

一本书只说自己的长处，是不诚实的。下面几处，本书自己觉得最薄。

其一，「观察者也是发生的沉淀」，目前是本书的解释，标待验。它依赖一个前提：发生比发动者更根本。要是有人能给出一个清楚的情形，其中一个「发动者」的存在先于并且独立于互动，而且这个情形确实在医患之间发生，这个判断就该收回。检验的办法不难：留意你的下一次就诊，看你能不能找到一个，医生和你都还没开口，你已经「是病人」了的瞬间。

其二，「病名是第一次回写」，来自本书对日常诊疗的概括，没有做过系统观察。要是大量的观察表明，病名对此后的日子几乎没有改写作用，这一条要大幅收窄。检验的办法也不难：问几位刚被确诊的人，病名出来以前和以后，家里的日子有没有变；变了的，变在哪里。

其三，「器质性与心因性不对易」，是比喻性的借用。量子力学里的不对易有精确的数学含义，医学里没有。本书只把它当成一个提醒：追一边，另一边往往变模糊。要是临床上两者可以同时测准，而且测得准并不损害另一边，这个说法就不成立。这个说法的好处是容易试。找两位条件相似的病人，让他们的医生分别把重点放在身体检查和谈话上，看哪一边更模糊。当然，这要由真正的研究去做。

其四，「科室是测量基」比喻的收回。本书认为它有力，也说它预设了选择者。要是有人证明这个预设无害，收回就是多余的。这一处的取舍，留给读者：如果你觉得「科室是测量基」这个比喻比本书的收回更有用，请保留它，并告诉我们为什么。

其五，医生端的症状。第 13 章把职业倦怠、指标焦虑、防御性医疗放进复合体的症状里。这是一个解释，不是已经有统计支持的结论。要是研究表明这些现象主要由个人因素决定，与医患互动关系不大，这一章要大改。检验的办法，是看数据：同一位医生，在不同的病人群、不同的科室、不同的医院里，倦怠与防御的程度有没有变化。

其六，所有病例都是虚构的。虚构能让道理清楚，也让道理显得过分整齐。真实的诊室更乱。读者若从自己的经验里找到一个说不进来的例子，请不要为了本书而收起它。把它写下来，寄给我们。一个好的反例，比十个好的例子更有用。

其七，关于机器的一章，是写在一个还在变化的时间里的。可以预期，其中一部分判断会过时。过时的部分，会在新版里标出来。读者读到的这一版，写在 2026 年 11 月；到那时机器会变成什么样，本书看不到。

推翻的方式很简单：给出一个与书中判断冲突的事实，写明时间、地点和来源。本书会据此改，并公开改了什么。

另外，本书有几件事，是不敢说的。

不敢说「所有病都是复合体的状态」。有些病，来得极快、极重，与诊室里的对话几乎无关，比如一场急性的意外。本书讲的是一大类情形，不是全部。

不敢说「改善沟通就能改善结局」。沟通好了，复合体会更顺，可是顺不等于愈。这中间有多远，要靠医学自己的研究去量，本书量不出来。

不敢说「这本书的说法比所有近邻都好」。附录一的账，是本书自己记的。别人也可以另记一本。

一 收窄前后各一句

按本书的体例，判断收窄时，要把收窄前后两句都写出来。下面先把七处弱点各预备好，万一被推翻，就这样改。

其一，收窄前：观察者与状态，都是发生的沉淀。收窄后：在医患这一类互动里，观察者与状态看起来是一起沉下来的，更一般的说法，留待检验。

其二，收窄前：病名是复合体的第一次回写。收窄后：在许多就诊里，病名会写进病历，也会写进日子，两者的轻重，因人因病而异。

其三，收窄前：器质性与心因性不对易。收窄后：在一些慢性、症状模糊的情形里，追一边常使另一边变模糊。

其四，收窄前：科室与读数一起显出。收窄后：科室对读数有影响，影响多大，要看具体的科室与病。

其五，收窄前：医生端的症状是复合体的症状。收窄后：医生端的症状中，有一部分与复合体的运行相关，相关程度待研究。

其六，收窄前：以虚构的一家人讲清道理。收窄后：虚构的一家人只作说明，不作证据。

其七，收窄前：机器是医患复合体里的新位子。收窄后：在机器已经参与问诊与回写的场合，它实际上占了一个新位子。

本书可能错在哪里的三个信号

要是读者在自己的经验里，遇到下面三种情形，请认真对待，它们可能意味着本书错了。

第一个信号：你发现某个医生，换了多少个病人，读出的东西都一样，而且后来都证明读对了。这说明有些部分，真的更接近「医生一头」的功劳，本书对第 2 章的判断要收窄。

第二个信号：你发现某个病人，换了多少个医生，说的都是同一个故事，听的人也都听到了同一个故事。这说明有些苦，的确先于互动就有了清楚的形状，本书对第 5 章的说法要收窄。

第三个信号：你按本书的办法试了一阵，家里的拉锯并没有松，反而更紧了。这不一定是本书错了，也可能是做的方式不对；可是这样的反馈，本书一定要听。

附录五

练习

练习分两组：一组给家里有病人的人，一组给医生。每组五题。每题都小，一晚上就能做。

做之前，请记住：这是为了理解，不是诊疗建议。身体或心里的难处真的大了，请找医生或心理咨询师。

五题不必一次做完。一个晚上做一题，一周刚好做完一组。做的时候，不要追求「做对」。这些题没有标准答案，只有你自己的答案。

一 给家里有病人的人

题一 找一个安静的晚上，请那位病人用三句话说说：这几天，最难受的是什么？只记，不评，不劝。写下来的那三句话，就是一个苦第一次有了形状。做完以后，看一件事：他用的词，是不是和平时说的一样？不一样的地方，往往就是平时被压住的地方。

题二 回想最近一次陪他去医院。你在候诊区是什么位子：陪着的人、翻译的人、拿主意的人，还是出钱的人？这个位子，是谁给你的，还是你自己站上去的？做完以后，试着换一个位子坐一次，比如只当那个陪着的人，不拿主意。看看复合体的哪里松了，哪里紧了。

题三 拿出上一次的就诊单或化验单，不看数字，只看病名那一行。问问病人：这几个字，对你意味着什么？再问自己：这几个字，对我意味着什么？两个答案，往往不一样。差在哪里，就是下一次谈话该从哪里起头。

题四 请病人说一件医生交代过、他没完全听懂的事。你不必当场解释，只要陪他把它写成一个问题，下次就诊时带上。这一步对的是「读得懂」：一个听不懂的词，是一条还没有接上的路。

题五 想一想，这个家里，有没有什么东西，在病名出来以后悄悄变了：谁做饭，谁说话，谁不再说话。写出来一件，不下判断。病名进了家，也是在写回日子。看见它怎样写，是改写它的第一步。

— 给医生

题一　选今天的一位病人，在看诊结束后，用一句话写下：这一次，我们是在什么位子上开始的？是谁先说话，说了什么，我怎么接的？做完以后，把这一句和前一天的同一句放在一起看。看的是自己的习惯，不是评分。

题二　下次说出病名以后，多停三秒，问一句：这个名字，放进你的日子里，会是什么意思？把听到的第一个回答记下来。常见的情形是，第一个回答并不是医生预想的那个。这时候，复合体才真的开始说话。

题三　回想最近一次你自己当病人的经历。那一次，你坐在哪个位子上？医生做了哪一件事，让你觉得被听见了；又有哪一件事，让你觉得被放到了一边？再回头想一想，你自己的病人，会不会也遇到过同样的两件事。

题四　找一次复诊。在接着往下谈之前，先问：上次定下的事，在你的日子里发生了吗？没有发生，先别急着换方案，问问卡在哪里：是说不出，读不懂，还是回写不进。三处里，通常只有一处卡得最死，先动那一处。

题五　看一眼你的科室、你的排班、你的指标。哪一样，在你和病人之间悄悄占了一个位子？写出来，不必解决，只要看见。有些东西，比如指标和排班，不是你一个人改得了的。看见它占了位子，已经是在为这个复合体减负。

做完整组，请把五个答案放在一起读一遍。往往有一个词，在五个答案里反复出现。那个词，就是你们这个复合体现在最卡的地方。

— 给医学院的老师

如果你在医学院教书，下面三题，可以拿到课堂上用。

第一题，请学生两人一组，一人扮病人，一人扮医生，各自拿到一张只写了「你的位子」的小纸条，不写任何剧情。演三分钟，然后问：你们是在哪一句话上，才真正成了医生和病人？

第二题，请学生把一份真实的病历（隐去姓名）读一遍，只找一样东西：这份病历里，哪一句是病人说的，哪一句是被医生改写过的。

第三题，请学生写一份「第一次复诊前的备忘」：假如这位病人下周再来，你最想先问的一句话是什么。

三题都不考知识，考的是看见。

— 一周七个晚上

如果你想把练习排成一周，下面是一个小安排。每晚不超过十分钟。

第一晚，只听。请家里的那位说说今天哪一刻最难受，不打断。

第二晚，只问一个问题：「你最怕的是什么？」不安慰，不解释。

第三晚，把上次医生说的话，请他用自己的话复述。听他漏掉了什么。

第四晚，一起写下一次就诊要带的三个问题。

第五晚，一起看一眼家里的安排：谁做饭，谁陪诊，谁管药盒。问一句：这样分，大家都撑得住吗？

第六晚，什么也不谈病。吃饭，聊别的，哪怕只聊一件小事。

第七晚，各自说一句：这一周，我觉得我们这一对（或这一家），有一处松了一点。

七个晚上里，没有一个晚上是在「治病」。可是七个晚上都在为这个复合体添一点力。

身体或心里的难处真的大了，请找医生或心理咨询师。

— 给读书会的五个问题

一，你读到这本书以前，自己是怎样想「病人」这个词的？读完以后，哪一处变了，哪一处没变？

二，母题的前半和后半，哪一半你更容易接受，哪一半更难？难在哪里？

三，书里说观察者也是发生的沉淀。你的生活里，有没有一个你一直当作「发动者」的人，其实是被一场互动推出来的？

四，拉大锯的比喻，在你的经验里还错在哪里？除了书里说的三处，你能不能再找出第四处？

五，如果下一版要加一章，你希望加什么？请写下它的第一句话。

后记

◆ 一、这本书怎样写成

这本书是在一个晚上开的头。

那天晚上，王德生博士谈起医生和病人。他说，人们总说病人生病了，医生看病；可是在诊室里真正生病的，也许是「医生—病人」这一对。他把这叫做健康发生学。

接着他谈起量子力学。他说，系统状态的发生里有观察者的参与和建构，这一点，量子力学早就讲过。可是在他看来，那个观察者仍然是发现学的：只是把发现者从幕后请到了台前，那个先在的发动者还在。本书要把观察者也一起拆掉。

然后他谈到诊断。发现学里，诊断是终点；在发生学里，诊断是起点，是复合体第一次显影。

最后他把说法收紧成：「医生—病人」互动复合体的状态发生学。

这几句话，是全书的骨头。按口述的次序，前后收紧了五步：从「复合体生病」，到与量子力学的关系，到观察者仍是发现学，到诊断是开端，再到「状态发生学」的精确说法。这五步，前言里有细讲。

书的写法，也值得交代几句。

这个晚上以后，这本书没有马上成书。先是一张交接卡：母题一字不改，四条命题不得改动意思，全书目录定为四编十六章，每章大约一万一千字。然后才是写。

交接卡里还有几条纪律，读者也许想知道。判断句的承载者必须是复合体；不写「量子力学证明了医学」；不写「意识影响病情」；「复合体生病」不等于责任稀释；不给诊疗和用药建议；不编造引文、数据和年份。这些纪律，每个写作者都要先读，写完再自查。

书的文字，是人和 AI 一起写出来的。要如实说清楚：

判断、口径和四条承重命题，来自王德生博士的口述。母题一字不改，也是他定的。写作的纪律，比如「判断落回复合体」「不写量子力学证明了医学」「不编造引文」，由他立下。

文字，由 AI（Claude）执笔。十个写作者并行，每人分一部分，各自对着同一张交接卡写，写完各自体检，再合成一本。因为是并行写的，书里的人物、比喻和语气，要靠交接卡来对齐；对不齐的地方，一定还有，请读者指出。

十个人并行，也有它的好处：每个人只管自己那一块，写得专心；统稿的人再把十块拼起来，看哪里接缝不齐。接缝处，正是复合体最容易出问题的地方，这本书写的是复合体，自己也不免。

书中的陪读人物，周老师、周岚、豆豆，是虚构的。病例是虚构的。引到的学者，都是转述大意；书目里的条目，逐条查过。

这本书里有一种工作，AI 做得比人快：把一个想法翻成十几种说法，试一试哪一种读起来不费劲。也有一种工作，AI 做不了：决定哪一句话不能动。后一种，始终在王德生博士手里。

还要说一句局限。AI 写作容易写得太顺、太整齐，顺到连该卡住的地方也滑过去了。这本书里一定有这样的地方。读到哪一句觉得「顺得不对劲」，请相信这个感觉，那多半是该停下来想一想的地方。

◆ 二、为什么写在今天

这本书写在 2026 年 11 月。这个时间，有它的道理。

一边是医院越来越忙，诊室里的时间越来越短，一次问诊常常只有几分钟。另一边是机器越来越会说话，一个人半夜睡不着，可以立刻问它，几秒钟得到一段看起来很完整的回答。

在这样的时间里，医生和病人这一对，比以往任何时候都更需要被重新看一遍。不是为了批评谁，是因为这一对正在被两头挤：一头是时间，一头是机器。

被挤的东西，是那把锯。锯口还在不在？两个人手上的劲，还对不对得上？

这是本书想问的问题，也是今天很多家庭正在问的问题。

◆ 三、关于引文与核验

最后交代一件小事：引文和核验。

书中提到的学者与著作，全部是转述大意，没有逐字引文。参考书目里的每一条，作者、题名、年份、出版社或刊物，都逐条核过；对不上的，没有列。中译本没有逐一核对，所以书目不列译者。

另外，书中凡写「本书的解释，标待验」的地方，是本书自己的判断，还没有被谁证明过的结论。

读者若手边有原书，发现哪一处转述得不对，请告诉我们，我们会改。

◆ 四、感谢

谢谢所有把苦说出来的病人，谢谢所有把话听进去的医生，谢谢站在走廊里等着、什么位子都没有的家人。这本书里没有一句是写给「病人」或「医生」这两个标签的，写给的是你们之间的那一把锯。

也谢谢周老师、周岚和豆豆。他们是虚构的人，可是他们身上的每一个场景，都是从真人的日子里借来的影子。要是你在他们身上看见了自己的家，那是因为这样的日子，很多人都有。

谢谢恩格尔、福柯、夏龙、玻尔、巴拉德，以及书目里所有的人。本书站在他们的肩上，才有了这一点高度。

谢谢那些在书中被拿来对账的人。对账不为挑错，要认真读完以后，才有资格说。

◆ 五、给下一版的话

一本书出版了，才真正开始被检验。

这本书的第一版，一定留着缺漏。有些章节写得过于整齐；有些例子读起来像是为道理而设；有些地方，本书用了一个比喻，却没有把它的错处说够。这些，都是这一版的真实状态。

下一版会怎样？不知道。可以确定的是，它会比这一版多出一批读者的回写，会改掉一批转述不准的地方，也会在附录四里，换掉几个已经被别人推翻的「最弱处」，补上新的。

这也是一个复合体的状态发生：作者、文字、读者，一起，把这本书慢慢做出来。

◆ 六、关于署名

书的封面上写着「王德生　著」。这个署名，指的是判断与口径的归属。书里的文字，由 AI 在他的指令下协作写成，已在出版信息页和本篇声明。

至于书里那些很用心的细节，一家人的对话，诊室门口的一声咳嗽，都出自协作者的笔。它们是虚构的，不应被当成观察记录。

署名这件事，本书想说得直接一点：判断是谁的，就是谁的；文字是谁写的，就写谁。不让两者混成一团，是对读者的一份老实。

◆ 七、请你回写

一本讲「回写」的书，最希望的，是被读者回写。

你要是读过这里提到的哪一本书，觉得本书哪一处转述错了，请告诉我们。你要是自己经历过一次诊室里的事，觉得本书的哪一句说不进去，也请告诉我们。附录四写着这本书最弱的七处，那是本书主动递出去的七个口子；你找到第八个，更好。

这本书，会因此改。

你写来的东西，不必长，也不必好。有四样就够：哪一章，哪一句，你的经历或者出处，以及你希望它怎样改。

要是你愿意，请再多写一句：写这封信的时候，你觉得自己坐在哪个位子上。

◆ 八、下一本见

这本书写的是医患这一对。同样的拉锯，还在老师和学生之间，父母和孩子之间，上司和下属之间，人和一台会说话的机器之间。每一对，都值得有一本书。

先把这一把锯，拉好。

拉好的意思，不是拉得快，也不是拉得齐。是两头都知道，对面也有一个人在用力；一头松了，另一头会觉得；锯口走偏了，两个人一起把它扶回来。

那张挂号单还在周老师的手里。一页薄纸，一个号码。

病人位，医生位，病名，一起冒出来。

医学研究的不是人的病，而是医患复合体的状态发生；诊断不是发现的终点，而是状态发生的开端。

版本说明

本版字数、版本与交付

本版为 2026 年 11 月第 1 版，德麦国际专著第 571 号，ISBN 979-8-90690-590-1，定价 US$20.00。前言、导读、导论、四编十六章、结语、附录与后记的正文实计 193,495 个汉字，合约 19.3 万字；章题、节题、表格与参考书目不计入。

书稿的形成经过：王德生在 2026 年 11 月 3 日口述母题与四条承重命题，定题《医患复合体状态发生学——病不在病人身上，也不在医生眼里》，大纲以「拉大锯」为总比喻、「挂号那一刻」为总钥匙；十位执笔者按同一张交接卡分章写出初稿，经统稿与三审（一审核实各家学说的转述与参考书目，去掉杜撰的引语、数据与年份；二审对齐母题与四条口述命题，守住「判断落回复合体」的主语纪律；三审通读文字、拆长句长段、统一体例）。

统稿中做过的统一：全书四编定名为「拆掉三个先在者：病人、医生、观察者都不先于互动」「诊断：状态发生的开端」「三态与转换：定型靠一锅粥和悬着活着」「复合体的病与修复」；每章章末统一为带走的话、两行小账、想一想三件；三态统一叫一锅粥、悬着、定型；陪读人物周老师、周岚、豆豆的设定全书一致；书中人物均为虚构；不给诊疗、用药建议。

交付：印刷版与阅读版 PDF、Word 版、全文网页、在线翻页；学习包（十六个单元，每章一个）；本书智能体。

核 心 命 题

医学研究的不是人的病，
而是医患复合体的状态发生；
诊断不是发现的终点，
而是状态发生的开端。

——王德生口述

人们总说：病人生病了，医生看病。本书说：在诊室里真正生病的，是「医生—病人」这个互动复合体。病不在病人身上，也不在医生眼里，在两个人一推一拉的那道锯口上。

挂号那一刻，病人位、医生位、科室和病名才一起露面；诊断不是真相到手的终点，是复合体第一次有了形状。之后是一锅粥、悬着、定型三种状态的转换：定型靠一锅粥和悬着活着，最好的痊愈是复合体散开、不再被需要。

量子力学把观察者请到了台前，观察者仍是发现学；本书连观察者一起拆掉。复合体生病不等于没人负责：追到那只手，也追到锯口卡住的那一维。

母题与四条承重命题由王德生口述；正文由 AI（Claude）执笔，经统稿与三审；书中人物均为虚构；只谈理解，不给诊疗用药建议；没有独立学术评审。

病不在哪一头，在锯口上。

德麦国际出版社 · Demai International Press
德麦国际专著第 571 号 · 前言、导读、导论、四编十六章、结语 · 约 19.3 万字
ISBN 979-8-90690-590-1 · 定价 US$20.00

ISBN 979-8-90690-590-1
9 798906 905901